

terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGIA
Y TERAPEUTICA
DEL GRUPO FAMILIAR

7/8

ELSA LABOS

Acerca de la policausalidad del síntoma infantil

JOSE BEBCHUK

Una célebre investigación de la dinámica familiar de la esquizofrenia

D. MALDAVSKY, N. NEVES y R. LEGUIZAMON

Análisis del valor de la desmentida en la formación y el funcionamiento del grupo familiar

SUSANA MATUS

Comentario acerca de una experiencia en el trabajo de familias con niños, dentro de un enfoque psicoanalítico/estructural

EDUARDO MANDELBAUM

Comentario sobre terapia familiar y el equipo terapéutico desde la experiencia clínica

JUAN CARLOS NOCETTI

Acerca de los obstáculos para pensar la experiencia clínica con familias

D. GIACOMODONATO y M. WEISSMARK

Familias como sistemas adaptativos complejos

JACQUES RUDRAUF

Filiaciones e Hitos

KATIA GIACOMETTI

Terapia familiar: un modelo de desarrollo y una propuesta de clasificación

PHILIPPE CAILLE

La intervención terapéutica y las premisas de un cambio real en la relación humana

PHOEBE PROSKY

El uso de lo analógico y lo digital para entrenarse en la percepción e intervención sistémicas

A. M. NICOLÒ, F. LEBENSOHN y L. JURI

Ateneo Clínico

A. CANEVARO y A. SERRANO

Diálogos

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica
del grupo familiar

Año IV, N° 7/8, Diciembre 1981

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina

Dr. Rafael Skiadaressis

Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Gerald Zuk (Filadelfia)

Alberto Serrano (Buenos Aires-San Antonio-Texas)

Jacques Rudrauf (París)

Helm Stierlin (Heidelberg)

Maurizio Andolfi (Roma)

Richard Sauber (Massachusetts)

Robin Skynner (Londres)

Mara Selvini Palazzoli (Milán)

Raymundo Macías (México)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argentina-St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Donald Bloch (New York)

Ives Colas (Lyon)

C. Sluzki (Buenos Aires-S. Francisco-California)

J. Howells (Ipswich-Inglaterra)

Director Administrativo

Alberto Cattán

Secretaria Administrativa

Graciela Rodríguez

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

Asesor Gráfico

Gabriel Kargieman

TERAPIA FAMILIAR, es una publicación semestral de Editorial ACE S. R. L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs. As., Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 142516.

Coordinación gráfica: Gabriel Kargieman, TE.: 771-8554.

Tarifa reducida 3052 — Franqueo pagado 339 — Número del Registro Internacional de Publicaciones Científicas ISSN 0325-5905

*Talleres Gráficos Garamond S.C.A.,
José A. Cabrera 3856, Cap. Fed.,
terminó de imprimir este libro
en el mes de marzo de 1982*

INDICE

EDITORIAL	7
OBITUARIO	9
ELSA C. LABOS	
Acerca de la policausalidad del síntoma infantil	11
JOSE BEBCHUK	
Una célebre investigación de la dinámica familiar de la esquizofrenia	29
DAVID MALDAVSKY, NILDA NEVES y RUBEN LEGUIZAMON	
Análisis del valor de la desmentida en la formación y el funcionamiento del grupo familiar	43
SUSANA MATUS	
Comentario acerca de una experiencia en el trabajo de familias con niños, dentro de un enfoque psicoanalítico/estructural	83
EDUARDO MANDELBAUM	
Comentario sobre terapia familiar y el equipo terapéutico desde la experiencia clínica	95
JUAN CARLOS NOCETTI	
Acerca de los obstáculos para pensar la experiencia clínica con familias	119
DANIEL GIACOMODONATO y MONA WIESSMARK	
Familias como sistemas adaptativos complejos	137
JACQUES RUDRAUF	
Filiaciones e Hitos	149

KATIA GIACOMETTI

- Terapia Familiar: un modelo de desarrollo y una propuesta de clasificación 181

PHILIPPE CAILLE

- La intervención terapéutica y las premisas de un cambio real en la relación humana 219

PHOEBE PROSKY

- El uso de lo analógico y lo digital para entrenarse en la percepción e intervención sistémicas 241

ANA MARIA NICOLO, FIDEL LEBENSOHN y LUIS JURI

- Ateneo Clínico 249

ALFREDO A. CANEVARO – ALBERTO SERRANO

- Diálogos 275

SINTESIS DE LIBROS 299

INFORMACION GENERAL 309

CONCURSO 1981 DE TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR 317

EDITORIAL

Una de las funciones constantes de la revista y de nuestros editoriales ha sido tratar de ubicar permanentemente a la terapia familiar como disciplina científica. Tratar de encuadrar un objeto de estudio específico y propio, ayudar a construir un cuerpo de teoría, enfatizar su carácter multidisciplinario y finalmente, ya en el campo de la confrontación con otros enfoques, mostrar su carácter integrador y complementario. Ha sido una línea personal, que transportada a una función periodística, por así decir, adquiere un compromiso distinto. El interlocutor pasa a ser parte de uno mismo, y con eso, si bien se puede ganar por la conexión íntima con nuestros pensamientos, también se puede perder la distancia óptima que se necesita para establecer un diálogo. Quizás sea el momento oportuno para abrir un canal más directo y vívido como pueden ser las Cartas a la Dirección. Si bien las respuestas tendrán un carácter indirecto en su mayor parte, a través de la selección de los artículos, de la Información General y de los capítulos más originales como los Diálogos y los Ateneos.

Clínicos, no se excluye el aspecto más fresco y espontáneo de la respuesta directa.

Como producción argentina, esta revista está imbuida de nuestras virtudes y defectos y como tal es conocida en el mundo principalmente a través de suscriptores y canje de revistas. Países tan lejanos como India y Australia, tan cercanos como los latinoamericanos, y tan íntimamente relacionados con la Argentina como lo son algunos europeos y del hemisferio norte, constituyen un mosaico heterogéneo y fascinante que nos puede ayudar a tener una visión transcultural de la terapia familiar, en la medida en que se va extendiendo en el mundo este enfoque cuya virtud y no la menos importante sea la de proteger al ser humano, en tanto ayude a revitalizar el nido ecológico en el cual crece y es ayudado a incluirse en la cultura.

* * *

Por razones principalmente editoriales y para obviar un cierto retraso en las entregas, hemos fundido los números 7 y 8, para poder finalizar nuestro cuarto año, a razón de dos números anuales. Intentaremos, durante el 82, tomar como referencia cronológica los meses de junio y noviembre.

Gracias y hasta la próxima.

El Director

OBITUARIO

JACQUES RUDRAUF

Falleció en París a fines de 1981.

Casi tan nebuloso e impactante como este título resulta bosquejar una biografía de este amigo distante, de cuya muerte nos enteramos al cierre de esta edición.

Resulta muy doloroso tener que rotular como póstumo el trabajo que en este número publicamos, trabajo cuyo autor valoraba a priori su publicación íntegra. Homenaje para un hombre cuya honestidad intelectual era una de sus mayores virtudes.

Lo conocí en un seminario del Profesor Luc Kaufmann, en el 5to Congreso Internacional de Terapia de Familia de Zürich en 1977. Ahí compartimos durante tres días junto a colegas de otras partes del mundo (Anna María Nicoló, entre ellos) momentos ricos en conocimiento e intercambio de experiencias sobre la terapia familiar en distintos países y con distintos encuadres.

Quizás el conocimiento de la obra de Szondi fue el punto de encuentro con quien apreciaba la obra del húngaro-suizo como la de un dilecto maestro. Precisamente en un libro suyo resitúa la obra del autor del "Diagnóstico experimental de las pulsiones", mal llamado Test de Szondi, como un aporte limitado para comprender el vasto alcance que el húngaro daba al encuentro profundo entre las personas, y creador hace años de nociones de "inconsciente familiar" mucho antes algunos autores de orien-

tación psicodinámica hablaban de este concepto. No es aquí el lugar para hablar de Szondi, sino del fervor con que Rudrauf defendía sus ideas, y de la profunda erudición que sus escritos muestran.

Fundador en París de la Asociación Francesa de Terapia Familiar, no pudo quizás dar a las luchas políticas internas la misma enjundia que a sus ideas. Intelectual nato, fiel representante de la tradición francesa, se destacaba más por la profundidad de sus caminos interiores que por ciertas mezquindades de la lucha por el poder en el terreno profesional. Pudo no obstante reunir un grupo de trabajo y de estudios en el Centre Médico-Psychopédagogique de Boissi Saint Léger en el cual volcó su alma de educador.

Licenciado y diplomado en estudios superiores de filosofía, médico-psiquiatra y psicoanalista, era dueño de una vasta cultura, que vertió en varios trabajos, y especialmente en un grueso volumen titulado "C'est toi qui le diras. . ." *propôs sur le métier médico-psycho-pédagogique**, donde analizó y definió pautas delineadoras de la identidad de los componentes de los equipos multidisciplinarios de salud mental. De él dijo Henri Bissonnier: "desde la lectura de sus primeros escritos, nos ha parecido inscripto en la línea de esos médicos franceses y filósofos entre quienes vienen naturalmente a la memoria nombres como Pierre Janet, Henry Ey y Jacques Lacan. El manifiesta también esa libertad de exposición que le permite hacernos compartir su amplia cultura, comunicarnos sus admiraciones y también entender su 'violon d'Ingrés'."

Muerto el mismo año que su querido terapeuta, Jacques Lacan, supo unir a sus conocimientos psicoanalíticos, los aportes de la escuela interaccional y sistémica, con un respeto intelectual —lamentablemente escaso hoy en día— que hacía de él un hombre fuera de serie. Nuestro Consejo de Redacción pierde un valioso colaborador, y sólo nos queda el triste orgullo de poder publicar en este artículo póstumo pensamientos muy valorados por él, y contribuir de esa manera a hacerlo vivir entre nuestros lectores como signo de respeto y de amistad.

A. Canevaro

* Editions Fleurus, París, 1974.

Acerca de la policausalidad del síntoma infantil

ELSA C. LABOS*

* Médica psicoanalista. Miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.

Villanueva 1365 – 1er. piso – Buenos Aires (Argentina)

La experiencia en análisis infantil, especialmente en lo que atañe al abordaje de los cuadros psicóticos, me llevaron a plantear distintos cuestionamientos que hacen a la teoría y específicamente a la técnica psicoanalítica.

Debo confesar, que desde los análisis cuyos resultados fueron frustrados en relación a las metas curativas —ya que incluyen la posibilidad de una transformación estructural de los sujetos— surgieron mis dudas en relación a las técnicas ortodoxas de abordaje, es decir aquellas que toman al sujeto individualmente, sin tomar en cuenta su entorno específico, como lo es su familia.

Especialmente los niños pequeños, que no tienen enteramente desarrollado el lenguaje, así como también sujetos con alteraciones narcisísticas serias, constituyen los casos en los que surgen necesidades cada vez mayores de información en relación a la historia del sujeto en interacción con los otros, para la comprensión de su patología.

En el caso del niño, en particular, habitualmente quedan excluidos los elementos referidos a los acontecimientos del mundo externo en que ellos son y fueron protagonistas, quedando el análisis así, enteramente encarado desde una perspectiva absolutamente transferencial, es decir, que la comprensión de la dinámica inconsciente de estos pacientes queda supe-
ditada a las experiencias transferenciales surgidas en el vínculo con el terapeuta.

Creo entender que esto no basta, para comprender específicamente lo que hace a la etiología psicodinámica de las enfermedades mentales, así como también a las posibilidades de reconstrucciones de los vínculos infantiles más arcaicos que estos pacientes han tenido y de cuya dilucidación va a depender el proceso de cura. Son éstos los casos de donde surge la necesidad de dar cuenta de estos procesos a través de un abordaje más abarcativo del paciente.

La observación de la dinámica familiar, nos permite ver a los sujetos protagonizando vivencialmente y en la mayoría de los casos repitiendo, en uno y otro contexto conductas e interacciones basadas en relaciones objetales específicas. Estas últimas surgen a partir de las estructuraciones inconscientes más profundas con que los sujetos se han debatido desde el momento en que se constituyó la familia como tal.

Sabemos, por otra parte, que el comportamiento de cada miembro de la familia es diferente, cuando se lo estudia aisladamente, que cuando se lo observa en interacción con los otros. Este fenómeno ocurre porque un individuo aislado no recibe los impactos que producen los comportamientos de los otros sobre él, en términos psicoanalíticos corresponderían a los fenómenos producidos por el mecanismo de la identificación proyectiva. La contrastación de ambos sistemas nos dan elementos dinámicos importantísimos para poder comprender la patología.*

* Para mayor información en relación a este tema ver "Test de Investigación de la Relación Vincular", Revista Argentina de Psicología, Año 3, Nro. 11, 1973.

No se me escapa que son muchos los autores que hacen hincapié en la reconstrucción, a partir de los elementos que surgen del proceso transferencial enfatizando, de que es ésta la única forma posible para que los sujetos enfermos cambien estructuralmente. Yo no niego esta posibilidad, simplemente sugiero que la observación sistemática de las conductas del paciente dentro del proceso analítico, por un lado y dentro de su familia por otro, enriquecen sin ninguna duda las posibilidades de comprenderlo.

La meta terapéutica es posibilitar al paciente, que incluya dentro del Yo-realidad, aquellos aspectos que han sido escindidos o reprimidos de su estructura mental. Éstos últimos son los que muchas veces están depositados en otros miembros de la familia. Lo inquietante es que estos sujetos, los depositarios, actúan y se conducen de una manera sugestivamente acorde al contenido de las fantasías depositadas en él.

Este proceso, muchas veces, queda dificultado de emerger dentro de la transferencia. ¿Por qué sucede esto? Pienso que en la medida en que el sistema colma los deseos inconscientes de ambos sujetos (los satura) conforman una estructura lo suficientemente fuerte como para no ser rota. Actúa como un "baluarte" de la enfermedad, muchas veces irreductible en el análisis encarado unipersonalmente. La fuerza coercitiva de estas estructuras, parte de la vigencia que adquiere en la interacción los aspectos más psicóticos de ambas personalidades, corresponden a aquellas tendencias de fusión más primitivas que tienen los sujetos.

Estas situaciones, se ven con mucha claridad en los niños, que son por otra parte, sujetos donde por leyes evolutivas naturales tienden a fortificar los vínculos con sus padres, a partir de la fijación a las fases simbióticas normales de crecimiento por las que han atravesado.

Cuando los padres padecen, tienden a depositar narcisísticamente en los hijos los aspectos más arcaicos de sus personalidades que tienden durante el proceso de individuación del sujeto infantil a su vez a distorsionar el crecimiento.

La interacción vincular, ejercida en el vínculo parento-fi-

lial, es la que provoca un sentimiento de cohesión interna dentro del sujeto infantil, base, por otro lado, si se da normalmente, del crecimiento y de la evolución. Normalmente la tendencia que tienen los padres de fortificar el vínculo con su hijo, va a ser un ingrediente necesario para estructurar la base de las primeras figuras o imagos idealizadas por el niño. Cuando recibe de los padres respuestas adecuadas a sus pedidos emocionales y a todas aquellas manifestaciones de origen narcisístico, el niño aprende sus limitaciones reales, abandona las fantasías omnipotentes y las reemplaza por metas y propósitos egosintónicos, así como también por el placer en sus funciones y actividades.

Los imagos parentales por el proceso de internalización de los padres reales que el niño acepta como una prolongación narcisística se transforman por una suerte de metabolización endopsíquica en funciones yoicas.

Si hay una alteración en la integración de este proceso, la evolución psicológica infantil se ve perturbada. Dicha estructura puede establecer escisiones del Yo-realidad o separarse de él mediante la represión. En tal caso, específicamente en aquellos en que se producen escisiones yoicas tempranas, el abordaje psicoanalítico individual se ve dificultado. Por ejemplo, tal es el caso de los cuadros simbióticos infantiles donde se establece un interjuego de identificaciones proyectivas cruzadas entre la madre y el niño, jugadas en la interacción, que va a ser estructural y estructurante del cuadro psicopatológico que afecta a ambos.

La posibilidad, en este caso, de un abordaje familiar que incluya por supuesto al padre desde su participación a partir, generalmente, de una omisión patológica de su funcionamiento, agiliza, a mi entender, la movilización y elaboración de las ansiedades más tempranas de individuación que tiene la familia y por ende el sujeto señalado como enfermo.

En el caso específicamente de los llamados procesos simbióticos, es donde se ve el aspecto realista que adquiere la identificación proyectiva. Este elemento tratado por Bion en "Apre-

diendo de la Experiencia" * hace referencia a los pasos realistas que sigue un paciente para lograr que el analista de hecho experimente emociones que el paciente no quiere tener; así expresa: "Un ejemplo de un intento de convertir la fantasía omnipotente en realidad puede verse en el paciente que se siente impulsado a obligar a otros a sentir que él es capaz de asesinar a los padres sexuales, para sentirse capaz de tener una relación sexual amorosa, libre del temor de que pudiera asesinar a su compañera y a sí mismo, como se sentiría obligado a hacerlo si tuviese la prueba de que entre él y su compañera hay una mutua pasión sexual. Sugerí que en una forma extrema esto puede llevar al crimen como un método para concretar en el mundo de la realidad la fantasía omnipotente de la identificación proyectiva, que sin tal acción permanecería sólo como una fantasía omnipotente".

Estos elementos realistas en términos de interacción es lo que también actúa en las simbiosis, donde el niño toma a la madre desde su demanda narcisística y la madre responde en una forma coherente y sincrónica acorde a la fantasía omnipotente infantil. Respuesta por otra parte que implica a la madre en una patología narcisística que la lleva, lo mismo que a su niño a tomar a éste como una prolongación de su propio self.

La posibilidad de dilucidar este sistema de compromiso inconsciente de a tres (tres en la medida en que el otro elemento interactuante es el padre desde su omisión), es lo que permite con mayor eficacia dar los pasos iniciales para que se establezca en los sujetos un cambio estructural. De hecho, producimos un ahorro en términos económicos ya que los fenómenos transferenciales se abordan directamente en el campo donde se estructuró el conflicto. Este hecho significa una ventaja no fácilmente desestimable en el proceso de cura.

Hicimos referencia anteriormente a los conceptos de Bion sobre la identificación proyectiva realista, nosotros en un intento de inclusión de los aspectos interaccionales en la teoría

* Capítulo XII, pág. 53.

analítica objetal, hablamos de una “*organización inconsciente vincular*” que en términos de comunicación la definimos como una “organización que se instala dentro del campo interpersonal”. Entendiendo con esto, un espacio a través del cual circulan los mensajes y señales que intercambian entre sí, por una parte las circunstancias fantasmáticas parentales y por otra las cualidades incipientes del self infantil. Estas corresponden a su vez a los modelos de organización objetal interna en un momento específico de su evolución.

La consecuencia que se desprende de este proceso es que se relativiza la noción de mundo interno y mundo externo. Tomamos el concepto de “circunstancia” de la teoría de la comunicación que expresa que una señal al transformarse en mensaje adquiere un valor significativo según las circunstancias que la rodean. Incluimos este elemento como un factor “realista” que participa de la fantasía inconsciente de un sujeto en interacción con otro. Es en este sentido que hablamos de organización. La necesidad de incluir el concepto de “Organización inconsciente vincular circunstancial” parte de considerar una nueva concepción de las fantasías inconscientes de un sujeto en acción con otro sujeto. Deriva de la imbricación de los elementos circunstanciales provenientes de las cualidades comunicativas de los padres con aquellas que provienen del Self infantil.

Estas organizaciones en la medida en que llevan impresadas determinadas fantasías parentales, hacen que cuando quedan ligadas a demandas específicas infantiles sean responsables de llevar al niño indefectiblemente a un tipo de evolución impregnado por el determinismo parental. En virtud del interjuego entre demanda y respuesta, el niño internaliza una determinada modalidad vincular. Esta es la base de la *compulsión repetitiva generacional*.

La trama interaccional, apoyada en fantasías inconscientes, organizadas en un sistema interpersonal donde se manifiesta la dramática conflictiva de un sujeto, en interacción con otros, constituye un campo observacional y terapéutico de privilegio por lo abarcativo del mismo.

Hice hincapié en la utilidad de aplicación de estas técnicas de abordaje a pacientes psicóticos y niños, que sin duda constituye la indicación específica con diversas variantes en ambos casos. Las consultas infantiles están originadas en algunas oportunidades por compromisos primarios, es decir, compromisos más o menos autónomos del niño, o por compromisos sintomáticos infantiles pero como emergente secundario a una patología del sistema familiar. Lo que observamos es que en todos los casos hay una expresión significativa en la situación familiar. La orientación del terapeuta en general se orienta hacia el sistema familiar como un sistema funcional integrado, pero sólo en algunos casos el terapeuta se dirige a la unidad entera.

Cuando la familia viene por un tratamiento relacionado con el niño, se incluye a éste en todos los casos durante las entrevistas iniciales al tratamiento, con el fin de abarcar la problemática de la unidad familiar, pero no en todos los casos se continúa con la inclusión del niño durante el abordaje terapéutico. La problemática dinámica que se plantea está fundamentalmente determinada por los aspectos infantiles de los padres en relación a sus familias de origen, pues pensamos que ésta es la trama inconsciente que compulsivamente se repite en el interjuego familiar. De esta forma los niños, aunque excluidos en forma material están incluidos desde la fantasmática parental. La experiencia en la aplicación de las técnicas psicoanalíticas clásicas demostraron que los logros o cambios conseguidos durante los tratamientos individuales no podían ser mantenidos si no se lograban cambios en la dinámica familiar. En muchos casos, cada avance terapéutico individual se veía devastado por la patología de la interacción familiar.

Experiencias de este tipo llevaron a pensar que la intervención terapéutica debía tomar en cuenta la problemática dinámica, emergente del impacto recíproco entre el niño y el sistema familiar.

Debemos decir también que no existe una única forma de abordaje terapéutico o estrategias uniformes terapéuticas, en la medida en que no se puede llegar a conceptualizar categorías standard de familias. Esta es la razón por la cual tampoco

existen normas fijas de abordaje sino que éstas dependen de las características de cada caso en particular.

Pasaré a relatarles someramente un caso clínico. Quiero aclarar que los datos históricos surgen espontáneamente mediante la utilización de la técnica de asociación libre. Las entrevistas fueron realizadas con ambos padres, y además se efectuaron entrevistas familiares. Esta es la forma en que se va desprendiendo la información desde el plano consciente, posibilitando asimismo la comprensión de la estructura profunda del conflicto. La acción terapéutica incluye señalamientos y en ciertos casos interpretaciones que tienden a favorecer la emergencia del material inconsciente.

A los fines de esta presentación daré una información esbuceta de los antecedentes, no explicitando, la naturaleza de los emergentes que posibilitaron la misma, pero sí transcribiendo frases textuales de los padres consideradas como "clave" para su comprensión dinámica.

El *motivo de consulta* es un niño Tomás de 7 años de edad. Los síntomas que presentaba estaban relacionados con problemas de percepción fina en el colegio, por lo cual mantuvo tratamiento psicopedagógico durante varios años, tenía reacciones de "cabeza dura", "ataquecitos nerviosos", que consistían en risas aparentemente inmotivadas.

Esta situación imposibilitó su permanencia prolongada en un colegio. La extrema agresión con los otros chicos era uno de los motivos fundamentales de consulta. El padre y la madre refieren en relación al niño que "se les va de las manos" —"es un chico que continuamente está hinchando, antipático y difícil de soportar"—.

Presenta un cuadro de masturbación compulsiva que realiza en presencia de cualquier persona.

El *vínculo con la madre* fue bueno durante el primer año, luego se transformó en un vínculo conflictivo. La madre lo describe como signado por "encontronazos de amor y odio". A los 2 años se queda durante 2 meses con los abuelos maternos. Desde ese momento emerge un nuevo síntoma expresado por la manifestación de momentos de pánico, aparente-

mente inmotivados. Cuando tiene 5 años el abuelo materno enferma, sufriendo luego mucho con su muerte. Se incentivan los miedos. Cambia 3 escuelas. La madre hace referencia de que necesita mucho a la abuela materna y en un murmullo declara de que existe una —"situación erótica"— con la misma, asociándola espontáneamente al amor que ella a su vez tuvo con su madre, amor que ha sido la —"relación central de su vida"—.

Una de las referencias que la madre hace de su vínculo con Tomás se refiere al sentimiento de culpa que la invade cuando intenta ponerle algún tipo de límites a su hijo. Únicamente se sintió feliz con él cuando estaba en la cuna. Cuando comenzó a movilizarse comenzó su odio. —"Me pide, pide y me ahoga"—. —"Me acuesto 5 ó 10 minutos a la noche con él, se duerme mientras yo le rasco la espalda". —"Hay en Tomás algo que me choca"—.

En las referencias que hace el *padre del vínculo* que mantiene con su hijo, la primera situación que enuncia es de que él es totalmente contrario a la madre y que Tomás responde totalmente a la abuela. —"Me jode que no tenga las pelotas necesarias para defenderse"—. —"Le dicen maricón, lo usan"—, y hace referencias a que la abuela le cuenta cosas —"intimidaciones"— que no corresponden, al mismo tiempo se pone en evidencia su conducta de no intervención a pesar de la protesta.

Reconstrucción histórica de Renata, madre de Tomás

Abuelo materno: A los 10 años de edad quedó huérfano durante la primera guerra mundial. Lo cría una familia y le enseñan el oficio de joyero. Queda viudo del primer matrimonio con dos hijos, el segundo matrimonio se realiza con Sara, abuela materna de Tomás. Los hijos del primer matrimonio van a vivir con él. En la reconstrucción que hace Renata de su padre, lo pinta como "un hombre sometido a su padre", pero que sin embargo la sorprendía con bromas macabras. —"Mi padre era un cero a la izquierda"—. —"Mi papá fue huérfano e

hizo huérfanos a sus cuatro hijos"—. Fallece hace 2 años, después de estar 2 años postrado a raíz de una enfermedad neurológica.

Abuela materna: Los padres han fallecido. No surge información de los abuelos maternos. Tanto en el relato que hace Renata en relación a su madre como en las entrevistas vinculadas realizadas entre ambas, la mayor parte del discurso estaba referida a las relaciones que ambas mantenían y mantuvieron entre sí, así como también el tipo de vínculo mantenido con Tomás. La madre dice: —"Tengo con Tomás la misma sensación de ahogo y asfixia que tenía con mamá"—. —"Mamá quiere que Tomás vaya a dormir con ella a la cama donde falleció papá"—.

Interacción de la madre de Tomás con sus padres

Queda explicitada a partir de los siguientes comentarios textuales:

1. "Fuí la que más quiso a mamá, fue un amor enfermo. Entre los 12 y los 18 años tuve una 'relación rara con ella', las dos nos enamoramos de un muchacho".
2. "Mamá armó con una amiga que era vidente, la relación con este muchacho, diciendo que me iba a casar con él. Me hacían mojar la menstruación en el azúcar y dárselo en el café".
3. "Mamá nos dijo que había fantasmas en la casa".
4. "Papá nos asustaba con los fantasmas en la escalera".
5. "Me sentí muchas veces el brazo ejecutor de mi madre".

Comentario: En estos comentarios se pone en evidencia la relación simbiótica perversa que Renata mantuvo con su madre. Esta situación es la que es transmitida durante la con-

fección dinámica inconsciente que se daba entre Carlos (esposo de Renata), Renata y Tomás.

Los fantasmas estaban referidos a los hermanastros de Renata que en la adolescencia fueron echados de la casa por Sara. Obviamente la expresión en la interacción familiar hablaba de una mala elaboración de esta situación, ya que se los mantenía como elementos siniestros.

Las primeras organizaciones inconscientes quedan de este modo explicitadas. Vemos claramente cómo Tomás pasa a ocupar el lugar que Renata ocupó en la primera generación. Vemos entonces la incidencia etiológica que tiene la dinámica inconsciente con que se gestó la segunda serie complementaria de Tomás.

Reconstrucción histórica de Carlos, padre de Tomás

Carlos pertenece a una familia de origen alemán. Desde que Carlos nació, la abuela paterna cumplió las veces de madre. En el relato de Carlos el padre aparece como un hombre tremendamente rígido que imponía a su hijo conductas de sometimiento a mandatos de tipo militar impartidos desde pequeño. En la acción esto se ve con claridad cuando el niño se enferma y es internado en un hospital. Durante un mes sus padres no concurren a verlo, siendo este recuerdo un elemento traumático que emerge durante las entrevistas de indagación, su expresión estaba impregnada de emociones violentas.

Interacción entre Carlos y su abuela paterna

Antes del casamiento con Renata, Carlos dinámicamente queda frente a su padre en una posición femenina. La madre es ausente en su funcionalidad y actuaba en coalición con su padre, sádico, por lo tanto el vínculo filial se daba desde una sola vertiente parental. La ausencia materna era suplida por la abuela paterna que mantenía con Carlos una relación simbiótica

cargada de erotización (colecho hasta los 10 años).

Así, en la segunda generación se repite esta estructura vincular. La abuela materna cumple funciones con Tomás que la abuela paterna cumplió a su vez con Carlos. También cumple funciones que antes había cumplido con la madre de Tomás, Renata.

Interacción entre Tomás y la abuela materna

Enunciaré algunos elementos que se daban en la interacción, que fueron relevantes para la comprensión dinámica del caso:

1) Ambos padres, producido el embarazo, consultan a la abuela —“si estaba de acuerdo”—.

2) Ambos construyen (Tomás y su abuela), un lenguaje expresado en un murmullo, por lo cual tienen que acercarse mucho para escucharse impidiendo la intervención de otros cuando se realiza este tipo de comunicación.

3) Tomás con su dinero le paga el taxi a la abuela para que vaya a su casa. Esta conducta se estableció entre ambos como pacto secreto que paradójicamente la madre relata en una sesión pero que en la interacción con ambos —“hace como que no sabe”—.

4) A partir de la muerte del abuelo materno, Tomás ocupa en la cama de la abuela la posición que éste ocupó. Conducta gestada en coalición con los padres.

Quiero recordar los síntomas patológicos de Tomás.

1. Ataques de nervios. Risas inmotivadas.
2. Masturbación compulsiva.
3. problemas de aprendizaje serio.
4. Agresión.
5. Hiperquinesia.
6. Pánico desde los 2 años.
7. Conductas eróticas con la abuela.

Los episodios de pánico surgen cuando tiene 2 años, momento evolutivo donde normalmente se resuelve la individuación, se sale de la simbiosis entrando en la autonomía. Este momento es

el que se vio perturbado por la “entrega real” que los padres hacen del niño. Coincidente por otro lado con una separación real y la entrega real del niño a la abuela. Suponemos que ambos no pudieron tolerar la ruptura simbiótica de esta etapa evolutiva proyectando e induciendo al niño a que permanezca en una relación perversa con la abuela.

Esta trama es la que actúa como factor etiológico específico para este caso de patología.

Los síntomas que presenta Tomás hacen pensar en un cuadro de psicosis mixta, con posibles alucinaciones. Cuadro que comienza a aparecer a la edad de 2 años, que coincide con un alejamiento brusco de la madre y un rechazo activo de la misma hacia el niño.

Suponemos que la madre no toleró la paulatina individuación infantil tornándose en una madre ausente en su funcionalidad. Coincide por otro lado con el segundo embarazo, situación que lleva a la madre a reconstruir con su preñez la unión simbiótica perdida con Tomás debido a su crecimiento.

Las únicas referencias que hace el padre del niño tienen un tono de absoluto rechazo, signándolo además en una posición femenina.

Quiero señalar que la “abuela” desde los primeros momentos de las entrevistas aparece ocupando un lugar “clave” en la problemática.

Reconstrucción dinámica de las fantasías de apareamiento marital

Carlos, casándose con una no-alemana, contradiciendo al padre, intenta romper el vínculo de sometimiento sádico que mantenía con él. Cuando se casa sufre una nueva reestructuración edípica pues interactúa con su mujer desde una posible identificación paterna. Esto se evidencia en el carácter violatorio que adquieren las relaciones sexuales entre ambos. En realidad ambos inducían en el otro conductas perversas.

Para Renata, Carlos ocupaba la posición que ocupó la madre.

en el vínculo simbiótico, ratificando a partir de las conductas de Carlos el carácter violatorio e intrusivo del vínculo. Esto se ponía de manifiesto en las técnicas sexuales ejecutadas por la pareja, fundamentalmente expresadas a través de felacio y relaciones anales.

Como consecuencia de los vínculos anteriormente expuestos podemos dar una hipótesis sobre las cualidades de la programación parental que condicionan la emergencia de síntomas psicóticos. De este enunciado se desprenden los elementos de la policausalidad en la confección de los síntomas psíquicos. Estos elementos son los que intento destacar en esta comunicación pues pienso que al abordar la familia se ponen en evidencia con absoluta claridad. La comprensión de esta múltiple causalidad son elementos necesarios no solamente útiles para la decodificación inconsciente del material sino que repercuten en la estrategia terapéutica a adoptar para cumplir con las metas curativas.

Experiencias concordantes parentales en la configuración de una programación psicótica infantil (mixta).

Desde la vertiente materna, Tomás es para la abuela lo que Renata quisiera seguir siendo inconscientemente para ella. Podemos suponer que cuando nació Tomás se rompió el idilio de Renata con su madre y en un intento de recuperarlo entrega su hijo a la madre.

Coincidentemente desde la vertiente paterna, Tomás es entregado a la abuela materna, repitiendo así el vínculo que el padre tuvo con su abuela.

Primera generación: desde la madre: simbiosis, antecedente con su madre mantuvo un vínculo simbiótico.

desde el padre: simbiosis, antecedente con su abuela mantuvo un vínculo simbiótico (colecho hasta los 10 años).

Este modelo concordante de Fantasías Inconscientes vinculares es lo que se proyecta en Tomás. Así tenemos que en la se-

gunda generación Tomás cumple con los deseos maternos y paternos.

Este es un ejemplo de una organización inconsciente vincular que se establece entre la madre y el padre de Tomás. Constituye un factor motivador y operante en relación directa con las conductas que ambos establecían con Tomás. Es decir que en la acción, establecían un sistema de conductas reales que llevaban a ratificar la fantasía onnipotente de recomponer con Tomás un vínculo simbiótico perdido.

El elemento "circunstancial" de esta organización está expresado a través de los sistemas interaccionales de inducción que llevaban a la abuela y a Tomás a gestar y potenciar un vínculo perverso.

Este tipo de organizaciones inconscientes vinculares son las que sostenían el apareamiento marital entre Renata y Carlos. La contribución que hace el niño en esta programación, está dada por la disposición libidinal que se establece en un determinado momento evolutivo. En este caso una sobreestimulación materna en la etapa oral de succión apoyada en una fantasía materna de confusión entre ser succionada y tener un orgasmo lleva al niño a establecer una erotización precoz de las zonas erógenas en los momentos más arcaicos de su evolución.

Esta situación es rota bruscamente a partir de un rechazo materno cuando comienza en el niño las primeras situaciones de individuación, es decir que se producía una sincronía comunicacional entre la ambivalencia materna y la ambivalencia del niño como producto de un momento evolutivo natural.

Esta secuencia llevó a ratificar en el niño vivencias paranoides de ser atacado por una madre retaliativa y cruel. La dinámica de esta confección objetal interna, ratificada desde el exterior por conductas maternas coherentes con tales fantasías, llevaba al niño a la confección de síntomas autísticos por un lado, tales como la masturbación compulsiva, risas inmotivadas, acompañadas de posibles alucinaciones, trastornos de aprendizaje serio que evidencian una distorsión del instinto epistemofílico, base del conocimiento y por otro, síntomas simbióticos. Estos últimos confeccionados a dúo con la abuela materna.

Con este caso clínico creo haber ilustrado con suficiente amplitud la necesidad de abarcar estrategias terapéuticas que incluyan a la familia. El objetivo primordial es poder dar cuenta de fenómenos patológicos que sin estas intervenciones no podrían de ninguna manera llegar a esclarecerse.

La dilucidación y explicitación de los vínculos inconscientes latentes que mantienen la coherencia normal o patológica de un sistema familiar, son los que permitirán, a mi entender, ir acercándose paulatinamente a las metas curativas propuestas, es decir a la posibilidad de romper estructuraciones inconscientes predeterminadas generacionalmente que llevan a un bloqueo cada vez mayor del crecimiento y del desarrollo de los sujetos que componen la red familiar.

Resumen

Se postula que en el caso del psicoanálisis infantil los procesos patológicos surgidos en el proceso transferencial, en muchos casos no bastan para comprender específicamente lo que hace a la etiología psicodinámica de la enfermedad. Es decir que el proceso de cura encarado desde la perspectiva de una reconstrucción de los vínculos más arcaicos constituidos por el sujeto infantil no dan cuenta del total de la patología.

Postulamos que la observación de la dinámica familiar nos permite ver a los sujetos protagonizando vivencialmente interacciones basadas en coaliciones inconscientes imposibles de detectar de otro modo que no sea el campo real donde se gestó y se desarrolló el proceso patológico.

Estos sistemas actúan como un "bahuarte" de la enfermedad, muchas veces irreductible en el análisis encarado unipersonalmente. La fuerza coercitiva de estas estructuras parte de la vigencia que adquieren en la interacción los aspectos más psicóticos de los sujetos que corresponden a aquellas tendencias de fusión más primitivas.

Esta "coalición inconsciente" entre los sujetos la titulamos como una "organización inconsciente vincular" que se instala dentro del campo interpersonal. En el caso particular del intercambio parento-filial dicha organización es producto de la fantasmática parental que se vehiculiza en la interacción a partir de las "circunstancias" que rodean al mensaje comunicativo y las cualidades incipientes del self infantil. Tomamos el concepto de "circunstancia" de la teoría de la Comunicación que expresa que

una señal al transformarse en mensaje adquiere un valor significativo según las circunstancias que lo rodean. Incluimos este elemento como un factor realista que participa de la fantasía inconsciente de un sujeto en interacción con otro.

Estas organizaciones en la medida en que llevan impresas determinadas fantasías parentales hacen que cuando quedan ligadas a demandas específicas infantiles sean responsables de llevar al niño indefectiblemente a un tipo de evolución impregnada por el determinismo parental. En virtud del interjuego entre demanda y respuesta el niño internaliza una determinada modalidad vincular. Esta es la base de la "*compulsión repetitiva generacional*".

Estos aportes teóricos son ilustrados a partir de una lectura psicoanalítica particular de un caso clínico donde el campo de indagación lo constituye el estudio dinámico de la familia en el curso de dos generaciones.

Summary

It is postulated that in the case of child psychoanalysis, the pathological processes emerging in the transference process are in many cases not enough to understand specifically what is related to the psychodynamic etiology of the illness. That is to say that the healing process taken from the perspective of a reconstruction of the most archaic ties constituted by the infantile subject, do not give an account of the whole of the pathology.

We postulate that the observation of the family dynamics allows us to see the subjects vividly acting their role in interactions based on unconscious coalitions which are impossible to detect in another way which is not the real field where the pathological process was conceived and developed.

These systems act as a "bastion" of the illness, often not appearing in the analysis faced unipersonally. The coercitive force of these structures emerges from the validity the most psychotic aspects of the subjects, which correspond to those most primitive merging tendencies, acquire in the interaction.

We call this "unconscious coalition" between the subject an "unconscious organization" installed in the interpersonal field. In the particular case of the parent-child exchange said organization is the product of the parent fantasmatic which is conveyed in the interaction from the "circumstances" surrounding the communication message and the incipient qualities of the infantile self. We take the concept of "circumstance" from

the theory of Communication which states that a signal, when turned into message acquires a significant value according to the circumstances surrounding it. We include this element as a realistic factor participating in the unconscious fantasy of a subject in interaction with another.

These organizations to the extent in which they carry certain parent fantasies imprinted, have the result that when they remain linked to specific infantile demands they are responsible of taking the child unflinching to a kind of evolution which is impregnated with parent determinism. By virtue of the interplay between demand and response the child internalizes a determined tie modality. This is the basis of the "*repetitive generation compulsion*".

These theoretic contributions are illustrated from a particular psychoanalytic reading of a clinical case where the research field is constituted by the dynamic study of the family in the course of two generations.

Bibliografía

- BION, W. R.: "Aprendiendo de la Experiencia", Paidós, Buenos Aires, 1966.
- GUERIN, P.: "Family Therapy", Gardnes Press, New York, 1976.
- HALEY, J.: "Tratamiento de la Familia", Ed. Toray, Barcelona, 1974.
- KLEIN, M.: "Desarrollos en Psicoanálisis", Hormé, Buenos Aires, 1962.
- LAING, R. D.: "Self and other", Tavistock Publication, Great Britain, 1961.
- LABOS, E.: "Organización Fantasmática Circunstancial y proceso de identidad", XII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, Río de Janeiro, 1980.
- LIBERMAN, D.: "Lingüística, Interacción Comunicativa y Proceso Psicoanalítico", Galerna, Buenos Aires, 1971.
- LIBERMAN, D.; LABOS, E.: "Test de indagación de la relación vincular", Rev. Argentina de Psicología, Año III, Nº 11, 1973.
- LIBERMAN, D.; LABOS, E.: "Contribución a la Teoría del Trauma Psíquico a la luz del procesamiento vincular", Rev. de Psicología, Año IX, Nº 25, 1981.

Una célebre investigación de la dinámica familiar de la esquizofrenia

A veinticinco años de la formulación de la teoría del doble vínculo (1956-1981)

JOSE BEBCHUK*

* Médico. Director de la Escuela de Psicoterapia Familiar.

Bulnes 1919 - Buenos Aires (Argentina)

En 1956, hace ya un cuarto de siglo, apareció el trabajo "Toward a theory of schizophrenia", producto del esfuerzo de un grupo de investigadores guiados por Gregory Bateson.

En ese trabajo se propuso la situación del doble vínculo como explicación de la naturaleza de la esquizofrenia y de la situación familiar actual del esquizofrénico.

El equipo de investigación estaba compuesto por Jay Haley, John Weakland, William Fry y Don D. Jackson, pero G. Bateson era no sólo el director, sino también el animador y promotor: *alma mater* sería el término exacto.

Entre otras cosas, Bateson consiguió que muchos científicos y especialistas de primera línea en una amplia gama de campos de trabajo fueran conocidos por el equipo (por ejemplo: Milton Erickson en hipnosis y terapia breve, Ray Birdwhistell en análisis del movimiento corporal y pautas vocales, Alan Watts en ideas de Zen y paradojas, Alex Bavelas en grupos pequeños, etc.).

Superando dificultades de apoyo económico y de lógicas divergencias de enfoque en un terreno inexplorado, Bateson

mantuvo el trabajo del grupo durante diez años. En ese período tres miembros del equipo y dos consultores produjeron alrededor de setenta artículos.

Cuando se decidió a poner en marcha el proyecto de investigación acerca de la comunicación, Bateson ya había pensado y trabajado en los siguientes tópicos:

1. realimentación (feedback): en 1942 Bateson tomó contacto con este concepto que lo llevó a interesarse por la cibernética. El estudio de la retroalimentación le interesaba a partir de su observación de los procesos que mantienen estable a un sistema cultural o grupal;

2. esquismogénesis: es un proceso de interacción en el cual el cambio direccional ocurre en un sistema de aprendizaje. Y a Bateson le intrigaba ese proceso que, entre oscilaciones y contradicciones, se desarrollaba en forma recurrente en la misma dirección;

3. deuterio aprendizaje: aprender a aprender, "un tipo de hábito que es un subproducto del proceso de aprendizaje". Este concepto que se derivó de experiencias sobre el aprendizaje lo llevó a Bateson a la observación del *contexto* en el cual el sujeto aprende; (por ejemplo: a pedir, a controlar sus esfínteres o a relacionarse con miembros extrafamiliares). Bateson pensaba que el deuterioaprendizaje podía ser "el puente entre la psicología elemental y la teoría psiquiátrica".

Tal como lo explican Sluzki y Ransom, toda situación de aprendizaje posee información sustantiva (el contenido, aquello que debe ser aprendido) e información acerca de la naturaleza de la situación (la estructura relacional, lo que se espera del sujeto, qué tipo de feedback correctivo debe ser previsto, etc.).

De 1952 a 1954

El primer subsidio que consiguió Bateson en el campo de la comunicación estaba destinado a estudiar "El papel de las paradojas de abstracción en la comunicación".

El punto de partida fue la teoría de los tipos lógicos de

Russel y Whitehead, que trata de la relación entre una clase y sus miembros y de la posibilidad del surgimiento de la paradoja semántica.

Bateson comenzó a reunir a la gente que necesitaba y a comienzos de 1953 contaba con Haley y Weakland. Más tarde, en ese mismo año, se unió al grupo William Fry, un psiquiatra que recién terminaba su residencia.

Durante el primer año de trabajo se trató de que el equipo tuviera un enfoque común. Una de las primeras dificultades que apareció giraba alrededor de si las paradojas eran meramente juegos de lógicos y lingüistas o si afectaban la comunicación humana o animal. También se puso en evidencia la necesidad de desarrollar un lenguaje común a fin de describir los niveles de la comunicación.

Así como Bateson había observado que en el aprendizaje existían diferentes niveles, la teoría de los tipos lógicos le sirvió para orientar la investigación de los distintos niveles de abstracción presentes en la comunicación.

El abordaje de la comunicación en términos de niveles no resultó fácil de asimilar por la falta de precedentes.

En este primer momento, los datos se obtuvieron tanto de la comunicación animal (el juego entre las nutrias, el entrenamiento de un perro guía para ciegos) como de la comunicación humana. (La filmación de niños mágicos en un grupo, el análisis del humor y del estilo lingüístico de un paciente esquizofrénico cuando se lo empezó a entrevistar).

Al acabarse el primer subsidio (1954) a Bateson se le presentó la hipótesis del doble vínculo y pensó en aplicar el enfoque y la metodología disponibles a la investigación de la comunicación esquizofrénica. La confusión de tipos lógicos distintiva del discurso esquizofrénico señalaba un campo propicio para la indagación y con estos lineamientos Bateson consiguió el apoyo de la Fundación Macy para dos años de trabajo.

El propósito de la investigación era explicitado de esta manera: "la investigación ... estudiará el uso esquizofrénico de aquella particular categoría de señales implícitas y no verbales

que indican si una determinada expresión es literal o metafórica, lúdica o seria, sincera o histriónica”.

Sin embargo, a fin de superar los desacuerdos que se manifestaron, Bateson, Haley y Weakland tuvieron que discutir durante dos días seguidos.

Hacia el doble vínculo

En esa época en que la esquizofrenia era separada de la conducta en general y se la definía negativamente como lo no normal y, en consecuencia, no significativo, resultó un mérito del equipo Bateson describir la conducta esquizofrénica como mensajes y conductas específicos en contextos específicos como la familia, el hospital o la entrevista de psicoterapia. Una parte de la investigación giró alrededor de la caracterización “más clara y sistemática de esta conducta en términos positivos”, afirma Weakland.

Bateson y sus colaboradores llegaron a la conclusión que el esquizofrénico carece de la capacidad de discriminar y rotular entre las clases y sus miembros correspondientes en lo que se refiere a los modos comunicacionales. Afirmaron que la etiología de esta modalidad debía buscarse en pautas secuenciales características y que dichas secuencias debían presentar la siguiente característica: “que el paciente adquiriera en ellas los hábitos mentales que se ejemplifican en la comunicación esquizofrénica. Es decir, debe vivir en un universo donde las secuencias de hecho son tales que sus hábitos comunicacionales no convencionales resultan, en cierto sentido, apropiados. La hipótesis que presentamos es que la presencia de secuencias con estas características en la experiencia externa del paciente es responsable de los conflictos internos de tipificación lógica. Utilizamos el término ‘doble vínculo’ para referirnos a estas secuencias insolubles de experiencia.”

En síntesis, “doble vínculo” es un término que, según Haley, describe un contexto dentro del cual está tratando de funcionar una persona.

Otro logro importante del grupo Bateson fue crear las categorías que permitieran describir con mayor amplitud la riqueza y complejidad de la comunicación humana. Un corolario de estos descubrimientos es que en la comunicación no existen mensajes simples ni mensajes aislados: “sólo un análisis del hecho histórico en curso, del contexto relevante, produce la información relevante”, nos advierte Weakland.

El año 1956

A comienzos de 1956 el equipo empezó a observar a una familia con un miembro esquizofrénico adulto, utilizando grabaciones y filmes. Estas observaciones contribuyeron a la descripción de la comunicación en términos de niveles con la comprobación de que cuando esos niveles eran conflictivos y generaban una paradoja, no era posible emitir una respuesta aceptable. Originalmente, la descripción hablaba de una paradoja que los padres le imponían al hijo, pero luego se constató que el vínculo era más recíproco, un vínculo que la gente de la familia se imponía entre sí. En una familia que observaron en esa época, la madre estimulaba a su hijo para que la criticara y cuando él lo hacía, ella lo desaprobaba. El hijo, por su parte, le imponía a la madre mensajes paradójicos parecidos. Por ejemplo: para el Día de la Madre el hijo le envió una tarjeta que decía: “siempre fuiste como una madre para mí”. Fue también para esa época que se empezó a observar con mayor atención el papel del padre en estas familias.

Varios años después, Haley reconoce que la teoría del doble vínculo no resultó útil para los terapeutas porque era una descripción de lo que estaba ocurriendo pero sin sugerencias de cómo cambiarlo.

Señala Haley (1961) que tal como fue propuesto originalmente, el doble vínculo no estaba descrito en términos de su función en la relación, sino cumpliendo una función para el sujeto, por ejemplo: la madre. La observación de un intercambio continuado llevó a la conclusión que las instrucciones para-

dólicas de la madre aparecían respondiendo a lo que el hijo hacía, y la conducta de éste era en respuesta a la de la madre.

Así se produjo el giro de la descripción de un individuo a la descripción de un sistema relacional de dos o más personas. Y este giro tuvo como consecuencia que no resultaran satisfactorias las premisas de la psicología de la motivación individual cuando se trataba de explicar la persistencia de pautas de conducta en las relaciones en curso.

Así como en un sistema cibernético hay un regulador que controla el rango de funcionamiento de sus componentes, se comenzó a sugerir que la gente en una relación controla el rango de la conducta de cada uno. En consecuencia, "el doble vínculo podía ser visto como una táctica en el intercambio entre dos personas, en tanto cada una intenta ganar el control del rango en el sistema. Mediante la imposición de un doble vínculo, una persona puede frenar efectivamente a otra de gobernar qué tipo de relación tendrán" (Haley, 1976).

La idea del control del rango de la conducta fue presentada por Haley en 1956, tratando de explicar la peculiar conducta de las madres de los esquizofrénicos.

En el trabajo "An interactional description of schizophrenia" (1959) Haley analiza una conversación entre dos esquizofrénicos y formula la sugerencia que ambos luchan a fin de no definir la relación con el otro. Los cuatro componentes de lo que luego se llamó "el paradigma de Haley" (yo/le digo algo/a Ud./ en esta situación) son negados en la interacción esquizofrénica en el intento de mantener la relación sin definición. Es decir, que cuando se niegan algunos o todos estos elementos (quien habla/contenido de lo que dice/a quien/en su situación) se trata de eludir la definición de la relación, lo cual no es posible ya que así como en una situación de interacción no es posible no comunicarse, tampoco es posible no definir la relación con el otro. Lo peculiar de la interacción esquizofrénica consiste en que no sólo alguien niega que dice algo, sino que la forma en que lo hace implica que niega su propia negación.

La descripción de la organización de la familia

En 1959 se publicaron varios trabajos sobre la organización de la familia. En los mismos apareció un giro importante ya que la organización familiar requería una descripción de tres o más personas interactuando.

Una parte conspicua de las investigaciones estuvo centrada en el tópico de la toma de decisiones. Bateson usó el modelo de la Teoría de los Juegos, según la cual tres robots tenderán a formar coaliciones y alcanzarán a tomar decisiones cuanto mayor sea la información que tengan acerca de las decisiones de los demás; pero comprobó que en la familia del esquizofrénico cuanto más se den esas condiciones, más incapaz se muestra la familia en formar coaliciones o en llegar a una decisión grupal.

En "The group-dynamics of schizophrenia" (1960) Bateson llegaba a la conclusión que "el paciente identificado se sacrifica para mantener la sagrada ilusión de que lo que dicen los padres tiene sentido".

En "Minimal requirements for a theory of schizophrenia" publicado en 1960, Bateson define a los padres del esquizofrénico como "esquizofrénicos encubiertos": "en tanto el esquizofrénico encubierto puede tener éxito en poner incómodo al otro, su patología está oscurecida y la culpa recae en otro lado". También concluía Bateson que el esquizofrénico y sus padres debían estar incluidos en la descripción de la esquizofrenia.

En 1961 se discutió otro trabajo de Bateson: "Biosocial integration of behavior", en el cual plantea la existencia de dos procesos de control que mantienen la estabilidad: la calibración y el feedback (retroalimentación).

Bateson postuló que el hábito es un ejemplo de calibración y que la conducta de ensayo y error es un ejemplo de feedback. Finalmente, llegó a la conclusión que las únicas calibraciones en la familia del esquizofrénico son el bajo nivel de formación de hábitos en el individuo y el nivel elevadamente superficial de apariencias externas. El resultado es un sistema que, aún en su patogenicidad, es estable.

Por su lado, Haley observó que en la familia de transacción esquizofrénica nadie se toma la responsabilidad de establecer algo de manera decisiva. La rigidez del sistema está acompañada por una indecisión extrema. Y la indecisión grupal —afirma Haley— se sustenta en la inestabilidad de las coaliciones.

A lo largo de esta búsqueda se fue caracterizando a la familia del esquizofrénico como un sistema en el que no hay un liderazgo definido, no hay coaliciones estables, no hay culpa clara ni enunciados claros de las reglas familiares (Haley, 1976). Cualquier enunciado de una regla familiar puede ser negado o descalificado.

En el artículo publicado por Haley en 1959, "The family of the schizophrenic: a model system", el autor sugirió que en esta familia, sus miembros se conducen descalificándose, mostrando así una sensibilidad peculiar ya sea ante la posibilidad de que su conducta esté gobernada por otros, como así también que él o ella desfinan o delimiten el comportamiento de otros.

Partiendo de esta observación fundamental, Selvini Palazzoli y sus colaboradores formularon —muchos años más tarde— la hipótesis que "este tipo de familia es un grupo natural regulado en su interior por una simetría exasperada al punto que no se la puede declarar y, por lo tanto, está encubierta" (1975).

En 1960, Weakland publicó "The double-bind hypothesis of schizophrenia and three-party interaction". Como en el artículo original de 1956 se hablaba de un "vinculador" y su "víctima", Weakland reformula este concepto ubicándolo en un marco sistémico más preciso: la "víctima" pronto aprende pautas de comunicación semejantes o recíprocas, tales como transmitir ella misma mensajes incongruentes, o responder a todos los mensajes que recibe como si fueran incongruentes y vinculantes".

Weakland describió tres maniobras —encubrimiento, negación e inhibición— coadyuvantes de la patología comunicacional en curso: "cada vez que se agrega un mensaje similar de encubrimiento, negación o inhibición para reforzar una comunicación original de doble vínculo, la combinación produce otra estructura de doble vínculo en una escala más amplia.

Por ejemplo, cuando a un par de mensajes incongruentes sigue otro que niega la existencia de una contradicción, esta combinación abarca otro par de mensajes del mismo carácter —de diferentes niveles—, cuya falta de congruencia es difícil de detectar o resolver. Y este proceso puede repetirse, haciéndose cada vez más amplio . . . El poder patógeno de las pautas de comunicación de doble vínculo y la dificultad de modificarlas parece relacionarse, en gran medida, con esta tendencia progresiva y acumulativa".

Veinticinco años después

¿Cómo encontramos el campo del doble vínculo un cuarto de siglo después? Terminados los años de trabajo sobre comunicación, Bateson no volvió al campo psiquiátrico: "Fue un viaje que me llevó diez años; aún estoy investigando los mismos problemas que investigaba entonces, pero los datos psiquiátricos ya no están en el centro de mi indagación", decía Bateson en 1978.

Bateson provenía de la antropología y le interesaban, entre otros, los problemas de cómo se mantiene una cultura. Se introdujo en el terreno psiquiátrico como un antropólogo en una cultura desconocida: para estudiarla y conocerla hasta en los más mínimos detalles, pero no para cambiarla.

Interviniendo en una conferencia sobre el doble vínculo decía Bateson: "no me siento muy feliz encontrándome como el padre de un enunciado no formulado de que 'el doble vínculo es una teoría de la terapia'. No pienso que fuera o sea . . . Todavía pienso que valió la pena investigar todo lo que uno pudo investigar acerca de cómo esas premisas (de amor y odio, respeto, dependencia, etc.) se entrelazan, se relacionan, se desenvuelven, cómo procede la maduración, etc. Hoy día yo no sostendría que esos pensamientos, son, necesariamente, terapéuticos" (1978).

A lo largo de los años de investigación del doble vínculo Bateson nunca se concentró totalmente en el problema de la

esquizofrenia. Tal como lo relata Haley, Bateson acostumbraba a elegir una secuencia característica que ocurría en las familias esquizofrénicas y generalizaba esa secuencia en el campo de la evolución, los procesos biológicos y otros. Por ejemplo, en un artículo de 1958, "The new conceptual frames for behavioral research", lo plantea así: "sabemos, por ejemplo, que cualquier característica sea esta anatómica, fisiológica o conductal, si continúa siendo adaptativa en un considerable período de tiempo, se hundirá profundamente en la estructura organizacional del sistema. Esto es, la constelación de causas que originan las características cambiará gradualmente de tal forma que cuando este proceso alcance sus últimas etapas puede ser necesaria una gran desorganización del sistema total para frenar la producción de las características adaptativas previas. Por otra parte, el dilema ante el cual se encuentra entonces el sistema será formalmente comparable con lo que llamamos el doble vínculo. Le parecerá al sistema (personificando nuevamente) como si sólo pudiera alcanzar la adaptación externa al precio de la desorganización interna".

Pensamos que a Bateson le interesaban la esquizofrenia y el doble vínculo como casos específicos de una problemática mucho más amplia. Y que dicha problemática, para ser entendida, requería de un nuevo enfoque, una nueva epistemología: "el hecho es que muchas de las 'teorías' del psicoanálisis y aquellas con las cuales yo contribuí a la discusión de la esquizofrenia no son realmente teorías en el sentido ordinario sino que se asemejan más a nuevos lenguajes o, tal vez, a nuevas epistemologías. Un lenguaje puede ser confuso o iluminante. Puede ser conveniente o desatinado. Pero, en sí mismo, no puede ser verdadero o falso" (1966).

Bateson nos lleva de la mano para que nos hagamos otra pregunta: "antes de interrogarnos cuál de los diferentes lenguajes o epistemologías se prefiere, debemos contestar, primero, la principal cuestión pragmática: '¿para qué?' Ciertamente, es muy dudoso que cualquier creación humana compleja pueda ser comprendida alguna vez sin que este interrogante haya sido respondido. Necesitamos saber qué amplios problemas huma-

nos deben ser iluminados o qué metas son servidas por un lenguaje antes que podamos juzgar acerca de su valor" (1966).

Jay Haley, por su lado, afirmó en esa conferencia sobre el doble vínculo de 1978: "aunque esta teoría haya sido muy interesante y el concepto de niveles haya sido muy valioso para describir la conducta, no pienso que la teoría haya sido útil para los terapeutas. Originalmente era una hipótesis acerca de lo que estaba ocurriendo, no una indicación de cómo cambiarlo y, en consecuencia, no orientaba a los terapeutas hacia lo que hacer".

Haley observa que los procesos de comunicación en la familia se hicieron interesantes desde el punto de vista de la investigación porque en esa época se daba por descontado que formar a un terapeuta y a un investigador era lo mismo, y también se pensaba que el entrenamiento en investigación era una forma de entrenar a un terapeuta. Hoy por hoy, Haley sostiene que la postura del investigador y la actitud del terapeuta son completamente opuestas.

Los desarrollos más recientes en el pensamiento de Haley se derivaron de su experiencia en la formación de terapeutas: "con este cambio encontré que me era necesario abandonar muchas teorías interesantes acerca de la esquizofrenia y la familia. Traté de simplificar antes que introducir más complejidad en el terreno, lo cual puede ser o no, haber ido más allá del doble vínculo. Con la simplicidad aparece una preocupación por el funcionamiento normal y menos interés por los detalles de la patología. Una teoría de la terapia parece ser más útil cuando enfoca a gente real con problemas reales en el mundo real y toma en cuenta el contexto social cada vez que explica la conducta humana".

En esa conferencia, Lyman Wynne comentó lo siguiente: "estoy inducido por Jay Haley y encuentro que estuve haciendo algunas de esas cosas a fin de tornar la terapia simple. Una de las cosas acerca de las que podemos hablar es de cómo la mantenemos simple y, aún así, la hacemos entretenida, porque una parte de la satisfacción consiste en mantenerla complicada".

Para poner fin a esta reseña queremos destacar tres aspectos

tos relativos al carácter de itinerario científico que constituyó el proyecto del doble vínculo y su relación con la dinámica familiar de la esquizofrenia:

1. uno de los rasgos que salta a la vista en el desarrollo de estas investigaciones puede describirse como la gradual transformación de ciencia pura en ciencia aplicada; uno de los tópicos clásicos de la relación entre teoría y práctica. "Obteníamos el dinero de la psiquiatría y nos dejamos influir fuerte y desastrosamente por la necesidad de aplicar nuestra ciencia en ese campo", relata Bateson en 1976 (7). Tal vez el interés de Bateson estaba más orientado hacia la ciencia pura, en tanto que Haley se fue inclinando cada vez más hacia la aplicación práctica de los descubrimientos que se hacían en el equipo y encontrando en esta aplicación nuevos estímulos para la reflexión teórica;

2. conviene tener presente el carácter de *pionero*, de verdadera avanzada del conocimiento científico en un terreno inexplorado que tuvo este proyecto. El conocimiento alcanzado y el método sistémico con que se lo obtenía se fueron forjando y modelando recíprocamente en el transcurso del proceso;

3. como resultado de estas búsquedas y construcciones se ha levantado un nuevo cuerpo de conocimientos relativo a la comunicación humana y su patología, al proceso evolutivo de la familia, al cambio y a la persistencia relacionales, los cuales dieron nacimiento, a su vez, a nuevos abordajes terapéuticos justamente en los casos de mayor perturbación. Fue así, finalmente, como quedó perfectamente definido el método sistémico que constituye un nuevo paradigma de la ciencia en general, y de la salud mental, en particular.

Bibliografía

1. BATESON, G.: Pasos hacia una ecología de la mente. Edic. Carlos Lohlé; Buenos Aires, 1972.
2. BATESON, G. y RUESCH, J.: Comunicación. La matriz social de la psiquiatría. Edit. Paidós, Buenos Aires, 1965.
3. BATESON, G.: The birth of a matrix or double bind and epistemology en (4).
4. BERGER MILTON, M.: Beyond the double bind. Communication and family systems, theories and techniques with schizophrenics. Brunner/Mazel, Publishers, New York, 1978.
5. HALEY, JAY: Development of a theory: a history of a research project en (7).
6. HALEY, Jay: Ideas which handicap therapists en (4).
7. SLUZKI, C. y RANSOM, D.: Double bind: the foundation of the communicational approach to the family. Grune and Stratton, Inc., New York, 1976.
8. WEAKLAND, John: The double bind theory by self-reflexive hindsight en (7).
9. WEAKLAND, John: Pursuing the evident into schizophrenia and beyond en (4).

Análisis del valor de la desmentida en la formación y el funcionamiento del grupo familiar *

**DAVID MALDAVSKY, NILDA NEVES y
RUBEN LEGUIZAMON**

Malabia 3319 - 5° B - 1425 Buenos Aires - Argentina.

Introducción

En este trabajo pretendemos describir las consecuencias del uso de una defensa intrapsíquica en los vínculos interindividuales familiares. El trabajo no pretende, pues, mostrar una técnica de abordaje, ni una evolución clínica, ni un problema psicopatológico familiar, sino que procura ser una reflexión acerca de la eficacia interindividual de un mecanismo defensivo del Yo.

La exposición parte de la descripción de dos sesiones de un grupo familiar, seguida de una primera generalización descriptiva, a partir de la cual es posible intentar la respuesta sobre los determinantes. Consideramos entonces, mediante una labor de construcción, las transformaciones ocurridas en el aparato

* Este trabajo fue presentado en el Primer Congreso Argentino de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires, 1981. A la versión original se le hicieron agregados surgidos de la elaboración de algunas preguntas y sugerencias de los participantes ante los cuales fue leída.

psíquico de algunos de los integrantes de la familia, para realizar una recapitulación general, de tipo clínico.

A partir de este análisis formularemos una hipótesis más abstracta, en el último apartado del trabajo, referido al modo como el mecanismo de la desmentida (*Verleugnung*) fuerza posiciones interindividuales en el grupo familiar. Algunas de estas hipótesis se relacionan con exposiciones de Maldivsky (1980, 1980a), en especial las referidas a la desmentida y lo siniestro, y a las estructuras intrapsíquicas en cuadros narcisistas.

Presentación clínica

Antecedentes

Elena se hallaba en tratamiento psicoterapéutico individual desde hacía dos años en una institución privada. En el momento en que pidió a su terapeuta una derivación para María, su hija mayor, obesa igual que ella (el motivo que la joven aducía para tratarse era su deseo de adelgazar), los terapeutas de ambas plantearon la conveniencia de realizar reuniones familiares. La familia aceptó la propuesta con el deseo de ayudar a María y Elena, "las enfermas". El material clínico que presentamos corresponde, pues, a esta familia. Está integrada por el padre (Ismael, 47 años), la madre (Elena, 40 años), dos hijas (María, 14 y Sandra, 10 años) y la abuela materna (Rebeca, 60 años).

Incluiremos a continuación una síntesis de la primera y de la tercera entrevista familiar (realizadas hace unos años), que luego comentaremos. Concurren Ismael, Elena, María, Sandra y Rebeca.

Primera sesión

Tras las presentaciones y un breve silencio, el padre (Ismael) interviene diciendo que estaban allí para que los terapeutas los conozcan, les vean la cara. A continuación la abuela se expresa

en el motivo que tiene para aceptar las reuniones: ayudar a su hija, "que es la mujer más buena y sumisa del mundo" y que no recibe nada de cariño o consideración de sus hijas y esposo. El relato es interrumpido por repetidos accesos de llanto. Rebeca centra la causa de los problemas familiares en María, "mala, maleducada", que además de no respetar a su madre y abuela se apoya en la tolerancia cómplice del padre para hostilizarlas.

Los acusados, María e Ismael, escuchan con actitud indiferente las quejas de la abuela. María responde por fin que ella personalmente no tiene problemas fuera de los que le ocasiona la abuela con sus eternas quejas y críticas, que transforman cualquier hecho insignificante en un drama que justifique lágrimas y lamentos.

Ismael interviene apoyando lo dicho por María, y agrega, a modo de explicación de la actitud de la abuela, que ella es una mujer de carácter fuerte y dominante que "ha sufrido mucho". Dice: "en realidad a todas ellas les gusta sufrir, es una competencia a ver quién sufre más".

Al preguntársele si hay alguien en la familia que quede exceptuado del sufrimiento, responde sin vacilar: "Sí, ella (Sandra) y yo. Claro —agrega—, siempre hay inconvenientes o dificultades pero hay que encararlos deportivamente".

Al promediar la reunión Elena aún no ha pronunciado palabra; permanece aparentemente ajena. En los momentos en que se le requiere alguna opinión sólo alcanza a balbucear monosílabos. Inmediatamente Rebeca acude para afirmar que sus dificultades están motivadas en la falta de amor de esposo e hijas. Ya sobre el final Elena dice que las discusiones entre María y la abuela la hacen sufrir mucho, que Ismael es indiferente a todo y que Sandra es la mejor de todos ellos. Rebeca apoya esta opinión y destaca lo indiferente a todo y que Sandra es la mejor de todos ellos. Rebeca apoya esta opinión y destaca lo inteligente y buena alumna que es Sandra. La niña, que hasta el momento había seguido el desarrollo de los acontecimientos en silencio aunque realizando gestos y muecas de fastidio sobre todo ante las manifestaciones de la abuela, cambia de ubicación; pasa del almohadón que había elegido a una silla, disponible

desde el comienzo, y empieza a hablar en forma desenvuelta a los terapeutas. Expresa su molestia por ser considerada la niña diez. Dice que los elogios que le dirigen en su casa, sobre todo la abuela, no corresponden con la realidad, y que exageran porque no tienen en cuenta cuántas otras chicas hay en el colegio que también son buenas alumnas.

Tercera sesión

Elena toma la palabra para hacer un relato de los males que la aquejan en el momento. Habla con dificultad, respira fatigosamente, tose, pide que se abra una ventana. Dice que ella es la culpable de todo lo que ocurre con su falta de carácter, sus problemas de salud y su incapacidad para interponerse entre María y la abuela y para hacerse respetar. Ismael muestra una actitud distante; sus verbalizaciones, cuando se le pide su opinión, intentan ser las de un observador lógico e imparcial. Manifiesta no sentirse comprometido en las rencillas familiares: "Ellas sufren porque están empeñadas en sufrir".

En un momento dado uno de los terapeutas comenta que entre los integrantes predominan la crítica mutua y los reproches, y pregunta acerca de si se prodigan también caricias. Esta intervención produce un cambio notable en el clima de la reunión. Hay murmullos y sonrisas, e Ismael comienza a hablar de la infancia de María, de lo muy cariñosos que eran todos ellos con la bebita y de cómo se establecía una especie de competencia entre Rebeca y él para mimarla y atenderla, todo lo cual hizo que Elena quedara desplazada. "Prácticamente nunca pudo tener en brazos a María". Elena reacciona negando lo dicho por Ismael y comienzan a discutir. En medio de este intercambio bastante animado, Sandra murmura una palabra. Se le pide que la diga en voz alta y repite: "milanesa". Explica que escuchó que alguien la decía en algún pasillo exterior. Uno de los terapeutas señala que la comida había reemplazado a las caricias. Sandra hace un gesto con la mano y se pega en la mejilla. Agrega: "quiero decir, cachetada". Se pide aclaración y surge el te-

ma de las palizas que Ismael le propina a Sandra. Elena acota que Ismael tiene arrebatos. Son momentos en que tiene otra personalidad. "Ismael se encuentra totalmente inconsciente y descontrolado". Ismael se muestra disgustado y niega que él se descontrola. Elena insiste vigorosamente y repite que su marido tiene dos personalidades, una descontrolada y otra fría y calculadora. Ismael está muy enojado y dice que nada de eso es cierto, ya que él no es "ningún salamín frío".

Ante la frase de un terapeuta: "Ismael nos está mostrando que él también se calienta", vuelven a aparecer las murmuraciones y sonrisas. Entonces Ismael critica a Elena: "es diferente del resto de las mujeres, es una mujer que no tiene nada en común con las demás; las otras hacen yoga, salen, tienen amigas, cuidan su cuerpo. A Elena lo único que le interesa es dormir, dormir, dormir."

Elena intenta defenderse, pero interviene María y apoya lo dicho por su padre. La voz de Elena se va apagando y termina diciendo: "bueno, lo que pasa es que yo soy así". Al indagar sobre esa frase comienza a explicar sus dificultades para relacionarse con la gente, para hablar delante de otras personas; siente que no tiene nada valioso para decir y que nadie la va a escuchar. Rebeca afirma que Elena de jovencita tenía una conversación muy atractiva, tanto que concitaba la atención de personas de diversas edades que alababan su madurez e inteligencia. Se pide a Elena su opinión sobre este dato tan contrastante y ella acepta que tal vez en alguna época fue distinta. Luego ubica esa época alrededor de sus 18 años, en el momento en que se separó de su grupo de amigos. Aclara que en realidad su madre la separó del grupo al enterarse de que existía un proyecto de viajar a Israel, ante el temor de que Elena pudiera llegar a participar de ese plan. Pese a las protestas de su hija de no tener ninguna intención de viajar, Rebeca envió a Elena a vivir durante un año en Córdoba en casa de su tío (hermano de Rebeca). Rebeca interviene explicando sus razones: "este grupo pretendía destruir al grupo familiar, iban a arrancar a una hija de los brazos de su madre".

Una primera generalización descriptiva

Preferimos comenzar el análisis de este material clínico realizando algunas observaciones que corresponden a un primer nivel de complejización. Dos preguntas (surgidas a partir de una teoría general) permiten orientarnos en este primer abordaje: 1) en qué circunstancias interviene cada integrante; 2) algunas características del lenguaje usado. Dilucidar estos puntos nos permitirá acceder a un nivel diferente de complejización teórica, en que resulta posible plantear otros interrogantes: por qué cada integrante interviene en este momento, cuáles son los efectos sobre los demás, y, en última instancia, cuál es el mecanismo psíquico que origina el estado mental de los pacientes al hablar.

Comencemos con la primera pregunta: en qué circunstancias interviene cada integrante. El análisis del material permite detectar una serie notable de redundancias. Comencemos por Ismael, quien fue el primero en intervenir. Muchas de sus intervenciones surgen cuando puede exhibirse en una posición distante y lúcida, como por ejemplo al afirmar que en su familia varias de las mujeres buscan sufrir, o que su suegra habla así porque ha padecido mucho. Otras intervenciones, sobre todo en la tercera sesión, lo muestran irritado, en la medida en que aparece la temática de su sexualidad. Se vuelve hipercrítico con respecto a su esposa, y podemos conjeturar que ésta es una defensa ante la posibilidad de descontrol en la sesión misma. Hay un tercer tipo de intervención, que en primera instancia resulta desconcertante: cuando evoca la situación posterior al nacimiento de su hija mayor, período en que pareció tener intensa participación en la vida afectiva familiar. Sin embargo, si nos preguntamos en qué circunstancias relata este episodio, la situación se aclara. En efecto, los terapeutas habían interrogado por las caricias en el presente, y los murmullos posteriores a esta pregunta indican que ha sido atinada. La respuesta de Ismael puede entenderse entonces como un esfuerzo defensivo, sustitutivo, por cambiar de tiempo: del presente al pasado, y de objeto: de la hija menor a la mayor. Con este esfuerzo defensivo Ismael

intenta, pues, restablecer una posición distante con respecto a procesos que le son exteriores. Este esfuerzo por sustraer su Yo de los conflictos tiene, pues, tres variantes: 1) observaciones frías, algo burlonas y presuntamente comprensivas; 2) cambio de tiempo y de objeto; 3) ataque hipercrítico al objeto. Estos recursos son crecientemente hostiles, y la sustitución del primero por el segundo, o de éstos por el tercero, resulta de la ineficacia de los anteriores, más acordes con su Yo. Es posible que el fracaso del último recurso lo suma en un estado de descontrol.

El segundo recurso defensivo de Ismael, además, provoca un efecto particular sobre los demás. Es un esfuerzo refinado, que reordena las posiciones en el grupo, e inclusive parecería centrar el problema en otros puntos. Tal vez el mayor efecto lo provoque en María, a quien ubica ilusoriamente como objeto de su amor. Es posible que conductas como ésta determinen reacciones posteriores de María, como su apoyo al padre y el ataque a la madre que entonces termina silenciada.

En cuanto a Rebeca, sus intervenciones se ubican en un contexto: la relación entre Elena, los otros y ella. En su mayoría estas intervenciones son reproches a Ismael y María por cómo maltratan a su hija, o bien tentativas de justificación de las fallas que Ismael y María critican en Elena. Ella interviene entonces para ocultar a los otros o disculpar la impotencia supuesta en su hija, con lo cual convalida dicha impotencia. Sin embargo, una intervención final de la madre la ubica en otra posición: ya no como quien protege a su hija del exterior sino como quien la mantiene aferrada, ante el riesgo de que le sea arrancada. Así, pues, la identificación con su hija y el esfuerzo por defenderse del reproche, dirigido contra Elena, o contra ella misma (por no haberle dado autonomía), parecen elementos fundamentales en sus intervenciones. Estas observaciones permiten suponer que las críticas que dirige ahora Rebeca contra María son similares a las que encaminó contra Elena, cuando surgió el proyecto juvenil de autonomía.

Las intervenciones de María, en cambio, son agresivas, tanto contra la abuela como contra la madre. Es posible conjetu-

rar que las peleas con la abuela surgen como consecuencia de la hipercrítica de María con respecto a la madre, como la que aparece en la tercera sesión. En la primera sesión María recibe el apoyo de Ismael en su crítica a la abuela, y en la tercera lo apoya a su vez en su crítica a Elena.

La madre parece tener sobre todo dos tipos de intervención. Una de ellas consiste en el autorreproche por sus incapacidades, y otra, la oposición crítica a la palabra de Ismael, que organiza los sucesos en una versión diferente de la suya. Sin embargo, la palabra de Elena no se sostiene, en especial ante la coalición hipercrítica entre Ismael y María.

Las intervenciones de Sandra, por fin, tienen un carácter diferente. Suelen ser descentradoras, sobre todo cuando las encrucijadas defensivas se articulan en una red paralizante, de la cual ella repentinamente pasa a ser el centro. Así ocurre en la primera sesión al cambiar de lugar o al comentar que le molesta la desproporción de la idealización de que es objeto, o bien, en la tercera sesión, cuando su intervención reintroduce la temática de las palizas, que su padre quiere evadir.

Dentro de este contexto descriptivo general, podemos incluir un análisis de las coaliciones en la familia, sus direcciones y sus traiciones, ya que toda alianza anticipa su ruptura.

Rebeca apoya a Elena contra María e Ismael, pero a su vez se ve amenazada por la posibilidad de que su hija desee tener autonomía. Ismael apoya a María, pero también la traiciona al elegir a Sandra, la hija menor, como compañera sexual y como la otra sana, junto con él. La alianza de Ismael con María es sobre todo ofensiva-defensiva ante Rebeca y Elena, pero cuando se trata de un contexto libidinal, se vuelca hacia Sandra. En cuanto a María, opera como aliada incondicional del padre ante Elena y Rebeca. En ella la traición es prácticamente insostenible. Le resulta exterior, traumatizante. Sin embargo, es necesario recordar que el origen del tratamiento familiar es en última instancia el pedido de psicoterapia formulado por María, y que ésta accedió a dicho tratamiento introducida por su madre. Elena, en cambio, parece aliarse con su madre, a quien desea proteger de las críticas de María, pero ante los terapeutas

narra cómo Rebeca la retuvo contra su deseo. En cuanto a la hija menor, no acepta la investidura idealizante de la madre, la abuela y el padre, y se alía a los terapeutas en el esfuerzo de rescatar una situación familiar en que se halla comprometida: los juegos con Ismael. Es posible conjeturar que una razón por la cual no acepta quedar como elegida por los adultos sea el temor al ataque de sus rivales, sobre todo la hermana, a quien parece apoyar, sin ser retribuida.

En cuanto al otro tipo de generalización descriptiva, tiene que ver con el lenguaje. Predominan los reproches, las críticas, las acusaciones, las denuncias. Pero además es notable la emergencia de contenidos orales en el material, verbal o corporal. En efecto, dos de las pacientes son obesas, y Rebeca, a su manera, ha devorado a su hija, al menos la palabra de su hija. En cambio, Ismael incluye una metáfora alimentaria en su discurso (cuando afirma que no es "ningún salmín frío"), y Sandra apela a la palabra "milanesa" para introducir el tema de las palizas. (Podríamos decir, tal vez, que "la verdad de la milanesa" es "un bife" = una cachetada). Sólo que mientras Ismael rechaza el juicio contenido en la metáfora que él mismo enuncia, Sandra apela al término alimentario para hacer surgir el relato de episodios familiares. La actitud de uno y otra ante los juicios acerca de la realidad son, pues, diferentes, aunque para todos esa realidad está categorizada en términos de la oralidad.

Esta primera generalización permite formular ahora en mejores condiciones los interrogantes sobre las causas. Consideramos que la respuesta es compleja, ya que existe, para cada situación, una sobredeterminación causal. Sin embargo, el peso de cada uno de los determinantes es diferente, y entre ellos parece privilegiado el tipo de vínculo de pareja establecido por Ismael y Elena, vínculo que es el origen de esta familia. Pero ello hace necesario considerar la historia de la pareja desde la perspectiva del aparato psíquico de cada uno de sus integrantes.

Transformaciones en el aparato psíquico de Ismael

El paciente pertenecía a una familia judía radicada en Argentina, compuesta, junto con sus padres, por dos hermanas, 4 y 6 años menores que Ismael. Su madre murió tras una crisis psicótica durante la niñez de Ismael, y su padre se volvió a casar al tiempo, durante la adolescencia de sus hijos. Estos repudiaron este nuevo enlace del padre y se alejaron hostilmente del hogar. Cuando Ismael tenía 18 años, junto con su hermana siguiente decidió realizar un viaje como integrante de un contingente de jóvenes que deseaban participar en la lucha por la constitución del estado de Israel. Como surgieron dificultades para ingresar en Asia Menor, Ismael debió permanecer en Londres, donde trabajó como maestro de hebreo en un colegio. Sus alumnos eran de origen yemenita. Después de un tiempo consiguió llegar a lo que luego sería el estado de Israel; residió durante varios años en un kibutz que finalmente fue invadido por tropas irregulares. Los integrantes del kibutz fueron divididos por sexo. Las mujeres, trasladadas a un campo de prisioneros, fueron entregadas al poco tiempo a la Cruz Roja. En cambio, los hombres fueron llevados a otro campo donde permanecieron varios meses. Al ser liberados sólo dos, Ismael y un compañero, conservaban la vida.

Ismael sobrevivió gracias a que se le proporcionó un mínimo de alimentación compatible con la existencia, a fin de realizar su tarea: impartir conocimientos de hebreo a los oficiales del campo, combinados con los rudimentos de árabe adquiridos en Gran Bretaña. Cinco años después de ser liberado regresó a la Argentina tras residir un tiempo en Londres; al cabo de unos años se casó con Elena. Trabaja desde entonces como empleado administrativo en una fábrica.

Estos datos de la historia son conocidos a través de terceras personas, sobre todo la hermana siguiente de Ismael, que también fue hecha prisionera. Esta hermana narró la historia de Ismael a Elena, quien a su vez la relató en sus sesiones individuales. Ismael, en cambio, no relató a su esposa e hijas lo sucedido en el tiempo transcurrido fuera del país. En la actualidad es un hombre parco, con muy pocos contactos sociales, cuyos intere-

ses principales están centrados en escuchar música y profundizar el estudio del idioma inglés.

Podemos discernir al menos cuatro momentos en la historia de Ismael. El primero corresponde a su vida anterior a su captura y su internación en un campo de prisioneros. En realidad englobamos en este período una serie muy grande de vicisitudes, y es posible preguntarse hasta qué punto puede considerarse un período único. En efecto, podríamos hablar, al menos, de dos períodos en este momento inicial: el de la Argentina y toda la serie de acontecimientos posteriores en el extranjero, durante su adolescencia y juventud. Pero el momento segundo, el de su captura e internación, que corresponde a una situación traumática, unifica su historia anterior, como el momento anterior al trauma.

Ahora bien, Freud (1927) postula que en las neurosis traumáticas ocurre una fijación libidinal al momento anterior al trauma. El trauma implica sorpresa, imposibilidad de ligadura intrapsíquica de una percepción extraña, ajena, incomprensible. Como defensa, el Yo puede apelar a la sobreinvestidura de una representación previa tranquilizante, conocida, familiar, que identifica con el Yo, como un doble protector. Podríamos decir que ésta es una forma de desconocer que el trauma ha ocurrido. Pero esta fijación defensiva al momento anterior al trauma tiene un efecto posterior en el Yo: queda a merced de la compulsión a la repetición, con lo cual el trauma resurge, inevitable, pero desde el interior de aquella representación usada como defensa, de modo que lo familiar se vuelve extraño, inquietante, siniestro. La ley general sería: cuando el Yo apela, como defensa ante un trauma, a la investidura libidinal (magnificadora, idealizante) de una huella mnémica anterior al trauma, queda finalmente expuesto a la repetición de la situación de la cual pretende defenderse, y esa misma representación usada como defensa se vuelve la causa del trauma. El trauma resurge entonces como un recuerdo que irrumpe en el Yo con la misma fuerza que tuvo la situación exterior que anteriormente desbordó las defensas del Yo. Esta afirmación abre un interrogante: ¿cuál fue la representación que Ismael sobreinvestió de-

fensivamente, representación correspondiente a momentos anteriores al trauma? El análisis de su historia permite dar una respuesta: sobreinvestió defensivamente su vida en la Argentina, a la cual retornó al terminar su cautiverio.

Podemos suponer entonces que el tercer momento, el momento postraumático, corresponde a un esfuerzo defensivo que se podría sintetizar así: "si yo hubiera estado en la Argentina, mi cautiverio no habría ocurrido; estoy en la Argentina, por lo tanto lo sucedido no tuvo lugar, y por ello no tengo nada que decir sobre esa historia". Este esfuerzo defensivo abarcó inclusive el período del casamiento con Elena y el posterior nacimiento de las hijas. Luego volveremos a considerar este punto, ya que la elección de pareja parece determinada también por este esfuerzo defensivo, tendiente a desconocer el trauma acontecido.

Pero hemos dicho ya que esta defensa ante el trauma supone un momento posterior, en que aquello que el Yo sobreinvestió (algo familiar, un doble del Yo) se vuelve en contra, adquire un matiz siniestro. Freud (1919) sostiene al respecto que se da una secuencia en tres tiempos: 1) un momento traumático, un sentimiento de aniquilación del Yo; 2) la sobreinvestidura de un doble omnipotente, como desmentida del trauma; y 3) una transformación del doble reasegurador en siniestro mensajero de la muerte. Desde este punto de vista podemos establecer ciertas correlaciones en la historia de Ismael:

Primer momento:	Argentina y migración	anterior al trauma
Segundo momento:	captura e internación en un campo de prisioneros	sentimiento de aniquilación del Yo
Tercer momento:	retorno a la Argentina y casamiento	sobreinvestidura defensiva de un doble
Cuarto momento:	situación actual	transformación del doble en siniestro

Como se habrá advertido, pretendemos realizar un análisis de la historia del paciente a partir de una teoría: la de las defen-

sas ante el trauma y sus efectos posteriores. Pero es conveniente precisar algunos puntos.

En primer lugar, es preciso discriminar qué tipo específico de trauma padeció Ismael. El campo de prisioneros fue, para Ismael, en primera instancia el lugar de la desprotección. Se trata de un momento traumático en el cual las personas y leyes que lo protegían dejaron de existir, y nada ni nadie lo amparaba; quedaba, pues, a merced de un enemigo arbitrario. Este disponía sobre su vida o su muerte a su antojo, y lo sometía a una situación de pasividad e inermidad.

La prisión le impuso una determinada ley: la de supervivencia. Sus deseos perdían sentido, sólo importaba permanecer con vida. Las leyes establecidas por la cultura quedaron trocadas por las de la supervivencia. La amenaza máxima era el hambre, y él debía quedar a merced de los deseos del enemigo para poder comer. Los deseos que él suponía satisfacer en el enemigo eran deseos cognitivos: el idioma hebreo. De modo tal que para Ismael él era un objeto gracias al cual el otro alcanzaba el goce cognitivo. El otro se retraía sobre sí en estado de goce (como en el yoga) y era indiferente con respecto a Ismael, mientras éste permanecía en una situación de pánico, ante la amenaza de su vida.

La vivencia traumática dio un nuevo significado a su vida anterior, y en especial quedaron sobreinvestidas tanto su vida en la Argentina como su posterior estadía en Londres, punto sobre el cual volveremos luego. Si intentamos ordenar estos acontecimientos según la trama de la fantasía edípica, inferimos un incremento de la fantasía masoquista de ser poseído por el padre.

Volvamos ahora al tercer momento, el del retorno a la Argentina y el casamiento. La elección de pareja puede ser entendida a partir del análisis realizado hasta aquí: Elena no había podido emigrar a Israel, retenida por su madre, y era obesa, como él deseó haber sido en el cautiverio, amenazado de morir de hambre. Elena pasó a ser, pues, su doble reasegurador, y la elección de pareja fue para Ismael de tipo narcisista, como defensa ante el trauma. La relación entre Rebeca y Elena debió de ser ideal para él: una madre retiene a su hija, a la inversa de la trasmudación

ocurrida en su hogar de origen, en que una mujer, compañera del padre, adquirió una significación expulsiva para Ismael.

Pero Ismael dio aun un paso defensivo adicional: la transformación pasivo-activa de un trauma. Estableció progresivamente en la familia una ley de la supervivencia. Sólo había que satisfacer las necesidades más elementales, y renunciar a los deseos.

Para el inconsciente de Ismael él seguía estando en la prisión, pero la situación se había invertido: él se retraía gozosamente, estudiaba inglés y oía música, mientras dejaba desprotegida a su familia, con indiferencia. Elena se quejaba del egoísmo y el desinterés de Ismael por los problemas hogareños: nunca proveyó el dinero necesario para el sustento. Sobrevivían gracias a los esfuerzos de Rebeca, su madre, por ganar algún dinero, y a lo que Elena ganaba en su trabajo. Ismael, por su parte, dijo: "en esta familia cada uno cultiva su propio jardincito", frase que expresaba su retracción narcisista.

La elección del inglés puede entenderse si recordamos que del campo de prisioneros se salvaron solo Ismael y otro. Con él hablaba Ismael en inglés. El hebreo o el árabe, los otros dos idiomas posibles, quedaron investidos con una significación traumática, y por ello la sobreinvestidura defensiva del inglés corresponde al recurso a un vínculo idealizado que preservaba al Yo de las amenazas y lo ubicaba como aquel elegido para salvarse del destino, de la muerte. Además, el inglés arrastraba la significación del recuerdo de su estadía en Londres, en un momento anterior al trauma. Fue precisamente allí donde aprendió algo de árabe, con lo cual adquirió otro de los instrumentos que le permitió salvarse de la muerte.

Pero hemos señalado ya que el paciente se halla ahora en un cuarto momento, cuando el objeto protector se ha vuelto siniestro, hostil. En efecto, en la tercera sesión el paciente se quejó de que su esposa no fuera un objeto sexual que despertara su deseo. Ocurría en él una secuencia, que podría sintetizarse así: al despertar un deseo sexual y dirigirse hacia su esposa, el displacer perceptual neutralizaba el deseo, e Ismael se enfriaba. Pero este destino sexual de su deseo, que terminaba en indiferencia, quedó anticipado por la elección realizada en el tercer

momento, es decir, su elección defensiva. En realidad, en este cuarto momento resurgía el trauma del segundo momento, cuando su deseo quedó desestructurado ante la amenaza a su supervivencia. Sólo que Elena, a la cual había apelado como su doble protector en el tercer momento, se transformaba, en el cuarto, en causa aparente de esta disolución del deseo. La elección de Elena, que al principio pareció defenderlo del trauma, estaba determinada en realidad por la compulsión a la repetición. El destino de su deseo era, pues, desestructurarse por el encuentro con un objeto al cual atribuía la causa de la disolución. Ese objeto era en realidad un doble de sí, y por ello podríamos decir que el destino de su pulsión sexual dependía del encuentro traumatizante con un doble, interpuesto entre su Yo y el objeto de deseo.

Desde esta perspectiva también puede entenderse qué lugar daba Ismael a Sandra, su hija menor. Recordemos que en la primera sesión grupal presentaron a Sandra como la carta de salud, como la niña diez, que todo lo hacía bien. En la tercera sesión la madre describió que Sandra era agredida por su padre.

En un momento posterior María expresó que su padre y su hermana mantenían esos juegos todas las noches, se decían de todo, se trenzaban en una lucha cuerpo a cuerpo, e Ismael le chupaba la oreja a Sandra. El juego era muy difícil de detener, iba en aumento, hasta que Ismael lastimaba a Sandra y la hacía llorar. La excitación sexual se descargaba en Ismael a través de la violencia sádica, y en Sandra a través del masoquismo y de las lágrimas.

Pero además Ismael dijo en la primera sesión que Sandra y él eran los que se exceptuaban del sufrimiento. Es por ello que consideramos que Ismael había investido a Sandra como equivalente del compañero que se salvó junto con él. Con este compañero mantuvo una relación apelando a un lenguaje diferente al convencional (el inglés); igualmente, con su hija se decían de todo. Ambos estaban destinados a salvarse de la muerte, eran los elegidos, pero también eran idénticos. La elección de Sandra era, para Ismael, una elección homosexual encubierta.

Ahora bien, Ismael se refirió a la competencia entre María,

Elena y Rebeca para ver quién sufría más, y a que era necesario encarar deportivamente las dificultades. Estas alusiones al deporte, en un vínculo entre iguales, también permiten inferir cómo entendía Ismael la relación con Sandra: como una competencia a ver quién gozaba más, en un vínculo entre iguales (homosexual), en que el goce tiene un carácter oral primario, ligado al placer de succión (chupar la oreja). La oreja de la hija tenía como destino satisfacer el deseo paterno, de tipo autoerótico, del mismo modo como él quedó al servicio del goce autoerótico del enemigo, en el campo de prisioneros. La actividad de Ismael consistía, pues, en convertir a un doble de sí, que como él se había salvado del trauma, en alguien que finalmente lo padecía. Así, Sandra comenzaba siendo su igual y terminaba traumatizada, y lo mismo le ocurrió con Elena, su esposa: primero fue su doble idéntico (salvada, como él, del trauma) y luego su doble anterior, cuando pasó a ser la que padeció el trauma sufrido por Ismael (transformación pasivo-activa del trauma). El paso siguiente es que su hija Sandra, como ocurrió con su esposa, se convierta en causa del trauma. Tal vez ésta sea también la posición a la que puede acercarse María, aunque por el momento ocupe, para el padre, el lugar de alguien traumatizado al que éste usa como ayudante. El había funcionado como una oreja para un goce ajeno, y ahora él gozaba oyendo música y se apoderaba de la oreja de Sandra.

El estado de Ismael, cuando culmina la pelea con Sandra, es de frenesí de cólera, con un descontrol sobre sí como el que él supuso en sus captores, en la prisión. Si recordamos que Ismael tiene ahora predilección por escuchar música, podemos suponer que en el campo de prisioneros él ocupó el lugar de un aparato que otro regulaba a su antojo para obtener un goce autoerótico, como él lo hace ahora con la radio o el tocadiscos.

Debemos responder aún a dos interrogantes que esta exposición impone. Por un lado, cabe plantearse por qué en la historia de Ismael jerarquizamos como explicativo un trauma de su adolescencia tardía, y no sus vicisitudes vitales previas. Tal vez la pregunta podría ser formulada más claramente en los siguientes términos: qué relación existe entre las vicisitudes vitales

previas y el trauma de su adolescencia tardía. La segunda pregunta se refiere a su situación actual: hasta qué punto es posible explicar la perturbación de Ismael como consecuencia de su historia. Esta pregunta también puede recibir una formulación más clara: qué relación existe entre las impresiones actuales y la estructura del aparato psíquico de Ismael, como determinantes de su estado.

Consideremos en principio el primer problema, el de las relaciones entre el trauma de la adolescencia y las vivencias previas. Ismael parece haber apelado a una defensa impulsiva, a una identificación heroica durante su adolescencia. Pero si discernimos que Ismael entendió el trauma de su adolescencia como una desestructuración del autoerotismo, ello no depende de la impresión fijadora sino de su estructura psíquica previa, organizada de un modo autoerótico. Además, no sería extraño que los juegos con Sandra puedan ser entendidos en los términos de los juegos sexuales infantiles con sus hermanas, y que el hecho de tomar el objeto de deseo como rival al que somete también derive de allí. De tal modo, la identificación adolescente de Ismael con el héroe de una gesta (conquista de un territorio) corresponde en cierta medida a una reacción ante el trauma de que en su hogar de origen una mujer lo había expulsado. También es posible suponer, en esta misma línea de razonamiento, la vigencia previa de un complejo de Edipo invertido. Además, tal vez haya habido una identificación con sus padres inmigrantes a la Argentina, que sobredeterminó su deseo de emigrar.

Pero esto nos lleva a discriminar metapsicológicamente un trauma constituyente de una disposición en el aparato psíquico, y un trauma posterior, cuando el aparato psíquico ya está estructurado, cuando ya las pulsiones libidinales han despertado por las vivencias y se han fijado a ciertos complejos. El nuevo trauma es entendido según la disposición previa, en este caso sobre la base de una fijación en el autoerotismo. A diferencia de los traumas constituyentes de un aparato psíquico, en que la impresión fijadora tiene un carácter accidental, en éste la impresión fijadora determina la magnitud del estímulo, pero no su significación psíquica específica. Esta magnitud del estímulo, con el

desborde cuantitativo que le es inherente, impone que el trauma arrase con las estructuras psíquicas vigentes, y determina su posterior repetición como recuerdo. Pero la cualidad específica del recuerdo depende no tanto de los rasgos objetivos del trauma sino de su significación, determinada por las características de la estructura psíquica arrasada por el aumento de cantidad aportada desde el exterior. El trauma aporta, pues, la cantidad, y el aparato psíquico, ya constituido y desestructurado, determina su significación específica, de cuyas características tomamos cuenta cuando el trauma se repite como recuerdo. En el caso de Ismael, el trauma adolescente fue categorizado como desestructuración del autoerotismo motivada por el empuje pulsional, por hambre. Ismael entendió este trauma como proveniente de un objeto exterior que retenía el goce autoerótico que él había perdido, y lo retenía usando al paciente como soporte, como estímulo para su propia satisfacción. El trauma adolescente, que Ismael entendió en términos autoeróticos, reordenó su pasado en la Argentina, de la cual tuvo nostalgia al constituirlo en el lugar en que el autoerotismo culminó en goce en su Yo.

Consideremos ahora el segundo problema: hasta qué punto el estado de Ismael depende de su estructura o del contexto actual. Cuando nos referimos al contexto actual aludimos a que el inconciente de Ismael capta los deseos inconcientes hostiles de su suegra y su esposa. Por ahora sólo daremos al respecto una respuesta provisional: en el inconciente de Ismael, la captación del deseo hostil de su esposa y su suegra se articula con el deseo de muerte captado en los oficiales enemigos del ejército irregular. Esta homologación inconciente promueve la defensa vindicatoria, o bien la potencia: el esfuerzo por realizar una transformación pasivo-activa de los traumas.

Transformaciones en el aparato psíquico de Elena

En su infancia, la paciente fue, según cuenta, solitaria y sumisa, con una madre dominante y un padre artista pictórico,

que nunca pudo ganar dinero de su profesión. El padre murió de cáncer de pulmón, luego de una operación realizada en su domicilio, sobre la mesa del comedor, delante de la niña. Elena tenía entonces 14 años y era delgada. Al poco tiempo requirió una operación de apendicitis, y sufrió un *shock* que hizo necesario aplicarle calor mediante bolsas de agua caliente. Alguna maniobra descuidada hizo que se le produjeran quemaduras en una pierna de tal gravedad que pasó varios meses con peligro de amputación. Por esta época comenzó su obesidad y un proceso de deterioro general en su salud. Sufrió varias intervenciones quirúrgicas, todas ellas de gravedad, la última hace aproximadamente un año, a fin de extirparle un tumor canceroso en la vejiga.

Elena fue una adolescente estudiosa y trabajadora, con una actividad social limitada a un grupo cerrado de pares que al terminar el colegio secundario comienza a planear un viaje a Israel. Para evitar su participación en dicho proyecto la madre la envió a Córdoba, donde permaneció un tiempo viviendo con un tío materno. Desde entonces Elena perdió todo contacto con gente de su edad, se volvió taciturna y callada y se limitó a trabajar. Su aporte de dinero era esencial para el sostén familiar, tanto antes como después del casamiento.

Según Elena, su madre decía que el amor más grande se lo profesó su propia madre; describió las penurias de Rebeca al lado de su marido y sostuvo que luego de enviudar sólo se dedicó a cuidar de su hija sin disfrutar de la vida.

Elena se encontraba inserta, pues, en una trama donde había una carencia de figura masculina y un engrandecimiento del lugar de madre. Además, también ella padeció un momento traumático que le imposibilitó una conducta autónoma: ante la mera posibilidad de alejarse de su madre fue condenada a permanecer con un tío materno.

Sin embargo, no es posible equiparar el trauma de Elena con el de Ismael. En ella no hubo una amenaza permanente a su supervivencia, una pérdida de la posibilidad de predecir el futuro inmediato. Su historia infantil constituye un factor eficaz en su patología actual. Podemos suponer que como desenlace de

su historia en ella dominó el complejo de Edipo invertido: una fuerte adhesión a su madre y una aceptación del hombre sólo en la medida en que permitiera preservar un circuito libidinal femenino: Elena-Rebeca-abuela materna.

En la adolescencia, en el momento en que debió realizar el hallazgo de objeto, en Elena coexistieron dos corrientes psíquicas simultáneas y contrapuestas. Por un lado, invistió intrapsíquicamente, en su preconciente, la representación de un hombre, pero la muerte del padre y el episodio de los 18 años reforzaron el privilegio de un complejo de Edipo invertido. El hermano de su madre pasó a ser un carcelero, con lo cual se potenció su representación del hombre como mero ayudante de una mujer, y no como objeto de deseo.

De tal modo, podemos decir que en ella había un complejo de Edipo invertido, inconciente, y dos tipos de investidura preconciente de objeto, una homo y otra heterosexual. Pero el tipo de complejo de Edipo invertido inconciente de Elena merece mayor análisis. Cabe preguntarse cuál era el lugar en que Elena se ubicada para su madre. Consideramos que ella se ofrecía como objeto para el goce materno, como aquella que le permitía satisfacer sus deseos, sobre todo los de devoración. Lo que ofrecía, para que la madre gozase, eran sus propios deseos libidinales y hostiles, de autonomía. En cambio, se ofrecía como oído que permite a la madre desplegar sus quejas y reproches, es decir, como una persona silenciosa y comprensiva, que permitía con su presencia que la madre se oyese a sí misma hablar (quejarse), y alcanzar así la felicidad.

La hija pasó a ser pues aquel objeto que permitía a su madre regular sus estados de ánimo. Podríamos decir que fue el muro de los lamentos para su madre, o sea aquel objeto en que la madre expulsaba lo displacentero de sí, en la queja. Retener este objeto era algo fundamental para su madre, puesto que aquello que la madre expulsaba de sí no tenía por destino perderse sino pasar a ocupar otro lugar, que la madre pudiera recuperar. Así ocurre con el objeto transicional: el niño expulsa en él lo displacentero: lágrimas, saliva, mordiscos. Pero este objeto no tiene por destino perderse, sino permitir al Yo recuperar lo expulsado en ese lugar.

Consideramos pues que el lugar de Elena ante Rebeca era el de un objeto transicional, que permitía a su madre mantener un equilibrio narcisista.

Cabe preguntarse entonces cuál es el efecto que producía en Elena ocupar esta posición. Ella se vio obligada a inhibir en sí misma los deseos hostiles, aquellas frases que, de ser proferidas, hubieran llenado a la madre de dolor psíquico. El desenlace de esta situación fue la obesidad: ella hacía con la comida lo que su madre con ella. Ella apelaba a la búsqueda de la devoración y la repleción del mismo modo que su madre, sólo que el efecto recaía sobre su cuerpo. Esta diferencia con respecto a su madre se debía a la relación distinta que cada una establecía con el lenguaje: mientras Rebeca hablaba abundantemente, Elena enmudecía. Desde este punto de vista, la devoración tenía en Elena el valor de una frase: las cosas que me tengo que tragar. Lo que Elena se tenía que tragar eran palabras, esas frases egoístas que (según suponía) hubieran aniquilado el Yo materno. En tanto Elena dependía de ese Yo (y por lo tanto no pudo proferir esas frases ni para sí ni ante ella), le fue necesario enmudecer y apelar a comer como transacción. Comiendo Elena regulaba su estado de ánimo, del mismo modo como suponía que le permitía a su madre regular el propio al suprimir de sí la manifestación de deseos de autonomía. Pero el comer tenía además otras determinaciones. Para Elena, el hombre era un ser endeble, incapaz de proveer el sustento. Las mujeres tuvieron que arreglarse para obtener y conservar la comida. El cuerpo pasó a ser el reservorio que aseguraba una provisión constante, y la gordura expresaba el deseo de independizarse de los avatares de los suministros externos de un hombre.

La obesidad conciliaba entonces varias corrientes psíquicas. Comer era un efecto de la desestructuración de ciertas frases egoístas en su Yo y también una realización disfrazada de deseos, correspondientes al complejo de Edipo invertido. En este sentido, comer era una expresión de la hostilidad hacia el padre. Era un modo de repetir la situación de aniquilación del padre, el episodio de su muerte en la mesa del comedor tras una operación

que Elena relató con los detalles más cruentos. Comer era, entonces, la repetición del festín totémico, de la devoración de un padre, devoración que había determinado en Elena la pérdida de la posibilidad de emitir frases con autonomía del estado de ánimo materno. En esta devoración sustitutiva del padre, Elena desestructuraba su propia autonomía pensante. El progresivo sometimiento de Elena a su madre determinó que hubiera más frases que no podía decir, más palabras transformadas en grasa.

Podemos describir la patología de Elena diciendo que su masoquismo implicaba una perturbación en el juicio de atribución, aquel que discierne lo placentero de lo displacentero, lo útil de lo inútil, y que conduce a que, en términos de las pulsiones orales, lo malo sea escupido y lo bueno incorporado. En efecto, en Elena el juicio de atribución la hubiera llevado a tomar a su madre como displacentera, y en consecuencia hubiera debido retirar la libido de las representaciones de ésta. Pero este proceso de desinversión le resultaba imposible, ya que su madre era para Elena un objeto único, irremplazable. Ocurrió entonces una pugna en su aparato psíquico: por un lado, el juicio de atribución discernía a su madre como displacentera; por otro lado, le resultaba imposible retirar la libido de la representación de la madre. En este conflicto predominó la fijación libidinal a su madre, y por lo tanto quedó desestructurada una función, la del juicio de atribución: Elena pasó a ser, en realidad, aquella que permitía que su madre desplegara juicios de atribución, es decir, el lugar en que su madre expulsaba (escupía) lo displacentero, mediante la queja.

Es en este contexto que Elena realizó su elección de objeto interindividual, que recayó en Ismael, y lo hizo desde una doble vertiente. En principio creyó encontrar en él a una persona que realizó el ideal que ella no alcanzó: ir a Israel. Desde esta perspectiva, Ismael fue su doble ideal. Por otra parte, ella pudo equiparar la reclusión de Ismael a la suya, en Córdoba, en el contexto de una identificación sin investidura objetual, origen de la empatía.

Pero además la retracción de Ismael, su poco interés por un progreso económico, le permitió realizar una transacción: casar-

se sin ser arrancada de los brazos de la madre. En este sentido, eligió un hombre como su padre, del cual extraer una hija como ella fue para su madre. Ella se dedicaría a su madre y tomaría a su hija como el paño de lágrimas, como su muro de los lamentos.

El pasaje a un complejo de Edipo positivo quedó interferido por múltiples situaciones, que ya analizamos. Sin embargo, el encuentro con Ismael determinó que en ella resurgiera también esta corriente psíquica. Esto puede inferirse del relato que Elena hizo del nacimiento de María. Elena describió su embarazo de María como una lucha contra las opiniones de todos: los médicos, sus allegados, sobre todo su madre, insistían en que debía interrumpir la gestación, ya que el niño iba a nacer deforme. "Me incorporé a la fuerza para ver si tenía piernas o si era un monstruo", comentó, al referirse al momento posterior al parto.

Consideramos que este temor a tener un hijo monstruoso se debía a que el embarazo quedó teñido en su mente con las investiduras libidinosas dirigidas hacia Ismael, como sustituto paterno. El deseo heterosexual podía contaminar el producto, María. La relación con un hombre implicaba una traición a los lazos homosexuales que la unían a su madre. El producto de la traición podía ser monstruoso, ya que recibió una maldición desde su interior, desde aquella parte de sí que mantenía la fidelidad a la madre y el deseo hostil hacia el hombre.

Por otra parte, el parto pareció reactivar en Elena el episodio de la operación de los 14 años, cuando corrió el riesgo de perder una pierna. Este temor reapareció en su parto, con respecto a su hija.

Pero hasta ahora no consideramos un aspecto de la vida psíquica de Elena, su actitud ante el complejo de castración, ante el juicio de que carecía de pene. El relato del episodio del nacimiento de María parecía aludir también a este aspecto (temor a la falta de piernas). De niña, Elena pudo tratar de sostener a su madre como fálica: si la madre tenía pene, ella también podía llegar a tenerlo. Para defenderse del juicio de la cas-

tración materna, ella se ofreció como la garantía de su falicidad: gracias a su hija, la madre podría gozar, ser omnipotente. Las posiciones de la hija como objeto transicional y como falo materno quedaron, pues, articuladas. En tanto la niña concebía la falta de pene como producto de una devoración, entendió que la alimentación podía restablecer lo faltante. Por ello su actividad oral adolescente podría tener también esta significación: la de recuperar lo perdido, apelando a un recurso que fuera el inverso de aquel por el cual el pene le había sido privado.

También podemos entender así el temor que Elena tenía con respecto a Ismael: ella lo tomaba como un equivalente de un padre devorador, que arrancaba con los dientes un pene. Este temor hacia Ismael era consecuencia de la proyección de su deseo hostil, vindicatorio, contra él.

La devoración era entonces también una realización disfrazada de deseo masturbatorio, en que ella obtenía un placer sustitutivo, oral, en la medida en que podía retener la ilusión de una madre fálica.

De tal modo, podemos sintetizar la secuencia de los momentos que se fueron desplegando en el aparato psíquico de Elena. En primer lugar, un complejo de Edipo invertido, en que la madre constituyó un ser idealizado, omnipotente. Pero cuando Elena deseó alejarse, la madre se transformó en traumática. El segundo momento fue, pues, el del trauma. La relación con Ismael y el nacimiento de las hijas correspondieron a una tentativa defensiva ante el trauma, en un tercer momento. Por fin, en el cuarto momento, Ismael, y también María, adquirieron un matiz hostil.

La queja de Elena contra María era que no entendía por qué su hija no le brindaba cariño cuando ella, con su ejemplo, le había enseñado a amar a su madre. En María se desplegaba, pues, el deseo hostil que Elena debió inhibir hacia su madre. María no era idéntica a Elena, sino como aquella que Elena pretendió (y no logró) ser. Es notable que la edad actual de María fuera la de Elena al morir su padre, momento en el cual quedó interferido en ella el predominio de una investidura objetual heterosexual. En la medida en que Ismael no corrió el mismo destino

de su padre, Elena suponía que María haría el cambio que ella no realizó, el viraje al hombre y la hostilidad contra ella. También era la edad que tenía Ismael cuando su padre volvió a casarse y él se alejó hostilmente del hogar, y era la edad en que la hermana siguiente del padre dejó el país para viajar al futuro estado de Israel. Por todo ello Elena adjudicaba a María la posibilidad (que ella misma había perdido) de alejarse del hogar.

En cambio, Sandra era para Elena aquella que ella fue antes del trauma, cuando aún el amor hacia la madre no era incompatible con el amor al padre. Recordemos que Rebeca había descripto también a Elena como una "niña diez", hasta el enmudecimiento posterior al trauma. Elena fue una "niña diez" para su madre y abuela, como lo era Sandra, para su madre y Rebeca.

Pero en la actualidad, la relación que Elena tenía con María e Ismael es aquella que tuvo en el segundo momento, el del trauma, con su madre: inundarse de autorreproches, con un goce masoquista. Así ocurrió en la tercera sesión cuando, vencida por las críticas de esposo e hija, Elena fue apagando su voz y finalmente dijo: "lo que pasa es que yo soy así". Aquellos que hubieran debido preservarla de la autocrítica (esposo e hija) se transformaron finalmente en ejecutores del trauma.

Por lo tanto, en el caso de Elena, como en el de Ismael, es posible distinguir cuatro momentos:

Primer momento:	infancia y pubertad	anterior al trauma
Segundo momento:	muerte del padre, reclusión en Córdoba	sentimiento de aniquilación del Yo
Tercer momento:	retorno a Buenos Aires y casamiento	sobreinvestidura defensiva de un doble
Cuarto momento:	situación actual	transformación del doble en siniestro

Las similitudes entre las transformaciones ocurridas en el aparato psíquico en el caso de Elena y en el de Ismael son de

tipo formal, y dependen de la defensa usada ante el trauma, en el tercer momento. Pero los contenidos de los recuerdos ante los cuales se defienden una y otro difieren, ya que la historia previa al trauma (primer momento), la naturaleza misma del trauma (segundo momento), el doble sobreinvertido defensivamente (tercer momento), y el tipo específico de siniestro (cuarto momento) son distintos para marido y mujer.

Cabe considerar, por fin, un punto que dejamos antes parcialmente en suspenso: la articulación de los deseos de Elena e Ismael, en el inconciente de éste. La frase de Ismael, en que sostenía que no era "ningún salamín frío", parecía surgir, en cierta medida, de su captación inconciente del destino que le daba Elena; es decir, un hombre muerto, como su padre, sobre la mesa del comedor, disponible para un festín totémico. Pero esta captación del deseo inconciente de Elena, de que su marido siguiera el destino del padre, quedaba magnificada en Ismael a partir del registro de lo que ocurría en su propio aparato psíquico con su deseo libidinal: se convertía en frialdad, en indiferencia. De tal modo, entre todos los deseos que captaba como provenientes de Elena, uno de ellos, el deseo de la muerte del marido, se ligaba a su propia captación de la muerte del deseo libidinal como consecuencia de la defensa. Este destino para su deseo libidinal adquirió vigencia durante el trauma de su adolescencia tardía, y ahora se articulaba con una captación de un deseo de muerte para su Yo (en su esposa) y de un juicio cuyo origen le resultaba ajeno, como si proviniera de otro Yo.

Transformaciones en el aparato psíquico de María

En el caso de María podemos conjeturar, como en su madre, un complejo de Edipo invertido. En la tercera sesión la observamos ponerse del lado del padre contra la madre. Ella se identificaba con el padre para la madre. Igualmente, en una sesión posterior, en que se hallaban presentes sólo María y Elena, ésta expresó su convencimiento de ser rechazada, no querida por

sus hijas. Contó que cuando estaba en el cuarto de María, su hija le hizo saber que le molestaba su presencia.

María explicó que lo que ocurrió fue que su madre se negó a arreglarle una prenda alegando que no sabía coser. María le dijo que aprendiera, que le pidiera a la abuela que le enseñara. Elena pasó por todos los justificativos: que no sabía, que no tenía habilidad, que no había quién le enseñara. Finalmente, ante el acoso de su hija, dijo que ella no podía aprender porque tenía un defecto en la mano izquierda, que la hacía casi inútil.

Continuó quejándose de sus hijas, que sólo querían una madre que les cosiera, que les lavara, que les diera cosas materiales y que no le permitían acercarse a conversar o a expresarles cariño. Se repetía así el acoso de la tercera sesión, que en esta oportunidad culminó en Elena con un autorreproche, y con un reproche a la hija.

María se identificaba con la actitud hipercrítica paterna, como transformación de un vínculo de devoración. Ocupaba, pues, el lugar del padre ante la madre.

El reproche de la joven a su madre parecería corresponder a una decepción con respecto a ella que seguía vigente: aún aguardaba de ella algo y quedaba nuevamente defraudada. Tal vez la actitud hipercrítica era un modo en que procuraba alcanzar lo que buscaba. Lo que esperaba recibir, como don materno, era algo que le permitiera alcanzar un equilibrio narcisista, un sentimiento de sí, y retener la masturbación clitorídea, y cuya ausencia la empujaba a comer sin límites, como sustituto del autoerotismo.

Eso que esperaba de la madre era aquello que al mismo tiempo le permitiera responder a una pregunta acerca de su ser, de su identificación, con lo cual podría acceder a un vínculo diferente con el hombre. La joven consideraba que la falta de respuesta a su exigencia no dependía de una imposibilidad general de respuesta (porque la pregunta por el ser, por la esencia, falla por su base, al ser secundaria a una herida narcisista, a una pérdida del sentimiento de sí), sino que era una desgracia (o una injusticia) personal, y por ello persistía en su ilusión y en su

acoso. La pregunta acerca de la identidad femenina, el deseo de que la madre le revelase la clave de lo que es ser mujer, tenía su origen en un trauma, el del registro y el juicio de su propia castración, que tomaba como un infortunio personal, y no como algo genérico. La pregunta era formulada desde un Yo incapaz de realizar una acción específica.

En la joven dominaba, pues, un complejo de Edipo invertido, en que la escena incestuosa sufrió una transformación regresiva en términos orales. Recibir la respuesta a esa pregunta era equiparado a ser alimentada. Es posible que los reproches de María a su madre contuvieran además otra vertiente: los celos homosexuales, por la devoción de Elena a Rebeca, y por la preferencia de aquella hacia Sandra, su hermana. Tal vez el nacimiento de Sandra, cuando María tenía 4 años, tuviera un valor eficaz para que se desencadenara este desenlace en su aparato psíquico.

Igualmente, el hecho de haber sido elegida inicialmente por su padre como objeto de intensas caricias, seguido esto por su sustitución por la hermana, le resultó traumático *a posteriori*. El comer tenía que ver, en este contexto, con un esfuerzo defensivo (autoerótico) ante recuerdos de caricias paternas vueltos traumáticos: era una tentativa de acorazarse contra el exterior (debido a la proyección) cuando el trauma provenía desde su interior, desde los recuerdos y los propios deseos. Tiempo después María adelgazó varios kilos, que luego recuperó en parte. La razón que la llevó a recuperar parte de su coraza fue advertida unos meses más tarde, cuando recordó que mientras estaba más delgada creyó percibir que su padre la observaba eróticamente.

De tal modo, las caricias paternas desbordantes, y su posterior abandono, determinaron en ella no tanto un complejo de Edipo positivo, sino una fijación en el complejo de Edipo invertido, en que el padre ocupó un lugar traumatizante.

Diferenciamos pues por un lado el modo como la invistieron la abuela y sobre todo el padre, y por otro lado el desenlace intrapsíquico de su historia infantil. En efecto, su nombre correspondía al de una heroína de la familia paterna que había salvado a su hermano de la muerte, y es éste el lugar que le

dio Ismael en su origen: la de una hermana salvadora, tal vez como debió ser para él su propia hermana, y como en el presente lo era Sandra. Por su parte, María tomaba al padre como modelo identificador para establecer un vínculo con la madre. Pero en este complejo de Edipo invertido María no ocupó el lugar de preferida para la madre, no fue reconocida como su heroína, como su salvadora. Ella ocupó pues el lugar de aquella que permite el goce materno, pero sin ser consagrada como tal, de modo que el goce de una ocurría a costa del sacrificio de la otra. El modo de defenderse del dolor psíquico correspondiente a esta situación consistió en la devoración, en la ingesta: ella le hacía a la comida lo que en su aparato psíquico la madre le hacía a ella.

Es posible que la ausencia materna y su sustitución por dos fuerzas traumatizantes en pugna: Rebeca e Ismael, haya sido en la niña un determinante de su fijación libidinal oral dentaria, en que la saciedad ofrecía un precario sustituto al dolor psíquico originado en la pérdida del sentimiento de sí. Podríamos conjeturar que en María hubo una falla en la constitución del objeto transicional, cuya presencia hubiera puesto freno a un estado mental de exigencia devoradora. El registro de la diferencia de sexos, ocurrido posteriormente, quedó articulado con este trauma anterior, a todo lo cual se agregó el nacimiento de la hermana para determinar una transformación de los complejos de Edipo y de castración en términos orales.

Aún podemos conjeturar otra determinación en la devoración defensiva de María. Cuando adelgazó expresó que ella consideraba ahora que en el interior de su cuerpo los distintos órganos estaban separados por espacios vacíos, y que la comida constituía un elemento intersticial de unión, que daba coherencia y unidad al conjunto. La paciente entendía pues que el interior de su cuerpo se regía por la lógica del autoerotismo inicial, es decir, distintas zonas erógenas sin coordinación entre sí, salvo que surgiera un factor intersticial. Esta es la lógica dominante en el aparato psíquico paterno. De tal modo en María se desarrollaba una angustia hipocondríaca similar a la paterna, y el comer la preservaba de ella. Este fue otro modo

en que el padre tuvo para la niña una eficacia traumática: María ocupó el lugar de soporte para el goce autoerótico paterno, y pasó a sufrir los desarrollos de afecto displacenteros que antes fueron traumáticos para Ismael.

La razón por la cual María buscó tratamiento era que pretendía adelgazar. Podemos suponer que en ella el empuje pulsional genital la llevaba a una rebelión contra el destino impuesto en su Yo a los deseos heterosexuales.

Recapitulación general

Estamos ya en condiciones de recapitular, al menos en parte, y de intentar explicar las razones por las cuales cada integrante intervino de un modo y en un momento específico. Cuatro de los cinco integrantes parecían obedecer a un esfuerzo: mantener el sentimiento de sí a costa del de los otros. La quinta, Sandra, operaba con criterios diferentes, como lo expondremos luego. Pero dentro de esta generalización, cada uno entendía por sentimiento de sí (la felicidad) algo diferente, que implicaba que los demás ocuparan ciertas posiciones. Por ejemplo, para Ismael el sentimiento de sí suponía obtener el goce autoerótico a costa de Sandra como compañero homosexual, y transformar el juicio traumatizante referido a la muerte de su deseo heterosexual en críticas burlonas a su esposa y suegra, por la mediación de María, e incluso a través de despertar el antagonismo latente entre Elena y Rebeca. En cuanto a Elena, el sentimiento de sí suponía que su marido fuera alguien de quien ella extraía un bien para otorgar a la madre, de modo de obtener de ésta el reconocimiento, la consagración, y que sus hijas constituyeran ese bien ofrendado a la madre, y que a ella le permitiera a su vez desatribuir lo displacentero del Yo. Por lo tanto, felicidad implicaba que los demás ocuparan ciertas posiciones con respecto al Yo. Luego procuraremos discernir para qué Yo esta situación anhelada hubiera sido alcanzar el sentimiento de sí. Digamos por ahora que este modo particular de entender la felicidad también aparece, aunque de un modo diferente, en

los demás miembros de la familia. Se trata de tentativas de realizar deseos narcisistas, deseos de ser y no tanto de tener (inversiones de objeto). A partir de estos deseos, los recursos empleados por cada integrante diferían, en la medida en que cada uno anhelaba que el otro se modificase para acceder así a la propia felicidad.

Este mecanismo común a cuatro de los cinco integrantes hacía que todos ellos se encerrasen en un circuito familiar en que pretendían forzar al otro a ser causa del goce. Pero finalmente encontraban en la palabra del otro una afirmación traumatizante que procuraban refutar o descalificar. No siempre lo que creían oír del otro coincidía con aquello que el otro había proferido, de modo tal que en estos casos se hacía patente que el encuentro de cada Yo con la afirmación traumatizante supuesta en otro dependía más de la lógica interna de cada aparato psíquico, de cada sistema defensivo, que del vínculo interindividual mismo. Así lo observamos, por ejemplo, cuando Ismael respondió que no era "ningún salmín frío", como si procurara refutar un juicio opuesto, o bien cuando Rebeca atacó a María e Ismael como culpables de la situación de Elena, como si alguien la hubiera hecho responsable a ella del estado mental de su hija. En otros casos, además, la frase traumatizante escuchada había sido promovida por el mismo Yo que luego la oía, de modo tal que existía una ley general: hacer que el otro dijese una frase traumatizante para luego refutarla.

El tipo de defensa utilizado determinaba pues un tipo de vínculo interindividual, basado en el esfuerzo por desconocer un juicio, una afirmación traumatizante, con lo cual para cada Yo resultaba imposible escuchar y entender la palabra del otro. Entonces se perdía la posibilidad de rectificarse o rectificar al otro mediante el lenguaje, y el vínculo interindividual oscilaba entre el silencio y el forzamiento (mediante críticas, burlas, autorreproches e insultos) de una posición en el otro, para convertirlo en causa del goce del Yo, al servicio del autoerotismo, como modo de satisfacción sexual del narcisismo.

Pero el esfuerzo defensivo de cada Yo no sólo lo cerraba al vínculo con el otro, sino que también obstaculizaba el acce-

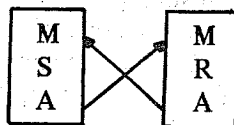
so al exterior, en tanto la palabra y la actitud ajenas eran entendidas a partir de una lógica en que imperaba la necesidad de resañar una herida narcisista. Por ello mismo resulta notable la observación de Sandra, quien afirmó que en su familia no tomaban en cuenta cuántas otras niñas eran iguales a ella, en el colegio. Pero con este comentario abrimos la exposición a un tema diferente, el de las investiduras posicionales interindividuales y el del tipo de defensa utilizado por cada Yo, que resulta eficaz en la determinación de estas relaciones interindividuales.

Forzamiento posicional de la desmentida en un grupo familiar

Hasta ahora no nos referimos específicamente a la defensa a partir de la cual cada integrante da sentido a las palabras y conductas de los otros. Esta defensa es la desmentida. Es precisamente éste el mecanismo empleado por Ismael y por Elena, como defensa ante los traumas. Lo expuesto hasta este punto permite preguntar ahora en qué consiste esta defensa intrapsíquica y cuáles son sus consecuencias en los vínculos interindividuales, en que los semejantes pueden ocupar diferentes lugares: modelo, objeto, rival, ayudante (Freud, 1921).

En síntesis, la desmentida genera una escisión del Yo. Una de sus partes (el Yo real definitivo) sostiene un juicio traumatizante para la otra (el Yo-placer purificado), que rechaza dicho juicio y aporta presuntas pruebas para sostener un vínculo de ser. El Yo-placer purificado procura sostener una identificación primaria, su coincidencia con un modelo o ideal. A veces, esta coincidencia puede quedar amenazada por la posible caída del ideal, y otras veces porque se advierte la diferencia entre dicho ideal y el Yo. El Yo-placer purificado recurre entonces a ayudantes, sea para sostener la idealización de un modelo, sea para sostener la coherencia del Yo con respecto a dicho modelo, según qué sea lo cuestionado por el juicio traumatizante. La estructura del Yo que desmiente consiste, pues, en un vínculo entre tres términos: el ideal, el Yo en coherencia con el

ideal, y un ayudante, que sostiene la idealización del modelo o bien la coherencia del Yo con él. En cuanto al Yo real definitivo, puede coexistir con el Yo-placer purificado, y en este caso en el aparato psíquico surge la necesidad de transacciones intrapsíquicas, como el fetiche (Freud, 1927, 1938). En cambio, cuando el Yo real definitivo es expulsado, surge la necesidad de transacciones interindividuales, como las que ocurrían en algunos miembros de esta familia, en que Sandra aparecía como punto de encuentro entre el narcisismo y la supuesta realidad objetiva. Pero además para cada paciente en que domina la desmentida, otros integrantes de la familia ocupan lugares diferentes del de un salvador, como el otorgado a Sandra. Ello deriva de la naturaleza misma de la desmentida y sus efectos, la escisión y la proyección. El Yo-placer que opera con la desmentida puede proyectar al representante de la realidad no sólo en el exterior a la familia sino en su seno mismo, y defenderse ante lo dicho por ellos (o lo que supone que ellos dirían) como lo haría ante los juicios traumatizantes intrapsíquicos. Esta parte escindida y proyectada del Yo queda constituida, para el Yo-placer purificado, el que desmiente, como una estructura simétrica e invertida con la ya descrita. En efecto, el Yo real definitivo, que sostiene un juicio traumatizante (para la otra estructura), queda equiparado a un modelo hostil, y el lugar de objeto de deseo queda transformado en el lugar de rival; es decir un simétrico inverso del Yo-placer purificado que desmiente. El sujeto constituye al objeto de deseo como rival que anhela sostener un vínculo de ser con su propio modelo (el ideal hostil al Yo-placer purificado), y que para acceder a dicha posibilidad debe transformar al ámbito del Yo-placer purificado en su ayudante. De hecho, el ámbito del ayudante del sujeto se constituye con aquellos que hubieran debido ser investidos como objetos (erótico u hostil), de modo que el deseo hacia dichos objetos se transforma en un medio para acceder a un fin narcisista. De igual modo, el sujeto supone que su rival procura transformarlo en ayudante para acceder a un vínculo de ser con su propio modelo: para el sujeto, su ser es contradictorio con el de su rival. La estructura sería ésta:



En ella se observa que, desde el sujeto, cada uno de los dos ámbitos debería constituir un ayudante para el otro.

En un vínculo interindividual, cada uno se supone entonces investido por el otro en el lugar de ayudante al servicio de la desmentida de un juicio traumatizante en relación con un pasado siempre presente que contiene una herida narcisista. Cada uno, pues, se esfuerza por imponer su anhelo al otro, para que le permita restañar su narcisismo herido. Se trata de una estructura narcisista organizada en forma de simetría invertida, en que es imposible concebir un grupo familiar o una pareja sostenida por la investidura libidinosa de objeto. El deseo del otro es un medio para alcanzar un fin narcisista.

En un grupo familiar, esta estructura defensiva suele articularse con otras, ligadas con la represión o con la desestimación, en cuyo caso el enlace posicional varía y se vuelve más complejo, sea a partir del hecho de que un mismo paciente tiene diferentes defensas, sea a partir del hecho de que distintos pacientes poseen mecanismos variados.

Esta exposición permite que realicemos algunas inferencias más específicas acerca de los lugares que cada integrante de la familia ocupaba para los otros. Recordemos, en principio, que describimos en la historia psíquica de Ismael y Elena cuatro momentos. En ambos casos el segundo momento es el de un trauma y el tercero, el de una defensa ante éste, consistente en desconocer el juicio ligado a dicho trauma. Ahora podemos agregar que dicho desconocimiento se realiza en el tercer momento mediante la desmentida, que implica colocar un doble al servicio de la defensa, doble que luego se volvía hostil, siniestro, en el momento siguiente, el cuarto.

Para Ismael, la palabra de su esposa constituía un juicio, el de que era un "salamín frío", por ejemplo, que procuraba desmentir. Ella ocupaba el lugar de un rival, representante de

un modelo hostil (Rebeca), todo lo cual era expresión de un complejo de Edipo invertido. Ella era ahora su doble hostil, al que derrotaba. Ya nos referimos anteriormente al lugar de sus hijas como ayudantes.

Pero el trauma del cual trataba de defenderse Ismael era específico: la desestructuración de sus deseos (su "enfriamiento"), por lo cual el juicio que procuraba refutar era heredero y sustitutivo del trauma.

En cuanto a Elena, tomaba a Rebeca como ideal, y a Ismael como rival, representante de un modelo hostil, el supuesto padre omnipotente que llenó de dolor a su madre. Pero en la medida en que Elena no poseía ayudantes en el contexto interindividual, apelaba como tal a la comida, con lo cual la satisfacción de la libido narcisista, el deseo de ser, se oponía a las pulsiones de autoconservación. En efecto, ella no comía para satisfacer el hambre, sino a pesar de no sentirlo; comía empujada por la necesidad de restablecer su narcisismo herido.

Para desmentir el Yo debe poner algo de sí que se oponga a un juicio traumatizante. Ismael ponía la música o el inglés, y Elena la sensación de repleción, ambos al servicio de la desmentida.

Pero antes señalamos que el Yo que desmiente transforma al objeto de deseo en rival amenazante, del que surgen juicios traumatizantes, y que procura convertir a este rival en ayudante. Esta era la actitud de Ismael ante Sandra: la tomaba como equivalente del compañero que como él se salvó de la muerte, pero procuraba derrotarla, convertirla en su sometida. La misma actitud tuvo Ismael en principio ante su esposa y luego ante María. Podemos suponer que esta fue su actitud hacia sus hermanas, en la infancia. También Elena había constituido a Ismael como rival, y no tanto como objeto de deseo, pero no había logrado transformarlo en su ayudante, en derrotado.

Ahora bien, el fracaso de la desmentida determina un efecto en el Yo, el desarrollo de un afecto, el sentimiento de lo siniestro, que es el opuesto del sentimiento de sí. En efecto, para Freud lo siniestro surge cuando un doble de sí, usado al servicio de la desmentida, cambia de signo, se vuelve hostil.

La relación con aquello que el Yo inviste como siniestro carece de lenguaje, no existen palabras para el vínculo, salvo aquellas que procuran exorcizar o eliminar el mal. Esta falta de lenguaje en relación con lo supuesto en el otro es una de las características de esta familia.

El destino dado por el Yo a los juicios traumatizantes determina pues el destino intrapsíquico que cada uno de los pacientes confiere a la palabra del otro. Por ello es que sólo pueden ocurrir cambios en el tipo de vínculo en la medida en que surjan como dominantes otras corrientes psíquicas, diferentes de la desmentida.

Es en este contexto que podemos considerar las palabras de Sandra. En su aparato psíquico no parecía dominar aún la desmentida sino la represión, y es por ello que para hacer conciente un recuerdo (el de los golpes) apelaba a formaciones sustitutivas, como cuando incluyó la palabra "milanesa". Observamos que, aunque padre e hija menor utilizaron metáforas ligadas a la devoración, el padre la tomó como un juicio que debía refutar ("salamín frío"), mientras que la hija la usó para expresar un recuerdo. Así, pues, para el padre la metáfora de contenido oral canibalista era exterior y hostil, mientras que para Sandra formaba parte del Yo.

Ello se debía a que para Ismael el Yo real definitivo, que emite juicios de existencia (es decir, aquellos que deciden acerca de la coincidencia o discordancia entre una representación y una percepción), era exterior, en tanto él desmentía dichos juicios porque le resultaban una herida narcisista. En cambio, para Sandra el Yo real definitivo era dominante, y el reconocimiento de una realidad exterior amenazante (el temor a perder el amor paterno) la llevó a que la represión tuviese hegemonía, y a que buscara transacciones para expresar deseos y recuerdos. Entre estas transacciones estaba el término "milanesa".

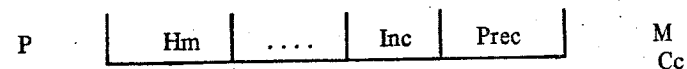
Esta era otra opción del Yo para aludir a una realidad interindividual familiar. No cabía, en cambio, una actitud de denuncia de esta misma realidad, ya que dicha actitud implicaría sostener igualmente la desmentida, es decir, implicaría ponerse como ejecutora de un ideal para desestructurar a un rival domi-

nante. Tal es la actitud de Elena, cuando describió a su marido en su relación erótica y agresiva con Sandra. Su denuncia condujo a una discusión cuyo efecto difirió del provocado por la palabra de Sandra. Así, pues, una frase que denuncie explícitamente la falsedad de la palabra ajena y demuestre una realidad supuestamente objetiva diferente, si bien posible desde un punto de vista abstracto, resulta imposible en el contexto de un grupo familiar cuyos integrantes operan sobre todo mediante la desmentida, es decir, no cabe en la lógica inherente al funcionamiento del aparato psíquico de dichos miembros.

La expresión menos deformada de estas relaciones interindividuales surge pues del análisis de los lapsus, los chistes, las alusiones, los equívocos o los sueños de aquellos integrantes que operan mediante la represión, aunque la versión que inicialmente ofrezcan tenga una apariencia más caótica, menos coherente.

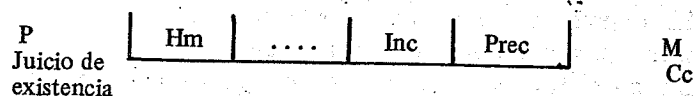
Ahora bien, Freud (1912-1913) sostuvo que ningún acontecimiento de importancia de una generación puede ser ocultado a la siguiente, puesto que, pese a las deformaciones, el aparato psíquico de los miembros de ésta posee un órgano para dar el verdadero sentido a las manifestaciones de sus antecesores. Este órgano es el inconciente, capaz de comunicarse con el inconciente del aparato psíquico de sus predecesores. Pero en el preconciente de cada generación ocurre una deformación en la manifestación de lo captado por el inconciente. Esta deformación es impuesta por las defensas. En este trabajo señalamos los efectos interindividuales de dos defensas diferentes, la desmentida y la represión, que obstaculizan el acceso a los recuerdos inconcientes.

La hipótesis enunciada por Freud acerca de la comunicación de inconciente a inconciente tiene que ver con una teoría acerca del aparato psíquico en el cual existe esta estructura:



Para Freud (1896, 1900, 1915), entre percepción (P) y

motilidad (M) y conciencia (Cc) existe una mediación por las huellas mnémicas. La represión opera separando la representación inconciente de la preconciente e imponiendo la formación de sustituciones ("milanesa", por ejemplo). Pero aún no se advierte dónde y cómo opera la desmentida. Quizá podamos responder a esta pregunta si recordamos que para Freud (1915) el camino de la percepción a lo inconciente también incluye un preconciente, pero que tiene que ver con la función del juicio de existencia, de la prueba de realidad (Freud, 1925). Es decir



Pensamos que la desmentida incide sobre este juicio, de modo tal que a lo inconciente llegan tanto la noticia acerca de la realidad como el desconocimiento acerca de ella, con lo cual la labor rectificadora de lo inconciente tiene que volverse no sólo contra las deformaciones de los demás sino también contra las del mismo aparato psíquico percipiente. El esfuerzo de desconocimiento realizado por el Yo ante la percepción vuelve a realizarse cuando el Yo establece una comunicación con un semejante, aunque supone que en éste ocurrirá la misma labor rectificatoria intrapsíquica operada en su inconciente, es decir que el mero hecho de desmentir implica, como requisito lógico, que el Yo suponga que el juicio rectificatorio desarrollado en sí ocurra también en el interlocutor. De tal modo, la lucha contra sí mismo (contra los propios juicios), transformada en una lucha contra otra persona, está condenada desde el comienzo a una derrota.

Bibliografía

- FREUD, S. (1896): "Carta 52", *O. C.*, I.
 — (1900): *La interpretación de los sueños*, *O. C.*, V.

- (1912-1913): *Tótem y tabú*, *O. C.*, XIII.
 — (1915): "Lo inconciente", *O. C.*, XIV.
 — (1919): "Lo ominoso", *O. C.*, XVII.
 — (1921): "Psicología de las masas y análisis del Yo", *O. C.*, XVIII.
 — (1925): "La negación", *O. C.*, XIX.
 — (1927): "Fetichismo", *O. C.*, XXI.
 — (1938): "La escisión del Yo en el proceso defensivo", *O. C.*, XXIII.
 MALDAVSKY, D. (1980): *El complejo de Edipo positivo, Constitución y sus transformaciones*, Amorrortu, Buenos Aires, en prensa.
 — (1980a): "La lógica de los procesos psíquicos en cuadros narcisistas", *Rev. de Psicoanálisis*, XXXVII, 4, Buenos Aires.

Comentario acerca de una experiencia en el trabajo de familias con niños, dentro de un enfoque psicoanalítico/estructural.

SUSANA MATUS

Lic. en Psicología

*Servicio de Psicopatología del Hospital Piñero, Varela 1300
Capital Federal. Buenos Aires, Argentina.*

Introducción

Este trabajo está destinado a ilustrar por un lado el pensamiento psicoanalítico aplicado a la Terapia de Familia; y por otro, una técnica para el trabajo con familias con niños pequeños.

Este trabajo forma parte de una serie de experiencias realizadas en el Hospital Parmenio Piñero, en el servicio de Psicoterapia y Salud Mental, cuya jefa es la Dra. Ana Giller, en el equipo de Familia y Pareja coordinado por el Dr. Oscar Taber.

Fundamentación teórica

Pensar psicoanalíticamente en el trabajo terapéutico con familias, implica la búsqueda de las determinaciones inconscientes de las relaciones familiares manifiestas.

Pero esto no significa una transpolación directa de los conceptos psicoanalíticos individuales. La familia es una totalidad distinta de la mera suma de los individuos que la componen, es algo más que una suma de inconscientes individuales.

Por lo tanto es necesario utilizar un modelo teórico que dé cuenta de esta diferencia y marque las determinaciones inconscientes propias del grupo familiar.

El modelo Psicoanalítico Estructural para una Psicoterapia de las Relaciones Familiares, de Berenstein, a mi juicio, da cuenta de esta línea de pensamiento. Sintéticamente este modelo es una conjunción de la Teoría Psicoanalítica, en tanto teoría del significado inconsciente, y de la Antropología Estructural de Levi-Strauss, en tanto establece la noción de estructura inconsciente de los fenómenos culturales.

Tomando como marco referencial, este modelo, entendemos que las relaciones familiares tienen un carácter simbólico cuyo significado yace en la estructura familiar inconsciente; esto quiere decir que las interacciones familiares que son las conductas observables, tienen un significado y una determinación que está dada por una estructura familiar inconsciente; por lo cual, resulta entonces que las relaciones familiares son de un orden lógico distinto del de la estructura familiar inconsciente.

Berenstein nos dice que la estructura inconsciente de las relaciones familiares es un conjunto ligado de relaciones entre términos. Dichos términos son: madre, padre, hijo y representante de la familia materna. Las relaciones son las siguientes:

- a) La relación marido/mujer, que llamaremos relación de alianza.
- b) La relación de la mujer con su familia (a la que llamaremos familia materna), a través de uno o varios representantes.
- c) La relación del hijo/a con el o los progenitores.
- d) La relación del hijo/a con la familia materna o su representante.

Hay una relación inversamente proporcional entre la relación de alianza y la relación con la familia materna. Cuanto

más preponderancia tenga una, menos tendrá la otra; lo mismo sucede en cuanto a la relación del hijo respecto de los progenitores o de la familia materna.

Este predominio de la familia materna es un significado que se halla en el nivel inconsciente, en la estructura familiar. En el nivel manifiesto de las relaciones familiares nos encontramos con la salida exogámica de los padres de la familia tratada, que posibilitó la constitución de la relación de alianza. Será pues necesario descubrir las vicisitudes del predominio de la familia materna para saber si la exogamia de los padres, fue sólo formal o verdadera, para saber cuál es el significado inconsciente de la relación de alianza.

La estructura familiar inconsciente tiene una expresión directa y una invertida. En la primera, encontramos observables el predominio de la familia materna. En la estructura invertida, su posición está ocupada por la familia paterna. En estos últimos casos nos encontramos con lo que conocemos en la clínica como "un padre maternizado". Quiero aclarar que me refiero a un padre desde el punto de vista biológico, pero investido por la estructura familiar, con funciones maternas. Por último, diremos entonces, que un terapeuta de las relaciones familiares, partirá de ciertos observables que son las relaciones o interacciones familiares y utilizará la interpretación y la construcción, para hacer comprensible, los significados y las determinaciones provenientes de la estructura familiar inconsciente.

Cabe aclarar, que se da por supuesto, que las relaciones familiares tienen una historia como sistema familiar. Por lo tanto, la intervención terapéutica tenderá a hacer consciente la estructura familiar inconsciente, que organiza las relaciones actuales y las recordadas o históricas, y que las hace comprensibles y vigentes.

Modalidad técnica

A partir de mi experiencia en el trabajo con familias con

niños pequeños (de hasta 7 años de edad), surge la necesidad de encontrar una modalidad que permita articular el relato de los adultos con el juego de los niños, y de este modo no tener que convertir la sesión familiar, o en una hora de juego o en una sesión psicoanalítica de adultos.

Para ello decido en primer término incluir en las sesiones familiares a un coterapeuta especializado en el tratamiento con niños, y en segundo lugar, dividir la sesión en tres momentos, de la siguiente manera: un primer momento con todos los miembros de la familia; un segundo momento donde dividido en dos subgrupos: el de los niños con el terapeuta de niños, y conmigo, los adultos y los adolescentes (los padres, hermanos y otras personas significativas). Después en un tercer momento integro a todos nuevamente, el terapeuta de niños cuenta qué pasó con ellos, a qué jugaron, cómo se relacionaron. Y en función de esto trato de integrar lo que los adultos hablamos con lo que los niños traen.

Quiero aclarar, que éste es un modelo que uso generalmente, pero no indefectiblemente, puesto que según las necesidades, puedo trabajar con toda la familia integradamente, o puedo dividir en otros subgrupos, según la problemática que se plantee: por ejemplo, madre e hijo. Por otro lado esta división del modelo, en tres momentos sucesivos, es sólo a los fines expositivos. En la práctica sucede por ejemplo, que el primer momento de integración es de poca duración, puesto que los niños comienzan a jugar entre ellos en la medida en que los padres inician sus relatos. Por el contrario puede ocurrir, que en determinado momento los niños estén jugando y deseen integrarse a la conversación de los padres, ya sea por ejemplo, porque se habla sobre ellos o porque escuchan algo que les es curioso. Quiero remarcar el tercer momento de integración como el más importante a cumplir en todos los casos.

Debo aclarar que generalmente los niños juegan en otro sector de la misma habitación en donde están los adultos, salvo que se desee conversar sobre algún tema por el cual sea conveniente su presencia.

Caso Clínico:

Esta familia está formada por: el padre, Hugo, de 46 años; la madre, Mónica, de 38 años; y dos hijos, Andrés de 6 años y Luis de 3 años. La familia concurre al servicio de Psicopatología, para realizar una consulta por dificultades de ambos padres de relacionarse con el hijo mayor.

La entrevista de admisión, se le realiza en un primer momento al padre, y más tarde se incluye también, a la madre y a los niños, al ser enterado el entrevistador sobre su presencia en la institución. La madre dice: "Andrés es un chico demasiado despierto, demasiado rápido, difícil de manejar. Estando con el hermano es el caudillo, yo puedo gritar y renegar que no me escucha". Y el padre acota: "por momentos me hace poner rabioso, me crea sentimientos de culpa, me dan ganas de decirle que se vaya a la calle".

A partir del motivo de consulta se puede suponer una problemática familiar y no sólo del hijo mayor; lo cual aparece confirmado por la concurrencia espontánea de toda la familia el día de la consulta. El entrevistador decide entonces, la derivación al equipo de familia. Luego de varias entrevistas diagnósticas, se acuerda comenzar un tratamiento familiar.

Se trabajó con el siguiente encuadre: se acordaron entrevistas familiares de una hora de duración, una vez por semana, y sin límite de tiempo en cuanto a la finalización del tratamiento. Se aclaró que salvo que el terapeuta indique otra variante, deberán concurrir todos los integrantes de la familia. Se explicitó el modo de funcionamiento de las sesiones, con relación a la coterapia y a la integración del juego de los niños con lo conversado durante la sesión. Voy a relatar un fragmento de una sesión realizada durante el tercer mes de tratamiento.

Están presentes: la madre, el padre, los dos niños, la coterapeuta de niños, una observadora y la terapeuta familiar.*

* Agradezco la colaboración de la Lic. Haydée Oks y la Lic. Cecilia Nan, quienes trabajaron como coterapeuta y observadora respectivamente.

El padre trae como problemática la situación de una de sus hermanas, que acaba de separarse del marido.

Mientras tanto Andrés y Luis empiezan a jugar entre ellos, entonces la coterapeuta comienza a observarlos y yo continuo conversando con los padres.

El padre cuenta que esta hermana es la "Celestina", la que aceleró el casamiento porque les consiguió un departamento para alquilar muy grande y muy barato.

Relata que es la segunda separación de esta hermana. La primera vez, ella hizo abandono del hogar, dejando un hijo de cinco años, el cual vive con el padre y visita a la madre. Nos llamó la atención, que la organización de esa separación fuera a la inversa de la que habitualmente se produce, ya que generalmente es la madre la que se queda con el hijo.

Cuentan entonces, que estuvieron recientemente con este sobrino, que les dijo que la madre lo quiere hacer casar. Hugo dice: "yo me doy cuenta que mi hermana no tiene ninguna justificación, ella parece el centro de la que hace los problemas, es totalmente dominante, las personas que viven con ella se reducen a cosas". Pregunto, si él vivió con la hermana, y responde que estuvo 6 meses con ella, cuando se rompió la pierna, después cuando se curó, se casaron. Les señalo, que están descubriendo que la hermana hizo con Hugo lo que ahora está tratando de hacer con el hijo, están descubriendo que no fueron dueños de ellos mismos. Mónica responde que la hermana quería casar a Hugo porque decía que vivía muy mal con el padre, que no es el de ella; y que ahora tampoco quiere que el hijo viva con el padre. Hugo dice con sorpresa, como si lo hubiera descubierto en ese momento: "tiene razón, mi papá no es el padre de ella ya que yo soy hijo del tercer marido de mamá y ella del segundo". Al escuchar este relato no podemos dejar de pensar en la identificación de la madre de Hugo y su hermana, en lo que se refiere a la circulación de los maridos. Acercándose al final de la sesión, le pido a la coterapeuta y a los niños que se acerquen y nos cuenten qué pasó. Relata que en un primer momento, Andrés, el mayor, dirige a Luis en el juego de los cochecitos, y si éste se niega,

lo amenaza con sacarle los chiches. Después el juego se hace más integrado, Luis, el menor, hace pasar los autos por arriba de las sillas, dice que es un puente. En otro momento, Luis dice que es una hormiga, y le pasa el autito por arriba a Andrés, y éste se deja y sólo después de un rato lo empuja suavemente. Por último el más grande pone en el suelo el cinturón de la mamá y coloca los autos arriba, dice que es un camino y hace mover el camino, lo hace girar con el coche encima, Luis que estaba dibujando, deja su hoja y pone el camioncito en el camino.

Les pregunto a los padres qué se les ocurre en relación a este relato sobre el juego de los niños. La mamá dice que siempre manda Andrés, pero que Luis se está rebelando, le pega y le grita. El padre dice que "está en el destape"; la madre acota que le gustaría que no se rebele tanto, que le parece bien en cuanto a las cosas que le hace el hermano, pero que se rebela con ella y le da la impresión de que está creciendo demasiado. El padre le pregunta si lo dice en serio, a lo que ella contesta que con el padre también le pasó.

Les señalo que el juego del camino, me hace acordar al juego de la hermana, donde hay uno que manejó el camino, mientras que los que están en los autos creen que los que andan son ellos. Además, aparece en toda la primera parte del juego alternativamente uno de los chicos manejando al otro. Al principio es Andrés el que le impone a Luis, pero después el menor maneja sobre su hermano y éste no se puede rebelar. Les muestro que Hugo y Mónica se sorprenden al descubrir que no fueron dueños de ellos mismos, que hay una hermana que decidió el casamiento por ellos, pero que sin embargo, les cuesta aceptar que los hijos puedan rebelarse, crecer demasiado, y por lo tanto ya no tener que decidir sobre ellos. Les señalo que los niños juegan adueñándose uno del otro, mostrando que lo que no está permitido en la familia es crecer y separarse padres e hijos.

Vale la pena comentar, que en ese momento no fue interpretado, por estar en los comienzos del tratamiento, pero quizá hoy, interpretaría acerca del obstáculo primario que deriva

de la relación entre los hermanos. Quiero decir, que la dificultad de separación de los hermanos es, en esta familia, un contenido primario, es decir, más inconsciente tal vez, que el referido a la separación con los padres. Se trabajó de este modo, durante casi ocho meses, lográndose algunos cambios importantes, fundamentalmente en la relación de los hijos con los padres.

Andrés dejó de ser el problema familiar. Luis ya no fue el bebé de la familia, y los padres empezaron a ocuparse más de la relación entre ellos. Se decidió entonces empezar a trabajar solamente con la pareja de padres. A continuación, voy a relatar trozos de algunas sesiones de pareja.

Mónica concurre a una sesión muy angustiada, porque había tenido noticias de su único hermano, al cual hace tiempo que no ven, a raíz de que su marido fue "estafado" por este hermano en una relación laboral. Hugo dice que a él también lo pone mal esa situación, pero que siente que no lo puede hablar con su mujer y que no la puede ayudar.

Cabe consignar que el tema del hermano materno, nunca había sido tratado claramente en las sesiones familiares, ya que cada vez que aparecía, Mónica se negaba a hablar, restándole importancia al asunto. Así fue, que a partir de comenzar a trabajar más profundamente la relación de ellos como pareja, la temática de la relación con el hermano materno, se hizo más evidente. Mónica contó entonces, que el hermano era el preferido de sus padres y que ella siempre lo admiró. Que lo que más le dolía de la situación, era que él dejara de ser "el mejor hombre que ella había conocido". Por otro lado, su marido compartía este dolor, en el sentido, de que su cuñado y él habían sido muy buenos amigos, y Hugo se había sentido ayudado, tanto afectivamente como económicamente, por él.

El trabajo terapéutico, se centró a partir de entonces, en mostrarles cómo la situación de "estafa", estaba referida a la "estafa de la relación matrimonial", ya que por un lado Hugo había decidido su casamiento a través de su hermana, y Mónica se había casado con un hombre al que consideraba muy poco al lado del "gran hombre" que había sido su hermano.

Analicemos la estructura familiar inconsciente partiendo del relato familiar y su interpretación terapéutica profunda.

Podemos decir que estos cuatro términos (padre, madre, hijos, y hermana paterna) están ligados en una relación de estructura. Vemos que la relación entre el padre y la hermana paterna tiene preponderancia sobre la relación de alianza, ya que es la hermana y no ellos, la que decide el casamiento.

La relación de la madre con el hijo menor, y en otro momento con el hijo mayor (la madre dice que con Andrés también le pasaba que no quería que crezca), pone de manifiesto nuevamente, la fragilidad de la relación de alianza, y la intensa ligazón de la madre con su propia familia de origen, ya que para poder aceptar el crecimiento de sus hijos tendría primero que haber accedido a instalar al marido como objeto de su deseo, en lugar del padre o del hermano.

Por otra parte la relación entre los niños, no es más que una repetición de esta situación básica de dependencia, Luis y Andrés alternativamente, funcionarían como dobles de papá o mamá, en la relación con sus propias familias de origen. El juego de los chicos está ligado con la jerarquización en la estructura familiar, inconsciente, de la relación de consanguinidad (entre hermanos), sobre la relación de alianza. La experiencia clínica nos muestra que otros chicos podrían jugar al papá y a la mamá; o a la mamá y su bebé; o como Luis y Andrés, jugar como dos hermanos; esto depende de por dónde pasa el énfasis de la estructura familiar.

Si revisamos la sesión de pareja, vemos como todas estas relaciones no sólo se repiten, sino que aparece totalmente confirmado, a través del relato de la "estafa" del hermano materno, el significado inconsciente del predominio de la familia materna sobre la relación de alianza.

Finalmente quisiera remarcar en el trabajo terapéutico, cómo partiendo de los observables familiares, se fue haciendo evidente la relación con la familia paterna, y a medida que se fue profundizando el análisis fue apareciendo la familia materna; esto permite inferir que estas relaciones estructurales tienen distintos status inconscientes. Aparece así la prepon-

derancia de la relación con la familia paterna, no sólo como significado indicador de la problemática del padre, sino también como lugar de desplazamiento del significado inconsciente de la relación con la familia materna.

Conclusiones

En primer lugar esta modalidad de coterapia (terapeuta familiar y terapeuta de niños), favorece la posibilidad de trabajar incluyendo a los niños pequeños en los tratamientos familiares, situación bastante desechada si el terapeuta no es especialista en niños. Por otro lado enriquece y facilita la observación de los distintos elementos que aparecen durante la sesión familiar, tanto al terapeuta que maneja la técnica de hora de juego, como al que no lo hace.

En segundo término, es posible articular el juego de los niños con el relato de los adultos, en tanto lo que mostremos sean los modelos que forman parte de la estructura inconsciente, acerca de los vínculos entre los integrantes de la familia. Podemos decir que la coincidencia se da, no en cuanto al contenido, ya que no necesariamente la problemática que nos traen los padres concuerda con la que nos traen los niños. Pero sí, hay un modelo de relación que generalmente se repite. Esta repetición que podemos observar en el nivel de las interacciones coincidiría con lo postulado teóricamente acerca de las determinaciones de la estructura familiar inconsciente, ya que si por ejemplo la relación con la familia materna prepondera sobre la relación de alianza, el vínculo del hijo con la familia materna será de mayor apego respecto de su vínculo con los progenitores.

En tercer término, deseo enfatizar la necesidad de trabajar en algún momento de la terapia familiar, solamente con la pareja de padres. En mi experiencia de trabajo terapéutico con familias con niños pequeños (esto es, niños que aún no han entrado en la etapa de latencia) fue muy frecuente encontrar como motivo de consulta problemas en la relación familiar a causa de síntomas de los niños. Dichos síntomas al tiempo de trans-

currir el tratamiento, iban desapareciendo; quedaba entonces al descubierto, por un lado, como central, la problemática de la pareja; y por otro lado, que si se lograba un cambio en la relación parental, éste se revertía directamente sobre la relación con los niños y entre los niños. Esto es que, si la relación entre la alianza y la familia materna se revertía, también lo hacía en la misma dirección la relación de los niños, que pasaba a un menor apego a la familia materna y por lo tanto, mayor apego a la relación con los padres.

Por todo lo dicho anteriormente deseo postular la importancia de tener como meta del tratamiento la construcción de una estructura familiar inconsciente, enfatizando la importancia de la inclusión de los niños pequeños, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento familiar. Deseo afirmar que el trabajo terapéutico familiar con niños pequeños, permite a la familia, a través de la interpretación terapéutica del juego de los niños, acceder a significados inconscientes profundos familiares.

Bibliografía

- BERENSTEIN, I.: Familia y Enfermedad mental. Buenos Aires, Paidós, 1975.
- BERENSTEIN, I.: 8º Congreso de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Simposio de Terapia Familiar. Buenos Aires. Rev. de Terapia Familiar. N° 4, Diciembre de 1979.
- DOLTO, FRANÇOISE: Psicoanálisis y Pediatría, México, Siglo XXI, 1978.
- LEVI-STRAUSS, C.: Antropología Estructural. Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- NOCETTI, J. C.: La organización de las relaciones familiares. Buenos Aires, Rev. de Terapia Familiar N° 1, 1978.

Comentario sobre terapia familiar y el equipo terapéutico desde la experiencia clínica

EDUARDO MANDELBAUM

Lic. en Psicología

Uriburu 1001 - San Isidro, Pcia. de Buenos Aires - Argentina.

Al intentar comunicar algunas reflexiones surgidas en el trabajo con grupos familiares y equipos terapéuticos, trataré de precisar el campo experiencial que defino como "campo clínico". Este reconoce en el ámbito geográfico, tres sedes básicas: el Hospital, la institución privada y el consultorio.

La experiencia a la que aludo en el título del trabajo se desarrolló pues al menos en dos ámbitos institucionales, estructurados ambos como Comunidades Terapéuticas Psicoanalíticas.

La experiencia clínica en una Comunidad Terapéutica ofrece características singulares contempladas desde varios ángulos. Desde el punto de vista de la significación cuantitativa, características altamente deseable al intentar validar clínicamente las hipótesis de trabajo, diremos que el terapeuta que trabaja en tales instituciones recoge diariamente un cúmulo de información que excede largamente la obtenible a partir de su práctica individual.

Las distintas variantes técnicas en que participa en coterapia le permiten operar y seguir procesos terapéuticos de un número

muy grande de pacientes y familias. Diariamente se ve enfrentado a una multiplicidad de problemas planteados por distintas interacciones, propias del campo psicológico en que se mueven los pacientes entre sí, con sus familias y con el personal. Estas interacciones, que son algo así como la "trama vital" característica de la convivencia en una Comunidad Terapéutica, fundamentarán muchas veces aspectos centrales del proceso terapéutico de los pacientes.

El terapeuta se ve así sometido a un aprendizaje intensivo que le obliga a la vez a afinar el instrumental técnico y teórico con que aborda la problemática psicopatológica. Al mismo tiempo se suceden ateneos clínicos, reuniones de elaboración, reuniones de equipos, etc. La información procedente de estos campos tan diversos es sintetizada bajo el rótulo de Experiencia Clínica. Pero a poco que se piense en ello, se verá que es una información que procede de diversas fuentes, procesada distintamente y por lo tanto, con diversos grados de elaboración.

En este sentido, la Experiencia Clínica no se reducirá por ejemplo a lo que el terapeuta familiar observa de sesión en sesión en alguna familia en tratamiento, sino que integrará lo que le informa la enfermera, por ejemplo, de lo ocurrido durante la semana con el paciente o su familia. Esta información de situaciones vivenciales, de las que la enfermera, como cualquier otro miembro del equipo, puede haber sido testigo, o en parte protagonista, es a su vez material de análisis y tratamiento.

La información se enriquece asimismo con lo que aporta el analista individual, o las observaciones que de sus pacientes han hecho otros terapeutas que hayan tenido diferentes contactos a lo largo de las actividades de la comunidad. Muchas veces, por ejemplo, los efectos terapéuticos de una determinada intervención podrá ser evaluada por otros terapeutas o miembros del equipo, antes que el terapeuta tenga la oportunidad de ver por sí mismo esos efectos. Pero esa elaboración de la información que recibe de sus compañeros de equipo, le ayuda a comprender con más amplitud y profundidad la índole de los distintos fenómenos con los que está tratando.

Para ilustrar esta descripción de la compleja interacción

familia-terapeuta-equipo, daré un ejemplo clínico. Considero clínico, no sólo lo referido al paciente, sino lo que se refiere también al funcionamiento del equipo tomado como unidad de análisis en su singularidad. Estamos así en el campo del fenómeno institucional abordado clínicamente.

Si bien me ocuparé de este tema más adelante, me permito avanzar la postulación acerca de la posibilidad de interpretar la dinámica de un equipo como significando complejas estructuras inconscientes propias de la patología del paciente y su familia. En este sentido, todo lo que ocurre en la interacción entre los integrantes de un equipo terapéutico, funciona como una "radiografía" o "caja de resonancia" del mundo objetal del paciente o sus interacciones familiares. Pasemos ahora a la situación clínica:

Se trata de una reunión de equipo, en la que participaban el analista individual, el terapeuta familiar, el médico administrador, la terapeuta ocupacional y otro médico representando por su cargo la institución asistencial. La paciente era una joven internada con un diagnóstico de esquizofrenia. Se discutía la amenaza familiar al tratamiento de la paciente. Esta había mejorado prontamente su sintomatología inicial, integrándose a las actividades comunitarias de una manera muy positiva. Su familia, sin embargo, la presionaba para cortar su internación de una manera abrupta.

Esta familia, una de las más enfermas con las que he trabajado, tenía otra hija psicótica estructurada como una paranoia, encerrada en su casa y que sólo en contadas oportunidades concurría a la terapia familiar. La madre era una personalidad con defensas paranoides, irónica y corrosiva, que escondía profundos núcleos melancólicos; complementada en términos patológicos con el padre que podía definirse como una "personalidad ambigua" o "como si", con rasgos pronunciadamente masoquistas en sus desempeños en el mundo externo.

El analista individual refería los logros y cambios de la paciente que pasaba de una etapa de absoluta desorganización en las sesiones, a una etapa de reconocimiento de la figura del analista como objeto real, capaz de ser asimismo deposti-

tario de una esperanza transferencial de percibir sentimientos cariñosos y de confianza, al mismo tiempo que tales sentimientos eran vivenciados claramente por la paciente por primera vez desde el comienzo de sus tratamientos.

Los intentos sabotadores de la familia eran vividos por el equipo como la típica respuesta del sistema con perturbaciones severas que intenta recuperar al depositario de los aspectos psicóticos, interrumpiendo su proceso terapéutico.

El análisis del clima de la sesión de equipo, por momentos sombrío y desesperanzado, a pesar del informe positivo del terapeuta individual, más el recuerdo de lo ocurrido con otras familias en situaciones similares, analizado en grupos multifamiliares, determinó como ocurrencia contratransferencial en el terapeuta familiar la idea de que esta paciente estaría fantaseando con la posibilidad del suicidio o la regresión severa, en caso de producirse su prematura externación por presión familiar. Al comunicar esta idea el terapeuta familiar, el analista individual se sorprendió y comentó a su vez que el análisis del material producido en las sesiones individuales no ofrecía asidero para detectar tales fantasías, ya que por el contrario, la paciente traía logros en la reestructuración de su aparato psíquico y en la instalación de un vínculo más firme y sólido con su analista.

Los aportes de la terapeuta ocupacional y el médico administrador, testigos de los intercambios cotidianos de la paciente en la comunidad, tampoco confirmaban la presunción del terapeuta familiar. Sin embargo, conocedores los integrantes del equipo de la dinámica y la producción inconsciente que se daba en las reuniones de evaluación, decidieron mantener una actitud alerta y expectante, ante los próximos pasos de la familia y la paciente. En la sesión de terapia familiar siguiente a la descripta sesión del equipo, para asombro del terapeuta familiar, la paciente relata como primer emergente un sueño fácilmente interpretable por ella misma como de contenidos psicóticos donde expresa el temor de volver a su casa y perder el grado de integración adquirido al encontrarse con la locura familiar, simbolizada en ese momento por la psicosis de su hermana. Seguidamente y a modo de advertencia dice que por primera vez en su

vida piensa seriamente en el suicidio como salida en caso de ser externada compulsivamente.

Esta situación permitió al terapeuta familiar, preparado ya por su elaboración previa en la reunión de equipo, trabajar intensamente con la decisión familiar, ya prácticamente tomada, de externar a la paciente, y conseguir un aplazamiento de esa actitud. El material de esta sesión, comunicado al resto de los terapeutas del equipo, permitió un ataque frontal y en situaciones experienciales terapéuticas diversas, del acting que la familia incubaba. La paciente pudo pues proseguir por un tiempo más su progreso terapéutico, interrumpido luego de todas maneras.

Retomando el análisis del concepto de "experiencia clínica" y que significa esto para el terapeuta con entrenamiento en Comunidad Terapéutica Psicoanalítica, creo que además del factor de acumulación y elaboración de información que señalábamos más arriba, debe tomarse en cuenta otra faceta significativa. Esa experiencia clínica es usada permanentemente en la evaluación de resultados terapéuticos, y los distintos tipos de cambios observables en pacientes y familias desde el momento de su inclusión en los distintos encuadres que ofrece la Comunidad. Las reuniones de evaluación que siguen a toda sesión de trabajo con pacientes, obliga a que los coterapeutas se formulen hipótesis sobre el análisis de los contenidos de lo ocurrido, de los aportes de las familias, así como de las respuestas interpretativas aportadas por los terapeutas.

Esto puede entenderse como un "análisis transversal" de la experiencia clínica concreta. La unidad de análisis para ese estudio es la sesión ocurrida en ese momento, y ya "congelada" para su elaboración y mejor comprensión. Pero esta dimensión transversal se complementa con el "análisis longitudinal" de esa experiencia, ya que es probable que ese mismo equipo trate esa familia y ese paciente durante mucho tiempo y tenga la oportunidad de evaluar los resultados de su accionar terapéutico a lo largo de prolongados períodos.

El hecho de que sea un equipo de coterapeutas asegura que la revisión clínica sea permanente fuente de información.

La experiencia es interrogada desde varios ángulos a la vez y las respuestas deberán ser a su vez integradas para promover estrategias terapéuticas, cada vez más eficaces.

La variedad de experiencias terapéuticas que favorece la estructura de la comunidad para el tratamiento de situaciones familiares especialmente graves puede ejemplificarse considerando la creación de un particular encuadre terapéutico que denominé en 1968, reunión de "microcomunidad". Por aquel entonces los pacientes psicóticos eran atendidos en reuniones de comunidad terapéutica o asambleas comunitarias y en grupos terapéuticos ortodoxos donde el grupo de pacientes se reunía con un terapeuta y un observador en sesiones semanales estipuladas previamente.

El rol del terapeuta era interpretativo de acuerdo a concepciones de la psicosis establecidas por Freud y los desarrollos posteriores de la escuela inglesa a través de autores como Klein, Bion, Rosenfel, Segal y otros. En las Asambleas los pacientes concurrían eventualmente acompañados por sus familiares y estaban presentes médicos, psicólogos, enfermeras y todos aquellos que intervenían en la vida comunitaria. En esa época las relaciones del equipo terapéutico con los familiares de los pacientes eran distantes y parciales. Se tendía a interpretar la presencia familiar como una interferencia o un intento de sabotaje del tratamiento de los pacientes cuyo campo transaccional debía ser lo más aséptico posible. Pero poco a poco fuimos entendiendo todo esto de una manera diferente.

Empezamos a considerar que las madres, esposas, hijas o hijos de los pacientes querían hacer algo por su familiar enfermo y en última instancia por sí mismos, además de intentar ambivalentemente preservar antiguas simbiosis o mantener sistemas patológicos homeostáticamente. Las luchas que las madres emprendían por su cuenta y riesgo para que los pacientes no fueran trasladados de nuestro servicio, ya que sentían que hacíamos algo por ellos; las oposiciones a las decisiones arbitrarias y extemporáneas que resolvían desde instancias jerárquicas superiores a la Comunidad misma que los pacientes debían ser trasladados a colonias y separados de sus terapeutas y familia-

res; y otros signos de interés de distinta naturaleza nos llevaron a concebir una variación en el encuadre grupal que permitiera incluir a esos familiares en las sesiones terapéuticas una vez cada quince días. Mantuvimos al mismo tiempo una sesión sin familiares, alternada, para que los pacientes pudieran trabajar con nosotros lo que iba ocurriendo en esos encuentros multifamiliares.

Dispusimos que se incluyeran en las sesiones de terapeutas, la enfermera, la asistente social y la terapeuta ocupacional que tenían a su cargo los pacientes y sus familias. Esas reuniones reproducían así, en pequeño, la estructura de las Asambleas o Reuniones de Comunidad habituales del servicio. Por eso las denominamos "Microcomunidades" y constituyeron una modificación importante en el tratamiento de pacientes psicóticos en grupo. Hoy se denominan "grupos multifamiliares pequeños" y tienen una estructura algo diferente.

Un ejemplo clínico nos ilustrará más claramente su forma de funcionar. Recibimos en el Servicio, con pedido de internación urgente, un paciente homosexual derivado por el C.A.S. a quien llamaré J. El informe consignaba que era inminente el riesgo suicida y se sugería para evitar esa posibilidad el empleo inmediato de técnicas de choque. Nuestras entrevistas de admisión con carácter perentorio, confirmaron la impresión diagnóstica del punto de urgencia contenidas en el informe de remisión y conseguimos que el paciente aceptara voluntariamente la internación, postergando por algunos días su decisión consciente de suicidio.

Decidimos, como recurso previo al electro-shock, obtener el apoyo familiar para el tratamiento que deseábamos intentar. Solicitamos la presencia de la madre a través de la asistente social. Concertada la entrevista, nos encontramos con una mujer con una actitud absolutamente fría y lejana que denotaba una estructura de personalidad fuertemente esquizoide. Parecía reforzar sus defensas ante la situación angustiante que representaba su venida al hospital psiquiátrico, para ocuparse de la locura de su hijo. Intenté explicarle, no demasiado concretamente, la situación del muchacho. Mencionamos la presencia

de situaciones importantes por las que requeríamos su ayuda a través de un compromiso de asistencia semanal a la sesión de microcomunidad.

Tuve ahí una primera negativa referida a que debía volver ese mismo día al pueblo en que vivía en la Provincia de Buenos Aires, ya que su marido había quedado solo atendiendo el negocio del que la familia obtenía su sustento. Intenté entonces hablarle francamente del riesgo en que podía encontrarse su hijo si no se hacía prontamente algo por él, mencionando aunque con reticencia, la palabra suicidio. Mis rodeos tenían que ver con mi deseo de no alarmar inútilmente a la madre del paciente haciéndola entrar en ansiedad sino, por el contrario, buscando una alianza con su parte más madura y responsable. Ante mi sorpresa, ya que esperaba una respuesta al menos con cierta tonalidad de angustia, la madre me respondió en forma incolora y monocorde la misma objeción: debía volver a su pueblo a acompañar a su esposo en la atención del negocio. Tuve la percepción de que estaba ante la dramatización de un abandono severo de la función materna, que seguramente tenía que ver psico genéticamente con la homosexualidad y la estructuración de las fantasías suicidas del paciente como respuestas tempranas al bloqueo afectivo y rechazo que denotaba la madre.

Decidí aumentar la intensidad del estímulo con el fin de quebrar esa rigidez defensiva y le dije directamente y no sin cierto dramatismo que su hijo iba a matarse. Esperaba entonces una reacción de desazón, angustia e incredulidad como tantas veces se observan en personas que se ven enfrentadas con realidades traumáticas, pero por toda respuesta obtuve la misma estereotipada y desafectiva argumentación, acerca de su necesidad de regresar ese mismo día a ayudar a su esposo en su trabajo. Ante el fracaso evidente de mis intentos por convencerla para participar en el proceso terapéutico de su hijo, la invité a que aprovechara al menos esa única mañana en el hospital acompañándonos en la sesión de microcomunidad que se haría ese mismo día con la participación de su hijo. Aceptó esta vez aunque aclarando que una vez finalizada la sesión debería re-

tirarse inmediatamente para alcanzar el medio de transporte con el que volvería a su pueblo.

Comenzada la sesión presenté a los demás pacientes y a sus familiares a la pareja madre-hijo explicándoles cuál era la situación con la que estábamos lidiando. En ese grupo se reunían habitualmente entre otros un hombre esquizofrénico de características crónicas, sumamente deteriorado, de 32 años al que llamaremos C. Su madre de 56 años que lo acompañaba permanentemente, presentaba características muy infantiles y deficiencias yoicas tan severas que impresionaba como una personalidad con características oligofrénicas o al menos con sus procesos intelectuales y su captación simbólica muy deterioradas.

Otro paciente, al que llamaremos P. de 24 años, con síntomas obsesivos tan severos que habían determinado su internación, había presentado regresiones profundas de características esquizofrénicas durante su tratamiento. Lo acompañaba su madre, de 50 años, graduada en una especialidad paramédica y su hermana, estudiante universitaria. No describiré al resto del grupo ya que no tuvieron en ese momento un papel decisivo en las modificaciones en la pareja madre-hijo que nos ocupa. Basta señalar que funcionaron como espectadores conmovidos ante la evolución de la sesión y que contribuyeron en su momento a la elaboración del material desarrollado.

Comenzada la sesión, y luego de breves intentos de los pacientes habituales de conectarse con la madre y el hijo mediante preguntas, el grupo cayó en una suerte de parálisis que yo no podía comprender inicialmente muy bien, ya que había sentido eso mismo en mi previa entrevista con la madre.

Decidí entonces poner en escena a través de una dramatización una fantasía temida y que parecía estar en el preconsiente de casi todos. Les dije que la situación tal como estaba llevaba a la muerte de J. y que parecía que su madre prefería una relación con un hijo muerto. La fantasía deseada de la muerte del hijo psicótico aparece con no poca frecuencia en los análisis de las madres esquizofrenogénicas, sea en las terapias individuales o en las familiares, asociadas generalmente a intensos

sentimientos de impotencia y aflicción frente a la enfermedad vivida como incurable.

Al explicitar la escena a dramatizar lo hice en forma de proponer un diálogo entre la madre viva y el hijo muerto. Pedí para ello a la madre del paciente crónico, que hablara a su hijo C. como si hubiera muerto. A éste le pedí que hiciera de muerto, confeccionando con las sillas del consultorio una suerte de ataúd, en el que el paciente se acostó con los ojos cerrados y las manos cruzadas. La inmediata indiferenciación entre yo-no yo, la no aceptación de la existencia del otro como objeto externo real y la consecuente dificultad en la elaboración del duelo, surgió dramáticamente en el discurso de esta madre que siguió reprochando a su hijo "muerto" las mismas "maldades" y "agresiones" de las que se sentía víctima en la vida cotidiana.

Esta madre mostraba claramente que nunca lo había sido realmente y como su hijo representaba sólo un objeto de su inconsciente a quien reprochaba permanentemente por las angustias y carencias que sufriera de pequeña con sus propios padres. Para el resto de los pacientes, la dramatización si bien impactante en cuanto a su significado, quedaba descalificada en su aspecto movilizador por este extraño monólogo-diálogo que no percibía la presencia de la muerte ni separación alguna.

Sugerí entonces que fueran la mamá del paciente obsesivo y su hijo quienes intentaran la dramatización. J. y su madre eran hasta el momento, expectadores silenciosos aunque conmovidos. Sin embargo la madre no parecía incorporar demasiados estímulos de aquello que presenciaba, o al menos así lo deducíamos de su lenguaje corporal y gestual. Comenzada la segunda etapa de la dramatización, el clima emocional subió rápidamente su intensidad, ya que esta nueva madre sí reconocía la muerte del hijo. Se reprochaba amargamente no haberlo comprendido para ayudarlo mejor. Su rostro surcado por las lágrimas mostraba a las claras que la dramatización le permitía expresar temores y sentimientos de culpa referidos a la relación con su hijo que no siempre surgían con esa claridad vivencial en las sesiones grupales. Su desesperación y culpa parecían ir en aumento provo-

cando el llanto de su hijo, que desde el rol de muerto y aún sin salirse del mismo, lloraba también conmovido, por el afecto que experimentaba ante las palabras de su madre. Madre e hijo se abrazaron entonces como corolario de la escena, y en ese momento, algo parecido al estallido de un volcán largamente contenido, ocurrió. La madre de J. se paró y rompiendo en lágrimas nos dijo qué angustiada se sentía al ver qué cerca había estado de vivir realmente lo que las dramatizaciones habían mostrado.

Abrazó a su hijo y entre lágrimas y algunas sonrisas le aseguró que no lo abandonaría y que lo acompañaría en su estada en el hospital el tiempo que hiciera falta. Dirigiéndose al resto de los pacientes y terapeutas les expresó en forma emocionada que agradecía lo que habían hecho por ella, prometiendo también al equipo su apoyo al tratamiento del hijo.

Estos propósitos fueron corroborados por su conducta concreta. Al día siguiente consiguió un alojamiento en Buenos Aires. Se comunicó con el padre de J. contándole lo ocurrido. Comenzó a participar en las sesiones de microcomunidad y lo continuó haciendo hasta que el peligro de una actuación suicida se disipó completamente. Posteriormente J. siguió su tratamiento, ya sin su madre, en el mismo grupo. Aunque sus fantasías suicidas reaparecieron en algunas ocasiones, estaban ahora relacionadas con sus temores a la impotencia heterosexual y al temor a terminar siendo un homosexual asumido. Esta situación le despertaba intensa angustia. Las fantasías suicidas no presentaban ahora peligros referidos a la actuación y se prestaban a ser elaboradas como parte del proceso terapéutico.

Este ejemplo clínico que demuestra un tipo de funcionamiento de un grupo multifamiliar pequeño representa un modelo de interacciones utilizado con importantes logros terapéuticos en muchas oportunidades. Plantea además el problema agudo acerca de los abordajes terapéuticos que requerirán no sólo los pacientes perturbados gravemente sino sus familias. La experiencia indica que así como lo señala Jorge García Badaracco, la familia es el "contexto real de todo proceso terapéutico". Ese "contexto real" sufre cambios importantes que hacen que el terapeuta sea llamado a continental pedidos de ayuda de las

personas vinculadas con esos pacientes. En forma paradójal recibiremos noticias de que el tratamiento funciona a través de situaciones críticas que se multiplicarán.

Me interesa señalar ahora un aspecto fundamental en el tratamiento de familias con miembros psicóticos pero del que las familias de neuróticos no están exentas. Me refiero a la regulación de los afectos y las emociones. Jay Haley dice que si ordenáramos como en un tren por orden de gravedad, los distintos sistemas y cuadros patológicos, las familias gravemente perturbadas conformarían el vagón de cola. Sospecho que ningún terapeuta que se haya sentido expuesto al encuentro y colisión de las profundas corrientes emocionales en las familias con miembros psicóticos podría dejar de coincidir con tal aseveración.

En virtud de las poderosas influencias transferenciales de las que ya Alfredo Canevaro se ha ocupado entre nosotros, el sistema familias expone al terapeuta a todos aquellos fenómenos emocionales que determinaron en su oportunidad la aparición de al menos un miembro con perturbaciones severas. Podrá percibir intensos sentimientos de fracaso, pérdidas o duelos inelaborables, fantasías agresivas y agresiones de todo tipo, a veces materializadas. Amores y excitaciones prohibidas por castigos temibles y sangrientos, muchas veces realmente ejecutados, son parte del clima o trasfondo emocional en que tales familias se vinculan.

Mucho antes que cualquier proceso de elaboración, "insight" o crecimiento pueda ocurrir, la labor del terapeuta será durante mucho tiempo la de disminuir ansiedades, aplacar persecuciones, despejar malos entendidos permanentemente generadores de gran frustración y agresión, así como reasegurar continuamente ansiedades de pérdidas generadoras de actuaciones y regresiones. Es una experiencia clínica compartida con muchos terapeutas, la observación de que gran parte del tiempo de análisis de un psicótico, se utiliza en ayudar al paciente a construir un vínculo estable; luego de someterlo a pruebas innumerables con el fin de comprobar que el analista no será nuevamente una madre simbiotizante o abandonica, capaz de agredir y amar

al mismo tiempo con un amor generador de odio, se hará posible la verdadera elaboración terapéutica.

También las familias ponen a prueba las capacidades y oícas del terapeuta permanentemente haciendo recordar aquella recomendación Winicottiana de que la primera tarea del terapeuta es sobrevivir. Es probablemente en las sesiones de terapia familiar, núcleo de pacientes psicóticos, donde nos encontramos con las ansiedades más extremas y violentas y con las fantasías, o actos a veces, más siniestros. En la terapia multifamiliar, si bien los fenómenos regresivos o destructivos pueden verse incidentalmente potenciados, será siempre posible encontrar en una buena parte del resto del grupo, elementos positivos con los que reagruparse para contener ansiedades o actuaciones psicóticas.

En la terapia familiar nuclear, en cambio, no es raro que el terapeuta se encuentre de pronto solo y sin aliados, luchando por recuperar aspectos del proceso secundario en una familia que funciona enteramente dominada por el proceso primario. Cuando a lo largo de las sesiones estos aspectos regresivos, tales como proyecciones e introyecciones masivas, descargas motrices de agresión, sistema de comunicación basado en el doble mensaje, en la incoherencia y en la disrupción, alucinaciones o delirios por parte de uno o varios miembros, empiezan a ceder y podemos comenzar un trabajo de elaboración, comenzamos a apreciar cómo las regresiones descriptas encubren las vivencias traumáticas reales y carenciales profundas que subyacen al despliegue mencionado.

Boszormenyi-Nagy postula que las interacciones psicóticas entre la pareja de los padres y el hijo psicótico tienen como función negar toda posibilidad de elaboración por el duelo de los propios padres. Jorge García Badaracco señala las carencias básicas detectables en los padres que instrumentan a través del hijo psicótico fantasías de recuperación de lo que nunca tuvieron. En mi experiencia el análisis familiar lleva inevitablemente al análisis de lo depositado en los hijos por los padres como repeticiones de sus propias situaciones traumáticas infantiles. (Rubinstein señala a este respecto una repetición puntual del proceso libidinal). Estas repeticiones se evi-

dencian en un complejo interjuego de fantasías y deseos de completud y desarrollo que se complementan linealmente con las propias trabas en el desarrollo yoico. La psicosis del hijo reproduce muchas veces los deseos reprimidos de algunos de los padres, aspectos de su ideal del yo, fantasías compensatorias, etc. La verdadera alteridad del hijo es negada de tal modo que estos pacientes son en el fondo perfectos desconocidos para sus padres.

Al mismo tiempo, los padres de los psicóticos son tratados por éstos como los objetos terroríficos de la infancia y alternativamente como los depositarios eternos de la simbiosis del otro. La red de interacciones familiares puede ser entendida como el resultado de un entrecruzamiento de aspectos primitivos transferenciales, de cada uno de los miembros sobre los demás. Esta situación mantenida como un sistema patológico en homeostasis conspira permanentemente contra el crecimiento y la maduración de cada uno de los miembros haciendo sumamente difícil la progresión de alguno de ellos por separado.

Los mecanismos simbióticos profundos que unen a la madre del esquizofrénico con su hijo, se disolverán sólo cuando en el proceso de desarrollo yoico al alcance no sólo al hijo sino también a la madre, quien podrá mediante su propio recrecimiento encontrarse con su propia vida, perdiendo el temor a que el crecimiento del hijo la lleve a la depresión y a las vivencias de muerte que experimentó con sus propios progenitores.

Este recrecimiento de la madre en sus aspectos personales como mujer por ejemplo no es independiente de la mejoría sustancial de la relación de pareja y la revalorización de sus aspectos femeninos.

Como decíamos anteriormente, antes de llegar a etapas elaborativas como las descritas, nos las veremos con todos los recursos defensivos que estas personas instrumentarán para evitar las percepciones conscientes de situaciones dolorosas tales como duelos tempranos, abandonos precoces, agresiones traumáticas, seducciones, etc., que componen la historia

de tales familias. En este sentido es interesante puntualizar que si bien se ha señalado el aspecto o función socializadora de la familia, su rol de agente reproductor y de crianza y otras funciones complejas, no se ha tomado en cuenta suficientemente que en la familia es donde aprendemos a regular las emociones, las descargas de afectos o las complejas regulaciones de cargas afectivas.

El psicoanálisis se ha ocupado de estos aspectos en la diada madre-hijo y en la situación edípica, pero es en la familia como estructura total donde se observa el despliegue de tales interjuegos con los que el terapeuta deberá lidiar como parte fundamental de su tarea. Freud había señalado que los cambios en psicoanálisis debían esperarse "a la alta temperatura de la transferencia". Creo personalmente que sin alta temperatura emocional no hay verdaderos "insights" productores de cambio; y en la terapia familiar esta temperatura transferencial no es lograda sólo con el analista sino con los miembros entre sí. El rol del terapeuta pasa pues por disolver una relación transferencial causante de sufrimiento y enfermedad que ya viene instalada en la familia y que es generadora de conflictos permanentes.

Concordantemente con esta hipótesis, los logros más importantes en familias se obtienen cuando tras difíciles procesos los hijos pueden visualizar a los padres como personas con historias reales, profundamente conflictivas, más que como objetos portadores de los deseos y fantasías infantiles proyectados en ellos y nunca resueltos. Correlativamente, cuando el proceso terapéutico de los padres es asimismo exitoso, pueden percibirse las verdaderas necesidades y deseos de los hijos, adecuados al momento evolutivo pertinente y acompañados con mayor disponibilidad emocional en sus propios crecimientos.

Llamo de "reconocimiento", a este proceso fundamental por el que el otro emerge como persona real de sus investiduras transferenciales, y por el que los hijos empiezan a ver a sus padres en una dimensión temporal, con una historia que ocurrió en el tiempo y que dejó sus rastros.

Este proceso es análogo al que ocurre en el tratamiento

individual cuando al disminuir la intensidad de la neurosis transferencial el analista es percibido más claramente como objeto externo real. En ambos casos coincide con desarrollos y fortalecimientos del yo que ya no necesita transferir desde estadios regresivos, ya que es capaz de funcionamientos más maduros y adecuados.

En una paciente de 30 años, con importantes desarrollos en lo que a su vida intelectual y profesional se refería, bloqueos severos de sus identificaciones materno-femeninas que le habían impedido logros emocionales en sus relaciones de pareja, comenzaron a movilizarse y resquebrajarse cuando pudo comprender que detrás de esa madre fría y abandonante a la que odiaba con rencor pertinaz se escondía una niña carenciada y vulnerable que nunca había desarrollado en ella misma sus capacidades y funciones maternas. La situación de cambio de la paciente en la terapia familiar fue sintetizada por ella misma al decir qué distinta se sentía y sentía a su madre cuando la pensaba como "enferma y no como mala": era sobre todo el tono emocional, reflexivo y triste que acompañaba estas expresiones, lo que reflejaba el cambio estructural.

Este cambio implicaba una modificación en la relación con su madre mala interna que dejaba de perseguirla y prohibirle la posibilidad de mejores experiencias e identificaciones.

La actitud emocional del terapeuta será tomada profundamente en cuenta por el sistema familiar, más que por la justeza o profundidad de su interpretación, será evaluada durante bastante tiempo la calidad de su respuesta emocional o la estimulación determinada que la constelación propone a cada instante.

De esta manera la familia "prueba" al terapeuta repetidamente en intentos de hacerlo participar en alguna configuración transferencial. Tendrá que ser padre que premia o castiga, juez severo, imparcial o corruptible, objeto de burlas, ataques, descalificaciones insidiosas u omnipotentes idealizaciones y esto durante el tiempo que le lleve a la familia y a cada uno de sus miembros emerger de las situaciones primitivas en las que esos mecanismos se desarrollan.

Espero ayudar al terapeuta individual y familiar a lidiar con

tales fenómenos que desde hace años hemos ido profundizando en la manera de operar de los equipos terapéuticos. Estos compuestos idealmente por todos aquellos que de un modo u otro están vinculados al proceso terapéutico del paciente se constituyen para el inconsciente del paciente y su familia en una red proyectiva sobre la que depositarán, como con los terapeutas individuales, toda una "ecología interna". Toda una "ecología interna" al decir de Pichon Rivière donde se buscará al mismo tiempo, reproducir y modificar, la estructura inconsciente de las relaciones familiares.

La investigación desarrollada supervisando equipos terapéuticos desde los años 1966-1968 demostró algunas hipótesis importantes:

1) Es probable analizar la interacción del equipo en términos de significantes del mundo interno del paciente y su familia.

2) Las proyecciones transferenciales se establecen con todo el equipo, no sólo con el analista individual, y no sólo por el paciente sino por toda la familia. Al convertirse el equipo en la "cabeza del paciente" sus miembros estarán expuestos a seguir las mismas vicisitudes que los objetos internos del psicótico.

3) El equipo terapéutico ofrecerá una alternativa de salud y modificación, sólo si es capaz de mantener adecuados procesos de pensamiento y simbolización, allí donde las ansiedades y actuaciones de la familia y el paciente intenten por vía de contraidentificaciones, incluir a los terapeutas en los sistemas patológicos.

4) El estudio detallado del accionar de los equipos terapéuticos permitió acuñar una clasificación provisoria en equipos psicóticos, neuróticos y psicopáticos, dentro de la operación más o menos iatrogénica y equipos sanos proveedores de crecimientos y desarrollos. Esta división es sólo con fines didácticos ya que es posible observar a lo largo de la vida de un

equipo terapéutico su pasaje por distintos estadios.

Dejo de lado en este momento la articulación más compleja equipo-institución aunque quiero dejar señalado que la potencialidad destructiva de la enfermedad por el cambio de las actuaciones contratransferenciales es lo que subyace a la mayoría de las crisis institucionales.

Los climas afectivos que señalé en las sesiones de familias, también se reproducen en las sesiones de los terapeutas. La posibilidad del "insight" que éstos desarrollos permiten la elaboración de los conflictos grupales intra-equipos y su transformación en crisis de crecimiento que facilitan el aprendizaje y la implementación de nuevas estrategias y modalidades terapéuticas.

Sólo el equipo que se cura podrá curar a otros. Y esto es especialmente cierto para la psicosis.

Del mismo modo, son los padres que crecen y se desarrollan a través de las vicisitudes del decurso vital, los que pueden ayudar a sus hijos a iniciarse en el mismo camino.

Resumen

El autor intenta en el comienzo del trabajo, precisar el campo de la "experiencia clínica" tal como se le presenta al terapeuta que trabaja en el ámbito de una Comunidad Terapéutica Psicoanalítica. Se contempla el alto nivel de información, directa e indirecta, sobre distintos pacientes y sus familias, que permiten la coterapia y el trabajo en equipo.

Se establece la diferenciación entre la experiencia clínica directa en el trabajo con pacientes, de aquella elaborada ya en cierto nivel, a través de Ateneos Clínicos, reuniones de evaluación, etcétera.

Las interacciones en Comunidad Terapéutica hacen que las evaluaciones clínicas dependan grandemente del grado de comunicación entre los terapeutas.

Se formula la hipótesis acerca de la posibilidad de comprender, a través de estudiar la dinámica y funcionamiento de un equipo terapéutico, estructuras complejas inconscientes del paciente y su familia. La interacción

entre los terapeutas puede leerse como una "radiografía" o "caja de resonancia" del mundo de relaciones objetales del paciente y sus familiares.

Se ejemplifica con el análisis de lo producido en la interacción de un equipo concreto que permitió detectar precozmente fantasías suicidas en una joven esquizofrénica y la elaboración de tales impulsos, favorecidos inconscientemente por amenazas de actuaciones familiares.

Se señala el "análisis transversal" de la experiencia; momento de elaboración que corresponde a cada operación terapéutica, que se corresponde con el "análisis longitudinal", ya que es posible seguir por períodos prolongados la evolución de un paciente y su familia.

El autor describe la organización en 1968 de estructuras terapéuticas denominadas "[microcomunidades]" que repetían en pequeños núcleos de pacientes y sus familias, las estructuras de las Reuniones de Comunidad. Las "microcomunidades" integradas por el equipo terapéutico interdisciplinario, comenzaron a integrarse con pacientes psicóticos y sus familiares, hasta 8 ó 10 familias, como evolución de lo que hasta ese momento había sido el tratamiento ortodoxo de pacientes psicóticos en grupo, siguiendo ideas de autores ingleses como Bion, Klein, Sigal, etcétera.

La clave para incluir familiares en el tratamiento de los pacientes psicóticos fue comprender el enorme potencial terapéutico que podrían tener las interacciones familiares múltiples.

Se ejemplifica con el material de una sesión, la movilización requerida en la madre de un paciente suicida, para ayudarla en los intensos bloqueos afectivos que padecía y que concurrían al fortalecimiento del impulso suicida del hijo.

Se señala en el trabajo los distintos fenómenos emocionales en que se verá inmerso el terapeuta. Se mencionan los siguientes sentimientos de fracaso, pérdidas o duelos inelaborables, fantasías agresivas y sexuales de todo tipo, a veces materializadas. Amores y deseos prohibidos por amenazas de castigos terribles y sádicos, muchas veces realmente ejecutados, forman parte del clima o transfondo emocional en que estas familias se vinculan. En función de estos elementos se describen funciones del terapeuta que concurren a hacer posible el comienzo del clima terapéutico.

Se describen procesos por los cuales las familias y los pacientes ponen permanentemente a prueba el vínculo terapéutico.

Se postulan como motivaciones de la enfermedad familiar la no elaboración de duelos primitivos y las carencias yoicas en el desarrollo de los padres.

Se contempla como posibilidad, la modificación de todo el sistema patológico familiar a través del desarrollo y crecimiento de cada uno de los

miembros del sistema, como única manera de disolver las simbiosis y dependencias más profundas.

Se señala la importancia del "aprendizaje de la regulación emocional" en la vida familiar, que se halla alterado en estas familias, y que debe darse en reaprendizajes o redesarrollos emocionales dentro del continente de la terapia familiar.

Se define como "reconocimiento" el proceso por el cual cada miembro de la familia puede tener una visión más realista del otro despojado de sus investiduras transferenciales.

Se destaca asimismo la percepción permanente que la familia hace del tipo de respuesta emocional del terapeuta, que comporta un intento ambivalente de introducirlo en el sistema, al tiempo que un intento de obtener una respuesta emocional diferente.

A partir de la idea del equipo como depositario de las relaciones objetales del paciente y su familia se verificaron las siguientes hipótesis superando sesiones de equipos tratantes entre 1966-1968:

- 1) Es posible analizar la interacción del equipo en términos de significantes del mundo interno del paciente y su familia.
- 2) Al establecer proyecciones transferenciales sobre todo el equipo éste funciona como "la mente del paciente". Sus miembros están expuestos a seguir las mismas vicisitudes que los objetos internos del psicótico.
- 3) El equipo terapéutico será una alternativa de salud y modificación sólo si es capaz de mantener adecuados procesos de pensamiento y simbolización, allí donde la familia intente, por vía de las conraidentificaciones, incluir a los terapeutas en el sistema patológico.
- 4) Las actitudes iatrogénicas de los equipos terapéuticos permiten clasificarlos en equipos psicóticos, neuróticos y psicopáticos, además de los equipos sanos que proveen condiciones de crecimiento y desarrollo.

División sólo desde lo didáctico ya que es posible observar a lo largo de la vida de un equipo, su pasaje por diferentes estadios y momentos. Los climas afectivos que se vivencian en las sesiones con las familias se reproducen en las sesiones entre terapeutas. Estos deberán transformar a través de sucesivos "insights", las crisis intraequipos en crisis de crecimiento. Sólo el equipo que se mejora a sí mismo, podrá ayudar a otros. Del mismo modo, son los padres que crecen y se desarrollan a través de las vicisitudes del decurso vital, los que pueden ayudar a sus hijos a iniciarse en el mismo camino.

Summary

The author attempts at the beginning of this paper, to delimit the field of the so-called "clinical experience" as it appears to the therapist who works in the Psicoanalytical Therapeutic Community. It is also viewed in mind the high level of direct and indirect information about different patients and their families which also allows to assemble the co-therapy techniques and the frame offered by the team work.

Interaction in therapeutic communities determines that clinical evolution mainly depend on the degree of communication among the therapists. A hypothesis on the possibility of understanding complex unconscious structures of the patient and his family through the study of the dynamics and functioning of the therapeutic team is put forward. The interaction among the therapists can be understood as an "x ray" or "resonance chamber" of the knot of the objectal relationships of the patient and his relatives. This is exemplified by the analysis of what happened in a group where suicidal fantasies in an esquizofrénic young girl were preconsciously detected and the impulses elaborated. The latter were favoured by family threats. It is pointed out the "transversal analysis" of the experience, moments of elaboration that correspond to each therapeutic operation, which is corresponded with the "longitudinal analysis" of the experience as it is possible to follow for long periods the therapeutic evolution of the patient and his family.

The author describes the organization of therapeutic structures called "micro-communities" in 1968, which with a small number of patients and their families repeated the structure of the meetings of the community. The "micro communities" made up by the therapeutic team, began to integrate with the psychotic patient and his relatives up to eight or ten families, as an evaluation of what had been up to that moment the orthodox group treatment of the psychotics, following the ideas of the English authors as Bion, Klein, Segal, and others. The clue to include the relatives in the treatment of the psychotic patients was to understand the enormous therapeutic potential that the multiple family interactions could have. The author can mention as an example the mobilization required to the mother of suicidal patient so as to help him in the acute affective blockade he suffered, which also helped him to strengthen his suicidal impulse.

It is also pointed out the different emotional phenomena in which the therapist would see himself immersed. The intense feelings of failure,

Acerca de los obstáculos para pensar la experiencia clínica con familias

JUAN CARLOS NOCETTI

Licenciado en Psicología – Miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar

Luis María Campos 317 – 2do. "B" – Buenos Aires, Argentina.

Para introducir este relato, un fragmento surgido de la pluma de un lúcido pensador de nuestro siglo: Gregory Bateson, que dice así:

“La proposición ‘Yo lo veo a Ud.’ o ‘Ud. me ve a mí’, es una proposición que contiene dentro de sí lo que yo llamo ‘epistemología’. Contiene en sí supuestos acerca de cómo obtenemos la información; de qué material está hecha la información y varias otras cosas . . . Trataré de mostrar que muchas de estas proposiciones resultan falsas, a pesar de que todos las compartimos. En el caso de esas proposiciones epistemológicas, no es fácil detectar el error y no es posible castigarlo de una manera rápida. Ustedes y yo estamos en condiciones de desempeñarnos en el mundo . . . y en general de funcionar razonablemente como seres humanos, a pesar del error muy profundo. Las premisas erróneas, de hecho, *funcionan bien*. Pero, desde otro punto de vista, las premisas dan

buenos resultados sólo hasta cierto límite; y en cierta etapa, y bajo ciertas circunstancias. . . " (1)

A las premisas erróneas que, de hecho, tienen éxito, voy a referirme en este artículo. Especialmente a dos de ellas.

Las que sustentan la traslación no crítica de conceptos útiles para pensar la práctica clínica individual o grupal al campo de las relaciones familiares, desconociendo las razones que definen su especificidad.

Las que permiten sostener que la única vía válida de acceso a este campo es la que ofrecen los modelos conductistas y pragmáticos, ignorando un siglo de producción psicoanalítica.

El trabajo estará dividido en dos partes. La primera estará dedicada al modo de dotar de sentido a la experiencia clínica con familias. La segunda a los obstáculos que es necesario encarar críticamente para pensar esa experiencia.

1. Acerca de la experiencia

Lamentablemente y pese a la opinión más sostenida por quienes se introducen en este terreno, me veo en la necesidad de afirmar que no se trata de tener experiencia, ni siquiera mucha experiencia, ni aún, muchas experiencias.

Repetir una y otra vez las mismas experiencias forma parte del destino inevitable de cualquier sistema más o menos vivo.

Porque también las familias tienen sus experiencias. A veces sumamente ricas y variadas, a veces insólitas, asombrosas, fascinantes. Ello no les impide, sin embargo, no saber cómo hacer para no repetirlas. Por eso algunas veces se animan a encarar la riesgosa experiencia de una consulta familiar.

Por supuesto, ellos no tienen obligación alguna de obtener algún nuevo conocimiento de esa experiencia. Ni siquiera de evitar que ella signifique para ellos una nueva repetición.

Porque no siempre los analistas toman en cuenta necesariamente esta característica fundante del sistema familiar: la repetición. A pesar de que, esto sí, forma parte de las obligaciones

y deberes inherentes a la función de todo analista: poner en palabras las condiciones de la repetición y dar lugar de este modo a la posibilidad de transformar repeticiones en conocimiento.

Esto es así en la medida en que no se trata fundamentalmente como analistas de tener experiencia, ni siquiera mucha experiencia, ni aún, muchas experiencias.

No. Se trata, tal vez, de ser capaces de *pensar* la experiencia.

Sin embargo, también los miembros de las familias piensan sus experiencias.

La familia Abbot (citada por Laing y Esterson) (4), pensaba que Maya, la hija, poseía "poderes mentales excepcionales" y que ello se ponía de manifiesto en la capacidad para leer el pensamiento de sus padres. Ella, por su parte, pensaba que éstos "inflúan sobre su mente". A consecuencia de todo esto, cada uno de ellos dedicaba buena parte de su tiempo a contrarrestar estas recíprocas influencias.

A pesar de todo, esta forma de pensar la experiencia no es peculiar de esta familia: una amplia bibliografía de moda, algunas películas y ciertas revistas de actualidad, compartirían este modo de pensarla.

Tampoco la familia de Viviana, tratada por Berenstein (2), deja de pensar sus experiencias. Viviana padecía una adicción a las anfetaminas. Ofrecieron dos explicaciones por esta situación: la más frecuente fue la falta de control por parte de los padres, que dejaban las anfetaminas al alcance de los hijos. Pensaban también que era una consecuencia del deseo de adelgazar propuesto por la madre, en franca oposición al padre que había prohibido la automedicación.

Si bien esta forma de pensar no ha evitado la perdurabilidad del problema ni ha arrojado luz alguna sobre las razones de su perpetuación, no deja de tener su fundamento. Pensar que los problemas actuales tienen su origen y explicación en el pasado y que existe una fuerte relación causal cuya dirección va de padres a hijos o de madre a hijo, es una forma bastante generalizada del pensar.

Y esto es importante señalarlo. Porque si, como analistas, sostenemos los mismos modos de pensar la experiencia que

las familias que tratamos, difícilmente podamos imaginar otros caminos que los de la repetición, tal como a ellas mismas les sucede.

Indudablemente, no se trata de tener experiencia, ni siquiera mucha experiencia, ni aún muchas experiencias. Pero, al parecer, tampoco basta con el hecho de pensarlas.

No, no se trata tan sólo de eso.

Porque nada significa la experiencia pensada sin las posibilidades de una crítica al modelo utilizado para pensarla. A las premisas epistemológicas que contienen.

Algunos pocos hombres, a lo largo del breve sendero recorrido en el mundo por el pensar, han sabido reflexionar acerca de la experiencia de un modo tal que su forma de pensarla ha marcado un surco lo suficientemente profundo como para guiar el trayecto hacia el conocimiento de varias generaciones posteriores: Parménides, Galileo, Newton, Kant, Frege, Einstein, Freud, son algunos de ellos.

Con todo, sus modelos son aproximados, falibles, siempre parciales. La experiencia se resiste a ser cabalmente pensada.

A veces podemos llegar a pensar que hemos logrado el modelo que permita dar cuenta cabal de la experiencia. Podemos entonces alcanzar la certeza de saber lo que se debe hacer con ella. Es más, podemos comenzar a pensar que sabemos lo que una familia deberá hacer con la suya.

Es entonces cuando nos decidimos con firmeza y convicción a orientarlas de una cierta manera y a dudar simultáneamente del saber psicoanalítico: comenzamos a dejar de ser psicoanalistas.

Porque ahora podemos saber de antemano qué es lo que una familia deberá hacer con sus experiencias y ofrecerles la receta segura de cómo realizarlo.

El método psicoanalítico impide esta vía. Impone limitaciones y no arbitrariamente.

Supone, por un lado, en el analista, la capacidad para tolerar el desconcierto y la de suspender la necesidad de dar una respuesta urgente que obture el desconocimiento. Además, por otro lado, por una razón constituyente de las posibilida-

des de acceso al conocimiento en su campo: sólo es después que la experiencia ha sido dotada de sentido cuando es posible decir algo acerca de ella, y sólo lo que de ella pueda pensarse, y del modo en que el modelo para pensarla lo permita. Así es como las teorías sexuales infantiles dan sentido a la experiencia de constatación de las diferencias sexuales anatómicas y la novela familiar a la diferencia generacional que impone la estructura del Edipo.

Una familia sabrá sólo después el destino de sus relaciones. Porque ellas no están fijadas por leyes inmutables y unívocos, sino por reglas que, por definición, incluyen aquellas que marcan los caminos posibles para la transgresión. Pero el camino recorrido sólo podrá saberse a posteriori.

Por razones que hacen pues a las reglas de constitución de su objeto de conocimiento y por los principios que rigen el modelo epistemológico para pensarlo, un analista se abstiene de dar consejos a los miembros de la familia. No posee modelo ideal alguno de funcionamiento para proponerles, no se dirige a la búsqueda de mojones evolutivos que aseguren la superación de "crisis vitales", ya que sus criterios de éxito se apoyan en razones que se desprenden del rigor de la teoría y no de la desaparición de los síntomas que motivaron la consulta.

Porque el modelo epistemológico que sostiene su acción afirma que —para la supervivencia de una teoría—, más valen los criterios de refutabilidad que las experiencias confirmatorias.

De aquí que no podamos saber qué haya otra forma de apurar el camino que cada familia deberá recorrer en el tránsito hacia el descubrimiento —de lo que podrá llegar a descubrir en el transcurso de un tratamiento—, que prestar atención flotante al curso de su devenir. Devenir en el cual el analista se encontrará siempre comprometido en un contexto paradójico en el cual, para colaborar en la resolución de un conflicto no podrá sino participar en su perpetuación. Porque es éste el supuesto de todo tratamiento analítico familiar posible.

Para que estas articulaciones entre la teoría y la práctica de las relaciones familiares puedan ser profundizadas, pasaremos a la segunda parte de este trabajo.

II. Acerca de los obstáculos para pensar la experiencia clínica con familias

La técnica psicoanalítica es el producto de un modelo teórico apropiado para pensar una clase particular de fenómenos. Modelo cuyas premisas epistemológicas básicas son hoy compartidas por otros desarrollos teóricos que alcanzan tanto a la física como a la filosofía, a la biología como a las ciencias sociales (6).

Estos principios han surgido de la necesidad de dar respuesta a errores epistemológicos que habían conducido a diferentes disciplinas científicas a callejones sin salida y obligaron a cuestionar sus mismos fundamentos. Para poder definir esos errores fue menester considerar algunos obstáculos que obstruían las posibilidades de comprensión y, por lo tanto, impedían el desarrollo de técnicas teóricamente fundadas.

A estos obstáculos quisiera referirme. Son obstáculos que he ido recogiendo de mi propio trabajo y del de aquellos que me propusieron supervisar su tarea clínica con parejas o familias. De las prematuras deserciones que sufrían, de las dificultades que tenían para comprender las familias que trataban y de mis propias dificultades para comprender sus dificultades, surgió la posibilidad de ir definiendo estos obstáculos.

El espacio conquistado por el pensamiento freudiano a la irracionalidad, la insignificancia, la intencionalidad, el biologismo y la omnipotencia queda, merced a estos obstáculos no reconocidos, cubierto por una maleza de conceptos y prejuicios provenientes de la aplicación de modelos evolucionistas y organicistas. Modelos más aptos para pensar las organizaciones biológicas que para desentrañar los universos semióticos que el

psicoanálisis había logrado dotar de eficacia y que Bateson y su equipo de Palo Alto colaboraron, en parte, en enriquecer.

Es posible de este modo definir cinco obstáculos que se interponen en nuestro trabajo.

Se trata, en primer lugar, de la *concepción atomista* que obliga a pensar la familia a partir de la desarticulación de sus elementos. De la *cosificación del orden determinante* que conduce a confundir el plano de la determinación con el de las manifestaciones empíricas. De la *visión voluntarista* que hace de los fenómenos de conciencia un universo cerrado y completo. Del *obstáculo objetivista* que, al desconocer la insuficiencia radical de pensar la relación sujeto-objeto bajo la forma de una interioridad óptica (3), impide pensar la oposición familia-analista bajo la forma de una interioridad cuya constitución está determinada por un conjunto de constricciones. Y, finalmente, de la *seducción fenoménica* que produce inexorablemente el relato de los acontecimientos familiares cuando no se los puede pensar desde una teoría pragmática de la enunciación (7).

Para que podamos contar con algún referente de estos obstáculos, transcribiré el fragmento de un trabajo anterior que contiene un trozo de sesión.

"Mary (la esposa de Juan) había sido internada, luego de un intento de suicidio. El analista los cita a una entrevista conjunta y dirigiéndose a la esposa les dice: 'le pedí que baje (de la sala) porque no quiero verlos separados, sino como lo que son, una familia, con líos pero juntos, mi intención es verlos juntos.

Juan: Usted el martes dijo que quería vernos separados.

Analista: Separarlos del todo, Ud. con otro médico y la Sra. con otro, pero es difícil por las características del hospital, prefiero verlos juntos."

"Intención loable, ¿quién puede objetar el deseo de volver a reunir a dos que han pensado en separarse? Quizá no sea necesario en estos casos preguntarse de dónde provienen las intenciones: ¿del deseo de Mary, del de

Juan, o tal vez, de la propia historia personal del analista?"

"La sesión continúa. Ambos cónyuges se reprochan infidelidades y malos tratos. Mary acusa a su marido de poner obstáculos a la visita de los hijos:

Mary: (al analista) desde que estoy aquí nunca me trajo a los hijos . . .

Analista (a Juan): ¿por qué no los trae? . . . (ante el silencio insiste) ¿por qué no deja que los hijos la visiten?

Juan: porque no soy de salir con los chicos.

Analista: ésta no es una respuesta.

Mary: no pongás excusas . . . Agarrala a Alicia y los traés.

Juan: y vos, ¿por qué no fuiste a verlos a casa?

Mary: porque el doctor me dijo que no podía salir.

Analista: (insiste) ¿por qué no trae a los hijos?

Juan: Ud. piensa que es una venganza, pero yo le digo que no.

Analista: pero, ¿no ve que está sufriendo? Es muy doloroso para ella.

Juan: y lo que ella me hizo a mí, ¿no es doloroso, no es una vergüenza?

Analista: no sé si es una vergüenza, es un estado. Ud. no sale nunca con sus hijos, ¿qué clase de padre es Ud.?

Juan: yo trabajo, pero igual me hago tiempo para jugar con ellos.

Analista: es que también hay que salir a pasear . . .

Quiero poner en claro nuevamente que no voy a hacer el papel de juez, a pesar de sus esfuerzos, yo no lo admito, no es ése mi papel".

"Es claro, se había propuesto verlos juntos pero, por lo visto, sólo puede ver las deficiencias de Juan".

"¿Por qué no admitir el papel de juez? ¿Acaso no lo está ya juzgando?, ¿Sería pertinente cuestionarse acerca de la

paradoja que plantea la contradicción entre sus intenciones y el sentido de sus acciones?"

Veamos ahora cómo los cinco obstáculos se entrelazan en un conjunto de errores mutuamente implicados que impiden una adecuada articulación teoría-práctica en el campo de las relaciones familiares.

1. Epistemológicamente, el primer obstáculo a encarar es el que presenta la *concepción atomista*. Ella permite suponer que es posible dar cuenta del conjunto a partir de sus elementos. La comprensión de la familia aparece entonces como el resultado de la acumulación de conocimientos obtenidos de cada uno de los miembros.

Este modo de pensar suele traducirse bajo la forma de una definición del sistema familiar realizada a partir de la adición de aparatos psíquicos, o de una concepción de la familia toda al modo de un aparato psíquico. Se acuñan así conceptos tales como "pareja sado-masoquista", "defensas familiares", "pareja narcisista". O se apela al recurso de arribar al diagnóstico familiar a partir de los rasgos de carácter de cada uno de sus integrantes.

Al proponer el *principio de intercambio* como fundante del orden familiar, la concepción atomista puede ofrecer una brecha por donde introducir la noción de *sistema familiar*. Permite pensar más en las relaciones que el intercambio impone que en las entidades necesarias para que ese intercambio se realice.

Y es el principio de intercambio el que permite articular el concepto teórico de sistema con la norma técnica que eleva a "por lo menos dos", es decir, *una relación*, el número mínimo de integrantes de una familia para la realización de una sesión familiar. Norma técnica que impide entrevistar a los miembros de una familia por separado cuando se trata de un tratamiento familiar.

2. A partir de los trabajos de la psicología de la Gestalt

—por no citar sino uno de sus antecedentes—, es imposible afirmar que el conjunto no es más que la suma de sus partes cuando se trata de variables no extensivas. Para referirnos a este *más* del conjunto debemos apelar a otro orden que trasciende a sus unidades, orden que no puede alcanzarse sólo a partir de ellas. Para lograrlo es necesario reflexionar acerca de un segundo obstáculo.

Porque el pensar puede equivocar su sendero tratando de hallar ese orden en algún miembro privilegiado del grupo. Surgen así hipótesis relativas a algún “chivo emisario” o, de mayor gravedad aún en cuanto a sus efectos, a una supuesta “madre esquizofrénica”. Desde allí, un miembro del grupo familiar pasa a formar parte del orden determinante y el resto al orden de los efectos.

Como le sucede al analista del ejemplo cuando define la conducta de Juan como causa de los padecimientos de su esposa.

Es que la cosificación del orden determinante obliga a encontrar un cuerpo material, una substancia tridimensional, un objeto hueco para alojar en su interior la causa del fenómeno.

Sólo de este modo es posible pensar en un encuentro, frente a frente, con el padre concreto de las fantasías inconscientes de un hijo. O con aquel pariente que alguna vez intentó buscar Freud como referente espacial y cronológicamente ubicable de las seducciones infantiles que poblaban los relatos de sus pacientes. De esta manera el largo proceso de reflexión que condujo a Freud a detener esta búsqueda y desentenderse de su primera teoría traumática, queda, ipso facto, fuera de lugar.

La crítica a la cosificación del orden determinante puede ser realizada cuando estamos en condiciones de oponer al orden empírico, el orden teórico, inferido a partir de aquél y producido de acuerdo a principios epistemológicos que permiten estudiar los “modos de organización” de los conjuntos observados. Ellos representan el orden, o, en otros términos, la entropía negativa, del sistema. El concepto teórico de *estructura inconsciente*, hace referencia a ese orden.

La estructura inconsciente apela a un orden diferente en el plano de las determinaciones, la *eficacia simbólica* que corres-

ponde a un orden semiótico. Aquella eficacia que, mediante el pasaje a una formulación verbal permite vivir, bajo una forma ordenada e inteligible una experiencia que, informada o informable, se manifiesta anárquica e inefable (5).

De aquí que las personas y las conductas manifiestas observadas en las sesiones pasan a ser efectos de un orden determinante que compromete al sentido. Las acciones pierden su valor explicativo para dejar lugar al orden del lenguaje, a la palabra.

De este modo es posible articular el concepto teórico de estructura inconsciente con el *objetivo de un tratamiento familiar*. Sobre todo en la medida en que este objetivo deberá ahora tender a jerarquizar en las sesiones y en oposición a las técnicas de “movilización” y de acción, el poder de la reflexión, el conocimiento, la palabra.

3. Una vez vislumbrados estos dos obstáculos podemos encarar un tercero: la *visión voluntarista* que, al mismo tiempo que permite apelar a la buena voluntad de Juan para comprender la situación en la que se encuentra Mary, borra de un plumazo los conocimientos más irrefutables acumulados durante casi un siglo de pensamiento psicoanalítico.

Porque desde aquí se deslizan insensiblemente dos modos de concebir la producción familiar.

O bien se supone que los miembros de la familia han llegado a las situaciones por las que consultan debido a una alarmante ingenuidad y desubicación frente a los problemas cotidianos, lo cual los conduce, obviamente, a encararlos de una manera equivocada.

O bien, se los supone dotados de una sutil y esterilizante picardía y malevolencia, siempre al acecho para trampearlos, engañarnos y sacar partido de nuestra buena voluntad.

En el primero de los casos, la función del analista se reduce —como en el caso del ejemplo— a aplicar el relato al sentido común. Será suficiente apelar a ese claro saber de la experiencia vivida —aunque no siempre bien pensada— para reorientar a la familia, desorientada por su inexplicada torpeza, hacia el correcto camino.

En el segundo caso, se recurrirá al desarrollo de estrategias más sofisticadas aún que las que se supone pone en práctica la familia. Estrategias que permitirían desplegar de manera sutil, subrepticia, subliminal, las más complicadas técnicas de persuasión.

Ambas concepciones producen en las sesiones o bien un conjunto de "sanos" consejos —como el de recordar a un padre su obligación de salir a pasear con sus hijos—, o bien una serie de instrucciones de "alto poder movilizador", dirigidos siempre a voluntades engañosas con el desinteresado interés de guiarlas hacia el "buen camino".

No resulta difícil percibir que esas producciones son consecuencia de las mismas premisas que otorgaban —en su tiempo— una personalidad caprichosa, ingenua, malévola, o portadora de una tara ingénita a aquella persona que podía ser definida como "histérica". Mucho esfuerzo le demandó a Ana O. convencer a Breuer y a Freud de la falta de estas premisas. Pero, claro, el esfuerzo por escucharla tampoco fue vano. Condujo al descubrimiento de una nueva manera de pensar los hechos humanos que el rebrote voluntarista en el campo de las relaciones familiares, parece pasar por alto.

¿Qué otras condiciones determinantes que mala voluntad o deseo de venganza pueden explicar la conducta manifiesta de Juan? Si no hay respuesta para esta pregunta tendremos que apelar a su "conciencia moral" y recordarle sus olvidados deberes de padre para transformar su mala voluntad en arrepentimiento. Pero esta transformación arrastra otra, una no buscada transformación de papeles: de buen analista en mal juez.

Es necesario reconocer que la supervivencia de un sistema se juega en la *reproducción de sus condiciones esenciales de existencia* para que pueda producirse un descentramiento capaz de encarar críticamente la visión voluntarista. Porque esa reproducción se produce más allá de la voluntad de sus integrantes, obligándolos —sin que lo sepan— a la perpetuación de sus conflictos y a la ignorada repetición de un sistema de relaciones.

Y es esta necesaria reproducción la que permite articular

los conceptos teóricos de sistema familiar y estructura inconsciente con las reglas técnicas que apelan a la *neutralidad* y la *abstinencia* del analista, cuando trata familias.

4. Sentado esto estaremos en condiciones de meditar sobre una cuarta fuente de obstáculos a la comprensión de las relaciones familiares: el *obstáculo objetivista*, que afirma una asimetría no funcional sino óptica entre analista y familia.

Esta distancia pasa por alto —y más grave aún para el desarrollo del conocimiento—, impide repensar en este campo todo aquello que acerca de la repetición en la sesión, el psicoanálisis ha logrado hacernos saber.

Porque la sesión se organiza también como un sistema de intercambio, sujeto a constricciones que escapan al control de sus integrantes. La relación familia-analista no está sólo determinada por las variables formales que la definen.

Si podemos sostener que la supervivencia de las relaciones familiares se juega en la reproducción de sus condiciones esenciales de existencia, debiéramos esperar que esas condiciones serán también reproducidas en las sesiones. Aun cuando ahora incluirán la presencia del analista y sus propias condiciones de existencia.

Aparece aquí definida una oposición: condiciones de existencia del analista versus condiciones de existencia en las relaciones familiares. El juego de esta oposición define las condiciones de supervivencia de un tratamiento, pero ella se resuelven en paradoja. Porque aquellas condiciones familiares de existencia se oponen —por su carácter conservador— a todo intento de transformación y definen por lo tanto la intervención del analista como una fuente de perturbación. Pero ellas son —al mismo tiempo y por vía de su reproducción— la única condición de análisis posible y, por lo tanto, la sola posibilidad de supervivencia del analista y su operación.

Es el obstáculo objetivista que sustenta las certezas de nuestro analista: él sabe que puede confiar en sus intenciones manifiestas y no en las de Juan, sabe cuáles deben ser las respuestas, qué clase de padre es Juan; él ve claramente el dolor de

Mary que Juan —no importa preguntarse por qué— no puede ver.

Es esta certeza de saber y ver lo que define el lugar de quien puede —y tal vez debe— decirle a Juan que “también hay que salir a pasear”. Todo esto lo sabe y lo ve sin ninguna duda. Pero esa visión y ese saber no le permiten entrever lo que un analista debiera preocuparse de ver y saber: que cuando neutralidad y abstinencia no forman parte de su bagaje teórico puede —sin percibirlo— colaborar en la reproducción de las condiciones de una repetición. Sin poder tomar conocimiento de ello ha estado validando la continuidad de un circuito inacabable de reproches y autorreproches, el mismo circuito que ha traído a esta pareja al tratamiento.

Es el concepto de *repetición*— sobre el que habrá que trabajar aún— el que permite introducir la crítica al obstáculo objetivista. El pivote que articula los conceptos teóricos de sistema familiar y estructura inconsciente con la definición de la *función de un analista de familias*. Básicamente aquella que hace a su posibilidad de poner en palabras las condiciones de reproducción de un sistema familiar— y con ello las de una repetición—, para dar lugar a la posibilidad de transformar repetición en conocimiento. La única objetividad posible es la que se apoya en esta repetición, repetición en la cual el analista no puede dejar de estar comprometido.

5. He de referirme por último al primero de los obstáculos que debieran ser encarados en las supervisiones: la seducción que produce el relato que los miembros de una familia hacen de los hechos de sus vidas.

Atraído por la luminosidad del hecho relatado —“desde que estoy aquí nunca me trajo a los hijos...”—, el analista toma inmediato partido por él sin poder vislumbrar que esa luminosidad es sólo el efecto del juego que entre opacidad y transparencia hace posible la verosimilitud del relato. Transparencia que, al mismo tiempo que vela las transformaciones que median entre un acontecimiento y su relato, da pie a la expectativa de encontrar en el relato a los hechos mismos.

Creemos poder encontrar en un discurso —por efecto de la transparencia—, la tridimensionalidad sustancial del hecho. (7) (9).

Para evitar esta engañosa seducción debiéramos prestar al relato que una familia hace de los acontecimientos de su vida, la misma distraída atención que Freud prestara al relato de un sueño en una sesión.

La seducción fenoménica puede ser sometida a reflexión en la medida en que opongamos a la *transparencia* del lenguaje su *opacidad*. Opacidad que al mismo tiempo que remite a las condiciones de producción de un discurso, permite articular los conceptos teóricos de sistema familiar y estructura inconsciente con la regla técnica de la *atención flotante*. Ella hace posible rescatar en la sesión la intrincada relación entre opacidad y transparencia que soporta el sentido manifiesto de un relato familiar.

III. Conclusiones

Hemos estado reflexionando acerca de las premisas epistemológicas contenidas en los modelos que solemos utilizar para pensar la experiencia. Su probada eficacia no parece criterio suficiente para liberarla del error.

La constatación de los límites de su validez nos condujo a la formulación de cinco obstáculos que impiden pensar las condiciones específicas de la experiencia clínica con familias.

Esos obstáculos pueden ser objeto de crítica a partir de la producción de conceptos que pongan en tela de juicio las premisas que sostienen su supervivencia. Ellos nos han servido para articular términos centrales de la teoría psicoanalítico-estructural de las relaciones familiares —de elevado nivel de abstracción— con términos que hacen referencia a la práctica clínica.

De este modo al proponer el *principio de intercambio* como fundante del orden familiar, el *obstáculo atomista* ofreció una brecha para introducir el concepto fundamental de *sistema*; y al mismo tiempo articular este concepto teórico

con la norma técnica que impone la presencia de *por lo menos una relación familiar* para la realización de una sesión.

La constatación de una *eficacia simbólica* permitió evitar la *cosificación del orden determinante* y articular el concepto fundamental de *estructura inconsciente* con el *objetivo del tratamiento familiar*.

El reconocimiento de la *reproducción de las condiciones esenciales de existencia* del sistema familiar como soporte de su supervivencia permitió descentrar la *visión voluntarista* y articular los conceptos fundamentales con la regla técnica que apela a la *neutralidad* y la *abstinencia* del analista de familias.

Al rescatar el valor y el sentido de la *repetición* en la sesión, el *obstáculo objetivista* pierde su eficacia y los conceptos teóricos centrales pueden ser articulados con las normas técnicas que definen la *función de un analista de familias*.

Por último, la relación entre *transparencia* y *opacidad* del lenguaje permite someter a reflexión el obstáculo que produce la *seducción fenoménica* del relato manifiesto y articular simultáneamente los conceptos centrales con la regla técnica de la *atención flotante*.

No resulta fácil eludir —en las sesiones— la tentación de elegir la huella que conduce a estos obstáculos. Muchas veces, y aún sabiéndolo, sólo después percibimos que nuestras falsas premisas nos han trampeado una vez más.

Sólo la clara convicción de que ganaremos en comprensión y operatividad puede ayudarnos a no caer en el fácil recurso de aplicar al contexto de las relaciones familiares los conceptos que resultaron útiles para explicar la constitución y el funcionamiento del aparato psíquico. Traslación que conducirá a reducirlos a conceptos meramente descriptivos y a empobrecer la realidad que se pretende explicar. (8)

Cuando podemos pensar que el psicoanálisis —además de una teoría del aparato psíquico— es una máquina de producir conocimientos científicos, esta limitación no tiene por qué implicar la caída en modelos conductistas —que difícilmente sobrepasan simples analogías naturalistas— ni en concepciones pragmáticas que se agotan en la mera eficacia adaptativa.

Bibliografía

1. BATESON, Gregory; Pasos hacia una ecología de la mente. Ed. Carlos Lohlé. Bs. As., 1976.
2. BERENSTEIN, Isidoro: Familia y enfermedad mental. Paidós, Bs. As., 1976.
3. HEIDEGGER, Martín: el ser y el tiempo. F.C.E., México, 1968.
4. LAING, R. D. y ESTERSON, A.: Cordura, locura y familia. F.C.E., México, 1967.
5. LEVI-STRAUSS, Claude: Antropología Estructural. EUDEBA, Bs. As., 1968.
6. NOCETTI, Juan Carlos: La organización de las relaciones familiares. Revista Terapia Familiar. Año I, N° 1, 1978, Editorial ACE, Bs. As.
7. — —: Teoría y práctica del tratamiento de parejas. Presentado en el IV Congreso Argentino de Psicología. Rosario, 1980.
8. — —: "El concepto de narcisismo y su relación con una teoría psicoanalítica de las relaciones familiares". Trabajo leído en la Escuela Argentina de Psicoterapia. 1980.
9. SERCOVICH, Armando: El discurso, el psiquismo y el registro imaginario. Nueva Visión. Bs. As., 1977.

Familias como sistemas adaptativos complejos

DANIEL GIACOMODONATO y MONA WEISSMARK

*Hahnemann Medical College & Hospital – Department of Family Therapy.
Miembros del Equipo de Terapia Familiar del Albert Einstein Medical Center.
York and Tabor Roads, Philadelphia, PA 19141
Department of Child Psychiatry*

*I have worked to practice living
in the world of truth instead of
the world of epistemological
fantasy; but I don't think I
have succeeded.*

Gregory Bateson

El fuego descansa cambiando.

Heráclito.

La evolución de la Terapia Familiar desde 1950 hasta el presente muestra que durante estas tres décadas la metáfora sistémica aplicada a las familias, la cual pone énfasis en los conceptos de homeostasis y equilibrio, ha sido uno de los principales modelos utilizados en el mencionado campo científico.

Los terapeutas de familia han tomado demasiado literalmente la idea de homeostasis, conceptualizando la familia como una "máquina" homeostática. Esto condujo al uso de expresiones tales como: "El síntoma sirve una función homeostática en la familia" o "La familia necesita el síntoma". El uso de este lenguaje refleja un error epistemológico en el pensamiento sis-

* Deseamos agradecer al Prof. Israel Zwerling, M.D., Ph. D., por su estímulo y asistencia en nuestro trabajo.

témico o, mejor expresado en las palabras de Bateson, "represente un corte (chop up) en la ecología.

Nosotros creemos que los modelos de equilibrio mecánico y homeostático, que han predominado en la mayor parte de las modernas teorías utilizadas en terapia familiar, están demostrando su relativa utilidad.

Dichos modelos no son aplicables si nuestra meta es, entre otras, conceptualizar:

1. Regulaciones dinámicas que se producen dentro de un sistema funcionando como un todo.
2. Actividades espontáneas tales como: repentinos cambios bruscos, "saltos" en la evolución.
3. Procesos cuya finalidad es la evolución hacia niveles superiores de complejidad.
4. Procesos de crecimiento, creatividad y desarrollo.

Las familias son un notable ejemplo de entidades que cambian a través del tiempo. Una propiedad que los sistemas familiares comparten con otros sistemas complejos es que dichos sistemas no cambian en forma llana y continua, sino a través de "saltos" discontinuos.

El físico belga Illya Prigogine lo expresa diciendo:

"En un punto en el tiempo, el sistema funciona en una forma particular, con fluctuaciones alrededor de dicho punto. Esta forma particular de funcionamiento posee un rango de estabilidad dentro del cual las fluctuaciones son "amortiguadas" y el sistema permanece más o menos con la misma estructura.

Cuando una fluctuación es amplificada, si ésta excede el rango de "estabilidad", el sistema puede comenzar a oscilar dentro de un nuevo rango de funcionamiento.

En este concepto, al cual Prigogine llama "orden a través de fluctuaciones", él enfatiza la idea de cambio discontinuo en lugar de homeostasis.

Los conceptos de continuidad, paridad, reversibilidad, equi-

librio y homeostasis son derivados de una actitud estética, la cual prefiere el Ser y la constancia en lugar del cambio y el devenir. Esta actitud se remonta a las ideas de Parménides y Zenón de Elea. Opuestamente, Heráclito enfatizó lo que transita en lugar de lo estacionario. Su filosofía está orientada hacia procesos, rehusando sacrificar la realidad en beneficio de la lógica comprehensibilidad o la perfección estética.

En nuestro modo, el énfasis es puesto sobre procesos en el sistema que tienden hacia su propia organización y hacia nuevos estados evolutivos, en lugar de procesos que tienden hacia el estado de equilibrio. En la teoría de René Thom (catástrofes) los sistemas vivientes tienden a establecer ciclos en los cuales ningún estado es estable, sino que la serie completa de estados resiste disturbios. Una catástrofe, en el amplio sentido que Thom le da al término, es una transición discontinua que ocurre cuando un sistema es capaz de alcanzar más de un estado estable. La catástrofe es el salto de un estado a otro.

Estos saltos jerárquicos adquieren significado cuando son observados en la interacción entre las diferentes jerarquías de un sistema (sub-sistema-supra). Los actos de crecimiento jerárquico no pueden ser deducidos de la pequeña estructura subsistémica; éstos deben ser evaluados en el todo.

Este punto de vista está basado en las ideas de David Bohm, un físico nuclear, quien describió un "proceso metafísico" en el que el Universo no debe ser entendido como compuesto de "cosas" sino como una compleja jerarquía de flujos, en los cuales las "cosas" son las que mantienen las características del flujo. Una moderna forma de expresar el pensamiento de Heráclito, "Todo es flujo o fuego."

Durante el curso del proceso evolutivo existen niveles de estabilidad y niveles de cambio en un determinado punto en el tiempo. Acorde con un punto de vista evolutivo, el sistema familiar se mueve hacia el futuro y a pesar de que aparece como estático, existe siempre la posibilidad de una pequeña fluctuación la cual va a conducir a una mayor amplificación, la cual va a inducir un salto a una nueva estructura. Si la familia es capaz de "sobrevivir" cambios críticos (internos y externos)

ella lo hace a través de constantes cambios en su estructura.

Bateson describe estos dos niveles en su comparación entre epigénesis y evolución diciendo:

“En contraste con epigénesis y tautología, las cuales constituyen el mundo de la replicación, existe un reino constituido por creatividad, aprendizaje, arte y evolución en el cual el proceso de cambio se “alimenta” al azar. La esencia de la epigénesis es repetición predecible, la esencia del aprendizaje y la evolución es exploración y cambio”.

Un sistema familiar adaptativo puede ser conceptualizado como una serie o sucesión de inestabilidades.

Una importante característica de este desarrollo evolutivo es el carácter de proceso como un todo; cada vez que el sistema alcanza un punto de inestabilidad, éste, irreversiblemente se desarrolla hacia una nueva organización funcional. Además, éstos “jumps” sólo pueden ocurrir en un determinado momento después de comenzado el proceso. En otras palabras, el sistema posee un tiempo de “reacción” asociado a sus propias características internas.

Platt afirma que la historia natural de estos saltos o bruscas transformaciones usualmente poseen la siguiente estructura:

1. Los saltos están siempre precedidos por la introducción de nueva información (inputs) en el sistema, a la cual Platt designa con el nombre de “disonancia cognitiva”.

2. Existe una acumulación de información que no concuerda con las “viejas” predicciones del sistema y que a su vez el sistema cataloga como error.

3. Pasado un tiempo, la “confrontación” con el “viejo” mapa juega un rol fundamental, y como reacción el sistema propone “reconciliaciones” entre lo “nuevo” y lo “viejo”.

4. Por último, bruscamente se produce una simplificación juntamente con una circular conexión entre los distintos “bits” de información, dejando como resultado una clara interrelación.

entre los distintos “trozos” de información, y una sensación de alivio en el sistema.

Este proceso se desarrolla en el tiempo, y la extensión de éste varía con cada sistema en particular.

Desde un punto de vista terapéutico, el proceso detallado concuerda con las conceptualizaciones del equipo de Milán, quienes aseveran que la construcción de una hipótesis sistémica se basa en la interconexión circular de los diferentes “bits” de información recogidos en forma neutral. Esto conduce a una precisa intervención, la cual acorta enormemente el tiempo que de otra manera la familia necesitaría para cambiar de estructura. Selvini y colaboradores explican que no obstante la precisión de la intervención, existe un tiempo necesario para que se produzca el cambio, y este tiempo es característico de cada sistema.

Cuando la organización interna de un sistema adaptativo adquiere patentes que le permiten discriminar, actuar y modificar las posibilidades y restricciones del medio (suprasistema), podemos decir que el sistema ha efectuado un “mapeo” de determinadas partes del medio (posibilidades y restricciones) dentro de su organización, como estructura y/o información.

Un sistema en estado de desequilibrio, el cual no es fundamentalmente homeostático, no necesita elevar el nivel de entropía. En tales sistemas en desequilibrio, existe una tendencia hacia niveles superiores de organización. La familia continuamente modifica sus “patterns” y su estructura con el objeto de alcanzar fines negentrópicos. Wiener expresa esta idea diciendo “Su presente es diferente a su pasado y su futuro es diferente a su presente.” En el sistema familiar, la exacta repetición es absolutamente imposible. En contraste con la Segunda Ley de la Termodinámica, los sistemas adaptativos se mantienen en estados improbables y preservan su orden a pesar de que sufren un continuo e irreversible proceso hacia el desarrollo.

Un sistema es el “self-organizing” cuando es capaz, no sólo de mantener una estructura, sino cuando también es capaz de elaborarla y cambiarla. Desde un punto de vista informacional este sistema funciona a través de conexiones y circuitos cam-

biantes constantemente, regulados por información acumulada (pasado) y corriente (presente). Por consiguiente, la respuesta del sistema no es explicada completamente en términos de los "inputs" actuales ni en base a circuitos preformados (pasado), sino a través de la integración de información derivada del presente y pasado, cuyos "inputs" provocaron un "output" específico.

Otra importante característica de los sistemas "self-organizing" es que no son creados con la capacidad de organizarse. Debe existir un grado de "preorganización" que le permita interactuar los primeros ciclos. A través de estas interacciones se generará la información que será acumulada para organizar futuros ciclos. Un sistema familiar se transforma en self-organizing a través de su operación como sistema. La información obtenida y acumulada en ciclos previos proveen la base para la organización de "inputs" y "outputs" en una manera diferente a la organización inicial del sistema.

La capacidad de persistir a través de un cambio de estructura es la llamada adaptabilidad del sistema. Otra forma de expresar este concepto es diciendo que el sistema familiar se adapta a un medio fluctuante y cambiante desarrollando nuevas estructuras a través de un constante proceso de aprendizaje e innovación.

Aprendizaje e innovación implican información y comunicación. Comunicación implica restricciones. La presencia de organización en un sistema es equivalente a la existencia de restricciones en el espacio de posibilidades. Tan pronto como la relación entre dos entidades A y B es condicional con respecto a un valor C, la presencia de un componente organizativo es necesaria. Comunicación entre A y B necesariamente implica algunas restricciones. Si para un evento A todos los posibles eventos son factibles en B, esto significa que no existe comunicación entre A y B, pues no existen restricciones. Por consiguiente, el curso de un evento está sujeto a restricciones y puede ser explicado a través del análisis de éstas. Esta explicación, llamada cibernética, es siempre negativa, contrariamente a la explicación causal, que es siempre positiva.

Nosotros explicamos las conductas del sistema en términos cibernéticos. En primer lugar consideramos las posibilidades del sistema, o sea los hechos que podrían haber ocurrido, y luego preguntamos cuáles fueron las razones por las cuales estas alternativas no fueron seguidas, de manera que la conducta que estamos tratando de explicar fue el único evento que ocurrió. En este marco, causalidad es irrelevante, pues la explicación es hecha en base a la naturaleza de las restricciones.

El desarrollo y persistencia del sistema familiar depende de los procesos de estructuración, desestructuración y reestructuración que ocurren en diferentes grados en diferentes momentos en el tiempo.

Estructura vs. proceso:

Break the pattern which connects the items of learning and you necessarily destroy all quality.

Gregory Bateson

Una de las principales razones que explican la dificultad en conceptualizar procesos con la misma claridad que hemos conseguido en el análisis de estructuras en Terapia Familiar, ha sido el uso de una antigua presuposición que opera implícita y explícitamente. Es una creencia casi-generalizada que los sistemas familiares tienden a mantenerse en equilibrio a menos que:

1. Sean disturbados por el impacto de una fuerza externa.
2. Se desarrollen "conflictos" dentro del sistema.

Luego, nosotros terapeutas, nos concentramos en encontrar de qué manera puede ser restaurado estepreciado y "equilibrado" (sano) equilibrio.

Si, opuestamente, nuestra presuposición es que las tendencias básicas de los sistemas familiares son hacia el cambio, inmediatamente comprenderemos que el solo uso de conceptos estructurales es equivalente a la arbitraria detención de un film con

el objeto de estudiar los "patterns" de una sola de las fotografías.

Un análisis procesual pone énfasis en el problema de describir e interpretar el proceso corriente en el sistema, y las estructuras son vistas como intersecciones, en un particular tiempo y espacio, de un grupo de procesos que incluyen constantes cambios en lugar de movimientos hacia estados de equilibrio.

Siguiendo nuestro marco teórico, los conceptos de estructura y procesos deben estar integrados en un análisis de diferentes niveles lógicos. Acorde con este modelo, partiremos desde una determinada estructura o tipología y estudiaremos el o los procesos que generaron las diferencias sumariadas en la tipología. El próximo paso será desde los procesos a una tipología de procesos o sea a una clasificación de ellos, y así sucesivamente.

En los sistemas familiares, estructura es sólo una relativa estabilidad de "microprocesos" corrientes. La unidad de análisis dinámico es una matriz sistémica de interacciones, y dicha matriz genera no sólo estructuras sino también procesos. De hecho, ambos están íntimamente relacionados y sólo son separables analíticamente.

Estructura es una construcción teórica, cuyo referente es sólo observable, o mejor dicho inferible, del proceso de interacción. Proceso incluye las acciones e interacciones de los componentes del sistema, dentro del cual, variados grados de estructuración se forman, persisten, se disuelven o cambian.

Desde el punto de vista procesual, nos preguntamos cómo una estructura es creada, mantenida y cambiada. Observado desde este ángulo, un sistema familiar es un continuo proceso morfogénico.

Finalmente queremos subrayar algunos conceptos importantes dentro de este modelo.

1. Neutralidad del síntoma:

Son conocidas las connotaciones positivas y negativas del síntoma. Ambas connotaciones están basadas en una forma de pensamiento lineal causalista. En su lugar podemos con

ceptualizar al síntoma como un circuito dentro del sistema que tiende a una nueva organización.

2. Impredictibilidad:

Debemos abandonar nuestro énfasis en las "metas" de la terapia, ofreciendo más alternativas a la familia. Creemos que la familia puede encontrar mejores "soluciones" de las que nosotros podemos brindar.

3. Inestabilidad:

Los sistemas familiares son conceptualizados como oscilando entre los estados de inestabilidad e intermedios estados de relativa rigidez.

4. Abandono de la idea de "resistencia":

Dell señala que "el sistema no se resiste, éste sólo se comporta de acuerdo con su propia coherencia. La idea de que la familia posee "resistencias" que son la expresión de las tendencias homeostáticas es no sólo totalmente lineal sino que también funciona como principio explicativo.

Bateson nos ofrece una bella diferenciación entre hipótesis y principio explicativo en uno de sus metáforas.

Hija: Papá, ¿un principio explicativo es lo mismo que una hipótesis?

Padre: Casi, pero no del todo. Verás: una hipótesis trata de explicar algo particular, pero un principio explicativo —como la gravedad o el instinto— no explica realmente nada. Es una especie de acuerdo convencional entre los científicos para no pasar más allá de cierto punto en su intento de explicar las cosas."

La clasificación o tipificación de una familia con el rótulo de "resistente" nos parece inadecuada e irrelevante si no va acompañada por una detallada descripción de los procesos que generaron tal categorización.

5. Orientación en la búsqueda de nada:

Cuando un terapeuta familiar comienza una sesión, él no sabe qué va a encontrar o qué información podría ser relevante en cada caso en particular. El no puede encontrar algo completamente desconocido. Por consiguiente es útil que él espere cualquier cosa en general pero nada en particular. De hecho, es sumamente peligroso permanecer en la búsqueda de nada. Cuando las preguntas e hipótesis no son explícitamente formuladas no significa que ellas no existen. Ellas pueden estar escondidas. La hipótesis no formulada es la más perjudicial de todas. Por consiguiente, se necesita mucho conocimiento y experiencia para permanecer en la búsqueda de nada.

6. Orientación en la búsqueda de diferencias:

El terapeuta familiar debe permanecer en la búsqueda no de determinados procesos o estructuras, sino de diferencias y distinciones que revelen un proceso o estructura. Cuando él encuentra estas diferencias, usualmente formula una hipótesis como punto de partida, luego de producido el hecho. En otras palabras, él descubre su orientación luego de que ha arribado.

La intención de este trabajo fue la formulación de un problema y no la presentación de una respuesta. Queremos recordar que la concepción de cualquier modelo es y será siempre un proceso aproximado.

Resumen

En este trabajo es delineada una nueva orientación epistemológica. Opuestamente a las ideas de homeostasis y equilibrio, la familia es conceptualizada como un sistema adaptativo complejo, cambiante constantemente en estructura y organización (self-organizing), y con la característica de que estos cambios se producen en forma de saltos discontinuos. El sistema familiar se adapta a un medio fluctuante y cambiante a través de un mapeo de determinadas partes del medio dentro de su organización. La explicación de las conductas del sistema son hechas en base

a las restricciones (restraints), en cuyo marco, la causalidad es irrelevante. Se analiza también el impacto de las ideas de homeostasis y equilibrio en el estudio de estructuras y procesos en Terapia Familiar. Finalmente, se subrayan algunos puntos considerados importantes, tales como: neutralidad del síntoma, abandono de la idea de resistencia, impredecibilidad, búsqueda de diferencias, etc.

Summary:

The major assertion of the theory outlined here is that the family is a complex-adaptative system. We argue that the mechanical equilibrium model and the organismic homeostasis model of families, that have underlined most modern families theories have outlived their usefulness.

The family changes constantly in organization and structure (self-organizing), and these changes are produced in discontinuous jumps. The family adapts and acts on the fluctuations of the environment by developing a "map" of some parts of the suprasystem (variety and constraints) in its organization.

The explanation of the behaviors of the family system are made on the basis of the constraints, and within this framework causality is irrelevant. The impact of the ideas of homeostasis and equilibrium on the study of structures and processes are analyzed and compared to the complex-adaptive framework.

Finally, some important issues are underlined as: unpredictable change, neutrality of the symptom, change and structure, the steady-state, process vs. structure, etc.

We hope to present a new framework that was useful to researchers, clinicians and trainees for conceptualizing family systems.

Bibliografía

1. ASHBY, R.: "Principles of the Self - organizing Systems", Principles of Self-Organization. New York: Pergamon Press. 255-78. 1962, USA.
2. BATESON, G.: Steps to an ecology of mind, New York: Ballantine Books, 1972, USA.
3. BATESON, C.: Mind and Nature. N. York: Bantam Books, 1979, USA.

4. DELL, P., L'ABATE, L., SELVINI, M., WATZLAWICK, P.: "Some Irreverent thoughts on paradox." *Family Process*, 20: 37-51, March 1981, USA.
5. HAWTON, M.: "Essentials of a Self-organizing system". *Cybernetica*, Vol. XVIII, N° 2, 85-123, 1974, USA.
6. HOFFMAN, L.: "Foundations of Family Therapy". New York: Basic Books, 1981, USA.
7. MAY, R.: "Thresholds and break points in ecosystems with a multiplicity of stable states". *Nature*, Vol. 269, 471-77, 1977, USA.
8. PENMAN, R.: *Communication processes and relationships*, New York: Academic Press, 1980, USA.
9. PRIGOGINE, I., LEFEVER, R.: *Stability and Thermodynamics properties of dissipative structures*, 1972.
10. PRIGOGINE, I.: "Structure, dissipation and life". *Theoretical Biology and Physics*. Holland Publishing Co. Holland, 1969.
11. THOM, R.: *Structural Stability and morphogenesis*, Massachusetts: Cummings Publ. Co., 1975, USA.
12. VOGT, E.: "On the concepts of structure and process in Cultural Anthropology". *American Anthropologist*, 62, 19-31, 1960, USA.

Filiaciones e Hitos*

JACQUES RUDRAUF

Médico psicoanalista. 120, rue d'Assas - 75006 paris (Francia)

Traducción: Lic. Stella Maris Molina

El movimiento designado con el término Terapia Familiar parece hoy en vías de definirse como una identidad delimitada. ¿Qué sucederá en veinte o en cuarenta años? ¿Qué quedará de este particular entusiasmo, de ese sentimiento de pertenencia que suscita, precisamente bajo la forma de un movimiento? No abordaremos esta cuestión como la de un devenir lineal, ni aún por el gusto de la paradoja. El movimiento —desde el punto de donde puedo observarlo— me evoca más bien una estructura arremolinada, como la de un torbellino: hay mucho que decir aún sobre la estructura topológica y física de los remolinos. Una niña de seis años, fascinada por el giro aspirante y ruidoso de una pileta vaciándose, pregunta: "¿Por qué hace eso?" y antes de cualquier intento de respuesta: "Ah, comprendí, es como nosotros, cuando comemos dulces" ¡Le atribui-

* Originalmente publicación interna en la Asociación de Centros Médico-psicopedagógicos del Departamento de Val-de-Marne, agosto de 1980.

mos todo al niño!... Lógica del fantasma y de la identificación... canibalística.

Y la terapia familiar “¿por qué hace eso?” Todo está ahí, en esa disimetría semántica entre el “eso” que hace y el “eso” que es hecho, o que se hace. La terapia familiar hace movimiento, produce efectos. A favor o en contra, se está implicado en un movimiento.

Sucedió extrávagantemente, a partir de un estancamiento aparente. Para algunos fue como un hallazgo sin continuidad con lo que lo precedía, a imagen del descubrimiento epistemológico de esa niñita: “¡Comprendí, es como nosotros!” Para otros, estaba presente en su pensamiento y su práctica, como algo que, por decirlo así, surgía por sí mismo en el movimiento ya emprendido en su práctica como terapeuta o trabajador social. Pero aquí también verdaderamente no sin ruptura. Individualmente o en equipo, se encontraban aislados en esta manera de comprender su trabajo, buscando a menudo compañeros y no encontrándolos fácilmente, quizás por no haber percibido que, en un movimiento de torbellino, el “sentido giratorio” común no va para el mismo lado en todos. Y sin duda implicado también en una problemática identificatoria: ¿quién soy yo terapeuta, en una relación común a todos los miembros de una familia? ¿De quién tengo que ocuparme además del *paciente identificado*. Y cuando el movimiento y la difusión de las nuevas técnicas tomaron cuerpo suficientemente, para llegar a interrogarme sobre la legitimidad de todos los procedimientos que encontramos, y sobre la de su propia identidad: ¿terapeuta familiar sistémico o psicoterapeuta orientado hacia las relaciones familiares?

Voy a intentar algunos hitos conductores: un hilo rojo no alcanza para designar una policromía. La tarea se revela compleja y difícil: la genealogía de las terapias familiares no se reduce a la historia de algunos grupos tenores que hicieron escuela. Si el cambio teórico que aparentemente les es común se reduce fácilmente a un bosquejo bastante simple, a pesar de la rica diversidad de sus variantes, eso no significa que ese esquema agote las aplicaciones de lo que enuncia. No hay que con-

fundir los *términos* y los *conceptos* a que se refieren. Encontraremos numerosos ejemplos, tales como los términos de sistema, de linealidad o circularidad. El primero, y el más problemático sin duda, es el término de *terapia*. Según los principios de análisis semántico de Alfredo Korzybski, “la palabra no es la cosa”, y la primera precaución para entenderse consiste en interrogarse sobre la resonancia de los términos más corrientes en el discurso del que los pronuncia y del que los escucha: su *reacción semántica*. Los términos están a la vez *sobredefinidos* por *intención* o definición verbal, a causa de nuestra creencia en la definición, y *subdefinidos* —desesperadamente— por *extensión* de uso. Desde este simple punto de vista semántico, el término terapia se presta a todas las confusiones. Corremos el riesgo de quedar como en una balsa en alta mar y de tomar como brújula a la nube que pasa. Agregar el adjetivo “familiar” no elimina la ambigüedad. Pero como lo subrayaba el mismo Korzybski (1933) “descuidamos habitualmente considerar, o dejamos de apreciar el hecho de que un simple término nuevo estructuralmente importante puede conducir a una reestructuración global del lenguaje en el campo considerado”. (1)

Es precisamente lo que sucede con la introducción del término *sistema* como marca clave de identificación de la terapia familiar. Hablar de “terapia familiar sistémica” es en efecto introducir algo muy importante, de consecuencias teóricas y prácticas considerables. Pero decir que esta terapia familiar *es sistémica*, es al mismo tiempo introducir una presuposición de identidad entre los términos empleados, de identidad de estructura entre los términos y su significación. Ahora bien, este presupuesto de *identidad* es lo que Korzybski señala como fuente mayor de confusión semántica. Y por un curioso rebote el sentido de las palabras identidad e identificación es diametralmente opuesto en el léxico de Korzybski y en el de Freud y los freudianos.

Tendremos que volver a propósito del lugar crucial del concepto de identificación —en el sentido psicoanalítico del término— en la articulación epistemológica de los conceptos fundamentales en terapia familiar. Encontraremos en la misma encrucijada, buscando la genealogía epistemológica de las terapias fa-

miliares, y remontándonos a partir de la mayoría de los autores, a Gregory Bateson y por su canal la influencia directa de Korzybski y su semántica general.

Ningún sistema —escribía también Korzybski— no había sido nunca plenamente profundizado hasta las presuposiciones inconscientes que le son subyacentes” (2). ¿El término *inconsciente* despierta la misma “reacción semántica” en Korzybski y en Freud? Otra expresión del mismo problema, que se puede centrar en la diferencia entre explicitar e interpretar, y que nos remitirá a otras derivaciones genealógicas.

*

No nos sorprendamos si chocamos con cierta confusión en el umbral de este estudio. El objetivo es ambicioso, y el punto de partida lleno de oscuridad. No supondremos el problema resuelto ni el camino fácil. Con esta entrada en materia quise indicar a los lectores que mi propósito es epistemológico. Hubiera podido titularlo “hacia una crítica de los fundamentos de la terapia familiar”, con lo que esta referencia a Georges Politzer (3) implica al mismo tiempo el aspecto concreto, vivo, del juego de las interacciones en el drama humano. Avanzaremos sin esquivar los obstáculos, pero guiándonos constantemente por el diálogo con lo visible, lo audible, lo comunicable, en pocas palabras lo concreto de la práctica terapéutica con las familias. Las muestras de doble sentido y de oscuridad con las que hemos marcado los primeros jalones de nuestra marcha están ahí para alertar nuestra vigilancia crítica. Me dirijo a los lectores para que me prendan en flagrante delito con las mismas consecuencias que yo trato de denunciar y para que me adviertan.

No se puede tener origen sino en múltiples filiaciones. Es uno de los postulados de *la identidad*, en el sentido que cada uno sólo puede responder de la suya con un acto de nacimiento, encuentro de un árbol genealógico y una oficina de registro civil, aunque la genealogía se reduzca a la mención “padre y madre desconocidos” y el acta, por falta de pruebas, sea reemplazado por un *certificado supletorio*, es decir por la garantía de un tes-

timonio, que no testimonia otra cosa que una exigencia convencional: un *significante* por otro *significante*. Lo importante es poder presentar ante cualquier pedido un documento de identidad válido: “Hete aquí, ¿quién eres?”.

La *terapia familiar*, como tal, no escapa a esta exigencia. Una *revista de las Asociaciones Francoparlantes de Terapia Familiar* no podría excluirse. Soy testigo de ello.

Con este fin, voy a disponerme a esta tarea: señalar las filiaciones con las cuales se constituye el término mismo de *Terapia Familiar* que me parecen esenciales para su *identificación* y tratar de hacer lo mismo conmigo en tanto pertenezco —¿pero por qué rama y en nombre de qué legitimidad?— a la familia de terapeutas ligados a ese linaje.

Para clarificar el mensaje en tanto que implica —cualquiera lo sabe hoy— un metamensaje que tiende a definir un “tipo de relación”, señalo que me encontré implicado en el movimiento vertiginoso de las terapias familiares por haber estado todo el tiempo confrontado con los efectos de los diálogos a varias voces entre los enfermos o presentados como tales y sus familias, efectos que tomaron un lugar central en mis preocupaciones terapéuticas desde los años 50, para llegar a mi primera lectura de los trabajos de Palo Alto recién en 1967, con el artículo de J. Hochmann, entusiasmado al regreso de un viaje a California (4).

He dado cuenta del hallazgo de algunas experiencias impresionantes de resoluciones espontáneas crónicas: psicosis alucinatorias, alcoholismo rebelde, disturbios del comportamiento, etc., en publicaciones anteriores, que, como el artículo de J. Hochmann tampoco encontraron eco sino negativo en los medios psiquiátricos y psicoanalíticos que frecuentaba entonces (5).

La cuestión era tan aguda, y mi soledad aparente tan grande, que provocaron en mí un cambio radical de perspectivas y de vida profesional con este doble cable conductor: estudiar y hacer conocer las posibilidades del abordaje familiar en psiquiatría, psicoterapia y psicopedagogía, —inducir a mis colaboradores, comprometidos sobre todo en los impasses de la psiquiatría pública, médica y hospitalaria, a retroceder todo lo posible y a

considerar concretamente, en el juego de las interacciones familiares, lo que la mayoría parecía saber teóricamente, repitiendo después de Freud y sobre todo de Lacan que el aparato psíquico se constituye sobre el modo intersubjetivo, que el inconsciente es el discurso del Otro, etcétera. . .

Pero la psiquiatría pública, médica y hospitalaria posee dispositivos de regulación sistémica que no se dejan llevar sin feedbacks negativos a *cambios de tipo lógico*. Uno de esos dispositivos contribuye, al menos en Francia, a alimentar la tasa de morbilidad necesaria en el mantenimiento de los equipamientos sanitarios y sociales por medio de la separación administrativa radical entre psiquiatría del adulto y psiquiatría del niño. Yo aprendí a mis expensas, y sobre todo a las de numerosas personas confirmadas en su status de *enfermos psiquiátricos* que pretender atacar de frente este tipo de obstáculo, ponía de manifiesto sin más la inhabilidad de no tener en cuenta los poderosos mecanismos de la ecología y la homeostasis social.

Así es como se demostró la urgencia de la tarea de difundir las posibilidades para todo el que lo deseara. Como cualquier otro —cada uno a su manera y sin saber demasiado cómo, se inscribe en el movimiento (vertiginoso) de ideas aceptadas o rechazadas —yo me comprometí en actividades de seminario y de formación continua, desembocando sin saber bien cómo en numerosos encuentros concretados por la constitución de una Asociación Francesa de Terapia Familiar, que se encontró en una situación algo difícil por el hecho de la anterioridad cronológica de su declaración oficial sobre la de otras más importantes y más activas. Pero ¿cómo podría haberlo sabido nuestro pequeño grupo si ni siquiera se había hecho conocer como tal?

La A.F.T.F. llegó así a provocar diversos movimientos pero sobre todo en el sentido de feed-backs positivos, es decir amplificadores de los inputs y movilizadores de energía informada. Además del enriquecimiento de los encuentros, contribuyó activamente a poner a disposición de los lectores franceses la traducción de libros americanos y alemanes, precisamente los difundidos por las ediciones J. P. Delarge: Minuchin, Haley, Stierlin, Satir . . . Actualmente y por muchos otros canales, la bibliografía

en francés sobre terapia familiar es lo suficientemente rica como para que no sea más necesario, con fines de información y enseñanza, “leer por ustedes” los textos claves —aunque nos falten aún muchas referencias esenciales para la comprensión coherente del desarrollo de las ideas y de las prácticas. Ante todo pienso en el segundo volumen de Gregory Bateson: “Hacia una ecología del pensamiento”, siempre por aparecer “hacia fin de año”, o “al comienzo del próximo”, y que debe contener la traducción del artículo inicial del cual no es exagerado decir que *todo comenzó allí*: “Toward a theory of schizophrenia” por G. Bateson, Don D. Jackson, J. Haley y J. Weakland, 1956. La obra colectiva capital dirigida por Don D. Jackson: “The etiology of schizophrenia”, si pudiera sernos contado, disiparía muchas oscuridades. Se esperan también las obras de Murray Bowen, las de Ivan Boszormenyi-Nagy. Y debo reconocer que la elección del editor por hacer conocer a H. Stierlin y al movimiento que representa, de preferencia “La primera entrevista familiar” y además, “Del psicoanálisis a la terapia familiar” me deja epistemológicamente con hambre. Más cargado de significaciones y de consecuencias es la carencia de traducciones de L. Szondi —el padre del “inconsciente familiar”— y las de A. Korzybski anteriormente mencionado, cuya revista de Semántica General sin embargo publicó los primeros artículos de G. Bateson. Pero he nos aquí al fin de este preámbulo, comprometidos en los laberintos oscuros de nuestra genealogía. Encontrar la “palabra” de un laberinto, como dicen los matemáticos, presupone una exploración sin ideas preconcebidas. El hilo de Ariadna, aquí me parece bastante anudado. Tratemos de desenredarlo un poco.

*

Yo recomendaría de buen grado para este fin la lectura de “Crisol Familiar” de A. Napier y C. Whitaker, traducido recientemente por R. Laffont. Lectura vivaz, atrayente y cargada de optimismo, que me consoló del retraso que su aparición produjo a la de otra traducción, el “Peoplemaking” de Virginia Satir, de título intraducible, que salió de prensa bajo

el mismo título, de modo que el editor tuvo que inventar otro a último momento. Anécdota (6).

Napier y Whitaker dan en el tercer capítulo una síntesis sorprendente de la mutación terapéutica que los condujo del psicoanálisis a la terapia familiar, de Freud a Von Bertalanffy, del inconsciente intrapsíquico al desconocimiento interpersonal. ¿Cómo Freud pudo enneguercerse a tal punto que no vio que sus pacientes no estaban solos en el mundo? ¿Se renegará por lo tanto de la filiación freudiana? ¿Roma no construyó la Iglesia católica sobre la renegación de Pedro? ¿Yo, freudiano? Qué aberración, yo soy sistémico. . . Y puede cantar el gallo sin que me atormenten los remordimientos. Ya he puntuado, bajo la denominación de "efecto Sicard", los desconocimientos repetitivos, de generación en generación de la lección inaugural del Abate de la Espada: "Si queremos enseñar nuestro lenguaje a los sordomudos, debemos estudiar primero el suyo. . ." El desconocimiento es sin duda uno de los resortes necesarios a la transmisión de la información. Nada más vano y nocivo que la trivialidad de un "lo sabemos bien". Hace falta lo nuevo. Mi maestro Korzybski, siempre él, lo había expresado así: "Todo eso cae por su propio peso; un niño lo sabe". Tales palabras promueven reacciones semánticas muy eficaces para prevenir la adquisición de nuevas nociones. . . Es por eso que el descubrimiento de las evidencias es siempre tan difícil: implica numerosos factores semánticos de evaluación y nuevas maneras de pensar" (7).

El efecto se manifiesta amplificado cuando se trata de lo que nos parece hoy evidente y de lo cual constatamos retroactivamente el desconocimiento, sea en el otro, sea en nuestro pasado. Pienso que toda persona que superó el hiato lógico que parece oponer el abordaje psicoterapéutico intrapsíquico individual y el abordaje sistémico interaccional, conserva en su propio recuerdo el lamento de *no haber sabido entender lo que pasaba* con algún enfermo apresado en su diagnóstico en tanto "algo sucedía en otra escena", la escena familiar en este caso. "Pero Doctor, usted conoce a mi padre, ¿qué hubiera sido de él si no hubiera tenido su loquito?"

La *otra escena* freudiana no era sin embargo el grupo familiar real, era el sistema inconsciente de sus representantes-representativos introyectados. Edipo reinando sobre los personajes en conflicto permanente *en* el inconsciente, y renaciendo en acto a cada paso *en* la transferencia. Sin embargo no fue ayer que J. Lacan nos enseñó, machacó y martilló que ese "adentro" no podía entenderse topológicamente más que como un "afuera" a imagen de esas superficies vueltas sobre sí mismas en donde cara externa y cara interna, borde externo y borde interno se prolongan sin discontinuidad. Simple lectura de Freud verdaderamente, como lo puso bien en evidencia Jean Florence (8). Todo psicoanalista en sus referencias y su reverencia a Freud sabe que el aparato psíquico es *intersubjetivo* en su ser mismo, y que todo psicoanálisis es *en esencia interpersonal*. Freud escribe por ejemplo en "Psicología de las Masas y Análisis del Yo" (G. W. XIII, p. 73-74): "La oposición entre la psicología individual y la psicología social o colectiva que puede, a primera vista, parecer muy significativa, pierde mucha de su agudeza cuando se la examina de más cerca. Sin duda la primera tiene por objeto el hombre singular e investiga las vías por las cuales éste trata de alcanzar la satisfacción de sus requerimientos pulsionales, pero, en esta búsqueda, no llega sino raramente y en ciertas circunstancias excepcionales, a hacer abstracción de las relaciones existentes entre este individuo singular y los otros individuos. En la vida psíquica del hombre, el otro aparece siempre como modelo (Vorbild), como objeto (Objekt), como ayudante (Helfer) y como adversario (Gegner), y la psicología individual es por consiguiente desde el comienzo y al mismo tiempo una psicología social, en ese sentido amplio pero plenamente justificado de la palabra. . . En su actitud con respecto a los padres, a los hermanos y hermanas, a la persona amada, al amigo, al profesor y al médico, el individuo (der Einzelne) siempre soporta la influencia de una o de un número limitado de personas, cada una de las cuales adquirió una formidable importancia. (. . .) Nuestro postulado descansa sobre otras dos posibilidades: la primera, que la pulsión social no puede ser originaria ni irreductible; la segunda, que se puede encontrar en un círculo estre-

cho, como el de la familia, los comienzos de su formación". (Citado por J. Florence, O. C., p. 177-178).

Es sorprendente observar que en los primeros tiempos de sus indagaciones y descubrimientos, Freud se refería constantemente y explícitamente a las interacciones entre los diferentes personajes en esencia. El caso Dora (tratado en 1900 y publicado en 1905) es muy instructivo al respecto como lo ha mostrado notablemente el Dr. Neuburger (París) que presentó al Congreso de Zurich de 1979, una lectura en términos de sistemas y de prescripciones paradójales totalmente convincente. En ese caso Freud señala claramente cómo los síntomas de Dora son copados sobre rasgos particulares de los miembros de su constelación familiar y afectiva, y sobre todo cómo les son "dirigidos" en tanto verdaderos elementos tácticos destinados a actuar sobre ellos. Del mismo modo en el curso del análisis los sueños serán *dirigidos* a Freud mismo, permitiéndole la puesta en evidencia de las identificaciones y las repeticiones en el aquí y ahora de la relación transferencial.

En el último capítulo sobre la terapéutica semántica (PBP, p. 436) leemos igualmente este párrafo sobre el lugar del entorno real, familiar, presentado como una parte activa del proceso o sistema de resistencias opuestas a la elaboración terapéutica: "No hemos hablado hasta aquí más que de resistencias interiores: éstas, que nos son presentadas por el enfermo, son necesarias y superables. Pero hay también obstáculos exteriores: éstos se desprenden del medio en que vive el paciente, son creados por su entorno, sólo tienen *un débil interés teórico*, pero tienen una gran importancia práctica". (La traducción francesa va más lejos y dice: ... "no tienen ningún interés teórico"). Siguen varias páginas llenas de enredos vividos por Freud con las familias de sus pacientes, representados de manera unilateral, como obstáculos al movimiento terapéutico, en un compromiso tal que se puede percibir una piedra de toque lista para recibir los cimientos del edificio que precisamente debe hacer terapéuticos los abordajes psicoanalíticos donde el juego de las interacciones constituye el nudo mismo de la pregunta formulada al psicoanalista. No hay allí ninguna contradicción fundamental, sino un simple

cambio de centro óptico, de puntuación en el sentido de P. Watzlawick. Terapeutas de familias, no seamos tan ciegos con respecto al psicoanálisis y los freudianos como ellos pudieron serlo con nosotros. . . antes de que hubiéramos existido.

Todos los materiales necesarios para que tuviera lugar una intervención terapéutica en el sistema familiar estaban presentes explícitamente en el espíritu de Freud, como también le era familiar la teoría de los sistemas homeostáticos (Más allá del principio del placer) y la naturaleza no lineal de la lógica del aparato o sistema psíquico con sus subsistemas percibidos de manera diferente según la evolución de la "tópica" (Sistema percepción/conciencia. Inconsciente — Yo, Ello, Superyó). Es difícil no evocar aquí el mito de la caverna de Platón; lo que resta a saber es por qué fue tan difícil a Freud y a las generaciones de terapeutas formados en su escuela, autorizarse a desviar las miradas de la fascinación de las sombras proyectadas y a abrirse al diálogo a varias voces con esta "persona en plural" que es la realidad familiar. Pues es la familia, Papá, Mamá, Edipo y yo, lo que Freud describe con el término de "Realitat", y aún como *instancias intrapsíquicas* "introyectadas". Sin duda la misma pregunta dada vuelta vanamente como una superficie de Moebius, consiste en interrogarse acerca de por qué tantos terapeutas de referencias comportamentales y sistémicas dejan de percibir la herencia freudiana en su manera de aprehender dicha realidad.

Sin embargo son bien diferentes los discursos sobre el psicoanálisis y sobre la terapia familiar, y no se le escapa a nadie que *hacer* una terapia familiar es totalmente distinto a *hacer* una terapia psicoanalítica ("la cura tipo"). Del mismo modo que escribir una novela y ponerla en escena. La lectura de las novelas y las piezas de Pirandello, respectivamente sobre el mismo tema, no deja de instruirnos sobre los aspectos opuestos y complementarios de nuestro oficio. Siempre queda una trama esencial común. El problema n° 1, tanto para unos como para otros, es precisamente *hacer resaltar* lo que hay de único y esencial aquí y allá.

Con seguridad es la lección de Lacan lo que mejor permite

salir de la pseudocontradicción lógica entre los abordajes del *sujeto* singular y plural. No tengo la pretensión de hacer transparente esta proposición en pocas líneas. Lo será, pienso, para cualquiera que haya recibido la lección de Lacan: precisamente su lectura de Freud y la puesta en evidencia de la naturaleza significativa de todo lo que instituye y constituye al ser humano como sujeto.

Pero esto introduce una importante fuente de malentendidos. El recurso de Lacan a la teoría del lenguaje no sería un mensaje receptible para el que no tiene la misma *reacción semántica* que Lacan al término mismo de lenguaje. La obra de Lacan —sobre todo su artículo inaugural de 1938 sobre la familia y los complejos familiares— se origina en un contexto cultural, estético, humanista del París de entre dos guerras. Una época en que se sabía escuchar entre los sonidos y las palabras, entre el Pirandello de “Esta noche improvisamos” y de “Seis personajes en busca de autor”, de “A cada cual su verdad”, de “Encontrarse”, etc., el Dr. Eduardo Pichon, psicoanalista, médico de hospitales y co-autor de una gramática de la lengua francesa de siete grandes volúmenes, verdadero “psicoanálisis” de la lengua, dedicado a hacer consciente lo que se dice inconscientemente, Georges Politzer, ya citado por su lectura de la obra freudiana en términos escénicos y dramáticos (igualmente su revista de psicología concreta). En la misma época (que fue también la del Número de Oro de Matila Ghyka) el estético Pius Servien publicaba su tesis sobre “Lirismo y estructuras sonoras”, en donde por primera vez se enuncian verdades sobre la disyunción entre Lenguaje de las Ciencias y Lenguaje Lírico, en cinco puntos, idéntica a la diferencia entre lenguaje digital y lenguaje analógico, hoy familiar a nuestras orejas sistémicas y americanizadas. Extraigo lo siguiente para ilustrar el contenido de Lacan: “el lenguaje es sonido y signo. Es la primera clasificación que tuvimos que hacer. Una de las caras es signo, sentido, significación. La otra remite al dominio sonoro como la música (...). Ciertamente no hay en poesía, ni en música, obras hechas de sonidos, sino solamente de posibilidad de sonidos (...). No estaba escrito que Fedra tuviera única y necesaria-

mente la voz de la Señorita N... de la Comedia Francesa, como fue una noche...” (lc., p. 71-73, “El análisis del tejido lírico”).

Todas estas precauciones fueron para reintroducir un debate sobre el “reproche de linealidad” que se le hace al psicoanálisis, y por el hecho mismo de que se inscribe en el registro del lenguaje. Hago alusión a la posición (paradojal) que adopta Mara Selvini Palazzoli en su obra justamente célebre “Paradoja y Contraparadoja”. Felizmente, la autora nos deslumbró suficientemente con las brillantes volutas de su palabra para que no tomemos por letra cerrada y muerta su afirmación brutal de que “el lenguaje es lineal” y con él el psicoanálisis.

El lenguaje *es* tan poco “lineal” que se presta a todos los nudos de significación y sobre todo a los deslizamientos semánticos que suscita la linealidad de proposiciones como ésta: “el lenguaje es lineal”...

La disyunción no se encuentra tampoco entre *lenguaje verbal* y *lenguaje analógico*, sino entre lenguaje *digital* (que puede ser verbal o no verbal) y lenguaje *analógico* (que igualmente puede ser verbal o no verbal). Es otra disyunción establecida entre *linealidad* y *circularidad*. En ese caso el círculo, en cuanto gira en redondo y puede ser vicioso, no es la metáfora adecuada y nosotros preferimos los toros y nudos lacanianos. Todo lo que se puede decir —y es mucho— sobre esta circularidad introducida por el “pensamiento sistémico” es adecuadamente expresada —dicha y escrita por Mara Selvini— por el lenguaje verbal. Por otra parte la lógica no lineal encuentra una expresión matemática adecuada en lenguaje digital, y aún formalizado. En cambio, la cibernética emplea máquinas electrónicas “analógicas” cuyos elementos y características no digitales prescinden del lenguaje verbal, pero pueden ser íntegramente retraducidos en palabras o escritos. Parece que la cuestión debe estar en otra parte.

El lenguaje verbal, el *verbo*, la palabra, es esencialmente comunicación. Cada palabra, cada articulación del discurso implica una densidad semántica. Toda palabra toma sentido del feed-back del que la escucha, aunque sea del locutor mismo enredado en los doble-sentidos de su propio discurso.

El psicoanálisis desembosca esos doble-sentidos. Los sitúa

en el polo extremo opuesto al uso lineal de la lengua. Toda la obra de Freud está consagrada a hacer escuchar ese *discurso inconsciente* que vehiculiza nuestra palabra (notorios ejemplos en el lapsus y el chiste), a manifestar la no linealidad no sólo de toda palabra sino de todo comportamiento en tanto es comunicación: *significante*.

Es por eso que la cuestión planteada por M. Selvini, con su enunciado de rechazo de la linealidad marcada por "lenguaje verbal-psicoanálisis" (cuestión esencial) debe ser desprendida de la trampa de la linealidad misma. Lo que ella denuncia es un cierto esquema fijo del "psicoanálisis" y más generalmente del "lenguaje verbal". Puntuemos esta reacción semántica de la expresión "trampa lineal (Selvini, 1979)". Lo que desembosca es justamente lo que también Freud desemboscaba en el lapsus, en el chiste, el doble sentido de las palabras primitivas, a saber el círculo vicioso (bien "circular" aquí) de un pensamiento encajado en la relación sujeto-predicado tal como Korzybski (1933) lo denunciaba como sistema *aristotélico*. Sin embargo, raramente escuché discurso más evocador de la semántica general Korzybskiana que el de la Dra. Selvini. La puerta de salida del "círculo vicioso lineal" está en el escape a la reacción semántica sujeto-predicado, en provecho del despojamiento de los significantes de su riqueza, de su densidad semántica.

Cualquiera sea el nombre que se pretenda detentar para designar esa trampa (lo "lineal-verbal-en-el-sentido-de-Selvini"), se trata en afecto de una trampa temible, obstáculo mayor a la toma en consideración de lo que *circula* en círculos, volutas y nudos significantes en las relaciones humanas.

Sería caer en la trampa que se denuncia si nos quedamos en la palabra, y reducir el aporte freudiano a la terapia —aunque sea familiar— a una caricatura del psicoanálisis. Cuando eso se produce por azar —y no es el caso de la Dra. Selvini, pues todo el resto de su discurso lo demuestra— resulta un "impasse" epistemológico, no solamente para la aprehensión de lo que se trata en psicoanálisis, sino también para la *reflexión* ("auto-reflexividad") de la terapia sistémica familiar sobre sí misma en tanto ella se caricaturiza a sí misma por referencia especular

negativa a una caricatura de toda una parte de sus modelos. No se niega impunemente las grandes vías de su propia filiación. Debo precisar que la lectura de las obras de Mara Selvini Palazzoli, la escucha de sus seminarios y de sus conferencias deslumbra en mí al psicoanalista, fascinado por su arte de dominar transferencia y contratransferencia, de interpretar el sentido secreto y sin embargo evidente en cuanto lo percibe en las situaciones más incomprensibles para la mirada ciega de *no cándidos*.

Pero ¿por medio de qué a priori de connotación positiva justificaríamos al psicoanalista y al psicoanálisis por esta distorsión que constituye la paradoja de aislar al paciente de la escena en que se vive el juego interaccional cotidiano de sus síntomas? Es en efecto una paradoja, una prescripción paradójica propiamente dicha, instalar al paciente en un diván durante una interminable secuencia de sesiones al abrigo de los lugares de intercambios donde funcionan y se mantienen día tras día sus síntomas. La relación de exclusión así establecida puede en efecto, ser presentada con todo rigor como una "prescripción paradójica de terapia familiar sin la familia". La prescripción implica dos condiciones técnicas mayores: la exclusión *real* del entorno, la exclusión *simbólica* del psicoanalista en su rigurosa posición de neutralidad y de desligamiento personal. *Doble mensaje* movilizador que deja al paciente impedido de evitar el retorno con toda la fuerza de su dinámica familiar. El analista está allí para recibir y representar todas las peripecias del drama, de un modo resueltamente disfuncional cuya eficacia proviene sin duda de su carácter paradójico. La frontera interna del silencio, de la abstinencia y de la neutralidad abre la posibilidad —en el límite— de *decir todo*. La frontera externa con los "partenaires" familiares, limitada para el paciente a la duración de las sesiones, pero generalizada para el analista, abre a su vez otro modo de relación entre el paciente y los suyos, por el resto de su vida y con efecto retroactivo. Sería ilusorio creer que ese cambio de "relationship" es unilateral, pues los miembros de la familia están infaliblemente comprometidos en el proceso. Los efectos son tan diversos como constantes, de la descompensación patológica de un miembro hasta entonces

considerado sano y equilibrado a la curación "incomprensible" de otro, hasta ese momento cargado de síntomas, o más corrientemente transformaciones más sutiles, simple alivio vivenciado por todo el grupo, o malestar cuya consecuencia frecuente es "la entrada en análisis" del cónyuge o de un pariente cercano.

No hice más que proponer una lectura sistémica del acto psicoanalítico como tal. Sin duda sería prudente volver a una doble lectura, psicoanalítica para el psicoanálisis, sistémica para la terapia familiar.

*

Los lectores que tuvieron la gentileza de seguirme hasta aquí, no dejarán de preguntarse adónde quiero llegar. ¿Adónde queremos llegar todos con la terapia familiar, con la terapia en general, y con estas interrogaciones, y aún con estas querellas sobre sus fundamentos, sus hilos conductores, su genealogía, su evolución?

¿No es suficiente constatar que la introducción del sistema familiar como tal en la práctica terapéutica aporta cambios y ventajas tan evidentes, que conviene ante todo sacar todo el partido posible, elaborar y profundizar las técnicas?

Puede ser. Pero todas las dificultades reaparecen precisamente más allá de los capítulos introductorios que se vuelven monótonos en su claridad convincente.

¿En qué se compromete y en qué nos compromete la terapia familiar? Antes de comprometerse, es prudente examinar el terreno. Pero es forzoso constatar que este proyecto sólo puede ser retroactivo, pues en el momento de pensarlo, ya nos encontramos "en pleno adentro".

Es imposible no estar comprometido. Tal será mi primer axioma, previo según mi parecer al de Paul Watzlawick: "Es imposible no comunicarse".

El compromiso es ante todo terapéutico, es decir ético, práctico en el sentido kantiano. Hay que recordar aquí lo que yo llamaría el principio de anterioridad de lo práctico sobre lo

teórico, de lo axiológico sobre lo ontológico: sabemos que aún Descartes, en su deseo de apoyar la búsqueda de la verdad sobre bases que excluyeran la duda, no encontró otras pruebas de la existencia real del ser (las cosas y el mundo en general: ontología) más que la garantía "de un ser absolutamente perfecto" es decir un fundamento moral, ético, axiológico. Hemos aquí confrontados nuevamente con la dificultad de definir nuestros términos, aunque se trate de los más simples como *teórico* y *práctico*, y conducidos al precepto de Korzybski: "reemplacen el antiguo imperativo científico "definan sus términos" por "señalen sus términos indefinibles" ... Pongan sobre la mesa su metafísica, su estructura implícitamente admitida, y sólo entonces procedan a la definición de sus términos, en los términos de esos "términos indefinidos", términos que escapan esencialmente a la definición". (Science and Sanity, p. 155).

Hablar de compromiso terapéutico puede ser entendido en un sentido adaptativo, y quizás sobreadaptativo. Puede ser también en el sentido de la antipsiquiatría (Laing, Cooper, Esterson, primeros discípulos en Europa, que yo sepa, de G. Bateson y de los descubrimientos de Palo Alto, pero con una connotación manifiestamente negativa sobre la familia). Cualquier precaución que se tome en favor de la justa medida y de la neutralidad "es ya una toma de posición" marcada ideológicamente. Según el mecanismo sistémico general, toda medida tomada para contrarrestar el movimiento instaurado tiene todas las posibilidades de reforzar los efectos.

Las terapias familiares nacieron de la toma en cuenta de efectos al comienzo inesperados, *paradojales*, sobrevinientes como contra la corriente, si no en contradicción con el efecto de confirmación homeostática enunciado precedentemente. Para darles lugar en el arsenal terapéutico, había que "poner sobre la mesa nuestras estructuras implícitamente admitidas", aunque tuviéramos que desplazar la mirada del islote "enfermo-enfermedad" hacia el medio ecológico, el caldo de cultura que lo designaba como tal, incluyéndonos los psiquiatras, pues la familia no es lo único a considerar en este asunto. Jay Haley —uno de los maestros de la terapia sistémica fundada sobre la teoría de la

comunicación (9)— hace esta pregunta: ¿Qué hacía el psiquiatra en el momento en que el paciente se comportó de tal manera que el psiquiatra concluyó que deliraba?”

Difícil aquí no caer en una polémica. Es que existen relaciones recíprocas complejas —“circulares” y no “lineales”— entre los desarrollos teóricos y las opciones prácticas. Frente a las constataciones de cambio, cuyos ejemplos jalonan todas las publicaciones de terapia familiar, la teorización puede servir también como recurso tranquilizante contra la angustia del compromiso. La experiencia muestra habitualmente que hace falta una decisión valiente para *afrentar* a la familia como tal. El corolario de nuestro primer axioma hace eco aquí al corolario del axioma de Watzlawick: “es imposible tampoco comunicarse sin dificultad” —no se puede además comprometerse *libremente como uno quisiera*. ¿Cuestión de voluntad?... Heme aquí otra vez ante una de las primeras situaciones que contribuyeron a sacarme de la lógica médica: signo, causa, diagnóstico y tratamiento de... en provecho de la toma en cuenta de las interacciones familiares. En el hospital psiquiátrico de una provincia del Oeste, hacia 1960, el *delirium tremens* ocupaba un lugar de privilegio. Se curaba entonces brillantemente con dosis masivas de hígado liofilizado: ¿algo más puramente médico como terapia? A menudo se producían recidivas, algunos decían siempre no tener ninguna consciencia de los casos que no producían recidivas, pues, simplemente, no se los volvía a ver más. Enseguida eran olvidados. Pero había otra constante en los casos de recidivas: el escenario estereotipado de la visita de las familias: “Mire Doctor, lo que haría falta es que él tenga voluntad. Debería decírselo. Yo se lo dije, pero no me escucha”. Esas palabras aladas marcaban con una regularidad de reloj, el punto de giro entre otros dos discursos. El discurso anterior, vengador, estigmatizaba con el mismo oprobio el jirón humano, la bestia borracha, el padre indigno y el psiquiatra que lo había dejado salir de la prisión hospitalaria. El discurso siguiente, suplicante y reivindicativo, pedía o exigía la rápida salida: “El ya comprendió”, o simplemente “pero yo lo necesito, tiene que trabajar, ¿usted cree que puedo darle de comer a los niños

sin un peso?” aderezado con palabras vengativas si el psiquiatra refunfuñaba ante una salida precipitada.

Así me vino la idea, luego el hábito, contrario a los usos corrientes, de recibirlos juntos, de confrontarlos en encuentros tormentosos, reveladores precisamente de lo que llegó a aclarar luego la teorización sistémica, fuentes inesperadas pero incontables de efectos sorprendentes, evocando a veces más bien una especie de *conversión*, que el efecto de un tratamiento médico o de una psicoterapia.

La génesis de ese cambio no puede deslizarse en silencio en el marco de un tratado de detección de *hilos*, cordones y/o filia-ciones. En esa época mi bagaje intelectual percibía ciertamente importantes cambios de punto de vista con respecto a referencias psiquiátricas consideradas como clásicas. Puedo dar tres hitos:

- 1) el aporte de un punto de vista psicopedagógico y educativo, ligado a varios años de prácticas en el seno de una “república de adolescentes caracterópatas” ..., otro sistema ...;
- 2) el jalonamiento psicoanalítico bajo la doble referencia de D. Lagache y de J. Lacan;
- 3) la influencia ya profunda de la corriente szondiana centrada en la cuestión de las elecciones de destino: “cómo este hombre y esta mujer se eligieron”, y cómo su vida común en sus avatares, les permite negociar sus necesidades y aspiraciones pulsionales, cada uno por sí y recíprocamente, por el efecto de su presencia sobre el otro.

En otro artículo (10) estudié las relaciones complejas y profundas entre la terapia familiar y el análisis del destino. En el marco del presente trabajo no puedo hacer más que alusiones episódicas. Sobre todo volveremos a este tema a propósito de las investigaciones transgeneracionales.

El intermedio anecdótico precedente, nos lleva a las implicaciones del compromiso profesional inmediato. Si como rebote el descubrimiento de las terapias familiares contribuyó paradójicamente a excluirme del sector psiquiátrico público y hospitalario, no es más que un accidente de mi destino personal. En

todo caso no es mi objeto desviar a los terapeutas de la tarea terapéutica.

En el curso de los treinta últimos años, uno de los *leit motiv* de la psiquiatría pública en Francia consistió en el retorno aguijoneante de las discusiones sobre las relaciones entre función curativa y función de escucha —a tal punto que se constituyó una oposición semántica paradójal, de abundantes consecuencias entre *terapia* y *terapéutica*.

En muchos prestigiosos lugares de psiquiatría instituida, el psicoanálisis se vio promovido a un rango de referencia central. Se habló mucho de “terrorismo psicoanalítico”, y la relación, en equipo, entre analistas y no analistas fue a menudo sinónimo de relación de poder (*one up man ship* contra *one down man ship*: J. Haley, O. C.). La dialéctica del saber y del poder no entendía ya nada, pues no sabía más si había que deplorar la crasa ignorancia del poder frente al saber sutil de los iniciados, o prevenirse contra la coalición del saber y del poder en los silencios de los mismos iniciados...

¿Hace falta entonces ser “al menos psicoanalista” para asumir responsabilidades psiquiátricas? O bien, ¿puede hacerse aún psiquiatría cuando se es psicoanalista? Recomiendo estas fórmulas estereotipadas como trabajos prácticos de semántica general. Comiencen por el verbo *ser*. No deja de ser cierto que todos los derivados del término *terapia*, con toda su ambigüedad, conservan una implicación axiológica, y que más allá de las querellas bizantinas, hay que encontrar tiempo para ocuparse de las personas que incumben a nuestra intervención terapéutica como pacientes.

La incidencia de las novedades y paradojas aportadas por el movimiento de las terapias familiares, cuando se hace sentir en alguna parte, aporta algo nuevo. No ser psicoanalista no implica más, para los miembros del equipo terapéutico, reducirse a la organización asilar y a la psicofarmacología. Y supongo atravesada una larga espiral de nuestro pensamiento no lineal para volver enseguida al mismo dilema: el de las relaciones de mutualidad y de pseudomutualidad, de compatibilidad o de exclusión, de dependencia simétrica o complementaria, entre las

formaciones del terapeuta familiar y del psicoanalista, cuando están comprometidos en la lucha contra las enfermedades mentales.

Ahora bien, la experiencia muestra que un servicio de psiquiatría público puede ser transformado por la introducción de la terapia familiar, sin haber pasado por el diván psicoanalítico. Al menos hace falta una formación apropiada, larga y difícil, formación que no se ofrece en sí misma a todo agente terapéutico deseoso de adquirirla.

En cuanto a las relaciones entre formación en terapia familiar y filiaciones psicoanalíticas, ¿qué mejor que observarlas hoy a través del filtro sistémico? No podrían ser llevadas a un esquema de inclusión o de exclusión. Al menos se impone la tarea de abrir el conjunto del personal implicado en la acción sanitaria y social a la apertura del diálogo a varias veces, y esto va más allá de la especialidad psiquiátrica.

Pero ¿a quién pertenece ese rol, y cuáles son las consecuencias?

Las técnicas llamadas sistémicas y afines, se caracterizan a la vez por su extrema facilidad y por su extrema dificultad. No es una paradoja. Piensen en la facilidad que ofrece la televisión al espectador, y en la cabeza del mismo espectador delante del aparato desarmado, ofreciendo a la mirada el inextricable rompecabezas de su “sistema”...

La facilidad de uso de las técnicas recomendadas por los manuales de terapia familiar las convierte en armas temibles en las manos de aprendices de brujo. Más temibles aún entre las de hábiles manipuladores al servicio de una sociedad tecnocrática.

Su dificultad técnica es de otro orden. Yo no la veo en el recurso que hacen de la *técnica* audiovisual: grabación de videotapes, espejo unidireccional; sino en la problemática de las relaciones humanas que provocan.

Yo me permito hoy suponer dado el paso decisivo del terapeuta de autorizarse al diálogo plural, y suponer evitados los escollos de la moda, de la manipulación tecnocrática, de la comercialización sin escrúpulos y otras perversiones comunes a toda profesión del campo de la relación humana. Igualmente

había que dejarlo asentado.

Queda aún el encuentro terapéutico familiar en la diversidad indescriptible de sus modalidades concretas.

En encuentro terapéutico familiar es esencialmente una situación de la vida privada. El *grupo* se hace presente en toda clase de niveles estructurales, pero las cuestiones que se ventilan pertenecen a la intimidad de las personas que participan. En ocasión de jornadas de estudio o de congresos, por un lado animados por un hálito humanista innegable y apoyados en el imperativo categórico del respeto de la persona que implica inevitablemente la difusión pública de todo método tendiente a "reubicar al sujeto en su deseo". (Lacan), numerosos participantes caen en la angustia ética al ver difundir a un amplio auditorio —gracias sobre todo a la pantalla chica— los más secretos movimientos afectivos de una familia en plena confusión, aún cuando nada garantiza la ausencia en la sala de personas que puedan reconocerlos. Ciertamente, la misma cuestión de discreción fundamental se le plantea al más "individual" de los psicoanalistas, si quiere comunicar lo esencial de su experiencia.

A lo que aquí me refiero es menos a una puesta en guardia contra los desbordes profesionales, que a una puesta en evidencia del carácter esencialmente personal del proceso psicoterapéutico, aún el familiar.

Cuando Virginia Satir (11) nos enseña a escenificar el juego de roles en los ejercicios de formación en terapia familiar, puede señalar legítimamente la posibilidad de *intercambio de los roles*. Según la actitud corporal asignada a cada participante, cada uno puede adoptar a su vez la pose, es decir el rol del "censor", del "sometido", del "calculador", del "enloquecido"... En el trabajo casi educativo de ciertos estilos de terapia familiar, la manipulación hábil de los cambios de rol puede desembocar en las transformaciones sistémicas deseadas (Family Sculpting). En psicopatología, se encuentran numerosos ejemplos espontáneos, que confirman ese modelo, bajo la forma de intercambio de síntomas o de fenómenos de relevo, tal el caso de dos hermanos bien conocidos en un hospital psiquiátrico por internacio-

nes alternadas a causa de estados esquizofrénicos típicos, que sucedían en uno cuando remitían en el otro.

Si evidentemente los paradigmas sistémicos se aplican a la descripción de semejantes situaciones, eso no implica que agoten la interpretación en términos de *causalidad*. No extraen toda su fuerza sino de la dialéctica que los une, oponiéndolos, a la toma en consideración del poder inductor apremiante de ciertas personas, a menudo difícil de distinguir del poder inductor apremiante de ciertas texturas contextuales. Es banal observar que el alejamiento de un elemento inductor en un grupo favorece su rápido reemplazo por otro en un rol que restablece la homeostasis, se trate de un líder eficaz o de un factor de problemas. Sin embargo no es una constante. El adagio según el cual nadie es irremplazable es una caricatura mentirosa. Se dirá quizás que es una cuestión de persona.

Pero ¿qué se dijo al pronunciar la palabra *persona*? ¿Qué decía yo un poco antes subrayando el carácter *esencialmente personal* del proceso psicoterapéutico?

*

Lejos de mí la idea de restablecer no sé qué ideología personalista. Tomo la palabra *persona* en su acepción casi gramatical, volviendo a las referencias del comienzo de este artículo. Puesto que se trata de filiaciones e hitos*, no renegaré de mis orígenes. El primer curso de psicología que hice, en el primer año de mis estudios universitarios trataba, en boca de D. Lagache, de tres perspectivas conjugadas: "psicología en primera, tercera y segunda persona". La locución estaba inspirada en G. Politzer reconociendo en los escritos freudianos la entrada en escena del hombre concreto en una psicología hasta allí alejada de toda presencia viviente. Paralelamente remitía a Eduardo Pichon bajo la forma de un sujeto de disertación, como se decía en esa época: "significación psicológica de la distinción entre yo, me y mí".

* En el original "re-pères". La puntuación de la palabra "repères" (hitos) pone de manifiesto otra: "père" (padre) (N. del T.).

La familia en terapia, habla de "nosotros", de "uno" y de "ellos" antes de hablar de tú y de mí. En los grupos de formación en terapia familiar, se recomienda a cada uno hablar en su propio nombre, y decir *yo* mejor que *uno* que oculta la posición subjetiva en provecho de un supuesto consenso general. A decir verdad, no es el mismo "uno", "la expresión instrumental de la persona".

(Pichon) por el pronombre complejo *nous, uno*, indica claramente la posición de la familia como *sujeto*: en el sentido lacaniano, sí se desea que precise, pero no es para nada indispensable ser lacanizante ni lacanizado para seguirme. La persona así *señalada* no es más que uno de los significantes de "con quién tenemos que vernosla", y es por eso que puede hablar en singular o en plural, siempre como sujeto de su deseo.

El contrato terapéutico en terapia familiar es fundamentalmente idéntico a un contrato individual, y dominado por la referencia a "la persona como fin y no solamente como medio" (Kant). Pero ¿con quién establece el terapeuta el compromiso? Las paradojas de Russell no están de más para sacarnos de la situación. Por otra parte Lacan tanto como Korzybski y sus descendientes family-terapeutas comentaron ampliamente la lección. ¿Por qué no hablaríamos de la paradoja de la familia de las familias que no se contienen a sí mismas?

¿Qué definición, qué filtro lógico-matemático puede aplicar el terapeuta de familias a la interlocución de la segunda persona del singular o del plural? ¿El nombre del padre? ¿"Ustedes", los Smith, los Dupont?

Más allá del sistema familiar nuclear de las personas que viven cotidianamente juntas y reunidas en el famoso "aquí y ahora" de la sesión en la tradición sistémica, es a toda una línea, un sujeto vivo *transgeneracional* que el proceso terapéutico da la palabra. El admirable capítulo de Murray Bowen "Hacia la diferenciación de un Self en la propia familia" (12) precisa bien cómo no es solamente con el "sujeto transgeneracional" de la familia en terapia que tiene que trabajar sino con un sujeto plural ciertamente, pero que lo implica personalmente a él mismo y a su propia familia. Los desarrollos que aportaron un Ivan Bos-

zormenyi-Nagy y un Helm Stierlin reencuentran aquí la genealogía szondiana. La presencia viva y significativa de los portavoces de generaciones anteriores es la realidad misma del sujeto familiar.

Algunos terapeutas de familias utilizan también la técnica del *genograma* que consiste en establecer un árbol genealógico subjetivo, marcado con las apreciaciones espontáneas que evocan cada uno de los personajes, presentes o ausentes, vivos o "desaparecidos" en los participantes del grupo.

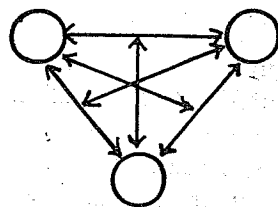
En psicoanálisis de niños, el árbol genealógico puede igualmente *representar* el camino hacia el descubrimiento de su identidad por el niño "golpeado" hasta en sus estructuras lógicas elementales (Nassif).

*

¿Es decir que no hay más que *significante*, aún gramatical (todo lenguaje, aún no verbal tiene su gramática) en la persona, y que ninguna otra cosa diferencia el *singular* del *plural*?

¿Los esquemas interaccionales están destinados, en cuanto a la exploración psicológica, a reemplazar a los de la profundización personal o individual? Luego del tratamiento que venimos a otorgarles, cada uno de sus términos quedó marcado con una ambigüedad tal, que la formulación de esta simple pregunta se vuelve en sí misma problemática. Lo que evoca está cargado de esta protesta emocional de alto tenor narcisístico: ¿el ser individual ya no es nada? ...

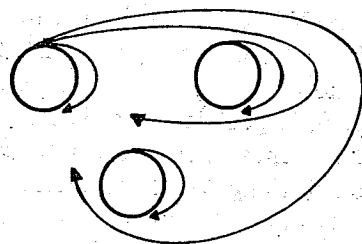
Es conveniente aquí examinar de más cerca los esquemas de la interacción a los cuales las publicaciones de terapia familiar nos han habituado. Nos comprometen a no considerar a los miembros de la familia como entidades aisladas, y que no entrarían en relación sino de uno a uno, en cambio a integrar en el mismo acto perceptivo, la posición de cada uno con respecto a los otros, y a las interacciones entre los otros. El esquema elemental se transforma en el triángulo así completado:



Este esquema es en efecto muy útil para llamar la atención de los terapeutas en formación sobre la estructura interaccional del grupo familiar, como por otra parte de todo grupo humano, con la facilidad que tiene para determinar las variantes en el seno de grupos más numerosos, y para inscribir con otras convenciones gráficas los aspectos estructurales funcionales y disfuncionales, vínculos o rechazos, rigidez o flexibilidad de las fronteras, alianzas, coaliciones, etc.

Pero deja deliberadamente sin figurar una de las características de toda relación humana: la *reflexibilidad*, es decir la relación consigo, inmediata o mediata, precisamente aquella que toda la psicología y la filosofía habían puesto hasta ese momento tan en primer plano que los aspectos interrelacionales quedaban borrados. La vieja psicología de la *consciencia* sabía ya que toda consciencia es *consciencia de sí*, y *consciencia para sí*, antes de darse cuenta que era *consciencia de* (algo). Que la consciencia tenga o no que tener lugar aquí como parámetro mayor, no es en este caso la dialéctica a la que me refiero. La misma estructura vale en términos de comportamiento.

El esquema precedente debe entonces completarse con las inscripciones siguientes (que no borran a las primeras):



Las nociones de narcisismo (primario y secundario), de relaciones especulares, de relaciones transitivas y mediatizadas, forman parte infaltablemente del equipamiento mental del terapeuta familiar. Pude sentir a menudo su alcance práctico inmediato en el momento mismo de proponer un abordaje familiar en ocasión de una demanda de intervención médico-psicopedagógica. Por ejemplo el caso de un portador de síntomas —llamémoslo Pierre— traído por sus dos padres, Jean y Paulette Dupont. Inmediatamente yo indico que quisiera verlos con los otros miembros de la familia. Ante la respuesta habitual “¿Por qué eso? ¿No tienen nada que ver!”, respondo de buen grado interrogando a Pierre sobre la identidad de las personas presentes, estableciendo la diferencia entre el Sr. Dupont, Jean y Papá, etc. Una vez constatado que Pierre de Papá no es exactamente el *mismo* que Pierre de Mamá, Pierre de los Padres, Pierre Dupont en la escuela, ... pone enseguida en evidencia que si sus hermanas Valérie y Nathalie no están presentes, yo no podría conocer de Pierre sino una parcela difícil de completar.

Nada es banal en este procedimiento en terapia familiar. Pero, el recurso directo a la reflexividad (relación de un elemento con él mismo en un conjunto) implica, me parece, la articulación fundamental que disuelve las antinomias entre abordaje individual y abordaje familiar en terapia.

Agreguemos también que si el conjunto considerado está constituido por seres humanos y no por entidades matemáticas, la relación reflexiva se diferencia en *relación con él mismo* y *relación consigo*.

¿Qué consideración particular, qué valor conviene acordar a la *relación consigo*? Es cuestión de apreciación, y no veo en qué criterio fundar la preferencia en la elección entre Jay Haley y Jacques Lacan. Por mi parte yo entro en contacto con *personas*, que según los casos, se presentan ante mí en un registro más o menos singular o más o menos plural. La familia como tal, tanto como cada uno de sus miembros, funciona con el modo de la reflexividad, de la relación consigo.

El único rasgo —y con qué consecuencia!— que distingue definitivamente el ser singular del ser plural, me parece ser la

relación con la muerte. La muerte es esencialmente singular, aunque para cada uno sean siempre el otro o los otros los que mueren. Freud y Heidegger deben figurar en el programa de formación en terapia familiar, puesto que todo trabajo psicoterapéutico es más que comparable a un trabajo de duelo. La familia está constituida tanto por sus muertos como por sus vivos, y los muertos no dejan de estar presentes en las sesiones. Pero la *muerte para sí* no aparece en absoluto en las sesiones familiares como lo hace en la especificidad de la experiencia psicoanalítica.

Por una u otra de sus caras, la del duelo y la del ser-para-la-muerte, la muerte es constitutiva del carácter temporal de la *duración* existencial.

Pero en cuanto tomamos por este camino se impone poner en nuestra perspectiva toda la dimensión de la relación con el propio cuerpo. El hecho de que la enfermedad de un miembro de la familia interese a todo el sistema familiar no significa evidentemente que implique a cada uno de la misma manera. La cuestión se aclara al considerar los efectos de una lesión cerebral cuando alcanza las integraciones corticales más elaboradas. C. Durieu en su libro sobre la reeducación de los afásicos mostró muy bien la extrema importancia de las personas cercanas en la restitución funcional del lenguaje (13).

Pero, una cosa es ser afásico y otra ser la mujer del afásico. En el cruce de lo intra y de lo interindividual será útil remitirse al libro de Gertrude Wyatt sobre la relación madre-hijo y la adquisición del lenguaje (14) y al sorprendente articulito de Mme. Raverdy Nozal sobre el nacimiento de un niño con una deformación en los miembros.

Así somos llevados a toda clase de preguntas concretas, cotidianas, que se imponen a la definición misma de las opciones terapéuticas. Cada uno responde y se compromete según sus propios criterios, producto de la red de sus disposiciones personales y del contexto socio-cultural donde se inscribe su trabajo. Por ejemplo, en cuanto a la duración de las terapias, ¿terapias sistémicas breves o profundizamiento sistemático a largo término?

Quizás no sea superfluo prevenir aquí otra confusión semán-

tica que tendería a identificar las posiciones "sistémicas" y "familiares" en terapia con la de las terapias breves, por oposición a la continuidad del psicoanálisis. En cuanto a cuestionar el valor terapéutico de las terapias breves, tendríamos que interrogarnos sobre ciertos efectos de fuego de paja, llameantes de euforia y de distensión sin futuro, e inversamente sobre otros efectos de inflexión radical que se producen al instante o fuera de tiempo. En ellos se inscribe también el riesgo de un cierto triunfalismo. También hay terapias familiares que parecían prometedoras y que patinan por el efecto de la resistencia sistémica familiar, y también por resistencias claramente localizables a nivel de uno de los miembros de la familia, fenómenos que nos remiten al problema de la técnica de los terapeutas, y seguramente al de sus propias resistencias. ¿Cuál debe ser la exigencia de los terapeutas en cuanto a los criterios de éxito? Ciertos autores presentan la reducción del síntoma como el único criterio a considerar: la regla "objetivo: síntoma" se apoya en la noción de contrato cumplido. Tiene por corolario cierta modestia de experto y se apoya en el postulado implícito de la autonomía de la evolución general de los consultantes, como es habitual en medicina: curar una angina, practicar un parto, no implica a primera vista ninguna toma de posición sobre el destino de las personas interesadas. Si desaparece el estado depresivo o la toxicomanía por lo que el equipo terapéutico fue consultado, el contrato ha sido cumplido. Sin embargo eso no impide otros modos de cuestionamiento.

A pesar de todo esto existen también terapias familiares a largo plazo, descritas sobre todo por autores de orientación psicoanalítica, como H. E. Richter. Este autor reconoce por ejemplo que tuvo que esperar 7 años de trabajo psicoterapéutico familiar para que le fueran confiados ciertos datos esenciales sin los cuales todo hubiera seguido patinando.

La intervención terapéutica, aunque sólo sea como puntuación, se inscribe en la historia de la y las personas interesadas: se puede constatarlo en perspectiva individual, familiar, transgeneracional y más allá si se investiga.

"La esquizofrenia aparece en la tercera generación de ma-

dres obsesivas" constataba uno de los pioneros de la terapia familiar (L. B. Hill). Cuando un psicoanalista, en relación dual, llega a movilizar el trabajo de duelo, en una niña muy perturbada por el drama de un recién nacido muerto, el efecto producido no se limita a la niña. El efecto secundario no se reduce tampoco a la madre traumatizada, sino que se extiende en oleadas sobre la familia entera. Será sensible también en la descendencia de la paciente designada. Pero el efecto más claro parece revelarse en el *otro niño*, nacido algunos años más tarde, y que se beneficiará no solamente con no ser *puesto en el lugar del niño muerto*, en la medida en que el duelo sea elaborado de manera "funcional" o "disfuncional". En el caso citado, la terapia de la niña había sido relevada por la de la pareja de los padres, al mismo tiempo que se respetó la intimidad de la relación dual inicial.

No, terapia familiar y psicoanálisis no es *de ningún modo* la misma "cosa". Pero no veo cómo una podría vivir sin la otra, unidas o separadas en la diversidad de situaciones y de opciones.

Propongo reunir los lineamientos y las filiaciones precedentemente señalados connotándolos conjuntamente con el término de *terapias de destino*.

Ante semejante programa, la prudencia semántica elemental nos recordará que, si la palabra no es la cosa, cada término empleado drena con él un universo de discurso... que tiene consecuencias. Si la palabra gato no puede arañar, ciertas palabras pueden volver loco o enfermo. Entonces, ¿qué palabras pueden producir el efecto contrario?

Bibliografía

- (1) KORZYBSKI, Alfred: Science and Sanity; an introduction to Non-Aristotelian systems and General Semantics. Lakeville, Conn., USA, 1933. (4a. ed., 1973, p. 107).
- (2) Ibid., p. LXXX.

- (3) POLITZER, Georges: Critique des fondements de la psychologie. 1928. (Réed. P.U.F., 1967).
- (4) HOCHMANN, Jacques: La psychothérapie familiale, une arme nouvelle pour le socio-psychiatre. En *L'Information psychiatrique*, nov. 1967, n. 9, p. 1157-1172.
- (5) Se puede leer el relato en mi libro: "C'est toi qui le diras..." "Propos sur le métier médico-psycho-pédagogique. Ed. Fleurus, París, 1974. (Notamment p. 432, sq.).
- (6) SATIR, Virginia: Pour retrouver l'harmonie familiale. J. P. Delarge, Ed. Paris, 1980. "Peoplemaking", date de 1972.
- (7) KORZYBSKI, Alfred: O. C., p. 29.
- (8) FLORENCE, Jean: L'identification dans la théorie freudienne. Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis. Bruselas, 1978.
- (9) HALEY, Jay: Strategies of psychoterapy. Grune & Stratton, N. Y., 1963, p. 4.
- (10) Cf. notamment: "Actualité de Szondi" in *Psychiatries* fin 1980 (en prensa) et "Etudes Szondiennes" (Recopilación de artículos y conferencias por aparecer).
- (11) SATIR, Virginia. O. C. Cf. Notamment, p. 58, etc.
- (12) BOWEN, Murray: Artículo publicado primero anónimamente con el título de: "Toward the differentiation of a self in one's own family" in: Family interaction, a dialogue between family researchers and family therapists. FRAMO, J. Ed. N. Y., 1972. Reeditado en: Family Therapy in Clinical Practice. Jason Aronson N. Y., 1978, cap. 21, p. 467-528.
- (13) DURIEU, Colette: La rééducation des aphasiques. Ed. Dessart, Bruxelles, 1969.
- (14) WYATT, Gertrud L.: La relation mère-enfant et l'acquisition du langage. Ed. Dessart, Bruxelles, 1973.
- (15) RAVERTY-NOZAL, E.: "La naissance d'un enfant malformé des membres". In *Réadaptation*, nro. 169. Janvier, 1973, p. 3-8.

Terapia Familiar: un modelo de desarrollo y una propuesta de clasificación

KATIA GIACOMETTI

*Miembro didacta del Instituto de Terapia Familiar de Roma.
Asistente de dirección de la revista "Terapia Familiare".*

Via Reno 30 - 00198 - Roma - Italia.

Traducción: Sandra I. de Canevaro.

Un modelo de desarrollo

El desarrollo de la terapia familiar está caracterizado por dos aspectos aparentemente contrastantes: "la falta de una historia, de un cuerpo de conceptos comúnmente aceptados y de descubrimientos confirmados" (61) por un lado; y "una lenta, coherente e inevitable evolución" (32) por el otro. Spiegel y Bell expresan en efecto la imposibilidad de considerar la terapia familiar como un único cuerpo de conceptos derivados de una misma matriz teórica y sujetos a un crecimiento constante en el tiempo, subrayando la presencia de una pluralidad de teorías y modelos terapéuticos distintos entre sí.

Jackson y Satir sostienen por el contrario la posibilidad de una reconstrucción lineal de la historia de este movimiento, visto principalmente como la tendencia de los investigadores

y operadores psiquiátricos a desplazar su objeto de intervención del individuo a sus relaciones significativas. Estos dos aspectos, contradictorios sólo aparentemente, individualizan dos características importantes de un mismo fenómeno que, en términos evolutivos, puede ser visto como el nacimiento de un nuevo paradigma (35) y su pasaje de una débil posición, con la vital necesidad de una momentánea radicalización, a un estado de mayor contractualidad, caracterizado por una acrecentada capacidad de recoger y desarrollar sus propias potencialidades de instrumento de lectura, comprensivo y no limitativo, de la realidad. En este sentido es posible individualizar cuatro fases.

La primera coincide con la aparición de nuevas tendencias en el campo de las ciencias humanas y sociales en la América de los años cincuenta. En general, en la cultura americana de la post-guerra se delinea claramente una tendencia a superar la sectorialización de los estudios y la recuperación de un acercamiento holístico a los problemas. El desarrollo de nuevas disciplinas, como la antropología y la sociología, contribuye significativamente al conocimiento de los contextos en el cual el individuo vive, en particular al estudio de las influencias que las relaciones y la organización familiar parecen jugar sobre el desarrollo de la personalidad. El clima de profunda y general renovación es subrayado por el nacimiento de una "ciencia de los sistemas" (8, 15), cuyo objetivo es ofrecer un esquema conceptual y de los instrumentos de estudio para fenómenos (como la autorregulación, la organización, el control, etc.) que no entran entre aquellos que la aplicación de una lógica analítica y elementalista permite estudiar. Con los conceptos de "sistema", "organización" y "causalidad circular", se subraya la necesidad de considerar cada fenómeno en la perspectiva de la globalidad, es decir tomarlo como compuesto en su totalidad y, contemporáneamente, la imposibilidad de considerarlo como suma de partes descomponibles, analizables en términos de causa-efecto.

En particular, en el campo de la psiquiatría emerge la tendencia del investigador a desplazar su atención de los factores

intrapsíquicos a fenómenos intrapersonales y a contextos donde se desarrollan, con la consiguiente individualización de nuevas unidades de diagnóstico e intervención. El trabajo de Sullivan y de la escuela de Washington (63, 64) muestra ya esta orientación en cuanto subraya el rol de lo interpersonal en el desarrollo de la personalidad y tiende a desplazar el foco de la patología sobre la interacción madre-niño. Es decir que lo interpersonal viene asumido, junto a lo intrapsíquico, como parte del proceso patológico.

Un claro testimonio de la búsqueda de una nueva orientación capaz de colmar la tradicional separación de los campos de investigación de las varias disciplinas y de ofrecer una teoría unitaria y comprensiva del individuo, del grupo y de la sociedad, está contenido en la obra de Ruesch y Bateson, *Communication. The Social Matrix of Psychiatry* de 1951. La propuesta de los autores es la de usar "un sistema único para la comprensión de los múltiples aspectos del comportamiento humano", para eliminar la artificial fragmentación de la realidad y para establecer una proficua colaboración interdisciplinaria. La afirmación de la *comunicación* como nuevo modelo científico unificador nace de la revisión crítica de los presupuestos del pensamiento psiquiátrico tradicional, identificado con la teoría psicoanalítica, y del reconocimiento de la inadecuación de su modelo reductivo y mecanicista.

La obra de Ruesch y Bateson advierte que se ha ido desdibujando la imagen de un individuo prisionero de sus propios problemas y de una dinámica solamente *interna*. La nueva orientación se basa sobre el reconocimiento que el individuo existe y se determina como un ser social insertado en una amplia red de relaciones interpersonales. La comprensión de su comportamiento es así nuevamente ligada al análisis de la cultura, de los valores y roles de la sociedad en donde vive. O sea, es subrayado el carácter relativo de salud y enfermedad mental y abandonada toda tentativa de formular una teoría universalmente válida de la naturaleza humana. Esta impostación aparentemente no tiene nada de original, ya que se basa directamente en la tradición neofreudiana, en la cual se

acentúa la importancia de las relaciones interpersonales y del ambiente cultural respecto de los factores constitucionales o evolutivos. Sin embargo, los neofreudianos, si bien revalúan el peso de los factores socio-culturales, permanecen fieles a la teoría y al lenguaje psicoanalíticos centrados en el individuo. La originalidad de Ruesch y Bateson se basa sobre el conocimiento de la necesidad de un lenguaje adecuado a la nueva unidad de estudio, ya no el hombre psicológico, concebido como entidad aislada, sino el hombre social, cuyo ser son sus relaciones sociales. En esta perspectiva se introduce el concepto de comunicación, entendido en su aspecto pragmático, o sea comprendiendo "todas aquellas operaciones con las cuales las personas se influyen recíprocamente" (52).

El pasaje del individuo a la interacción y del concepto de energía al de intercambio de información parece llevar a una redefinición de la psiquiatría en términos de análisis de la comunicación. Esta definición se fundamenta sobre la premisa que el hombre no puede no comunicar y que cada evento y acción presentan inevitablemente un aspecto comunicacional. Entre las implicaciones que derivan de esta impostación adquiere un rol relevante la idea de enfermedad como 'lenguaje' cuya comprensibilidad está relacionada con el sistema de codificación y decodificación en el cual se actúa. De esta manera el nuevo universo psiquiátrico parece delinearse en términos de sistemas de comunicación.

De todas maneras sería equivocado pensar que nos encontramos frente a una teoría ya afirmada como praxis psiquiátrica. En efecto, se trata todavía de una hipótesis de estudio y de trabajo nueva y en gran parte desconocida, que encontrará su aplicación y su verificación en sucesivas investigaciones. Haley lo confirma cuando, trazando un cuadro de la primera mitad de los años cincuenta, observa cómo los primeros estudios y experiencias en clave relacional, hechos por pocos estudiosos y sin ninguna coordinación, tengan lugar justo en un período en donde el psicoanálisis se consolida (26). Sin embargo, justo en el curso de esta creciente difusión de las teorías y de las técnicas psicoanalíticas vemos emerger, junto a nuevas hipótesis

sobre la enfermedad mental y a la experimentación de varias formas de terapia, sobre todo en el sector infantil, una creciente insatisfacción en el plano terapéutico por la impotencia de las terapias psicoanalíticas frente a ciertos tipos de perturbación, en particular la esquizofrenia (16).

Al comienzo de la reflexión crítica sobre el psicoanálisis, empezada en América en el período inmediato la post-guerra, y que de todas maneras no parece dificultar su creciente afirmación, existen dificultades percibidas desde el interno, sobre el plano clínico, y objeciones de carácter epistemológico sostenidas por un movimiento de ideas todavía minoritario. El punto de encuentro entre estas dos posiciones está representado justamente por la esquizofrenia que, en este sentido, puede considerarse como el punto de ruptura y de crisis del viejo paradigma (35).

Ya en 1948 Frieda Fromm-Reichmann acuña el término madre esquizofrenógena y en 1951 John Rosen dedica al problema un capítulo intitulado "The Perverse Mother" en su libro *Direct Analysis*. La raíz de la perturbación se encuentra en una relación insatisfactoria con la madre en el período infantil. Hacia la mitad de los años cincuenta, en los estudios sobre la esquizofrenia, se retoma la relación entre madre-niño. De estas investigaciones surgen una serie de observaciones que originan un decisivo impulso en desviar la atención del investigador y del operador del individuo a sus relaciones y al contexto en el cual vive. Por lo tanto, en estos estudios es posible individualizar un lento y gradual desplazamiento desde la consideración del individuo como entidad aislada y aislable a la díada madre-niño, de consecuencia a la tríada padre-madre-hijo y por último a la familia entera. Contemporáneamente aparecen nuevos términos como "doble vínculo" (6), "pseudomutualidad" (76), "masa indiferenciada del Yo familiar" (14, 15), "cisma y sesgo" (40), que subrayan la necesidad de una renovación del lenguaje psiquiátrico en relación a las nuevas unidades individualizadas.

En el mismo período, en Inglaterra se realizan análogos estudios conducidos por John Howells y Ronald Laing. Los resultados de sus investigaciones sobre familias esquizofrénicas y

mayormente sobre familias enfermas (29, 36, 37, 38) confirman los descubrimientos de los investigadores americanos. O sea, ponen en evidencia el peso de las relaciones familiares en la determinación de la enfermedad mental y subrayan la necesidad para el operador de considerar el contexto en el cual tiene que intervenir en su globalidad, en lugar de limitarse al individuo indicado como "el paciente". A esta *primera fase*, caracterizada por la *afirmación de una nueva orientación común*, sigue *otra* en la cual se evidencia claramente una mayor *diferenciación entre los distintos estudiosos* que señala a la familia como nueva unidad de estudio y de intervención. Sus divergencias son respecto a la conceptualización de la familia y, más en general, a la valoración de su influencia sobre el origen de la "perturbación" psiquiátrica.

Se definen *dos tendencias*:

- a. se busca insertar las nuevas adquisiciones en el cuadro conceptual del psicoanálisis, y más en general en la tradición que privilegia el individuo y su mundo interno, afirmando una estrecha continuidad con el pasado;
- b. se afirma la necesidad de una firme ruptura con la tradición y de una profunda renovación del lenguaje y de las categorías conceptuales para utilizar a la luz del nuevo paradigma.

Para los primeros (Ackerman, Boszormenyi-Nagy, Bowen, Whitaker) se trata de llenar algunas lagunas, para los segundos (grupo de Palo Alto (1) Minuchin) de una verdadera y propia revolución científica. Por lo tanto, no se llega a la afirmación de un modelo teórico y terapéutico único, sino a la creación de

(1) En noviembre de 1958, cuando el proyecto Bateson sobre la esquizofrenia (1952-1962, Bateson, G., Weakland, J. H., Haley, J., Jackson, D. D., Fray, W.) estaba todavía en pleno desarrollo, D. Jackson funda el Mental Research Institute (MRI) de Palo Alto, donde participan Virginia Satir, Jules Riskin y desde 1962 (fecha de la disolución del proyecto Bateson) también Jay Haley, John Weakland y Paul Watzlawick.

distintos modelos, que de alguna manera pueden ser referidos a estas dos orientaciones citadas.

La presencia de estas dos tendencias es ya evidente en los escritos sobre la esquizofrenia. A pesar de que el acento sea puesto sobre la familia y sea advertida unánimemente la inadecuación del modelo de estudio tradicional, en las investigaciones de Wynne, Lidz y Bowen persisten conceptos y términos anclados en el psicoanálisis (necesidad intrínseca, internalización, objeto de identificación, proyección, etc.); términos que Haley y los otros miembros del proyecto Bateson retienen inutilizables para el estudio del sistema familiar. En el debate posterior a la publicación de estos escritos, volvemos a encontrar estas dos posiciones enfrentadas. La discusión versa sobre la utilización de los esquemas teóricos y del lenguaje tradicionales en el proceso de descripción y cambio de la familia. Detrás de este problema de lenguaje se esconde un problema más fundamental, de carácter epistemológico, que concierne al *objeto de análisis y de intervención*.

En 1964, en el primer congreso dedicado a los procesos y a la psicopatología de la familia, realizado en el Eastern Pennsylvania Institute, Haley (25) pone en evidencia este aspecto afrontando el tema de los "hechos" para observar y para recoger.

A los hechos observables, las interacciones, se contraponen eventos no observables (emociones, expectativas, motivaciones, etc.) que parecen estar incluidos en el concepto de "relación" utilizado por los exponentes de la orientación "psicoanalítica". En el término *interacción* lo que se subraya es la *acción entre*, mientras que el término *relación* implica simplemente una *referencia a* y no necesariamente acción. Por un lado, la relación es observada, o reducida, en sus manifestaciones observables, como *proceso interaccional aquí y ahora*; por el otro, es entendida en su significado "más profundo" como necesidad intrínseca, como esquema de relación interiorizada, como motivación.

En este segundo caso es afirmada la prioridad de las relaciones intrapsíquicas con respecto a la acción social, de las relaciones pasadas respecto a las interacciones presentes. La conexión

entre *profundo* y *relacional* pasa a través de la individualización de la necesidad de relacionarse a los otros como necesidad primaria y estructurante del conjunto de motivaciones de cada individuo. La "relación" es así hipostatizada como parte constitutiva interna al individuo, a la intensidad de las pulsiones y de los instintos freudianos, tanto que a menudo llega a perder significado el contexto específico en el cual se desarrolla la interacción. De esta manera el Otro es, ante todo, parte constituyente de la estructura simbólica de la experiencia del Sí Mismo y sólo en segundo lugar copartícipe de un sistema de interacciones en curso.

Por el contrario, para los sostenedores de una radical renovación, el comportamiento del individuo se ve determinarse en el proceso de interacción con los otros, en el cual asume forma y significado. La personalidad no es, entonces, conceptualizada sino en términos de *interacción*. Según estas impostaciones, los síntomas, las defensas, la estructura del carácter y la misma personalidad pierden su característica de cualidad intrínseca de la naturaleza humana, para convertirse en simples términos descriptivos de las *típicas interacciones de un individuo que se manifiestan en respuestas a un particular contexto interpersonal* (31). Con el concepto de "caja negra", tomado de la electrónica, ellos subrayan el grado de complejidad de los mecanismos internos de la mente humana y la imposibilidad de estudiar tal dispositivo sino a través de sus datos de ingreso (input) y de salida (output). La utilización de este concepto permite así liberarse de lo intrapsíquico y poner como único objeto de estudio, observable y verificable, *la comunicación*, en su aspecto pragmático, o sea como *proceso interaccional entre dos o más personas en un determinado contexto* (65). Una investigación efectuada en los años setenta por el Group for Advancement of Psychiatry recalca la existencia de estas dos orientaciones. Sus diferencias conceptuales se reponen a nivel de modelo terapéutico en una distinta consideración de la historia, del diagnóstico, del concepto de cambio y más en general de la misma terapia familiar (22). Sin embargo, de un examen de las publicaciones de fines de los años cincuenta y sobre todo de la pri-

mera mitad de los años sesenta si, de un lado, es posible recoger claramente la existencia de distintos modelos, por el otro, tras una investigación más cuidadosa, resulta que estas dos posiciones que se enfrentan no son, después de todo, tan homogéneas en su interior. Muchas veces, modelos teóricos y terapéuticos de orientación distinta dejan entrever potenciales puntos de convergencia, mayores de los existentes entre teorías que se autocolocan en el interior de su misma orientación.

La tendencia a la radicalización caracteriza, sin embargo, la *tercera fase*. Este fenómeno encuentra su explicación, por un lado, en la necesidad de afirmar un nuevo paradigma, definido "sistémico", en su investidura más eficaz y "revolucionaria" por parte de estudiosos alejados de los círculos de poder, sobre todo académicos, de la psiquiatría dominante y, por el otro, en el clima socio-político y cultural de aquellos años.

Crisis de las instituciones, peso creciente de los grupos étnicos, aumento de las enfermedades mentales, necesidad de reformas de los servicios sociales parecen caracterizar los años sesenta. La creación de los Community Mental Health Centers (1963) representa el reconocimiento oficial del aumento de las perturbaciones psiquiátricas después de la crisis del '29 y en particular después de la segunda guerra mundial. Es subrayada la exigencia de revisar los presupuestos de la asistencia psiquiátrica de manera que sea reconocido el rol jugado por los factores sociales, económicos y culturales en la determinación de las enfermedades mentales, y conjuntamente la necesidad de anclar su tratamiento en el ambiente en el cual se desarrollaron. El acento se desplaza de manera significativa de un interés exclusivo por el individuo a un interés dirigido a la vida de pequeños grupos y, más en general, a las potencialidades patógenas y curativas de la comunidad. El trabajo en equipo, terapias breves, intervenciones sobre los sistemas significativos para la prevención y la rehabilitación y colocación de los servicios en el interior de la comunidad, están indicados como los puntos centrales para la actuación del nuevo programa de asistencia (33). El operador es llamado para intervenir en realidades nuevas, que no son más las cuatro paredes de un consultorio o la sala de un

hospital psiquiátrico, sino las varias formas de organización en las cuales el individuo crece y actúa, o sea, la familia, la escuela, el lugar de trabajo, el barrio.

El pedido de la sociedad americana al operador es de abandonar la óptica circunscripta a lo individual para encontrarse con las necesidades de la colectividad, y de tener instrumentos de lectura y de intervención adecuados al nuevo orden de los servicios socio-sanitarios. El efecto pragmático de este pedido es un desequilibrio de la situación a favor de los sostenedores de la nueva orientación, definida "sistémica" en contraposición a aquél individual y psicoanalítico, conjuntamente con una detención de la investigación y de la experimentación del nuevo modelo a favor de su aplicación prevalentemente técnica (por ejemplo, terapias familiares breves) (67). La afirmación de la terapia de orientación sistémica en el campo operativo parece, por lo tanto, coincidir con la esclerotización de la teoría, utilizada cada vez más en forma reductiva. Esto contrasta con la necesidad que el nuevo paradigma, además de resolver "algunos problemas relevantes y generalmente reconocidos como tales, que no pueden enfrentarse de ninguna otra manera" permita "conservar una parte relativamente amplia de la concreta capacidad de resolver problemas que la ciencia ha heredado de los paradigmas precedentes" (35).

En esta frase comienzan a emerger más claramente las diferencias internas dentro de una misma orientación. Minuchin, en un artículo de 1969 "Family Therapy: Technique or Theory?" testimonia este desplazamiento. En efecto, junto a la denuncia de las tentativas persistentes de conceptualizar a la familia dentro de una óptica individual, donde se habla todavía de transferencia y contratransferencia, de inconsciente y Yo familiar, en este artículo encontramos también formulada claramente una denuncia de los límites que debe tener la misma terapia familiar a orientación sistémica. Justamente en base al conocimiento de estos límites y a los resultados de las investigaciones efectuadas sobre familias de los Slums (43), Minuchin afirma la necesidad de que la orientación sistémica se desarrolle como una prospectiva de intervención más amplia y articulada, en la

cual sean recuperados tanto el individuo como el contexto socio-cultural de la familia. Uno de los problemas expresados es el retorno a la teoría y a la terapia individual dentro de una óptica sistémica. De esta manera se abre una *cuarta fase*, aquella en la cual nos encontramos actualmente, que parece caracterizada por una toma de interés por la experimentación y la profundización teórica; las exigencias estrictamente sociales y la anterior radicalización son abandonadas sobre todo sobre el plano de la investigación científica. Para recoger en pleno las potencialidades de esta fase es necesario proceder a una revisión de los distintos modelos de terapia familiar actualmente existentes y, más allá de una rígida clasificación, individualizar tanto los elementos diferenciales como los presupuestos para una confrontación.

Una propuesta de clasificación

Mi clasificación de los modelos de terapia familiar se propone dos objetivos:

1. individualizar dentro de la definición genérica de orientación sistémica la presencia de distintas posiciones, que corresponden a la adopción de particulares modelos sistémicos, elegidos en base al nivel de organización privilegiado en la observación y en la intervención.
2. hacer entrever algunas posibilidades de confrontación y de intercambio entre posiciones que históricamente se contrapusieron, para llegar a individualizar las premisas de una profundización teórica.

Utilizando como parámetro principal la relación individuo-familia, leída en términos de figura-fondo, se distinguen tres posiciones que con Wertheim (68) podemos definir Supra-individual, Supra-individual-Individual e Individual-Supra-individual.

Posición Supra-individual

Con este concepto se recoge y define la posición de aquellos (Haley, BTG (2), Selvini-Palazzoli) que eligen como objeto de análisis y de intervención la unidad supra-individual, o sea, la familia como sistema de interacciones, abandonando toda pretensión de conceptualización del individuo, si no en términos de miembro de un sistema. Las categorías conceptuales y el lenguaje usados son tomados de la cibernética y la teoría de la comunicación (65). Los conceptos claves son aquellos de información y de retroacción.

El comportamiento intrasistémico se ve determinarse en base a las modalidades de interacción entre los componentes individuales (miembros de la familia), que se evidencian en el nivel supra-individual del sistema tomado como unidad (68). El acento está puesto sobre los aspectos de input y output del sistema, o sea sobre el comportamiento-comunicación que lo caracterizan. La familia es definida como un sistema gobernado por reglas, cuya estabilidad es mantenida por mecanismos homeostáticos que actúan en dirección de una limitación del comportamiento dentro de los confines establecidos. Estos mecanismos, pertenecen, entonces, a un nivel más elevado que aquellos comportamientos a los cuales se refieren, en tanto tienen el poder de regular la posibilidad de desviación (31).

Con esta definición se subraya que en la vida familiar actúa

- (2) En junio de 1967 el MRI de Palo Alto (Jackson, D. D., Satir, V., Riskin, J., Weakland, J.H., Watzlawick, P., Beavin, J.) se reestructura (Watzlawick, P., Weakland, J. H., Fisch, R., Bodin, A.) y asume oficialmente el nombre de Brief Therapy Center. Por seis años se desarrolla una intensa actividad de experimentación sobre formas de tratamiento breve, concentradas en la resolución de la enfermedad en el término de 10 sesiones. La afirmación de este modelo terapéutico se inserta en el más amplio movimiento de reestructuración de los servicios psiquiátricos americanos y representa una propuesta de intervención que va al encuentro de la exigencia de nuevas técnicas capaces de garantizar una potenciación de la actividad de los servicios psiquiátricos (67).

un principio de redundancia, o sea, que el comportamiento de los componentes de la familia puede ser reconducido dentro de modelos de interacción que tienden a repetirse en modo previsible. El término "regla" es entonces una metáfora acuñada por el observador para indicar las regularidades que observa, una fórmula para una secuencia de comportamientos típicos y repetitivos que caracterizan la familia como unidad supra-individual (31).

La posibilidad de evaluar de modo 'objetivo, el sistema familiar está ligada a su conceptualización en términos de sistema homeostático. "En efecto, las normas se vuelven evidentes si se puede observar la reacción a su abrogación y de esto deducir la regla que fue violada. Una fatigosa y prolongada observación del camino recorrido, con una cuidadosa transcripción de los itinerarios *NO* acertados, puede llevar a una hipótesis plausible sobre las reglas del juego" (31). Son estas retroacciones, que constituyen *un cambio observable*, quienes proveen a los terapeutas "las informaciones necesarias para la construcción de una ulterior hipótesis, y por lo tanto de una ulterior intervención" (59).

Esta conceptualización de la familia deriva de los primeros estudios sobre la esquizofrenia y precede a la afirmación del modelo general de familia como sistema abierto, gobernado por mecanismos de retroacción negativo y positivo, en transformación a través de las fases de su ciclo vital (65, 27). Me parece importante la individualización de este parámetro, o sea el tipo de familia y el contexto en el cual sucedió la primera experimentación según una óptica familiar. Su utilidad es evidente si consideramos posiciones como aquellas del BTC y de Minuchin, contenidas aproximativamente bajo la etiqueta de 'sistémico'. Michel Rittnerman refiere las diferencias entre estos dos modelos terapéuticos a una diversidad de impostación teórica, subrayando que el sistema abierto y el sistema cerrado, el organismo activo y el organismo reactivo, se convierten en regla o excepción, según cómo se los considere desde el punto de vista del estructuralismo holístico de Minuchin o del estructuralismo elementalístico del grupo de Palo Alto (51). Quizás

estas diferencias pueden también ser vistas en términos de puntuación. En efecto, mientras que para el grupo de Palo Alto el primer objeto de conceptualización es la familia esquizofrénica (sistema cibernético a preponderancia homeostática), para Minuchin el primer objeto de análisis es la familia con problemas de comportamiento delincuenciales (sistema extremadamente abierto y no integrado en su interior, caracterizado por inestabilidad e impredecibilidad de roles y funciones). De aquí una distinta formulación de la intervención misma, para los primeros en términos de prescripciones paradójales, para Minuchin en términos de maniobras reestructurantes, donde el elemento diferenciante es la consideración de la predecibilidad del sistema.

Este mismo parámetro puede ser aplicado para los exponentes de la posición Individual-Supra-individual. Los conceptos de crecimiento (Whitaker), diálogo (Boszormenyi-Nagy) y diferenciación (Bowen) surgen de las primeras observaciones sobre la *diada* madre-hijo y de las primeras tentativas de tratamiento de la *diada* conyugal, y se utilizan para la formulación del concepto de patología y de cambio en términos de Psicología del Yo, de su desarrollo y de su acrecentamiento.

De todas maneras, la adopción del modelo cibernético tiende a subrayar que la familia 'patológica' es un sistema "auto-correctivo, establemente ligado, a *predominancia homeostática*" (59), en donde el cambio, a nivel de organización, necesita de la acción de un agente externo. Coherentemente con estas premisas el terapeuta es considerado como agente externo, que debe insertarse en el sistema en el nivel de metaregulador para cambiar el programa (24) y el objetivo terapéutico es definido en términos de ruptura de esos círculos viciosos que dificultan las posibilidades de reprogramación del sistema. La utilización preponderante en este modelo de técnicas paradójales tiene su presupuesto teórico en la lectura de las relaciones en términos cibernéticos (3), de donde viene subrayada la necesi-

- (3) "... cuando una persona señala un cambio en la relación con otro, el otro reaccionará de manera de minimizar y modificar ese cambio" (24).

dad para el terapeuta de adoptar una estrategia en grado de crear un contexto en el cual el cambio sea igualmente inevitable.

El abordaje de Selvini (53) representa una de las aplicaciones más rigurosas del modelo sistémico de molde cibernético, que ella propone y utiliza de manera original también como clave de lectura de las macro-organizaciones (54-60). La consideración del sistema familia como unidad Supra-individual es coherentemente repropuesta en el nivel de intervención para el sistema terapéutico. El homeostato de Ashby es el ejemplo teórico de referencia (59).

Los terapeutas, agentes externos y centrales, anotan, apuntan, discuten y prescriben. Su tarea es la de individualizar las reglas disfuncionales a través de un estudio 'objetivo' de las secuencias de comportamiento que actúan como fuerzas de mantenimiento del síntoma. La lógica del cambio es aquella de la ruptura del sistema en base a la introducción de constantes no funcionales a su circuito (59). O sea, los terapeutas introducen en el sistema un input que representa una información no prevista en su programa. El objetivo es alterar el universo ontológico y perceptivo de la familia y contemporáneamente introducir una posibilidad de aprendizaje. De esta manera, a las prescripciones paradójales se unen maniobras reestructurantes como los rituales, que Selvini define "prescripciones ritualizadas de un juego donde las nuevas normas substituyen tácitamente a las anteriores" (53). El deber de los terapeutas es el de funcionar como enzimas activando, pero manteniéndose fuera del sistema, para no ser neutralizados y para que la familia pueda elaborar su input.

El Supra-sistema familia-terapeutas es considerado a la medida de un aparato cibernético, "en donde el máximo peligro en lo que se refiere al intento del cambio, es el de vincularse de manera demasiado estrecha, dificultando o imposibilitando a los terapeutas quedarse en posición "meta" (59). La eficacia de su intervención parece, entonces, directamente proporcional a su capacidad para obrar fuera del sistema, de colocarse en el nivel de metareguladores. Por esto, después de haber introducido el input, los terapeutas interrumpen la relación con la familia por

estas diferencias pueden también ser vistas en términos de puntuación. En efecto, mientras que para el grupo de Palo Alto el primer objeto de conceptualización es la familia esquizofrénica (sistema cibernético a preponderancia homeostática), para Minuchin el primer objeto de análisis es la familia con problemas de comportamiento delincuenciales (sistema extremadamente abierto y no integrado en su interior, caracterizado por inestabilidad e impredecibilidad de roles y funciones). De aquí una distinta formulación de la intervención misma, para los primeros en términos de prescripciones paradójales, para Minuchin en términos de maniobras reestructurantes, donde el elemento diferenciante es la consideración de la predecibilidad del sistema.

Este mismo parámetro puede ser aplicado para los exponentes de la posición Individual-Supra-individual. Los conceptos de crecimiento (Whitaker), diálogo (Boszormenyi-Nagy) y diferenciación (Bowen) surgen de las primeras observaciones sobre la *diada* madre-hijo y de las primeras tentativas de tratamiento de la *diada* conyugal, y se utilizan para la formulación del concepto de patología y de cambio en términos de Psicología del Yo, de su desarrollo y de su acrecentamiento.

De todas maneras, la adopción del modelo cibernético tiende a subrayar que la familia 'patológica' es un sistema "auto-correctivo, establemente ligado, a *predominancia homeostática*" (59), en donde el cambio, a nivel de organización, necesita de la acción de un agente externo. Coherentemente con estas premisas el terapeuta es considerado como agente externo, que debe insertarse en el sistema en el nivel de metaregulador para cambiar el programa (24) y el objetivo terapéutico es definido en términos de ruptura de esos círculos viciosos que dificultan las posibilidades de reprogramación del sistema. La utilización preponderante en este modelo de técnicas paradójales tiene su presupuesto teórico en la lectura de las relaciones en términos cibernéticos (3), de donde viene subrayada la necesi-

(3) "... cuando una persona señala un cambio en la relación con otro, el otro reaccionará de manera de minimizar y modificar ese cambio" (24).

dad para el terapeuta de adoptar una estrategia en grado de crear un contexto en el cual el cambio sea igualmente inevitable.

El abordaje de Selvini (53) representa una de las aplicaciones más rigurosas del modelo sistémico de molde cibernético, que ella propone y utiliza de manera original también como clave de lectura de las macro-organizaciones (54-60). La consideración del sistema familia como unidad Supra-individual es coherentemente repropuesta en el nivel de intervención para el sistema terapéutico. El homeostato de Ashby es el ejemplo teórico de referencia (59).

Los terapeutas, agentes externos y centrales, anotan, apuntan, discuten y prescriben. Su tarea es la de individualizar las reglas disfuncionales a través de un estudio 'objetivo' de las secuencias de comportamiento que actúan como fuerzas de mantenimiento del síntoma. La lógica del cambio es aquella de la ruptura del sistema en base a la introducción de constantes no funcionales a su circuito (59). O sea, los terapeutas introducen en el sistema un input que representa una información no prevista en su programa. El objetivo es alterar el universo ontológico y perceptivo de la familia y contemporáneamente introducir una posibilidad de aprendizaje. De esta manera, a las prescripciones paradójales se unen maniobras reestructurantes como los rituales, que Selvini define "prescripciones ritualizadas de un juego donde las nuevas normas substituyen tácitamente a las anteriores" (53). El deber de los terapeutas es el de funcionar como enzimas activando, pero manteniéndose fuera del sistema, para no ser neutralizados y para que la familia pueda elaborar su input.

El Supra-sistema familia-terapeutas es considerado a la medida de un aparato cibernético, "en donde el máximo peligro en lo que se refiere al intento del cambio, es el de vincularse de manera demasiado estrecha, dificultando o imposibilitando a los terapeutas quedarse en posición "meta" (59). La eficacia de su intervención parece, entonces, directamente proporcional a su capacidad para obrar fuera del sistema, de colocarse en el nivel de metareguladores. Por esto, después de haber introducido el input, los terapeutas interrumpen la relación con la familia por

un período prolongado "indispensable para la acumulación de retroacciones observables", que funcionan de control para la hipótesis construida y como guía para las sucesivas intervenciones. El contexto es de observación, de recolección de informaciones y de espera. El terapeuta es distante y neutral. En sesión no usa sus propias emociones y fantasías ni activa tareas o prescripciones que lo vean activamente participe o implicado en el proceso en curso.

Coherente respecto a un modelo que desplaza el foco de atención sobre los efectos del comportamiento, Selvini considera el síntoma "un signo indudable de disfunción de un sistema, pero no como señal intencionalmente dirigida para provocar un cambio" (55). Aquello que aparece en su modelo es un sistema víctima de disfuncionalidades circulares que necesita ser reprogramado.

Posición Supra-individual-Individual

Los representantes de esta posición (Minuchin, Andolfi) consideran la familia un sistema abierto, capaz de autogobernarse, en constante transformación, con sus propios confines internos y externos. Las categorías conceptuales y el lenguaje usados son tomados de la teoría de los sistemas abiertos (8) y del estructuralismo (39), este último como llave de lectura del funcionamiento del sistema familiar.

En el interior los confines garantizan la individualización de subsistemas con funciones distintas y específicas. Esto no sólo permite a la familia cumplir con sus deberes de socialización y de guía para la entrada en el mundo externo, sino que garantiza también la relativa autonomía de cada subsistema (individuo, díada, tríada) en su intercambio con los otros.

Lo mismo vale para los confines que delimitan la familia en el exterior. Sus funciones son de mantener una proficua comunicación bidireccional con la comunidad, preservando contemporáneamente, un cierto grado de autonomía en su interior.

MODELO DE DESARROLLO Y PROPUESTA DE CLASIFICACION

MODELO TEORICO

<i>Posición Supra-individual</i>	<i>Familia</i>	<i>Patología y Etiología</i>	<i>Cambio</i>
1. Brief Therapy Center Palo Alto (Watzlawick P., Weakland, J. H., Fisch, R., Bodin, A.)	"Sistema cerrado de información donde las variaciones en las salidas o en el comportamiento retroalimentan para corregir la respuesta del sistema" (30). Sistema gobernado por reglas (31, 65).	Rigidez de las reglas, evidente en la redundancia y esteotipia de las interacciones.	Eliminación o modificación de comportamientos, o secuencias que actúan como fuerzas de mantenimiento del comportamiento sintomático. El verdadero cambio consiste en un salto cualitativo de un sistema de reglas a otro (65); lo cual implica, en base al modelo cibernético y a la teoría de los grupos matemáticos, la intervención de un agente externo.
2. Family Institute Washington D. C. (Haley J. y col.).	Modelo cibernético. Sistema dotado de un mecanismo de corrección de error, o sea, de un proceso de regulación en el cual cada miembro desarrolla la función de regulador con respecto a los otros (24).	Lucha por el poder Insertada dentro de un cuadro de coalición. Tomar el concepto de ciclo vital de Erickson M.: "... los síntomas no se desarrollan porque sí, sino siempre en los momentos de crisis, que coinciden con el paso de la familia de un estado a otro de su ciclo vital" (27).	Modificación en la lucha por el poder que bloquea la familia en modelos de interacción estereotipados.
3. Centro para el Estudio de la Familia de Milán (Selvini Palazzoli M. y col.).	"Sistema autocorrectivo, que se autogobierna mediante reglas que se constituyeron en el tiempo a través de ensayos y errores" (53).	"... tendencia cada vez más rígida a repetir compulsivamente las soluciones memorizadas al servicio de la homeostasis". Toma la hipótesis trigenacional de Bowen, traducida en términos de modelo cibernético (53).	"Modificación de aquellos parámetros organizativos que, gobernando de manera repetitiva las relaciones entre los miembros de un sistema, bloquean sus latentes potencialidades evolutivas" (55).

<i>Posición Supra-individual-Individual</i>	<i>Familia</i>	<i>Patología y Etiología</i>	<i>Cambio</i>
4. Child Guidance Clinic Philadelphia (Minuchin S. y col.).	Sistema abierto, capaz de autogobernarse, en transformación (organismo activo) (45).	Grado de permeabilidad de los límites internos y externos relativo al tiempo y al espacio (45).	Modificación de la estructura familiar de manera que cambien las posiciones de cada miembro en su interior y con ellas las respectivas experiencias, en base a las cuales sea posible llegar a afirmar nuevos modelos de interacción recíprocos (45).
5. Centro Estudios de la Comunicación en los Sistemas - Roma (Andolfi, M. y col.).	Sistema en constante transformación, activo, con capacidad de autogobernarse y abierto, en interacción con otros sistemas (2).	Grado de rigidez-flexibilidad relativo al tiempo y al espacio (posibilidad de mutar en el tiempo el equilibrio entre homeostasis y transformación, "los equilibrios entre funciones desarrolladas por sus miembros —estado de cohesión— y el crecimiento de cada uno de ellos —estado de diferenciación—") (4).	Modificación de la relación entre H (homeostasis) y T (transformación), entre función y crecimiento, para llegar a un nuevo equilibrio dinámico (4).

Posición Individual-Supra-individual

<i>Posición Individual-Supra-individual</i>	<i>Familia</i>	<i>Patología y Etiología</i>	<i>Cambio</i>
6. Georgetown Family Center Washington DC (Bowen, M. y col.).	Sistema emocional con un cierto nivel de diferenciación equivalente al nivel que cada miembro suyo puede alcanzar y mantener contra la oposición de la unidad familiar. Sistema activo caracterizado por fuerzas que van hacia la diferenciación y fuerzas que tratan de mantener un estado de pertenencia recíproca y de unidad emocional (16).	Grado de diferenciación del yo de la familia. Nivel de fusión de un sistema emocional (21). Falta de diferenciación del propio <i>Sí</i> mismo en el sistema emocional de origen. Teoría etiológica trigeneracional (14, 20).	Modificación de la relación de cada individuo con cada uno de los padres. Un más alto nivel de diferenciación' insight + cambio del comportamiento.

Posición Individual-Supra-individual

<i>Posición Individual-Supra-individual</i>	<i>Familia</i>	<i>Patología y Etiología</i>	<i>Cambio</i>
7. Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute Philadelphia (Boszormenyi-Nagy y col.).	<i>Sí</i> mismo plural, "fruto de las experiencias subjetivas de los miembros que lo componen y con una estructuración de las fronteras <i>Sí</i> mismo-otro". <i>Nosotros</i> que puede constituirse como <i>Nosotros amorfo</i> o <i>Nosotros diferenciado</i> en el curso de su desarrollo a través de las fases de autismo, fusión simbiótica, individuación y separación (10).	Grado de incapacidad del sujeto de referirse al Otro sin contaminar su percepción con elementos de relación interiorizados, que establecen, respecto al Otro exterior y actual una clase de instrumento selectivo de sus mensajes. Evidente la teoría etiológica.	Insight y consecuente reorientación relacional respecto a las imágenes del pasado para alcanzar el estado dialógico.
8. Medical School University of Wisconsin-Madison (Whitaker C. y col.).	Totalidad en la cual se comparan tendencia a la unión y capacidad de individuación.	Incapacidad de estar con los otros sin perder la libertad de ser uno mismo.	"En psicoterapia un objetivo es el de aumentar las áreas de conocimiento. Sin embargo, otro aspecto importante del tratamiento es volver al paciente menos consciente de algunos aspectos de la experiencia, o sea, desarrollar su espontaneidad y autenticidad" (41). "El crecimiento de la familia, como aquel del individuo es un proceso de ruptura de todos aquellos vínculos que ponen en jaque a la libertad de cambiar, la libertad de ser más espontáneos, más creativos" (48).

MODELO TERAPEUTICO

KATIA GIACOMETTI

Relación Terapeuta-Familia

1. Relación Sujeto-objeto (unidad supra-individual) Terapeuta agente externo en función de metaregulador. S/T-F.
2. Relación Sujeto-objeto. Terapeuta agente externo. Metaregulador. Modelo de comunicación. S:T-T-F.
3. Supra-sistema Familia-Terapeutas como aparato cibernético (59). Terapeutas agentes externos catalizadores. SS: TT-F.

Contexto terapéutico

- Desapagado. Observación, Recolección de informaciones y espera.
- 'Directivo'. Recolección de informaciones; 'paradoja!' (28).
- Desapagado. Observación 'objetiva'; recolección de informaciones, espera.
- Explorativo, de experimentación y de aprendizaje a través de la acción.

4. Concepto de sistema terapéutico: encuentro y acomodación de dos sistemas abiertos y activos (46). Terapeuta provocador y sostenedor. Familia protagonista del propio cambio. S: T-F.

5. Concepto de sistema terapéutico (2). Encuentro entre dos organismos activos. Terapeuta provocador y sostenedor al mismo tiempo. Entrenador y supervisor. Familia protagonista.

Diagnóstico

- Observación de redundancias clas-input-retroacciones.
- Lectura del sistema en términos de coalición.
- Observación de redundancias comunicativas-input-retroacciones. Las "retroacciones" funcionan de control para la hipótesis construida por los terapeutas. Si la hipótesis resultara equivocada, se deberá formular una hipótesis distinta" (56).
- Interaccional y progresivo. Uso del mapa (45).

- Progresivo, en términos de rigidez-flexibilidad del sistema terapéutico (2, 4).

Técnicas de intervención

- Prescripciones paradojales.
- Prescripciones paradojales y manobras reestructurantes (28).
- Prescripciones paradojales y rituales (57-58).

- Uso del Sí mismo y del espacio. Asignación de deberes y activación directa de transacciones intrasistémicas en sesión. Concepto de base: reestructuración.

- Prescripciones paradojales, reestructurantes, metafóricas. Provocaciones (23, 4).

Relación Terapeuta-Familia

- nir de su propio cambio. S: T-F, S: TT-F.

6. Sujeto-objeto-Terapeuta modelo de diferenciación (1-position, 18); Enseñante-entrenador y supervisor. T-I.

7. Sujeto-objeto-Terapeuta guía del proceso de autoexploración. Modelo de identificación: aquí que demuestra, a través del pasaje de una fase a la otra del proceso terapéutico (fases que son las mismas del proceso de desarrollo y maduración del Sí mismo) cómo es posible no rigidizarse en roles objetuales. Lectura en términos de transferencia-contratransferencia S: T-F TT-P; C(consultor)FF.

8. Sujeto-objeto-Terapeuta modelo de crecimiento: compromiso sin fusión (49)

- "Es necesario que los miembros de la pareja terapéutica pongan en relación dialéctica sus diferencias individuales, su derecho a separarse y su necesidad de pertenecerse" (74) TT:F; CT:F.

Contexto terapéutico

- nir como setting terapéutico al ambiente familiar y por lo tanto al setting terapéutico como contexto de supervisión (5).

- Pedagógico-formativo de supervisión.

- Autoexploración de los objetos introyectados y examen de la realidad.

Diagnóstico

- Escala de diferenciación del Sí mismo (19).

- Esquema de desarrollo de las relaciones (ver definición de la familia). Recolección de las historias personales y familiar.

Técnicas de intervención

- Instrumento verbal manipulación del espacio emotivo-geograma (23).

- Instrumento verbal. Utilización del material onírico. Interpretaciones. Parcialidad multidireccional (13).

- Experiencia existencial en la cual el Terapeuta, la familia y el individuo participan [tanto en el nivel racional como emotivo (41)] desde la fase de la batalla por la estructuración y el control hasta aquella del compromiso y la creatividad (49). "Los terapeutas se zambullen en su propia imaginación creativa y la familia aprende a hacer lo mismo" (74).

- Uso del Sí mismo "Cuanto más estén los terapeutas en condición de utilizar sus componentes irracionales, impulsivos, asociativos y fantásticos, tanto más es posible para la familia franquear su propia rigidez" (74).

MODELO DE DESARROLLO Y PROPUESTA DE CLASIFICACION

De esta manera la familia se encuentra en relación dialéctica con el exterior. Al mismo tiempo los conceptos de *frontera* y de *subsistema* (Minuchin, 45) ofrecen una clave de lectura de la relación individuo-familia. El sistema familiar (unidad supra-individual) es en efecto conceptualizado en términos de subsistemas (individuos) en interacción, con propios confines que garantizan a cada uno un grado de diferenciación con respecto a los otros y, contemporáneamente, una comunicación y un intercambio recíprocos (45).

“La lectura del comportamiento intrasistémico, presupone entonces, la consideración de ambos niveles, familiar e individual, a la cual se agrega la del contexto social más amplio”. En otras palabras, según Minuchin se trata de afirmar, coherentemente con los presupuestos de un modelo a sistema abierto, una relación de circularidad entre individuo y ambiente, vistos ambos como sujetos en interacción recíproca. De esta manera el individuo es tomado en relación con los otros componentes de la familia y de distintos sistemas (individuos, familias y otras estructuras) que encuentran justo en los respectivos miembros un puente para sus transacciones recíprocas. A través de estas transacciones internas y externas que tienden a repetirse, él adquiere su propia identidad en el tiempo. Es así subrayada la complejidad del comportamiento del individuo en la totalidad de sus componentes (incluyendo su pasado y sus cualidades distintivas, 45), y afirmada la necesidad que, para evaluar un evento, se toma en cuenta al ecosistema entero sin caer en peligrosas dicotomías. Individual-intrapersonal-social, tomados en su estrecha interdependencia, vienen incluidos en el área de consideración del terapeuta, para decidir intervenir sobre los confines de la familia con ecosistema entero sin caer en peligrosas dicotomías. Individual-intrapersonal-social, tomados en su estrecha interdependencia, vienen incluidos en el área de consideración del terapeuta, que para decidir de intervenir sobre los confines de la familia con algún otro sistema externo (por ejemplo, la escuela), sobre los confines internos de algún subsistema (por ejemplo, el individuo) o en los confines del sistema familiar (45).

En cada caso, también dónde se adopte, en el nivel terapéutico, un confín artificial entre familia y ambiente externo, no significa descuidar los vínculos y el modo en el cual se efectúan. Lo social entra en terapia con el individuo, la familia y el terapeuta mismo, a través de sus modalidades de relación, sus valores y sus estereotipos. De todas maneras, el problema es justamente el de establecer los límites de intervención del operador psiquiátrico. Si entre sus deberes existe el de no confundir las fuentes de displacer, que pueden ser de naturaleza socio-económica, y no correr el riesgo de intervenir terapéuticamente necesidades que tienen su solución en otros niveles (1), es asimismo importante que todo esto no signifique negar indiscriminadamente la posibilidad de un sufrimiento más “limitado” de naturaleza distinta.

La concepción de la familia como sistema activo y no sólo reactivo, abierto hacia el exterior y articulado en su interior y por esto menos predecible, es repropuesta coherentemente en el nivel de lectura del sistema terapéutico del modelo de Andolfi (2). El sistema terapéutico es leído en términos de subsistemas (supervisor-terapeuta-familia) en interacción, con confines propios internos y externos, tomados en un espacio y en un tiempo definidos. Esto significa que las características de este sistema surgen de la confrontación entre espacio personal y espacio interaccional de cada subsistema y del entrelazado de los respectivos ciclos vitales.

Es entonces evidente que una característica de este modelo es la consideración del terapeuta como *parte integrante del proceso terapéutico*. El uso del sí mismo del terapeuta y la prescripción y la activación de los deberes en sesión, que permiten a cada miembro verificar su ser en relación a los otros (42), definen en la praxis una relación terapéutica en la cual convergen la delegación y las expectativas del exterior (5). El contexto es colaborativo, explorativo, de experimentación y de aprendizaje a través de la acción. En un contexto así definido (3), el deber del terapeuta es alterar los viejos esquemas y sostener, contemporáneamente, la creatividad del sistema y de cada miembro individual. No aceptando ninguna delegación pedagógica.

gica, él se limita a promover un proceso que apunta a potenciar las capacidades de cada miembro y a valorizar la utilización para la resolución de los conflictos internos o externos al sistema. Es así afirmado el principio según el cual debe ser la familia, en primera persona, artífice y protagonista de su cambio (2). Esto significa que el terapeuta debe adherir a la realidad afectiva, emocional y cultural del sistema familiar, sin por esto perder nunca su libertad de acción, que representa la mayor garantía contra el miedo de la familia de ir hacia el cambio.

El hecho de que en el proceso terapéutico entren maniobras de asociación y de reestructuración, de desafío al síntoma y de sostén a la persona, es indicativo de una concepción del individuo y por lo tanto del terapeuta como persona, más allá que como pieza de un juego de resistencia y de cambio. Es así mismo indicativo del reconocimiento de las potencialidades internas del sistema. De esta manera el proceso de reestructuración consistirá en el "modificar los esquemas relacionales habituales de la familia utilizando elementos y energías ya presentes en el sistema, por lo menos en el nivel potencial. El edificio asume nuevas perspectivas, es modificado, más los ladrillos que lo forman son siempre los mismos.

Posición Individual-Supra-individual

En esta posición entran los sostenedores de una continuidad con el pasado (Bowen, Boszormenyi-Nagy, Whitaker), que adoptan un lenguaje más cercano al modelo psicoanalítico y que están en general más anclados a una tradición que privilegia el individuo y sus relaciones internas respecto del contexto de interacción presente. *El comportamiento intrasistémico se ve determinarse en base a la interacción y a la integración entre los dos niveles de la organización sistémica (el nivel del sistema familiar supra-individual y el nivel de sus componentes individuales o subconjuntos-personalidad) al cual se agrega una relación dinámica entre el proceso familiar presente y los procesos pasados de sus subsistemas* (68). Sin embargo en la relación figura-fondo

"individuo-familia" es el individuo que mantiene una posición de primer plano. Quiere decir que la familia encuentra en el sí mismo individual y en su desarrollo su mejor modelo de conceptualización.

Como sí mismo plural, ella viene definida como un sistema de motivaciones multipersonales (Boszormenyi-Nagy) y, a pesar del uso del término 'sistema', parece prevalecer aún la categoría de sumatividad (10,11). Es la clase del proceso de maduración y de individuación de cada uno sobre los cuales juegan los otros significativos precedentemente interiorizados, que determina el tipo del sí mismo familiar, que puede constituirse como Nosotros amorfo o como Nosotros diferenciado en el curso de su desarrollo, a través las fases de autismo, de fusión simbiótica, de individuación y de separación (10).

Adoptando el modelo de sistema abierto (8) Bowen elabora una teoría del individuo como organismo activo complejo, que es tomado en todos sus componentes constitutivos: el sistema de las emociones, de los sentimientos y del pensamiento (16). Su desarrollo de la infancia hasta la edad adulta está caracterizado por el pasaje de un estado sincrético a una siempre mayor diferenciación del sí mismo, que corresponde a un funcionamiento complementario de sistema emocional y sistema de pensamiento y por lo tanto a la capacidad de entrar en relación sin caer en un estado fusional. De esta teoría de la personalidad individual Bowen llega a la definición de familia como sistema emocional, caracterizado por fuerzas que van hacia la diferenciación y fuerzas que buscan mantener un estado de unión y de pertenencia recíproca (34). También en este caso la configuración del sistema familiar depende del grado de diferenciación de sus miembros, que coincide con "una cantidad fija determinada desde los primeros estadios de la infancia en base al grado de diferenciación de los padres y al clima emocional de sus familias de origen" (17). El estilo de vida de cada individuo y su capacidad de relacionarse con los otros depende de las primeras relaciones que él establece con las figuras significativas de su pasado. Se crea de esta manera una cadena intergeneracional que establece un continuum entre pasado, presente y futuro. Sin embargo,

es evidente que en el interior de esta cadena son las relaciones pasadas las que se ven privilegiadas respecto de las interacciones actuales.

Para Whitaker la necesidad de considerar la familia y no el individuo aislado nace del reconocimiento que cada persona es el fragmento de un grupo familiar que, a su vez, constituye para el sujeto el ambiente externo e interno y la guía en su confrontación con la realidad. La recuperación de la dimensión familiar nace, por lo tanto, de la necesidad fundamental del individuo de estar con los otros, sin por esto perder la libertad de ser él mismo. La estrecha interdependencia entre individuo y familia es afirmada con este concepto de crecimiento: la creciente unidad del grupo familiar pasa a través de la capacidad de individuación de sus miembros y, al mismo tiempo, esta capacidad de individuación depende de Otros significativos (48).

La construcción de una teoría de la personalidad más comprensiva, en donde encuentren igual reconocimiento la dimensión intrapsíquica e interpersonal, parece constituir el punto de partida para la recuperación de la dimensión familiar en el análisis de la perturbación mental. La consideración de las relaciones internas de la familia adquiere frecuentemente el significado de una ampliación del campo de investigación de las causas del disturbo. Esto resulta evidente desde el interés de estos autores por una dimensión etiológica, en la cual se estudia la génesis de la perturbación a través de la historia del individuo y de la familia, que a veces parece reproponer una relación lineal de causa-efecto (ver, el concepto de programación de Bowen, 17, 20; los esquemas de necesidad de relación de Nagy, 9; la recuperación de los mitos y de las realidades introyectadas de Whitaker, 67). Esta prioridad de las relaciones verticales sobre las horizontales se traduce en el plano operativo por la cual se indica la posibilidad de ir más allá del estudio y el tratamiento de la familia nuclear. Además, mirando la formulación del concepto de cambio, se puede notar cómo emerge claramente un modelo de salud mental que se basa sobre los conceptos de diferenciación (17, 19) diálogo-lealtad (10, 12, 13) y crecimiento (entendido como recuperación del propio sí mismo

dentro de su parte irracional, 69). De esta manera la terapia tiene un objetivo 'en positivo' interno a sus mismas premisas teóricas. Sobre el plano terapéutico se retoma y utiliza en manera elástica y flexible el lenguaje y los instrumentos propios del modelo psicoanalítico.

La relación terapeuta-familia se traduce a menudo por una relación diádica terapeuta-individuo en la cual se utilizan, además de los conceptos de transferencia y contratransferencia, los sueños, las fantasías, la metáfora y más en general los productos del inconsciente. De esta manera la persona del terapeuta, en sus componentes tanto sea racionales como emocionales, se convierte en un *ingrediente esencial del proceso terapéutico* (41). Sobre estas bases la respuesta intuitiva y emocional parece adquirir a menudo mayor importancia que la comprensión racional (49). La hipótesis es la de poder estimular un cambio ya sea a través del insight como a través de la valoración inconsciente de un comportamiento inducido. "En efecto ellos creen que el individuo lleve adentro suyo una verdad de naturaleza irracional e inconsciente, y que el encuentro con esta verdad, en el contexto significativo de la terapia, ayude al individuo a transformarse en un ser libre" (7).

Coherentemente a esta impostación, Nagy e Whitaker privilegian una relación de coterapia. El encuentro con la familia activa, en efecto, procesos de tipo primario que el terapeuta utiliza (74). O sea, él no niega ni controla su compromiso emocional, sino que se limita a buscar una garantía contra el riesgo de ser succionado "en las arenas movedizas de la fusión con el sistema familiar" (73). El deber del coterapeuta es de detener un proceso negativo, de acelerar uno positivo y de ofrecer tanto a la familia como al terapeuta un sostén en el compromiso recíproco, garantizando el proceso final de desprendimiento y separación. La misma función puede ser desarrollada por un consultor con respecto a la pareja terapéutica. La figura del consultor y del coterapeuta permiten, entonces, "entrar en el sistema tanto como para poder salir".

Individuo-Familia / Familia-Terapeuta Un intento de integración

De los análisis de estas tres posiciones emerge claramente una distinta consideración de la relación individuo-familia sea en el nivel teórico como en el nivel de modelo de intervención.

En la concepción Supra-individual lo que cuenta son las *interacciones* entre los individuos y las reglas que se constituyen sobre la base de estas interacciones. Con respecto al sistema familiar los terapeutas representan un suprasistema, cuyo objetivo es el de asegurarse una visión de conjunto que les permita romper "aquellos parámetros organizadores que bloquean las latentes potencialidades evolutivas de la familia" (55). El objetivo de la terapia es limitado y definido en negativo, en términos de alteración de circuitos de interacción redundantes y estereotipados. Esto probablemente no significa descuidar el individuo como persona, sino sólo afirmar, coherentemente con el modelo cibernético basado sobre la comunicación, que la ruptura de esos circuitos es la premisa de individuación de nuevos modelos de interacción. ¿Es posible pensar que ella sea el preludio a una intervención a otros niveles y con modalidades distintas? ¿La ruptura de un circuito puede llevar, por ejemplo, a la formulación de un pedido de terapia a nivel individual?

En la concepción Individual-Supra-individual lo que cuenta es una vez más el individuo y la consideración del sistema de relaciones familiares está vista como un adelanto con respecto al modelo psicoanalítico. La terapia familiar permite en efecto un examen de realidad de las distorsiones relacionales de cada miembro, una comparación entre imágenes reales e introyectadas. El objetivo terapéutico aparece entonces como la liberación de una 'programación' más allá del espacio interior. La relación terapeuta-familia, que frecuentemente se traduce en una relación persona a persona, es leída en términos de encuentro entre dos sujetos. De esta manera el ser persona del terapeuta, su capacidad dialógica, de diferenciación o de aceptación de la parte irracional de su propio sí mismo adquieren un preciso significado terapéutico.

En la concepción Supra-individual-Individual la tentativa de considerar la dimensión individual en el interior de una óptica sistémica se propone a nivel terapéutico una búsqueda de modalidad de intervención que tenga presente *contemporáneamente* ambos niveles. El objetivo no es en efecto la simple ruptura de circuitos homeostáticos, sino la modificación de la relación función (nivel supra-individual) persona (nivel individual) adentro del sistema terapéutico. Esto implica, también para los sostenedores de esta posición, la consideración del terapeuta en la doble investidura de experto y de persona. Por cierto, mantenerse coherentes con esta concepción introduce complejidad en el modelo de conceptualización y de intervención.

Encontramos una tentativa de integración de ambos niveles (supra-individual e individual) en el modelo de intervención en la familia con paciente esquizofrénico formulado por Andolfi y col. (4). En esta aproximación, en la conceptualización de la familia, a los conceptos de cierre y apertura, en cuanto característicos de un sistema (51), son substituidos por aquellos de rigidez y flexibilidad, y por lo tanto de actividad y reactividad, relativamente al tiempo y al espacio. Esto permite no ver, en contraposición y en relación estática, las teorizaciones de la familia en términos de "sistema abierto" y de "sistema cerrado" y de individualizar una posibilidad de utilización de conceptos como diferenciación e individuación también a nivel 'sistémico'.

El grado de rigidez y flexibilidad de un sistema corresponde en efecto a su posibilidad y capacidad de "cambiar en el curso del tiempo el equilibrio entre homeostasis y transformación, o sea los equilibrios entre las *funciones* desarrolladas por sus miembros (estado de cohesión) y el *crecimiento* de cada uno de ellos (estado de diferenciación)" (4). Se ponen así en primer plano, a través del concepto de ciclo vital, las relaciones con el exterior y con el interior. En particular es subrayada la necesidad de actuar en ambos niveles, *supra-individual* (funciones) e *individual* (persona), afirmando de esta manera el concepto de crecimiento como capacidad de *individuación en la relación*. "A través de un intercambio continuo y recíproco de comportamientos-informa-

ciones, los componentes de un sistema adquieren progresivamente una imagen más precisas de sí mismos y de otros y de sí mismo con respecto a los otros, pudiendo definir en medida siempre más clara una clase de *frontera* entre el propio yo y el de los otros significativos" (50). La recuperación de una mayor flexibilidad coincide entonces con la capacidad de volver a poner en juego los equilibrios entre espacio personal y espacio interactivo.

En principio el modelo de los sistemas rígidos parece basarse sobre el concepto de sistema compacto reactivo (62) y por lo tanto sobre la elección de técnicas paradójales en las primeras tres fases, a las cuales siguen movimientos reestructurantes que tienen como interlocutor un sistema articulado y de nuevo activo donde la predecibilidad de la intervención disminuye con respecto al resultado. Sin embargo, el acento puesto sobre la provocación hace que ya en las primeras fases sea evidente la consideración de la familia como sistema abierto y activo, articulado en su interior y por esto menos predecible.

Usar la provocación, y no la simple paradoja, con el doble nivel de desafío al síntoma y de sostén a la persona, significa en efecto reconocer y tomar tanto sea instancias homeostáticas como instancias a la transformación, subrayando el doble aspecto de autonomía y de diferenciación del subsistema individual y de funcionalidad del sistema supra-individual. De esta manera a la simple prescripción de la homeostasis en el nivel supra-individual se contraponen un modelo de intervención que, a través la amplificación del nivel funcional, tiende a provocar en sesión una diferenciación de los individuos. La terapia se estructura entonces como un contexto de aprendizaje en el cual cada uno aprende a accionar su función, sin perder por esto su capacidad de crecimiento y de individuación.

La lectura en ambos niveles es coherentemente repropuesta por el sistema terapéutico. La intervención es concebida y leída en términos de encuentro entre dos sistemas, el terapeuta y la familia y sus recíprocas tendencias a la homeostasis y a la transformación. El contexto es redefinido como colaborador a través de la activación en sesión de la familia, libre de explo-

rar sus propios espacios personales e interaccionales en la medida en que el terapeuta se hace guardián de la tendencia a la homeostasis y del miedo a cambiar. Su función es la de ofrecer a la familia una estructura de continente, que permita a sus miembros abandonar funciones reaseguradoras y de buscar nuevos equilibrios entre nivel funcional y nivel de diferenciación del sí mismo. En términos de sistema terapéutico, esto significa que el terapeuta debe medirse con el grado de diferenciación de sí mismo, con su propio miedo de la locura y con los riesgos del cambio. Amplificar de manera contraprovocatoria la provocación significa, en efecto, aceptar afrontar un proceso que requiere del terapeuta mismo el abandono de una función, para encontrar su propio espacio personal en el momento de escisión del sistema terapéutico.

En base a estas observaciones emerge claramente una afinidad entre la posición Supra-individual-Individual y la de Individual-Supra-individual. El punto de convergencia parece estar representado por la consideración del individuo ya sea como miembro de un sistema ya sea como personalidad emergente y, en el nivel del sistema terapéutico, por la consideración de la relación familia-terapeuta en términos de encuentro entre dos sistemas complejos que se miden en el nivel emocional, cognitivo y afectivo con la propia capacidad de individuación y de unión. A la luz de esta concepción la terapia parece poder asumir, más allá de las rígidas teorizaciones, el significado de un adiestramiento del entero sistema terapéutico para tolerar el caos y la angustia que inevitablemente acompañan un proceso de asociación y separación, en el cual es verificado el grado de rigidez y flexibilidad de la relación función-persona.

La consolidación de la terapia familiar en el nivel institucional y académico (sobre todo en América) y una mayor apertura de los canales de confrontación y de intercambio entre las varias posiciones pueden jugar a favor de retomar la actividad de investigación y de experimentación en este campo.

Para poder proceder en esta dirección sin embargo es necesario, por un lado, abandonar el uso indiferenciado de términos como 'sistémico' y, por el otro saber tomar la posibilidad de in-

tegración y articulación de conceptos y modelos sólo aparentemente antitéticos. La utilización del concepto de diferenciación en la posición Supra-individual-Individual permite, por ejemplo, evidenciar el carácter reductivo de una identificación de la óptica sistémica con el modelo cibernético y, contemporáneamente, introduce complejidad reponiendo el problema del estadio y de la profundización del nivel individual sea en el sistema familia como en el sistema terapéutico.

Resumen

En este artículo la autora presenta un modelo de desarrollo de la terapia familiar individualizando cuatro fases.

Utilizando el parámetro Individuo-Familia elabora una clasificación de los varios modelos teóricos y terapéuticos que vuelven a tres posiciones fundamentales: Supra-individual, Supra-individual-Individual, Individual-Supra-individual.

Por último, deteniéndose en la fase actual, examina el modelo de intervención sobre los sistemas rígidos, tomando las implicaciones para la profundización del estudio del nivel individual sea en el sistema familia como en el sistema terapéutico.

Summary

In this paper the author reviews the family therapy field. Four stages of development are described.

Three basic positions (Supra-individual, Supra-individual-Individual, Individual-Supra-individual) in the family therapy field according to the Individual-Family relationship are proposed.

Finally, in the actual stage, the approach dealing with rigid systems is examined and implications of this view for individual level research in both family system and therapeutic system are outlined.

Bibliografía

- (1) ANDOLFI, M., MENGHI, P., "La terapia con la familia", in *Neuropsichiatria infantile*, 180: 487-98, giugno 1976.
- (2) ANDOLFI, M., *La terapia con la famiglia*, Roma, Astrolabio, 1977.
- (3) ANDOLFI, M., "La ridefinizione in terapia familiare", in *Terapia Familiare*, 1, giugno 1977, pp. 7-27.
- (4) ANDOLFI, M., MENGHI, P., NICOLO A. M., SACCU, G., "L'interazione nei sistemi rigidi: un modello d'intervento nella famiglia con paziente schizofrenico", in *Terapia Familiare*, 3, giugno 1978, pp. 35-65.
- (5) ANDOLFI, M., *Family Therapy. An Interactional Approach*, New York, Plenum Press, 1979.
- (6) BATESON, G., JACKSON, D. D., HALEY, J., WEAKLAND, J. H., "Toward a Theory of Schizophrenia", in *Behavioral Science*, 1956, 1: 251-264 (trad. it. in Bateson G., *Verso un'ecologia della mente*, Milano, Adelphi, 1976; *Verso una teoria della schizofrenia*, Cancrini L. (a cura di), Torino, Boringhieri, 1977; *Il doppio legame*, Szulzki C., Ransom D. C. (eds.), Roma, Astrolabio, 1979).
- (7) BEELS, C., FERBER, A., "What Family Therapists do", in *The Book of Family Therapy*, Ferber, A., Mendelshon, M., Napier A. (eds.), Boston, Sentry Edition, Houghton Mifflin Company, 1973, pp. 168-232.
- (8) BERTALANFFY, L. von, *Teoria generale dei sistemi*, Milano, iLi, 1971.
- (9) BOSZORMENYI-NAGY, I., "Modi e significati relazionali", in *La Famiglia: Patologia e Terapia*, Zuk G. H., Boszormenyi-Nagy (eds.), Roma, Armando, 1970, pp. 101-122.
- (10) BOSZORMENYI-NAGY, I., "Una teoria dei rapporti: speranza e transazione", in *Psicoterapia intensiva della famiglia*, Boszormenyi-Nagy I., Framo J. L. (eds.), Torino, Boringhieri, 1969, pp. 60-114.
- (11) BOSZORMENYI-NAGY, I., "Il processo della terapia familiare intensiva", in *Psicoterapia intensiva della famiglia*, op. cit., pp. 115-170.
- (12) BOSZORMENYI-NAGY, I., SPARK, G. M., *Invisible Loyalties*, Hagerstown, Maryland, Harper and Row, 1973.
- (13) BOSZORMENYI-NAGY, I., "Dialectic of Intergenerational Family Therapy", ciclostilato. Pubblicato in Atti del 4° Simposio Internazionale di Terapia Familiare di Zurigo, ottobre 1975, EHE, *Zentralblatt fur Ehe und Familienkunde* 3/4, 1975.
- (14) BOWEN, M., "Interpretazione della schizofrenia dal punto di vista della struttura familiare", in *Eziologia della schizofrenia*, a cura di D. D. Jackson, Milano, Feltrinelli, 1964, pp. 421-452.

- (15) BOWEN, M., "Psicoterapia familiare nel trattamento della schizofrenia in ospedale e nella pratica privata", in *Psicoterapia intensiva della famiglia*, op. cit., pp. 242-273.
- (16) BOWEN, M., "The Use of Family Theory in Clinical Practice", in *Changing Families*, Haley J. (ed), New York, Grune and Stratton, 1971, (trad. it., in volume di prossima pubblicazione presso la casa editrice Astrolabio a cura di Andolfi, M., e de Nichilo, M.).
- (17) BOWEN, M., "Toward the Differentiation of Self in One's Family of Origin", in *Georgetown Family Symposia*, vol. 1 (1971-1972). *A Collection of Selected Papers*, Andres F. D., Lorio J. P. (eds.), Washington, 1974, pp. 70-86 (trad. it., volume cit.).
- (18) BOWEN, M., "Principi e tecniche di terapia familiare multipla", in *Terapia Familiare*, 1, giugno 1977, pp. 129-150.
- (19) BOWEN, M., "Theory in the Practice of Psychotherapy", in *Family Therapy and Practice*, Guerin P. J. (ed), New York, Gardner Press. Inc., 1976, pp. 42-90 (trad. it. volume cit.).
- (20) BOWEN, M., "Il processo di proiezione di immaturità nella formazione di un sistema schizofrenico", in *Terapia Familiare*, 3, giugno 1978, pp. 75-80.
- (21) FOGARTY, T., "Fusion in the Family System", in *Georgetown Family Symposia*, op. cit., pp. 42-48.
- (22) Group for Advancement of Psychiatry, *The Field of Family Therapy*, New York, G. A. P., Publications Office, 1970.
- (23) GUERIN, P.J., PENDAGAST, E. G., "Evaluation of Family System and Genogram", in *Family Therapy. Theory and Practice*, op. cit., pp. 450-464.
- (24) HALEY, J., *The Strategies of Psychotherapy*, New York, Grune and Stratton, 1963 (trad. it., *Le strategie della psicoterapia*, Firenze, Sansoni, 1974).
- (25) HALEY, J., "Verso una teoria dei sistemi patologici", in *La Famiglia: Patologia e Terapia*, op. cit., pp. 31-55.
- (26) HALEY, J., "A Review of the Family Therapy Field", in *Changing Families*, op. cit., pp. 1-12.
- (27) HALEY, J., *Uncommon Therapy. The Psychiatric Techniques of Milton Erickson*, New York, Norton W. W. and Co, 1973 (trad. it. *Terapie non comuni*, Roma, Astrolabio, 1976).
- (28) HALEY, J., *Problem-Solving Therapy*, San Francisco, Jossey-Bass Publ., 1976.
- (29) HOWELLS, J., *Family Psychiatry*, Springfield, Ill., Thomas, 1963.
- (30) JACKSON, D. D., "The Question of Family Homeostasis", in *Psychoanalytic Quarterly Supplement*, 1957, 31, parte 1, pp. 79-90 e in *Human Communication*, Jackson D. D. (ed), Palo Alto, Science and Behavior Book, Inc., 1968, vol. I, pp. 1-11.
- (31) JACKSON, D. D., "The Study of the Family", in *Family Process*,

- 1965, 4:1-20 (trad. it., *La prospettiva relazionale*, Watzlawick P., Weakland, J. H. (eds), Roma, Astrolabio, 1978, pp. 14-34).
- (32) JACKSON, D. D., SATIR, V., "A Review of Psychiatric Development in Family Diagnosis and Family Therapy", in *Human Communication*, op. cit., vol. II, pp. 249-270.
- (33) KENNEDY, J.H., "Message from the President of the United States relative to Mental Illness and Mental Retardation", in *The American Journal of Psychiatry*, febbraio 1964, pp. 729-737.
- (34) KERR, M. E., "An Evolutionary View of the Emotional System", in *Georgetown Family Symposia*, op. cit., pp. 112-118.
- (35) KUHN, T. S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, Einaudi, 1969.
- (36) LAING, R., *The Self and Others*, Londra, Tavistok Publications, 1959 (trad. it., *L'io e gli altri*, Firenze, Sansoni, 1973).
- (37) LAING, R., ESTERSON, A., *Sanity, Madness and the Family*, Londra, Tavistock Institute of Uman Relations, 1964 (trad. it., *Normalità e follia nella famiglia*, Torino, Einaudi, 1970).
- (38) LAING, R., "Mistificazione, Confusione e Conflitto", in *Psicoterapia Intensiva della famiglia*, op. cit.
- (39) LEVY-STRAUSS, C., *Antropologia Strutturale*, Milano, Il Saggiatore, 1966.
- (40) LIDZ, T., CORNELISON, A., TERRY, D., FLECK, S., "Intrafamilial Environment of the Schizophrenic Patient. IV. The Transmission of Irrationality", in *Archives of Neurology and Psychiatry*, 1958, 79:305-316.
- (41) MALONE, T. P., WHITAKER, C., WARKENTIN, J., FELDER, R. E., "Rational and Non Rational Psychotherapy" in *American Journal of Psychotherapy*, 1961, vol. XV, 2:212-220.
- (42) MENGHI, P., "L'approccio strutturale nella terapia con la famiglia", in *Terapia Familiare*, 1, giugno, 1977, pp. 53-74.
- (43) MINUCHIN, S., MONTALVO, B., GUERNEY, B. G., ROSMAN, B.L., SCHUMER, F., *Families of the Slums*, New York, Basic Books, 1967.
- (44) MINUCHIN, S., "Family Therapy: Technique or Theory?", in *Science and Psychoanalysis*, vol. XIV, pp. 179-187.
- (45) MINUCHIN, S., *Families and Family Therapy*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1974 (trad. it., *Famiglie e Terapia della famiglia*, Roma, Astrolabio, 1976).
- (46) MINUCHIN, S., "Structural Family Therapy", in *American Handbook of Psychiatry*, vol. III, Revised Edition, Caplan G. (ed), New York, Basic Book, 1974, pp. 178-192.
- (47) MINUCHIN, S., "L'uso di un'ottica ecologica nel trattamento del bambino", in *Terapia Familiare*, 1, giugno, 1977, pp. 151-167.
- (48) NAPIER, A., WHITAKER, C., "A Conversation about Co-Therapy",

KATIA GIACOMETTI

- in *The Book of Family Therapy*, op. cit., pp. 480-506.
- (49) NAPIER, A., WHITAKER, C., "Problems of the Beginning Family Therapist", in *Techniques of Family Psychotherapy*, Bloch D. (ed), New York, Grune and Stratton, 1973, pp. 109-121.
- (50) PIPERNO, R., "La funzione della provocazione nel mantenimento omeostatico dei sistemi rigidi", in *Terapia Familiare*, 5 giugno 1979, pp. 39-50.
- (51) RITTERMAN, M. K., "Classificazione paradigmatica delle teorie di terapia familiare", in *Terapia Familiare*, 2, dicembre 1977, pp. 105-134.
- (52) RUESCH, J., BATESON, G., *Communication. The Social Matrix of Psychiatry*, New York, Norton W. W. and Co, 1951 (trad. it., *La matrice sociale della psichiatria*, Bologna, Il Mulino, 1976).
- (53) SELVINI PALAZZOLI, M., BOSCOLO, L., CECCHIN, G., PRATA, G., *Paradosso e controparadosso*, Milano, Feltrinelli, 1975.
- (54) SELVINI PALAZZOLI, M. e coll., *Il mago smagato*, Milano, Feltrinelli, 1976.
- (55) SELVINI PALAZZOLI, M., "La famiglia dell'anoressica e la famiglia dello schizofrenico: uno studio transazionale", in *Terapia Familiare*, 1, giugno 1977, pp. 29-41.
- (56) SELVINI PALAZZOLI, M., et al., "La prima seduta di una terapia familiare sistemica", in *Terapia Familiare*, 2, dicembre 1977, pp. 5-13.
- (57) SELVINI PALAZZOLI, H., "Family Rituals: A Powerful Tool in Family Therapy", in *Family Process*, 4, 1977, pp. 445-454.
- (58) SELVINI PALAZZOLI, M., "A ritualized prescriptions in Family Therapy: odd days and even days", in *Journal of Marriage and Family Counseling*, 3, 1978, p. 3-10.
- (59) SELVINI PALAZZOLI, M., "Terapia della famiglia a transazione schizofrenica. Il controllo terapeutico del sovrasisistema famiglia-terapisti", in *Terapia Familiare*, 3, giugno 1978, pp. 67-74.
- (60) SELVINI PALAZZOLI e coll., "I trabocchetti delle istituzioni", in *Terapia Familiare*, 4, dicembre 1978, pp. 43-57.
- (61) SPIEGEL, J., BELL, N., "The Family of the psychiatric Patient", cit. in Erickson G. D. e Hogan T. P. (eds), *Family Therapy. An Introduction to Theory and Technique*, Monterey, California, Brooks/Cole Publ., 1972, p. 2 (trad. it., in *Manuale di psichiatria*, Arieti S. (ed), Torino, Boringhieri, 1969, vol. I, pp. 64-102).
- (62) STANTON, D., "Sintesi e commento del modello di Andolfi verso un'integrazione tra intervento strutturale e paradossale", in *Terapia Familiare*, 5, giugno 1979, pp. 51-54.
- (63) SULLIVAN, H. S., *Conceptions of Modern Psychiatry*, William Alan-son White Psychiatric Fnd., 1947 (trad. it., *La moderna concezione della psichiatria*, Milano, Feltrinelli, 1961).

- (64) SULLIVAN, H. S., *The Interpersonal Theory of Psychiatry*, New York, Norton, 1953 (trad. it., *Teoria interpersonale in psichiatria*, Milano, Feltrinelli, 1972).
- (65) WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. H., JACKSON, D. D., *Pragmatics of Uman Communication*, New York, Norton, 1967 (trad. it., *Pragmatica della comunicazione umana*, Roma, Astrolabio, 1971).
- (66) WATZLAWICK, P., WEAKLAND, J. H., FISCH, R., *Change*, New York, Norton, 1974, (trad. it., *Change*, Roma, Astrolabio, 1974).
- (67) WEAKLAND, J. H., FISCH, R., WATZLAWICK, P., BODIN, A., "Brief Therapy: Focused Problem Resolution", in *Family Process*, 1974, 13:141-168 (trad. itl, in *La prospettiva relazionale*, op. cit., pp. 278-307).
- (68) WERTHEIM, E. S., "Family Therapy and the Science and Typology of Family Systems", in *Family Process*, 1973, 12:361-376.
- (69) WHITAKER, C., "Psicoterapia dell'assurdo", in *Terapia Familiare*, 1, giugno 1977, pp. 111-128.
- (70) WHITAKER, C., "A Family is a Four Dimensional Relationship", in *Family Therapy. Theory and Practice*, op. cit., pp. 182-192.
- (71) WHITAKER, C., "The Hindrance of Theory in Clinical Work", ibidem, pp. 154-164.
- (72) WHITAKER, C., "Il margine in più", in *Tecniche di terapia con la famiglia*, Haley, J., Hoffman L. (eds), Roma, Astrolabio, 1974, pp. 241-326.
- (73) WHITAKER, C., FELDER, R., WARKENTIN, J., "La controtras-lazione nel trattamento familiare della schizofrenia", in *Psicoterapia intensiva*, op. cit., pp. 346-364.
- (74) WHITAKER, C., "Coterapia di un caso di schizofrenia", in *Terapia Familiare*, 3, giugno 1978, pp. 107-119.
- (75) WIENER, N., *Cybernetics*, New York, John Wiley & Sons, 1948 (trad. it., *Cibernetica*, Milano, 1970).
- (76) WYNNE, L., RYCKOFF, I., DAY, J., HIRSCH, S., "Pseudomutuality in the Family Relations of Schizophrenics", in *Psychiatry*, 1958, 21:205-220.

La intervención terapéutica y las premisas de un cambio real en la relación humana

PHILIPPE CAILLE

Médico Director del Centro de Asistencia Familiar de Sagena, Drøbakst 1, Oslo 4 (Noruega)

Traducido por: Lic. Stella Maris Molina

"Lo que es primordial es aceptar que las ideas (en un sentido muy general del término) poseen su propia realidad. Son todo lo que podemos saber y no podemos saber nada más. Las conexiones o las "leyes" que relacionan las ideas entre sí, las llamamos "verdades". Están tan cerca de la realidad última como nos es posible llegar".

Gregory Bateson. "Mind and Nature"

Si miramos sobre el pasado de las familias o el de las naciones, no es excepcional encontrar la prueba de cambios súbitos en el modo de funcionamiento de esos sistemas humanos.

La importancia de esos períodos de cambio está subrayada por el hecho de que, a menudo, están caracterizados por la desaparición de ciertos dogmas y también por la aceptación de nuevas creencias y nuevas percepciones del mundo. Aunque no podamos controlar ni el advenimiento ni el contenido de esos cambios, parece retrospectivamente que suelen tener un efecto benéfico en lo que concierne a la supervivencia y al funciona-

miento de los sistemas humanos. El mantenimiento rígido de ciertas reglas y creencias con exclusión de toda otra en el interior de un sistema, tarde o temprano entra, efectivamente, en conflicto con las necesidades de los participantes. Estados de tensión y síntomas de angustia aparecerán si las necesidades del individuo son tan diferentes de las exigencias de la colectividad que la distinción misma entre esas dos demandas se vuelve peligrosa de enunciar.

Un objetivo terapéutico importante es entonces promover el cambio en el interior de los sistemas humanos. Sin embargo se trata de una tarea difícil que promueve preguntas de una complejidad mayor que la naturaleza imaginable de cambios que podría proponerse. Los sistemas humanos parecen extremadamente resistentes a la imposición de orientaciones seleccionadas con anticipación. Además semejante imposición tendería más a provocar una adaptación superficial que un verdadero cambio específico. Será necesario más bien investigar los mecanismos internos que alteran la facultad del sistema de someterse al cambio y por eso mismo de sobrevivir, literalmente o funcionalmente. Tales mecanismos deben figurar en el centro de nuestra exploración y de nuestro esfuerzo terapéutico.

En consecuencia puede ser útil revisar brevemente algunas hipótesis de base sobre la naturaleza y la dinámica de la relación humana antes de abordar la cuestión de la inducción terapéutica de las condiciones del cambio.

1. Naturaleza y dinámica de las relaciones humanas

1.1. La esencia de la relación humana es la concepción misma de ese fenómeno en el espíritu humano.

Nuestra comprensión del funcionamiento de los grupos humanos se ha modificado recientemente de manera impresionante. Esto es tan válido tanto para los pequeños grupos como la familia o los grandes grupos como clases sociales o aún naciones. Se ha pasado de modelos estadísticos y exageradamen-

te simplificados a representaciones más adaptadas inspiradas en nuevas disciplinas como la cibernética. Estos nuevos modelos rinden cuenta de importantes características de los sistemas humanos. Ponen de manifiesto el carácter único de cada sistema, su estabilidad homeostática así como sus cualidades adaptativas. Sin embargo, esos modelos al principio son difíciles de comprender y de utilizar, en razón de que rechazan la lógica convencional y las evaluaciones cuantitativas. Pero como demostró Bateson en "Mind and Nature", lógica convencional y evaluaciones cuantitativas son medios inapropiados para la descripción de los organismos vivos y de sus interacciones.

Debemos descubrir palabras que describan los esquemas que mantienen la unidad de los miembros de la familia aún cuando atraviesan como individuos considerables cambios biológicos y psíquicos. Estos esquemas o estilos operacionales guardan a través del tiempo una forma identificable aunque sufran ciertas modificaciones. Tienen la importante propiedad de ser la manifestación exterior o la expresión de la concepción que la familia tiene de sí misma. La familia les otorga mucho valor y, a pesar de ciertas apariencias de querer desembarazarse de ellos, confirma repetitivamente su validez justamente porque testimonian la existencia de la relación misma. La modificación de algunos importantes esquemas puede ser sentida por la familia como un cuestionamiento de la naturaleza o aún de la supervivencia misma de la relación.

Los sistemas humanos son comparables en este punto a los cerebros electrónicos programados con una finalidad, en el sentido que constantemente aparecen en ellos datos de significación combinada. Todo elemento de información que aparezca en términos de similitud o de diferencia, concerniente a los participantes, al entorno, a acontecimientos pasados o actuales debe ser previamente comparado e integrado para tener sentido. La "historia" fabricada a partir de esos elementos de información crea y convalida a la vez la realidad de la interdependencia de los mismos.

Si se considera el aspecto del establecimiento de una relación humana, debería ser evidente que hay siempre un costado

accidental; en otros términos, existen algunos datos debidos únicamente al azar en la emergencia de los esquemas de funcionamiento de un sistema. Este hecho garantiza la originalidad de toda relación humana. Sugiere también la transformación potencial profunda de la relación, que puede suceder si los factores ya existentes son objeto de una apreciación completamente nueva y son puestos en relación de manera diferente.

Sin embargo este aspecto accidental de los vínculos humanos no es a menudo reconocido porque lo que nos informa de tales vínculos es explicado históricamente y parece ineluctable. De modo totalmente ilógico, se acuerda más importancia a los acontecimientos de la historia de la familia si tienen consecuencias, que reciben el nombre de legados o constreñimientos, que si esas mismas consecuencias faltan aunque hubieran podido ser esperadas. No obstante deberíamos saber que un acontecimiento sólo puede tener sentido en un contexto y que a menudo el contexto más que el acontecimiento mismo determina las consecuencias de este último.

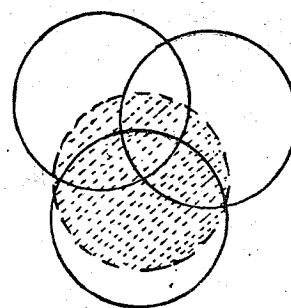
El terapeuta debería recordar que el establecimiento de una relación familiar es un proceso de alta complejidad. Por eso los conceptos mecanicistas de determinación histórica propuestos por ciertos autores parecen bastante improbables. Por ejemplo es posible que ciertos rasgos de comportamiento sean adoptados por varias generaciones sucesivas en tanto expresión metafórica de una concepción subyacente de la naturaleza de la relación familiar. En ese caso sería un error considerar lo que es expresión metafórica como real factor causal.

1.2. La representación de la relación que se crea en el espíritu humano no puede ser homogénea.

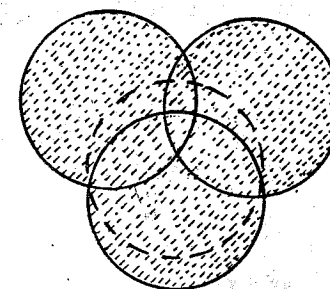
El conocimiento que tanto los participantes como los observadores pueden adquirir del fenómeno en sí mismo inaccesible de la relación humana, ha sido descripto por Bateson. Sugiere que la percepción humana por su naturaleza misma sigue una vía puntuada por la alternancia de dos actividades. Por un lado,

tenemos la observación y la experiencia de los procesos en curso, por el otro, la tipología lógica de esos procesos. Con un movimiento pendular de un tipo de actividad a la otra, el espíritu humano de alguna manera asciende los grados de dos escalas yuxtapuestas pero no imbricadas, en un camino en zig-zag. De un nivel de tipología, el camino va "al estudio de los procesos que han engendrado las diferencias resumidas en la tipología" y a un nuevo nivel de tipología (Bateson, 1979).

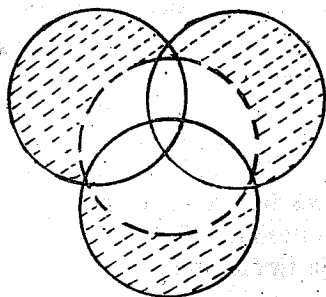
En nuestro contexto, esos niveles de tipología corresponden a diferentes niveles de concepción o de definición de la misma relación humana. Estos niveles coexistentes de descripción pueden ser ilustrados en una familia de tres miembros como muestra la figura 1, utilizando en versión modificada los diagramas de Venn. Al contrario de la lógica clásica, dos descripciones del mismo fenómeno conceden un mejor grado de precisión que una sola, pues al no pertenecer al mismo nivel lógico, no pueden entrar en contradicción o debilitarse una a la otra.



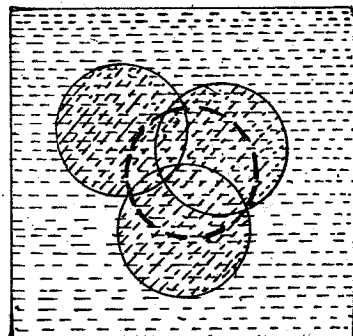
Percepción o definición de las reglas que rigen al desarrollo de una interacción.



Percepción o definición de las características de conjunto de la relación familiar.



Percepción o definición de los roles asumidos por los diferentes miembros del grupo familiar.



Percepción o definición del tipo y de la función del grupo familiar en el interior del medio social en que se inserta.

Por otro lado, la autonomía de los niveles de tipología implica que cada nivel posible de descripción es por sí mismo una explicación suficiente del fenómeno. La descripción de una familia que deja aparecer una clara disposición de roles, por ejemplo: padre autoritario, madre sumisa e hijos obedientes y respetuosos, pertenece al nivel B. La descripción de la misma familia como una familia de inmigrantes asiáticos que defiende sus características de minoridad contra una sociedad escandinava permisiva, pertenece al nivel D. Estas descripciones pueden coexistir o no. Todas las familias asiáticas de Escandinavia no tienen necesariamente una estructura patriarcal. Todas las familias escandinavas que tienen una estructura jerárquica marcada no pertenecen tampoco a la inmigración asiática. Por lo tanto estos niveles de descripción deben mantenerse separados si se desea evitar la confusión provocada por el establecimiento de relaciones causales entre elementos de información pertenecientes a niveles lógicos diferentes, o para decirlo de modo diferente, por la producción de paradojas.

1.3. Permanencia y flexibilidad, dos necesidades contradictorias con respecto a la relación humana.

El deseo de una cierta permanencia en la relación parece corresponder a una necesidad humana muy profunda. El sentimiento de acuerdo sobre la naturaleza de la relación está acompañado de una sensación de estabilidad y de armonía. Del mismo modo, un conflicto con respecto a los roles o a las reglas de la relación engendrará ansiedad y aparición de comportamientos desusados. Esto es enunciado por Shands de la manera siguiente: "Así nos encontramos con la paradoja sin fin de la búsqueda de la estabilidad y del equilibrio aunque sea fácil demostrar que equilibrio y estabilidad son sólo posibles en los sistemas inorgánicos, y aún en ellos de modo imperfecto. El equilibrio es incompatible con la vida y la adquisición de conocimientos" (Shands, 1971).

Este conflicto immanente penoso para los partícipes, puede sin embargo ser visto por el observador neutro como un signo de vitalidad y de potencial creativo de la relación humana. Debe admitirse que un cierto esfuerzo adaptativo es requerido a los seres humanos que tratan de establecer una relación común, puesto que esa relación crea en su concepción del mundo una nueva dimensión compartida en el porvenir de cada uno. Las relaciones de larga duración a las que pertenecen tradicionalmente las relaciones familiares, requieren varias redefiniciones en el curso de su existencia. Esto es inevitable si la familia debe integrar los cambios biológicos individuales que modifican su estructura tanto como enfrentar el advenimiento de conflictos interiores o de cambios en el contexto ambiente. Es importante observar que las situaciones de crisis parecen propicias a la renovación o a nuevas síntesis. Es posible que las relaciones que pecan de una extrema laxitud o de una extrema rigidez no puedan acceder a esos períodos transicionales y estén condenadas a repetir indefinidamente los mismos ciclos de interacciones. La aparición de nuevas síntesis es definida por Wilden como "un producto de la ultraestabilidad o de la

morfogénesis: la elaboración de nuevas estructuras por el efecto de actividades sistémicas" (Wilden, 1972).

Los sistemas rígidos, como lo veremos, a menudo registran la aparición del síntoma, pero la noción de la experiencia del estado de crisis aparece raramente.

2. La rigidez como la principal emboscada de la relación humana.

2.1. Cuando las defensas se transforman en trampas

No elegimos nuestra familia de la misma manera que optamos por un partido político, preparados para dejar esta organización si no responde más a nuestras expectativas. La familia es a sus miembros más bien lo que una nave espacial a su tripulación. El funcionamiento flexible del sistema entero es necesario para que los participantes puedan realizarse de manera óptima en los planos psíquicos, biológicos y sociales. Estar a bordo facilita a los integrantes las transiciones necesarias del desarrollo a medida que las etapas psicosexuales sucesivas son alcanzadas, por ejemplo la identificación masculina o femenina, la pubertad, la separación de la familia de origen. Esta pertenencia ayuda, además, a la aparición de actitudes e intereses particulares en cada uno. Como todo sistema vivo, la familia transforma sus componentes y por eso mismo se modifica a sí misma sin perder su identidad y su finalidad como contexto confiable para sus participantes.

Sin embargo las defensas pueden relevarse como trampas. Ocurre que los sistemas humanos desarrollan la importancia de uno de sus programas —la supervivencia— a expensas de los otros y por eso mismo comprometen sus posibilidades de adaptación. Esto corresponde al fenómeno de "run-away" en cibernética (Ashby, 1952). El desarrollo de los participantes es sacrificado por el mantenimiento incontestable de la relación. "Una familia disfuncional es un sistema que respondió a las demandas exteriores e interiores de cambio transformando

su funcionamiento en un estereotipo. Las demandas de cambio fueron anuladas por una reificación de la estructura familiar" (Minuchin, 1979). Sin embargo no hay que confundir una buena descripción con una explicación pertinente, y debemos admitir que sabemos muy poco sobre las razones que hacen que ciertos sistemas humanos continúen funcionando según su propio designio y otros no lo hagan. Por analogía con la cibernética es razonable pensar que ciertos factores causales son inherentes a los programas de los sistemas, mientras que otros son puramente accidentales. La superposición de varios factores puede precipitar un sistema humano en un "run-away". Por ejemplo, el nacimiento de un niño discapacitado en una familia notoriamente programada sobre la competencia o sacudida por la incertidumbre debida a una reciente desilusión puede conducir a consecuencias desastrosas. Otro importante concepto es que, conforme al principio de la equifinalidad, combinaciones de factores muy diferentes pueden conducir al mismo estado de disfunción sistémica.

Estudios de tipo prospectivo podrán aportar más conocimientos sobre las diferentes combinaciones de acontecimientos que pueden crear un estado de disfunción en un sistema humano y por consiguiente facilitar la elaboración de acciones profilácticas. Nuestra comprensión actual no se extiende mucho más allá de los fenómenos homeostáticos que perpetúan el estado de disfunción ya establecido y permiten esencialmente intervenciones de tipo curativo. El verdadero dilema para el terapeuta confrontado con un sistema rígido es: o tener que admitir la superioridad de las fuerzas homeostáticas en juego a las estrategias terapéuticas posibles, o reducirlas, transformando de nuevo la trampa en una defensa y liberando las posibilidades bloqueadas del sistema. La rigidez del sistema familiar es entonces no solamente la emboscada esencial de la relación familiar, sino también puede tener por efecto conducir a la relación terapéutica a una situación sin salida.

2.2. *Los triunfos familiares contra la persuasión terapéutica.*

2.2.1. "¡Ya que es un experto, díganos lo que hay que hacer!". Los miembros del grupo familiar pueden estar de acuerdo con el hecho de que sus vivencias de la relación familiar no concuerdan con la idea que podrían tener de una relación familiar normal. Sin embargo podrán estar en total desacuerdo en lo que concierne a las razones de tal situación. Semejantes períodos de la vida familiar dominados por el espectro de la disolución y el sentimiento de que algo debería ser emprendido, son sentidos como horribles situaciones de crisis. No obstante, como ya se ha mencionado, son períodos excepcionalmente creativos en los que nuevas concepciones de la relación pueden aparecer y formas hasta ese momento desconocidas de interacción pueden ser creadas.

La salida del estado de crisis recurriendo al especialista no representa seguramente una salida favorable. Las diferencias de opinión son ofrecidas al terapeuta para que las evalúe y las juzgue. Importantes acontecimientos sistémicos como por ejemplo la expulsión de un miembro del grupo familiar, pueden efectuarse bajo la apariencia de una decisión terapéutica. La crisis puede de ese modo atenuarse por un tiempo y la familia no siente más la necesidad de comprometerse más profundamente en el proceso terapéutico.

2.2.2. "Lo hemos intentado todo y nada sirve". La familia rechaza el principio de que todo sistema humano debería ser capaz de encontrar una solución a los problemas que aparecen en su seno. Toda persona que tenga alguna experiencia en terapia familiar conoce la fuerza de esta posición.

De manera sorprendente los argumentos presentados para sostener tal opinión son raramente convincentes aunque sean a menudo difíciles de rebatir. La mujer de un alcohólico suele así sostener que no puede dejar de comprar bebidas a su esposo o bien porque se encolerizará y molestará a los vecinos, o bien

porque debe ser el marido el que haga el primer movimiento para compensar las numerosas decepciones de la esposa.

Parece entonces que no es tanto la fuerza lógica de esos argumentos sino su presentación táctica lo que representa un problema para el terapeuta. Una acción emprendida a un nivel de la interacción relacional es presentada como una intervención a otro nivel. Una familia puede por ejemplo contar el episodio del padre dándole un regalo importante a su hijo mayor, al mismo tiempo que le otorgan la significación de una imitación sarcástica de costumbres que critican en sus vecinos. Confrontado con esta práctica extrema de la presentación paradójica, el terapeuta se encuentra, como los miembros del grupo familiar, en la imposibilidad de confirmar o de refutar tales alegatos. Se trata de una situación de doble vínculo basada en la confusión de niveles lógicos diferentes. "El efecto de todo salto de nivel, hacia arriba o hacia abajo, es que la información apropiada como elemento de decisión en un nivel será utilizada para tomar una decisión en cualquier otro nivel, una variedad común de error en la tipología lógica" (Bateson, 1979).

2.3. *Desenmascarar la emboscada reemplazando la persuasión terapéutica por la comprensión sistémica.*

En tales situaciones sería imposible refutar la argumentación de impotencia introducida por la familia sin caer en la crítica o tomar a su cargo la responsabilidad de la situación. Sin embargo es posible utilizar las explicaciones dadas por la familia como medio de comprensión de las convicciones que subtienden su organización sistémica. El enredo masivo de los argumentos que es responsable de la incapacidad de cambio es también un punto débil que vuelve a la familia vulnerable a las intervenciones terapéuticas dirigidas hacia esta particularidad.

3. La rigidez en tanto punto vulnerable de la relación humana patológica.

3.1. *Una familia rígida es una familia que tiene una visión rígida de sí misma.*

Como se afirma en la cita de Bateson colocada como epígrafe, todo lo que podemos decir es acerca de la rigidez de la autorrepresentación de la familia. El carácter inflexible y monolítico de semejante representación es el resultado de la yuxtaposición de parcelas de información pertenecientes a niveles lógicos completamente diferentes. Por ejemplo, el hecho de que un muchacho descuide cumplir con las tareas que le incumben en la casa no es puesto en relación con el monto insuficiente del dinero que recibe semanalmente, sino visto como el éxito del péfido esfuerzo de la madre para deteriorar la autoridad del padre o la confirmación de la incapacidad de la familia para establecerse en un nuevo medio.

Lo que Watzlawick considera ser característico de las dictaduras es también válido para las familias rígidas (Watzlawick y col., 1975). Se infringen a sí mismas y a sus allegados las consecuencias de un salto constante de niveles de referencia, circunstancia en la cual una red masiva de paradojas asegura el estado de no cambio aunque el deseo de cambio sea ampliamente afirmado. La rigidez ligada al pensamiento paradójal que protege a la familia contra la rebelión interior y contra las influencias externas implica sin embargo una vulnerabilidad por el hecho mismo de la falta de adaptación posible. El problema es hacer fracasar la paradoja con la contraparadoja (Selvini y col., 1978).

3.2. *Modelo fenomenológico y modelo mítico.*

Para llegar a la contraparadoja, debemos primero comprender la naturaleza de la paradoja tratando de separar groseramente algunos niveles jerárquicamente organizados en el conjunto de

las convicciones familiares compartidas. En un artículo precedente hemos propuesto alcanzar ese objetivo por medio del establecimiento de un modelo fenomenológico y de un modelo mítico para cada familia estudiada (Caillé, 1980).

Los esquemas de interacción descriptos por el modelo fenomenológico pueden parecer inútiles o destructivos. Esos modos de reacción y de comportamiento adquirirán sentido cuando otros niveles de representación sean distinguidos y representados por el modelo mítico de la familia.

Aquí puede ser útil notar la similitud evidente entre la terapia familiar y la investigación etnológica. En su libro "Tristes Trópicos", Lévi-Strauss describe una sociedad de indígenas de la meseta del Brasil Central, los Bororos (Lévi-Strauss, 1955). Muchas reglas y disposiciones practicadas pueden parecer tan poco prácticas como lógicas al recién llegado. Chozas idénticas están colocadas en círculo alrededor de una choza mucho más grande. La choza central, el "Baitemannageo" es "la casa de los hombres", donde duermen los solteros y donde los hombres casados pasan la mayor parte del tiempo cuando no están cazando o pescando. Las mujeres tienen prohibido el acceso a esta choza. Ellas viven en las chozas de la periferia con los hijos. Entonces los maridos deben hacer el trayecto entre la choza central y su choza familiar varias veces en el curso de la jornada.

Sería cómodo transformar este conjunto de comportamientos (modelo fenomenológico) en algo más práctico. De hecho, algunos misioneros obligaron a varias tribus a abandonar su pueblo y a vivir en estructuras más modernas donde las familias viven en casas dispuestas en hileras paralelas según el modelo de nuestras calles. Padre, madre e hijos tienen así la experiencia de vivir juntos a imagen de nuestra familia nuclear occidental. El resultado inesperado es que los indios presentan síntomas de profundo desorden. Parecen incapaces de conservar su identidad y sus hábitos. Se someten cómodamente a toda forma de presión y de persuasión y se vuelven proclives al alcoholismo y a la prostitución. No se trata de un cambio sistémico en el sentido propio sino de la integración de un sistema.

PHILIPPE CAILLE

La explicación de este fenómeno es que el habitat (parte del modelo fenomenológico) está en el nivel más bajo de una jerarquía extremadamente complicada de sistemas conceptuales compartidos por los indios. El círculo trazado por las chozas está, en sus espíritus, dividido en dos por un diámetro paralelo al río más cercano. Este diámetro divide la tribu en dos partes: los "Ceras" y los "Tugares". Esta distinción es fundamental porque un individuo pertenece siempre a la misma parte que su madre, pero solamente puede casarse con un miembro de la parte opuesta. Si mi madre es una Cera, yo soy también un Cera y no puedo casarme sino con una Tugare. Los hombres abandonan la casa donde nacieron cuando llegan a la pubertad para ir a vivir en la choza central. Más tarde, luego del casamiento, pasan al otro territorio. La disposición del pueblo tiene entonces una significación en tanto organización sociológica, y en otras extensiones demasiado complejas para ser mencionadas aquí, condensa y afirma la relación entre hombre y universo (modelo mítico). Vemos entonces que ingerencias en apariencia pragmáticas que se funden únicamente en el modelo fenomenológico pueden llevar a una organización sistémica a desintegrarse, en razón de que tales intervenciones no toman en consideración las creencias subyacentes representadas en el modelo mítico, modelo que gobierna de hecho el sistema.

En el contexto de una terapia, la familia podrá interrumpir el contacto o descalificar al terapeuta, oponiéndose de este modo victoriosamente a las intervenciones puramente fenomenológicas. Es necesario saber aislar los diferentes niveles de integración sistémica que sobredeterminan la formulación del síntoma si se tiene como objetivo el cambio sistémico. Esto puede ser realizado imponiéndose la formulación de un modelo fenomenológico y un modelo mítico de la familia considerada. Esta dualidad se resuelve en la superposición jerárquica de esos dos niveles en la contraparadoja, en tanto la posición dominante sea correctamente atribuida al modelo mítico.

3.3. *El uso de la contraparadoja como intervención*

La contraparadoja contiene siempre de manera bastante extraña una aceptación de las creencias familiares existentes en tanto organización sistémica de supervivencia aceptable. La posición contraparadojal es, en esencia, que el deseo comprensible que la familia tiene de preservar las convicciones que comparte con respecto a su origen, su lugar en la sociedad, sus tradiciones (modelo mítico) constituye un obstáculo para la modificación del modelo fenomenológico, y por eso mismo vuelve improbable, o al menos indeseable, la desaparición del síntoma. Las tesis familiares son corroboradas sin que se tome posición en cuanto a la necesidad del síntoma. Está sobreentendido que los miembros de la familia quieren intrínsecamente el bien de los unos a los otros y que ese género de apreciación, como todo juicio de valor, les está totalmente delegado.

Parece perfectamente justificado desde un punto de vista lógico admitir que las creencias y los contextos de aprendizaje de las familias que buscan ayuda no son más incoherentes o absurdos que en el caso de los Bororos. Cuando esto se acepta acompañado de una connotación positiva del rol del portador del síntoma, la familia se halla colocada en una situación de doble vínculo terapéutico y el estado de crisis es reintroducido. Si la familia acepta la validez que el terapeuta da a sus creencias, no puede considerar más al síntoma como un "síntoma" y deben dejar de utilizar al portador del síntoma como la explicación del malestar general sentido por la familia. Si la familia objeta la validez de sus creencias, implica una reformulación de las creencias familiares y un verdadero cambio a todos los niveles conceptuales.

La validación contraparadojal puede ser administrada de manera más o menos explícita. Parece ser importante sobre todo la estabilidad en la formulación de base de la justificación del síntoma, es decir la manera en la cual los niveles lógicamente más elevados de autorrepresentación que figuran

en el modelo mítico, imponen el nivel inferior expresado en el modelo fenomenológico.

La prescripción directa de la continuación del síntoma es una apreciación positiva no disfrazada de su importancia para la familia. La atmósfera de las sesiones, el tipo de preguntas formuladas por el terapeuta, el uso del espejo unidireccional y las conversaciones en el curso de las sesiones con los observadores pueden ser perfectamente suficientes para transmitir el mismo mensaje con un modelo analógico. De todos modos, ese mensaje debe ser repetido y amplificado de diferentes maneras en el curso de las sucesivas sesiones.

4. ¿Para qué sirve la hemorragia intestinal de Laura?

Laura es una niña de 12 años que sufrió los dos últimos años de colitis ulcerosa severa con defecaciones frecuentes, diarreas hemorrágicas y dolores abdominales. Su rostro redondo y su aparente obesidad revelan un tratamiento prolongado con corticoides asociados a la salicilosulfapiridina. Su conducta se modificó notablemente desde el comienzo de la enfermedad. Era alegre y activa. Ahora rechaza ir a la escuela y se aísla de sus amigas. Los cinco miembros de la familia que viven bajo el mismo techo participan de las sesiones, Laura, su hermano Conrado (8 años), el padre (45 años), la madre (35 años), y la abuela materna (58 años) que es propietaria de la casa.

El señor Petersen es un experto en relaciones comerciales. Es un hombre corpulento de modales reservados. Cuando interviene en sesión lo hace de manera demostrativa, sumisa pero un poco distante. La abuela, una señora de conducta sorprendentemente despreocupada y joven, se mantiene ostensiblemente en un segundo plano y muestra así que deja el primer plano de la escena a su hija.

Los dos últimos protagonistas son los más activos. Conrado está agitado. Se aburre rápidamente y parece bastante exigente con respecto a los adultos. La señora Petersen parece ten-

sa e inquieta. Su preocupación principal parece ser la de comunicar a los terapeutas una impresión correcta de los problemas de la familia que ella misma relata a los niños. Claramente ella espera que su marido soporte su versión de las cosas, pero, a pesar de sus maneras marcadamente autoritarias, el soporte del marido es mínimo. Tal como la presenta, la vida de la señora Petersen no ha sido más que un continuo surmenage los últimos quince años, aunque abandonara su trabajo de secretaria cuando se casó. Haciendo caso omiso de las expresiones de sorpresa de su marido y de su madre, se demora en una larga serie de acontecimientos traumatizantes. Entre éstos incluye el deseo que tenía su marido de que ella se quedara en la casa y los cuidados que tuvo que prodigar a diferentes familiares alejados. Actualmente está preocupada sobre todo por la enfermedad de Laura o, más exactamente, por la falta de eficacia del tratamiento. Casi tan preocupante es la insubordinación de Conrado. Este la enfrenta constantemente cualquiera sea la actitud que ella adopte. Como él no quiere obedecer más que a su padre, sus peleas terminan en llamadas telefónicas desesperadas al marido al cual exige volver inmediatamente a la casa si no quiere tener la responsabilidad de su suicidio.

El modelo fenomenológico parece bastante claro. El simulacro de autoridad de la señora Petersen es un elemento que es soportado por todos. Las cóleras de Conrado revelan la fragilidad de su poder y hacen que el padre vuelva a la familia. La llegada de éste sin embargo está acompañada de rencor. Para prevenir un desfallecimiento por ese lado, la señora Petersen está obligada a formular amenazas cada vez más dramáticas que no hacen más que acrecentar el resentimiento de su marido. La enfermedad de Laura tiene como efecto evidente detener o reducir esta escalada entre los esposos. Su enfermedad es a la vez objeto de preocupación y una amenaza para todos los participantes. Las rabietas de Conrado parecen menos importantes, los padres tienen la ocasión de compartir alguna ansiedad y un problema real, la madre de la señora Petersen puede demostrar un poco de comprensión por la agitación.

de su hija. Sin embargo esta solución resulta imposible pues la condición de Laura es tan severa que se vuelve un fardo suplementario para todos.

Para establecer la contraparadoja es necesario descubrir cómo la enfermedad de Laura puede ser una tentativa de solución apropiada a las contradicciones propias del contexto familiar determinado. Una intervención no específica en el nivel fenomenológico definiendo por ejemplo la enfermedad de Laura como un medio de detener el creciente conflicto entre los esposos, sería rechazada con razón por la familia como poco convincente e hipotética. Por el contrario, la justificación del síntoma por el hecho de la superposición de niveles jerárquicos de las convicciones de esta familia, tendrá por efecto provocar una crisis y promover un cambio.

Con el objeto no de llegar a una comprensión completa ilusoria de la familia, sino de establecer un modelo mítico, examinemos los contextos de orientación familiares, las posibles líneas orientadoras.

La madre de la señora Petersen se divorcia cuando su hija tiene 3 años a causa del alcoholismo del marido. La señora Petersen será entonces la hija única de una madre sola sin ninguna relación con una figura masculina. Su padre no estableció nunca ningún contacto con ella y su abuelo murió tempranamente.

El señor Petersen es también en los hechos un hijo único educado por el padre del mismo sexo. Luego que una pequeña hermana murió de raquitismo, su madre se retiró a vivir en el campo con otro hijo discapacitado mentalmente, dejándolo en la ciudad al cuidado de su padre, un hombre religioso y severo.

El señor y la señora Petersen deciden entonces establecer una relación conyugal sin conocimiento concreto de lo que implica, puesto que tal relación falta en sus respectivos medios de origen. Es probable que este casamiento represente una suerte de desafío puesto que sus únicos modelos (el padre del señor Petersen y la madre de la señora Petersen) son evidentemente dos personas incapaces de adaptarse a un cónyuge. Se

puede emitir la hipótesis de que el señor y la señora Petersen también ven su matrimonio como un rechazo de las condiciones de sus respectivas infancias y como un progreso para la célula familiar. Tienen grandes dificultades en sus relaciones, pero también les sería muy difícil separarse puesto que eso significaría el retorno al comportamiento de la generación precedente. De este modo los problemas que oponen al señor y a la señora Petersen no deben ser considerados como una simple disensión conyugal que sólo concierne a los esposos, sino como un conflicto simbólico mayor. Lo que está en juego es la manera en que abuelos, padres e hijos van a concebirse a sí mismos y a concebir su familia.

Siguiendo esta línea de razonamiento, podemos comprender las cóleras de Conrado como destinadas a consolidar el matrimonio, pero arribando finalmente a una situación sin salida. El intestino de Laura comienza entonces a sangrar, ofreciendo así un último recurso a los padres atormentados por un matrimonio problemático.

El tratamiento, que aportó un resultado positivo, duró 9 sesiones repartidas a lo largo de un período de 9 meses. La intervención principal fue imponer la imagen de Laura como una niña extremadamente seria, extremadamente responsable que de buen grado se había atribuido una misión completamente desproporcionada para su edad. Verdaderamente ella quería aprehender el significado del matrimonio de sus padres y de sus vicisitudes, pues pensaba que eso tenía importancia para todos los miembros de la familia. Aunque la realización de su proyecto fuera sin ninguna duda imposible, era importante que hiciera ella misma el descubrimiento, y eso se produciría más rápidamente dándole la oportunidad de reflexionar sobre el particular que impulsándola a retornar a una actividad normal. Los padres deberían entonces controlar que, cada vez que Laura expresara el deseo eventual de una actividad aparentemente normal, ese deseo se compruebe ser absolutamente sincero y no una piadosa mentira destinada a tranquilizar a los padres. Los disturbios intestinales de Laura eran apa-

rentemente una manera de expresar una preocupación oculta que debería aparecer al descubierto.

El estado de Laura mejoró al punto que ella exigió retomar todas sus actividades anteriores y fue autorizada por el pediatra a dejar de tomar toda medicación. Conrado se volvió menos discutidor y los padres revelaron ciertas dificultades sobre las que años atrás se habían puesto de acuerdo en considerarlas como un hecho ineluctable que no debía ser mencionado jamás. Al final de la terapia Laura no presentaba más ningún síntoma y los padres aceptaron participar en una terapia conyugal de grupo para continuar mejorando su relación.

Para nosotros el punto importante es la elaboración de un modelo mítico suficientemente específico para poder imponer la prescripción más o menos explícita del no cambio a nivel fenomenológico y así establecer el doble vínculo terapéutico. Las intervenciones sistémicas pueden ser de naturaleza extremadamente diferentes y conducir sin embargo al mismo resultado favorable.

Conclusión

Los problemas terapéuticos están constantemente ligados a la cuestión del cambio y de los factores que lo favorecen.

Se podría discutir la importancia de la terapia familiar si su definición se limitara al tratamiento conjunto de todos los miembros de la familia en lugar de ver separadamente al portador del síntoma. Semejante abordaje es de hecho muy equivocado si no se acompaña de una renovación de nuestra comprensión epistemológica. Si no ese abordaje correrá el riesgo de ser, o bien pedagógico (enseñando a la familia lo que debería saber), o bien interpretativo (revelando a la familia lo que traba su desarrollo). No obstante hay excelentes razones para creer que los sistemas humanos, aún más que los individuos, son refractarios a ese tipo de información.

Parece entonces necesario relacionar el concepto de terapia familiar con el de una nueva comprensión epistemológica.

La visión sistémica de la dinámica de los grupos humanos presentada en este artículo (la comprensión de la manera en que los grupos humanos piensan y toman decisiones) representa, en el desarrollo actual de nuestros conocimientos, una base teórica extremadamente preciosa. Vuelve comprensible la manera con la que los sistemas rígidos organizan su resistencia al cambio y permite el descubrimiento de nuevas técnicas útiles para destruir los círculos homeostáticos indeseables, creando así las condiciones de un cambio.

Summary

The purpose of this paper is to stress our belief that therapeutic intervention does not have the power to create durable, predetermined changes in human systems. Still, a number of therapists seem to feel that certain adjustments are necessary if improvement is to occur and try to convince families to adopt them. Such partial moves ignore the question of what has prevented the family from discovering such beneficial adaptations on its own.

We suggest that the basic rules of the family prohibit it from changing. To stimulate the inherent healing capacities of human systems, a preferable goal might be to validate the present functioning of the family through an understanding of the different levels of its self perception (phenomenological model, mythical model). If this is done effectively, a possible reformulation of the relationship is truly facilitated. Relations between the participants will continue, but will no longer be what they were before. The effectiveness of the intervention is confirmed by the appearance of new beliefs, new perceptions. Any behavioral modifications shown by family members are logical consequences of their new conception of the relationship, not the causes of it.

Bibliografía

- ASHBY, W. R.: Design for a Brain. Chapman and Hall, Ltd., London, 1952.
BATESON, G.: Mind and Nature. E. P. Dutton, New York, 1979.
CAILLE, P.: "Phase d'évaluation en thérapie familiale systémique" en

"Changements systémiques en thérapie familiale", Annales de Psychothérapie. Editions E.S.F., 1980.

LEVY-STRAUSS, C.: Tristes tropiques. Librairie Plon, Paris, 1955.

MINUCHIN, S.: Familles en thérapie. Ed. Delarge, 1979.

SELVINI PALAZZOLI, M.; BOSCOLO, L.; CECCHIN, G.; PRATA, G.: Paradoxe et contreparadoxe. E.S.F., Paris, 1978.

SHANDS, H. C.: The War with World. Mouton. The Hague, 1971.

WATZLAWICK, P.; WEAKLAND, J.; FISCH, R.: Changements, Le Seuil, Paris, 1976.

WILDEN, A.: System and Structure. Tavistock Publications Ltd., London, 1972.

El uso de lo analógico y lo digital para entrenarse en la percepción e intervención sistémicas.

PHOEBE PROSKY

Trabajadora Social. Miembro del Staff Terapéutico del Ackerman Institute de New York. 149 East 78th. St. New York, NY 10021

Traducido por la Lic. Silvia E. Stuhlman

Este trabajo describe una modalidad en el entrenamiento y supervisión de terapeutas que les enseña a identificar disfunciones en las familias e intervenir, a través del uso del concepto de congruencia entre lo analógico y lo digital, en la forma en que es usado por los miembros de la familia para intercambiar información. En este acercamiento la identificación de los elementos disfuncionales en las familias se hace detectando los puntos de discrepancia entre los elementos analógicos y digitales en su proceso de comunicación. (1)

Podemos describir el proceso de comunicación humana como teniendo lugar básicamente en dos modos o sistemas de codificación, el analógico y el digital, que se combinan para producir en nuestra experiencia un "bagage comunicacional" conocido como significado global del mensaje. Cuando estas dos modalidades son portadoras del mismo mensaje, el significado global es congruente. Sin embargo, con frecuencia son portadoras de mensajes discrepantes dando como resultado una incongruencia del significado global del mismo. (2)

Un ejemplo muy común es la diferencia notoria entre la

- "Changements systémiques en thérapie familiale", Annales de Psychothérapie. Editions E.S.F., 1980.
- LEVY-STRAUSS, C.: Tristes tropiques. Librairie Plon, Paris, 1955.
- MINUCHIN, S.: Familles en thérapie. Ed. Delarge, 1979.
- SELVINI PALAZZOLI, M.; BOSCOLO, L.; CECCHIN, G.; PRATA, G.: Paradoxe et contreparadoxe. E.S.F., Paris, 1978.
- SHANDS, H. C.: The War with World. Mouton. The Hague, 1971.
- WATZLAWICK, P.; WEAKLAND, J.; FISCH, R.: Changements, Le Seuil, Paris, 1976.
- WILDEN, A.: System and Structure. Tavistock Publications Ltd., London, 1972.

El uso de lo analógico y lo digital para entrenarse en la percepción e intervención sistémicas.

PHOEBE PROSKY

Trabajadora Social. Miembro del Staff Terapéutico del Ackerman Institute de New York. 149 East 78th. St. New York, NY 10021

Traducido por la Lic. Silvia E. Stuhlman

Este trabajo describe una modalidad en el entrenamiento y supervisión de terapeutas que les enseña a identificar disfunciones en las familias e intervenir, a través del uso del concepto de congruencia entre lo analógico y lo digital, en la forma en que es usado por los miembros de la familia para intercambiar información. En este acercamiento la identificación de los elementos disfuncionales en las familias se hace detectando los puntos de discrepancia entre los elementos analógicos y digitales en su proceso de comunicación. (1)

Podemos describir el proceso de comunicación humana como teniendo lugar básicamente en dos modos o sistemas de codificación, el analógico y el digital, que se combinan para producir en nuestra experiencia un "bagage comunicacional" conocido como significado global del mensaje. Cuando estas dos modalidades son portadoras del mismo mensaje, el significado global es congruente. Sin embargo, con frecuencia son portadoras de mensajes discrepantes dando como resultado una incongruencia del significado global del mismo. (2)

Un ejemplo muy común es la diferencia notoria entre la

comunicación verbal y no verbal. Bateson ha delineado claramente los modos de comunicación analógico y digital en su libro "Pasos hacia una ecología de la mente". (3) El código digital acompaña a todas las operaciones racionales. Es la capacidad de inferir y deducir de acuerdo a las reglas de la lógica. Es lineal en la orientación temporal. Es una operación del hemisferio izquierdo del cerebro. Se expresa a través del lenguaje escrito y hablado y sus símbolos son palabras y números. Lo que mejor diferencia las propiedades de lo digital —lenguaje y matemáticas— de lo analógico, es la naturaleza arbitraria de sus símbolos: no tienen una relación directa con lo que representan. Por ejemplo, la palabra "grande" (big) no tiene características correspondientes respecto de lo que describe y es más corta que la palabra "pequeño" (little). La palabra "mesa" no se asemeja a una mesa. El número 7 no tiene una relación implícita con la cantidad a la que se refiere y es sólo pura coincidencia que la barra que lo corta es más larga que el número 1, que se refiere a una cantidad menor, dado que la barra de ningún modo representa un aumento de 6. Lo analógico, por nuestra tendencia a la intelectualización, aparece a menudo como "todo lo demás" de la comunicación después que las palabras fueron consideradas. Entre sus procesos están incluidos sensación, intuición, creatividad, percepción extra-sensorial. (4) Es sincrónico en su orientación temporal. Es una operación del hemisferio derecho del cerebro. Fácilmente incorpora polos opuestos de manera que aparecen como paradójicos en términos digitales. En lugar de palabras y números, el código analógico es kinésico (movimientos del cuerpo) y paralingüístico (atributos de las palabras que acompañan al lenguaje, por ej. tono de voz, ritmos, etc.). Su codificación se distingue de los símbolos usados por el código digital por su correspondencia con la real magnitud o cualidad del tema del discurso: una voz fuerte es fuerte, no está representada por un símbolo asignado pero está codificada en su propio medio.

Bateson dice que el sueño del lógico de que las palabras reemplacen lo analógico en evolución no está ocurriendo. La comunicación analógica realiza funciones totalmente distintas de las

del lenguaje y por cierto ejecuta funciones que el lenguaje verbal es incapaz de cumplir. Cuando un muchacho le dice a una chica: "te quiero", está usando palabras para expresar lo que es más convincentemente expresado por su tono de voz y sus movimientos. Y la chica, si está alerta, prestará más atención a los signos que acompañan a las palabras, que a estas mismas. (5) ... Pareciera que el discurso de la comunicación no-verbal se refiere precisamente a situaciones de relación: amor, odio, respeto, miedo, dependencia, etc. ... (5). Lo analógico es procesado generalmente sin darse cuenta.

Bateson sugiere que el procesamiento sub-consciente de lo analógico es un aspecto inevitable por ser la principal modalidad de comunicación en situaciones de relación.

Sugiere también que el hecho de ser procesado subconscientemente no nos permite tener un control directo y en consecuencia le da un viso de confiabilidad necesaria para manejar (o conducir) estas relaciones.

Por lo tanto en un contexto terapéutico el estar atento a la comunicación analógica es de vital importancia. El procesamiento de las transacciones interpersonales desde el punto de vista de su congruencia dígito-analógica es muy útil, no sólo como un camino para identificar áreas problemáticas sino también para realizar intervenciones terapéuticas.

Las intervenciones terapéuticas son más efectivas cuando tienen una congruencia dígito-analógica de parte del terapeuta. Cuando hay incongruencia la intervención es ineficaz, produce y genera en el paciente un estado de desconfianza.

Entrenar en el uso de ambas modalidades simultáneamente percibiendo y sintetizando sus intervenciones, le permite al terapeuta identificar las áreas problemáticas y maximizar su impacto terapéutico. "Trainees" * llegan a nosotros conociendo

(*) *Nota del traductor:* trainer: entrenador; Trainee: persona que se entrena. Hasta tanto se generalice el uso en nuestra área de trabajo de las palabras entrenador y entrenado, dejamos la denominación en inglés que aparece en el original.

bien el uso del modelo digital. El mayor desafío para nosotros en entrenar terapeutas capaces de detectar una congruencia dígito-analógica, consiste en encontrar la forma de volver completamente conscientes procesos de los que habitualmente no nos damos cuenta.

El uso del código digital para enseñar a detectar lo analógico es muy limitado. Citando nuevamente a Bateson: "... resulta que traducir en palabras mensajes kinéticos o paralingüísticos lleva a grandes errores debido no sólo a la inclinación humana de tratar de falsear expresiones de "sentimientos" y relaciones, sino también a causa de distorsiones que surgen cuando los productos de un sistema de codificación son analizados bajo las premisas de otro sistema, pero especialmente por el hecho que todas esas traducciones deben dar, al más o menos inconsciente e involuntario (analógico) mensaje, la apariencia de intención consciente". (6) Por lo tanto nosotros debemos señalar lo analógico a través de métodos de entrenamiento que no traduzcan primero estos hechos al modo digital. Esto nos obliga a innovar, ya que como dice Bateson posteriormente: "en realidad no hay casi ninguna teoría formal que trate sobre la comunicación analógica... nada equivalente a la teoría de la información o a la teoría de los tipos lógicos" (7). Estamos obligados a identificar lo analógico experiencialmente, en sus propios términos (o sea analógicamente). Para eso el supervisor puede crear y/o subrayar elementos de intercambio analógico entre el supervisor y el supervisado o entre los "trainees" en el grupo de supervisión, ya sea amplificando su propia comunicación analógica haciéndola así perceptible más rápidamente o identificando repetidamente los acontecimientos analógicos.

El supervisor puede enfatizar lo analógico a través del uso prolijo de formas verbales analógicas, un caso especial de lo verbal, como por ej.: metáfora, fantasía y todo el lenguaje poético, donde las palabras son usadas principalmente para crear un modelo formal más que por su valor descriptivo lineal. El ejemplo más destacado de la forma analógica verbal es la onomatopeya, donde el sonido de la palabra imita lo que representa.

Otra forma de aumentar la capacidad de los "trainees" en el

uso de lo analógico es hacerlos trabajar con la escultura de la familia. Esta modalidad describe la red de las relaciones emocionales entre los miembros de la familia haciéndolos ubicarse físicamente para representar visualmente la forma de su sistema. En una modalidad sin palabras cuyo producto puede ser percibido completamente en términos analógicos. "Trainees" trabajando con la escultura aprenden a utilizar sus capacidades analógicas de percibir, comunicar acerca de, e intervenir en sistemas.

Otra forma de acceder a la percepción consciente (o al darse cuenta) de lo analógico, es a través de la implementación de técnicas que disminuyen o bloquean el funcionamiento digital. En el trabajo con imágenes y fantasía dirigida predomina el procesamiento analógico y se utiliza lo digital en forma auxiliar como un vehículo para la comunicación de los acontecimientos analógicos. Otras técnicas son capaces de producir un cese completo del procesamiento digital dando lugar en cambio a la experiencia, que es puramente analógica. Entre estas podemos mencionar actividades repetidas rítmicamente como caminar, correr, "mantra" * y meditaciones que llevan todo el funcionamiento digital a concentrarse en un solo punto, luego lo borran y de ese modo anulan toda la operación digital. Para describir una experiencia puramente analógica se necesitan innumerables palabras.

Por largo tiempo Oriente buscó el desarrollo de capacidades analógicas del mismo modo que Occidente lo hizo con lo digital. La inmersión del "trainee" en la filosofía oriental es otra forma de acceso al "darse cuenta" analógico. Algunos libros muy útiles figuran en la bibliografía con un asterisco.

Fijar la atención en la comunicación analógica durante el proceso de entrenamiento, trae como consecuencia un aumento de la familiaridad consciente con el modelo analógico. A medida que los "Trainees" aumentan su capacidad analógica consciente, empiezan a oír y a usar lo analógico y lo digital a la vez. Entonces se encuentran en una posición que les permite identificar incon-

(*) mantra: la fórmula mística hindú de invocar (N. del T.).

gruencias entre los dos códigos y al mismo tiempo determinar y usar la congruencia dígito-analógica en sus intervenciones. Trabajar hacia su congruencia personal es una condición indispensable para los "trainees" para poder reconocer la congruencia e intervenir congruentemente. Un estado de congruencia analógico y digital no es fácil de adquirir. La mayoría de la gente está llena de incongruencias entre los dos modos de comunicación. Sin embargo, si los terapeutas intentan intervenciones bimodales en áreas en las que ellos mismos son incongruentes, introducen más incongruencias en el campo transaccional y mistifican en lugar de crear un impacto terapéutico. Entrenamientos de esta naturaleza incluyen en su mayoría elementos terapéuticos.

El entrenamiento con estas características pondrá en movimiento un proceso que recién empezará una vez que el entrenamiento formal haya sido completado. Como un pergamino chino o como una cápsula que libera su contenido lentamente a través del tiempo. Es como anticipar el surgimiento de un terapeuta maduro.

Esta modalidad de trabajo presenta una complicación para los "trainees", ya que requiere de ellos que desarrollen una gran congruencia. Si, como dice Ram Das, "la terapia es tan buena como el terapeuta" (8), de la misma manera el entrenamiento es tan bueno como el "trainer". Ser un buen "trainer" significa no sólo poseer un cuerpo de conocimientos sino también desarrollar en forma continua la conciencia hacia una congruencia cada vez mayor. Esto lo pone al "trainer" frente a un desafío permanente no menos riguroso que el que se le presenta al "trainee".

En resumen, el "trainee" que desarrolla su capacidad de detectar simultáneamente procesos analógicos y digitales, tiene una excelente herramienta con la cual identificar áreas problemáticas e intervenir eficientemente en los sistemas familiares.

El entrenamiento en una congruencia dígito-analógica requiere una gran congruencia de parte del "trainer".

- (1) Eso no quiere decir que la discrepancia en la comunicación es la causa de la disfunción, sino que es un buen indicador de áreas de conflicto intra-psíquico e interpersonal.
- (2) El origen de tal incongruencia puede ser represión o supresión, conflicto o disimulación respectivamente.
La incongruencia tiene elementos del fenómeno del doble vínculo, pero es un concepto mucho más amplio en la medida en que la discrepancia que ocurre en el campo transaccional abarca muchas más transacciones que las del doble vínculo.
- (3) Bateson en "Problemas de la comunicación en cetáceos y otros mamíferos" en Bateson, G.: *Pasos hacia una ecología de la mente*.
- (4) Incluyendo estos receptores que son conocidos o denominados como "el sexto sentido", "el tercer ojo" en el pensamiento oriental y el "tercer oído" en la terminología usada en asistencia social.
- (5) Op. cit., p. 412.
- (6) Ibid., p. 413.
- (7) Ibid., p. 291.

Bibliografía

- BATESON, G., *Steps to an Ecology of Mind*, Chandler Publishing Company, New York, 1972.
- CASTANEDA, C., *The Teachings of Don Juan*, Balantine Books, New York, 1968.
- , *A Separate Reality*, Simon and Schuster, New York, 1971.
- , *Journey to Ixtlan*, Simon and Schuster, New York, 1972.
- , *Tales of Power*, Simon and Schuster, New York, 1974.
- , *The Second Ring of Power*, Simon and Schuster, New York, 1977.
- HERRIGEL, Eugen, *Zen in the Art of Archery*, Random House, New York, 1953.
- RAJNEESH, Bhagwan Shree, *The Way of the White Clouds*, Rajneesh Foundation, Poona, India, 1975.

PHOEBE PROSKY

RAM DASS, *The Only Dance There Is*, Anchor-Doubleday

——, *Grist for the Mill*, Unity Press, Santa Cruz, 1977.

SHANDS, H., *The War with Words*, Mouton, Paris, 1970.

SUZUKI, S., *Zen Mind, Beginner's Mind*, Weatherhill, New York and Tokyo, 1970.

ATENEO CLINICO

Se realizó en el Centro de Estudio de Terapia Familiar (CE. TE.FA) de la ciudad de Rosario, con la participación de: Dra. Ana María Nicoló, Dr. Fidel Lebensohn y el Psicólogo Luis Juri.

Resumen del caso clínico

Paciente designado

Danilo, de 36 años de edad, ingeniero.

Vive con su esposa Liliana, de 24 años, y sus dos hijos varones de 3 y 1 años.

Entre sus antecedentes personales cuentan el estar sufriendo de ataques de asma desde los cinco años y de diabetes desde los diecinueve.

Respecto de su familia extensa, su padre, que era comerciante jubilado, muere cuatro años atrás, a la edad de 60, y su madre, viva, actualmente tiene 56 años. Además, Danilo tiene una hermana de 34 años, sana, casada con un comerciante muy adinerado. Estos últimos también tienen dos hijos.

Datos aportados por Danilo en la primera entrevista

(Cuando él llama por teléfono para pedir la consulta se le dice que tiene que concurrir con su esposa. Sin embargo, llega solo y excusa a su mujer "porque debió viajar a Córdoba").

Consulta "ya que mi madre y mi esposa dicen que lo necesito".

Sus síntomas son difusos, poco claros: "nervios", ansiedad, inseguridad.

En mayo de 1977 muere su padre y él, que siempre había pensado qué le pasaría si, en caso de morir uno de sus padres, tuviera que quedarse solo con el otro, comienza con sus malestares.

En unas vacaciones pasadas en Mar del Plata, donde se hallaba veraneando con sus padres, unos meses antes de la muerte de su padre (en febrero), conoce a Liliana y se enamora de ella.

Su madre, que en reiteradas ocasiones previas había "descartado" otras novias, y que ahora tenía elegida como candidata a la hija de una familia de mucho dinero, de sólo 14 años, también se opone a la relación con la nueva joven.

Danilo no la obedece y comienza a viajar todos los fines de semana a Córdoba (donde a la sazón vivía Liliana), y su padre comienza a sufrir problemas circulatorios coronarios, que se empeoran en una ocasión en que Danilo sufre un accidente automovilístico en la ruta, volviendo de Córdoba, y en el que el padre cree que había quedado inválido.

Al morir el padre, la madre de Danilo, que siete años antes había hecho un intento de suicidio a raíz de enterarse que su esposo tenía otras mujeres, cae en un profundo cuadro depresivo del que, sin embargo, emerge en breve lapso de tiempo.

Estas eran las condiciones cuando en julio del mismo año (1977), Danilo decide casarse, en Córdoba.

En esta ciudad viven la madre de Liliana (el padre murió cuando ella tenía nueve años en un accidente de aviación), y sus tres hermanos. Es una familia "unida" pero en la que a Li-

liana nunca se le ha prestado atención. Sus abuelos maternos, a los que ella quiere "como padres" (sobre todo al abuelo), nunca le han retribuido sus manifestaciones de afecto.

Inmediatamente luego de casados, la pareja va a vivir con la madre de Danilo. Allí, ella rechaza abiertamente a Liliana. Y esta coyuntura los decide a vender la casa y a comprar dos departamentos, uno para la madre y otro para ellos.

La madre vuelve a sufrir un episodio depresivo.

En este momento, al separar las viviendas, la madre y Liliana comienzan a llevarse muy bien. Y, al poco tiempo (1978), comienzan los problemas de pareja entre Danilo y Liliana, que alcanzan su cumbre en una oportunidad en que ella se va, un viernes, con los niños a Córdoba, a la casa de su madre (1980).

Al otro día vuelve, pero sin los niños. Danilo le exige que se vuelva a buscarlos pero Liliana discute la necesidad de estar ambos a solas, para hablar de sus problemas. El decide ir a lo de su madre y contarle todo lo ocurrido. Luego vuelve y se reconcilia con la esposa.

Al acontecer esto, explota una gran pelea entre la madre y la esposa, en la que la primera le reprocha a Liliana el que a ella se ha debido la enfermedad y muerte de su esposo y la ruina de su hijo. Liliana, a su vez, entre otras cosas, la acusa de sobreprotectora.

La consecuencia es un distanciamiento de la madre.

Ya a principios de este año (1981), y alrededor de estos episodios, Danilo comienza a padecer insomnio. Comienza, además, a beber una pequeña cantidad de whisky por día.

En este momento el carácter de las peleas con Liliana ha variado. También han variado los temas: antes era por la madre, ahora es porque Danilo se siente atado, sin poder darse los gustos, viajar, etc.

Por último, es de hacer constar que él, que se siente con bronca hacia su madre, su hermana, su esposa, y sus empleados, sin embargo encuentra plena satisfacción sexual con Liliana y bienestar en el desarrollo de sus actividades profesionales.

Posturas y diálogo

Dr. Lebensohn. Si te parece bien, comenzás vos Luis.

Psic. Juri. Sí. Bueno, lo primero que podría comentarles es que el motivo de consulta es, en parte, complicado. El dice que viene porque "mamá y mi esposa dicen que lo necesito", por lo que, si lo tomamos así, no existe, por parte de él, una motivación directa hacia la terapia. Los síntomas que plantea, son realmente vagos.

En este caso, lo primero que a mi juicio habría que hacer es aclarar el motivo de consulta, porque no es claro; y también la motivación de él para la terapia. Sin esto, encarar la terapia puede ser una cuestión, digamos, sin bases suficientemente sólidas. Por lo tanto me daría un tiempo de entrevistas, en principio con él, eventualmente con la pareja, y realizar algún tipo de acuerdo mínimo, si fuera posible, como para que se establezcan las bases de una terapia, para esclarecer los objetivos con mayor claridad.

Voy a hacer algunos comentarios del material clínico, de algunas de las cosas que podría ver. En general, ante una historia, por lo menos desde mi punto de vista, lo que trato de observar son las redundancias, o sea, aquellos elementos repetitivos en la historia, que nos van dando los puntos de apoyo más firmes para establecer algún tipo de hipótesis con respecto al material. Por lo tanto en este caso también aplicaría esa metodología.

Lo que uno puede ver es que varios conflictos se reiteran alrededor de separaciones, en el relato de Danilo. Comienzo con lo primero: los malestares de él empiezan cuando el padre fallece y él tiene que quedarse solo con la madre.

Mi impresión es que ésta es una familia de tipo cohesivo o, en otros términos, simbiótica, por la cual, para los miembros es muy difícil poder lograr la separación o la diferenciación. Por lo tanto, al quedar él solo con la madre es probable que haya tenido algún tipo de angustia relativa a no poder "salir". "Salir" es muy difícil en este tipo de familias.

Después, cuando él establece una relación con Liliana, que significaría "salir" del grupo familiar, aparece una violenta oposición de la madre.

Uno puede suponer que la madre desea tener el control de la relación.

Luego, cuando él empieza a separarse físicamente, cuando empieza a viajar a Córdoba, a hacer separaciones de fin de semana, aparecen problemas en el padre. O sea que la familia, mientras está unida y cohesiva mantiene de alguna manera un equilibrio, que se resquebraja ante la separación, ante el hecho de que alguno de los miembros salga o se aparte.

Cuando se casa Danilo lo particular es que vuelve otra vez a vivir con la madre; o sea que restablece un tipo de vínculo cohesivo, simbiótico. No es fácil la diferenciación.

Pero como hay conflictos y la madre rechaza a Liliana, compran dos departamentos, que sería un ejemplo, en lo fáctico, de un intento de diferenciación. En vez de estar en una unidad indivisa o indiferenciada, se parte en dos departamentos, que sería la diferenciación. Lo que trae un episodio depresivo en la madre, al separarse las viviendas.

Bueno, luego, lo que yo observo es que empiezan los problemas de relación entre Danilo y Liliana. Acá voy a hacer mención a mi punto de vista psicoanalítico para enfrentar el caso clínico. Vendría a ser lo siguiente: los vínculos familiares, desde el punto de vista psicoanalítico, se internalizan. O sea, podríamos decir que hay una "familia interna", y que él interiormente, ha internalizado el siguiente tipo de vínculo: "Relación con otro de la que no se puede salir". O sea, una relación de posesividad.

Al estar con la mujer, podría uno suponer que van a emerger conflictos también de pareja en la medida en que la relación sea sentida como de carácter posesivo o sea de características simbióticas. Por eso aparecen problemas de pareja cuando él está con su mujer y ya no estando presente la madre. Pero si está la madre entre comillas; es decir, la representación interna que él tiene de la madre como posesiva.

Por supuesto que faltarían integrar los elementos referidos

a la esposa, y sobre el funcionamiento del sistema de la pareja.

Otro elemento que podría comentar es cuándo él tiene peleas con Liliana y va a contarle a la madre. Realmente, él está casado con una mujer pero el vínculo con la madre es muy fuerte aún, como por otra parte es esperable que sea.

Aparecen ciertos síntomas en él, el insomnio, la necesidad de beber, y el carácter de las peleas con Liliana... él se siente atado y habla de no poder viajar. El sentirse atado y no poder viajar vendría a ser lo mismo: la sensación de no poder salir.

Bueno, en síntesis: Creo que se relata el caso de una familia de tipo cohesivo, simbiótico, donde el problema fundamental radica en las separaciones.

En este tipo de familia no se puede salir libremente, sino que siempre el salir está acompañado de recriminaciones o de culpa. Las atribuciones de culpa que puede haber en este tipo de familia, son utilizadas, a mi juicio, con el fin de controlar la distancia del miembro. Si se lo acusa de malo o egoísta, o lo que sea, esa atribución de identidad tiene objetivos de controlar la distancia; o sea que no se vaya muy lejos, que se quede cerca. Lo que tendría quizá que expresar es que la pareja —también la familia— es un sistema de atribuciones de identidad y de significaciones, por las cuales las atribuciones hechas al otro tienen un sentido en función de la propia identidad y del equilibrio del sistema. Digo esto porque es fácil que en esta familia haya atribuciones de identidad de maldad, de egoísmo, etc., que parece realizar la madre respecto de Liliana, pero que no es extraño que ella realizara, a su vez, respecto de Danilo. El fin, como decía, es controlar la relación, la distancia, el control del objeto. Y esto hace a una economía o llamémosle homeostasis psíquica a través de la presencia del otro.

Por lo tanto, diría lo siguiente: hay un problema familiar pero uno observa una internalización de este tipo de vínculo dentro de Danilo, por lo que él tiende a repetir esa situación familiar en el ámbito de la pareja. No estaría entonces contraindicado el realizar un doble abordaje: individual y de pareja.

Dr. Lebensohn. Bueno, lo que me parece muy interesante es, en el aporte de Luis, el plantearse, al inicio, qué hacer.

De acuerdo a la entrevista, es un poco complicado cómo viene la consulta. Yo me voy a referir al punto de vista sistémico que es lo que a mí me interesa.

Ante una consulta así lo que uno generalmente se pregunta, o se plantea, es qué significa tanto para él que consulta como para el consultado.

Y creo que en ese sentido es bastante interesante porque es el punto del inicio de cómo consulta en este caso este paciente, o del equívoco que se produce al principio en que es citada la pareja y viene él solo y, justificadamente o no, la mujer 'tiene que viajar a Córdoba, a la casa de los padres'. Creo que nos da un punto bastante claro de partida desde el punto de vista del sistema. O sea, lo que quiero decir es que en este caso, a pesar de que sea un poco anómala la situación, porque se ha citado a la pareja y aparece solo, eso nos da una información muy importante. Y que muchas veces, por no ser cautos, por eso estoy de acuerdo con lo que planteaba Luis, y no pensar desde el primer momento esa realidad y trabajar a partir de esa hipótesis, muchas veces puede fracasar todo el tratamiento o todo el abordaje posterior. En ese sentido, yo diría que frente a este punto hay dos caminos: uno de los caminos es —siempre pensándolo desde el punto de vista sistémico, de la terapia de contexto— rechazar la consulta, ya que como no han venido como se ha pedido, es decir, en pareja, se rechaza la forma en que llega el paciente designado y citándolo para una nueva entrevista en pareja, se retiene la definición de la relación que ellos han intentado redefinir no viniendo como se les indicó; o el otro camino sería aceptar la situación, aceptar lo justificado del haber tenido que irse de la mujer y tratar de recabar la mayor cantidad de datos, toda la información posible, y entender lo que está pasando. Yo me inclinaría, dado que es un caso así planteado, de aceptar la consulta individual y tratar de recabar la mayor información posible, ya planteando que éste es un paciente que es designado, o sea que se lo está induciendo a venir, él como portavoz de una situación sistémica, pero que a su vez se autodesigna. O sea que serían las dos cosas. Tanto que lo designan como que acepta esa designación. En ese sen-

ATENEO CLINICO

tido yo creo que lo que es muy importante es ver que el sistema en sí es un sistema, por los datos que aporta la entrevista, coincido, a lo mejor no en el mismo término, pero sí en el sentido de que es un sistema cerrado. Un sistema en el cual hay un paciente que está hablando de una serie de problemas que él supuestamente tiene y que viene a propósito, digamos, de lo que a él le indican como si él estuviera un poco excluido de la situación, pero mostrándonos quizá, que está en un encierro del cual quiere salir. En este sentido es que yo creo que es muy importante tratar de recibir a este paciente para intentar dilucidar, a través de esta consulta, cuánto es lo que él quiere y cuánto es lo que los demás quieren, de lo que él dice. Porque si nos atenemos un poco a lo que él expresa de entrada: "consulta porque mi mamá y mi esposa dicen que lo necesito", realmente sería una indicación para decirle: "Cuando Ud. realmente lo necesite, venga", desde el punto de vista sistémico, ¿cierto? Pero creo que también es importante el hecho de que se lo pueda escuchar y poder tratar de ver, sobre todo en una realidad como la nuestra en la cual creo que vienen muchos pacientes en esas condiciones. Es decir, como portavoz de un grupo familiar o de una situación de pareja en la cual no aparece la pareja de por sí o no viene la familia de por sí. Entonces sería lo que hemos visto tantas veces, como que es el gestor del sistema. El sistema tiene un gestor con el cual viene a conectarse terapéuticamente, tanto, como lo siento en este caso, porque lo designan, porque un poco él se propone como tal.

Aparte, que esto es una cosa que me parece muy importante porque sería un poco cómo recibir el mensaje. Es decir, nosotros podemos recibir un mensaje como una demanda puramente individual o podemos interpretar el mensaje como del contexto. Depende de quién reciba el mensaje y cómo lo reciba, que es un poco cómo va a percibir toda la realidad posterior. En ese sentido yo creo que existirían dos variables: o, en función de esta entrevista, podemos hacer u orientarnos hacia un tratamiento de pareja o un tratamiento de familia. Pero para poder dilucidar eso creo que previamente debemos recibir esta consulta y hacer hipótesis. En este caso creo que lo que po-

demostramos ver, desde el punto de vista sistémico, es que da la impresión de que este sujeto habla de que estaría un poco encerrado entre lo que parecen dos mujeres: su madre y su esposa, a la par que él, como lo está planteando de entrada, nos plantea una relación bastante significativa con su hermana. En el sentido de que daría la impresión de que es un sistema constituido por, en este momento, tres mujeres y un hombre como si estuvieran encerrados, sobre todo él. Y allí estaríamos planteando si él estaría encerrado o él se encierra: qué sería un poco la situación a dilucidar. En qué medida él acepta esa designación o si realmente lo designan: cuánto pone él, cuánto la otra parte del sistema. Sería de que en realidad, lo que trataríamos de ver: si esta situación central de este sujeto, respecto de su madre y su esposa y de su hermana, es una situación central en la cual lo han puesto, o él se quiere poner.

Daría la impresión de que este sujeto, haciendo hipótesis sobre este sistema, está en un contexto en el cual él está ubicado en esa situación central un poco porque lo han puesto y aparte porque él se ha puesto en esa situación. Desde este punto de vista, quizás, lo que podemos observar es que sus intentos de separación, en ese sentido coincido en que realmente hay un lazo en que la madre y el padre y él, han forjado desde el principio con la hermana una familia de tipo realmente cerrada en la que circularmente diría que él es un producto de esa madre sino que los cuatro son víctimas de una misma situación. Lo que pasa es que da la impresión de que este sujeto siempre se ha victimizado, es decir, él se ha transformado en una víctima; por los datos de la clínica, puede pensarse que es un individuo sobreprotegido por su mal asmático y su diabetes juvenil, con una madre que se ha preocupado permanentemente por él que ha querido salir de esa situación y no ha podido, fracasando en cada uno de sus intentos. Desde el punto de vista clínico, acostumbramos siempre a considerar tres variables: 1) En qué etapa del ciclo evolutivo está el sistema (si las reglas redactadas corresponden o están detenidas en un período anterior al que deberían estar); 2) la paradoja central (quién es el inductor paradójico y quién el inducido, cómo están fun-

cionando estableciendo un circuito circular entrampante; y 3) valorar la crisis del sistema (o sea, cómo detectar el feed-back positivo para ampliarlo y desviarlo aún más).

1) ¿en qué etapa del ciclo evolutivo está este sistema? Es una familia nuclear constituida por padre —paciente designado—, la esposa y dos chicos, que están en una relación de hijos con respecto a la familia de origen. Aparece aquí una confusión en el nivel del ciclo evolutivo: Es una familia nuclear pero dependiente, en la que no sólo no se ha separado él sino parece que la mujer tampoco, que se habría hecho “adoptar” por la familia del esposo. El ciclo evolutivo parece detenido: por un lado, el paciente juega el rol de padre y esposo y por otro juega el rol de adolescente sometido o queriendo que lo sometan; respecto de la esposa, y ésta es una hipótesis que habría que comprobar después, por lo que él dice, parecería que no ha tenido un desarrollo afectivo en su familia de origen, por lo que da la impresión de que se une a él pero se hace adoptar por la propia familia del esposo. Aparece lo que parecería una confusión respecto de los ciclos evolutivos de estas dos familias. Es decir, de una familia nuclear que a su vez se confunde con la familia de origen, y en donde de ninguna forma quedan definidos los roles presentes. Habría una confusión de reglas redactadas que sirven para una familia en la adolescencia pero no en una familia en la adultez.

2) Otra cosa que a mí me interesa expresar sería, en mis términos, la paradoja central de este sistema. O sea: cuál es la situación que lleva a estos sujetos, al sistema, a que no pueda desanudarse, no pueda seguir el proceso evolutivo. Daría la impresión de que los mensajes que ha recibido este sujeto, el paciente designado, son mensajes en los cuales siempre se le ha dicho: “Tú tienes que ser fuerte” o “que salir” o “movilizarte”, pero “como yo quiero”; que sería un poco el mensaje de la madre. Cosa que él en un momento determinado quiere desafiar, sobre todo cuando el padre se halla enfermo, en el período previo a su muerte, relacionándose con una mujer que le per-

mita, de alguna forma, encarar o enfrentarse con la definición que hace la madre de esa relación, y no lo consigue. Es decir, en lo aparente lo consigue, la enfrenta a la madre, a consecuencia de esto el padre se enferma, se muere, pero ocurre que la mujer que en un principio se alía con él y enfrenta a la madre, después lo traiciona de alguna forma también (todo esto según como está relatada la historia), y se alía y es leal a la madre, cosa que es un fracaso bastante importante de separación de su ciclo evolutivo. Es decir, él que pretendió, por primera vez, salir de su adolescencia, de su dependencia, poder individuarse como lo hizo siempre su hermana, en este momento no lo consigue. Una vez más. Siente que la madre forma parte de la relación con la esposa. Cosa que posiblemente él también ha inducido. Yo no estoy puntuando las cosas como para que se vea que él es víctima de las circunstancias. Creo que es una circunstancia de circularidad en la que permanentemente todos están tratando de repetir, redundantemente, una pauta de la que no pueden salir y que impide la movilización del ciclo evolutivo de la familia de origen y de la familia nuclear que han constituido.

Otra cosa que parece importante es divisar esa paradoja central en el sentido de que él ha estado tratando de que se le dé libertad, y a la vez negándose, al igual que el resto de los implicados.

3) Otra cosa que me parece importante es la crisis actual de esta pareja. Es decir, me da la impresión de que este sistema está en crisis: en la crisis máxima. En mi esquema, hay que tratar de valorar en qué momento del ciclo evolutivo está el sistema, la paradoja central y tratar de ver el período de crisis y aprovechar la crisis, en la que se exponen síntomas de él, de la madre y de la esposa, no para que todo vuelva a como está sino para ampliar esta circunstancia (esto ya iría orientado hacia qué pauta de tratamiento o hacia dónde podríamos guiar el tratamiento).

Esto sería, por ahora, lo que quiero plantear. Y otra cosa

que me parece importante, entonces, es qué hacer. Yo diría que frente a esta circunstancia mi indicación sería, y esto es fundamental para poder probar si algunas de estas hipótesis son ciertas y no puras suposiciones mías, citar a la familia en totalidad. Es decir, la familia nuclear y extendida. Es decir, citar al paciente designado, la mujer, la madre, la hermana y los chicos. Si es posible que venga también, por supuesto, el yerno.

La familia de ella sería muy complicado en este momento. Pero sí los convivientes de esta circunstancia actual, y en este lugar. A partir de eso tratar de comprobar las hipótesis que yo elaboré, es decir, si realmente él está en una situación central porque lo designan y él se designa; ver las relaciones que hay entre él, la madre y la hermana, ver si la hermana es como él la divisa, es decir independiente. Podríamos comprobar algo que es muy importante: que ante una lucha simétrica como dan la impresión de haber tenido siempre los padres en su estructura, el más perjudicado ha sido él y la más libre ha sido la hermana, cosa que suele ocurrir cuando hay una simetría explícita, de lucha entre los padres, en que aparece un sujeto sintomático y una persona totalmente libre de la situación: alguno de los dos hermanos. Sería un poco comprobar esto para después, quizás, orientar un recorte de la familia extendida y trabajar específicamente con terapia de pareja.

Dra. Nicoló: —Este caso me parece una epopeya, no un caso. Propiamente homérico.

Una cosa que hizo notar Fidel pero que no teníamos anotada aquí, en estos resúmenes, es que ellos habían sido citados para terapia de pareja.

Psic. Juri: —Sí, a mí me ocurrió lo mismo... aquí eso no figura...

Dr. Lebensohn: —Se leyó al principio...

Psic. Juri: —Sí, pero tenía la idea...

Dra. Nicoló: —No, porque es muy diferente si este paciente pide una consulta a nivel individual porque lo mandan o si se hace una consulta de pareja pero él aparece solo. Es una gran diferencia en lo que respecta a la actitud del terapeuta, ya sea que se presente solo, enviado, como un adolescente, o ya sea

trayendo el mensaje, cuando debiendo venir en pareja, la mujer decide no venir, el sistema se corta, y viene él como designado de la situación.

Pasando a otra cosa, creo que, desde mi punto de vista, es importante en este caso clínico, la presencia del terapeuta. Porque ésta es una historia clínica que no permite ver dónde estaba el terapeuta respecto de este paciente, cómo recolectó la información, qué ha pensado, cómo asumió su relación con el paciente. Tenemos una historia transversal del paciente que bien podría ser una historia anónima, que bien podría haber sido tomada por el Dr. Lebensohn, la Nicoló o el Dr. Luis, pero falta el aspecto de la relación con el terapeuta, lo que para mí y mi modo de trabajar es importante, justo porque no existe una información aséptica, sino que ésta incluye al terapeuta y a su modo de recolectar la información, y esto es un proceso de información circular, que incluye, sobre todo, al terapeuta. Dejando esto, lo que debemos probar es hacer fantasías acerca de este caso.

Este señor va a la consulta porque la madre y la esposa le dicen que lo necesita. Es verdaderamente un clásico adolescente, como dijo Fidel, que va porque lo mandan, sin manifestar su voluntad ni su responsabilidad, ni su adultez respecto de tomar una posición respecto de algo que es muy importante, como es la terapia. Al mismo tiempo, si esta es una terapia de pareja, y él se presenta solo, mandado por algún otro, evidentemente, y más en este caso, se evidencia su posición de adolescente, de niño que llega enviado por algún otro. Y se excluye como sujeto del encuentro, como participante activo. Con él se podría comenzar haciendo una provocación. Este sería un mensaje terapéutico, y se emplearía para comenzar a ver su posición respecto al resto del sistema, cuánto puede él, frente al input terapéutico, comenzar a asumir su independencia, aún un pequeño movimiento de desvinculación.

Naturalmente, luego se puede armar el resto de una entrevista.

Hagamos un análisis de este caso. Ahora, aquí dice que en mayo de 1977 muere el padre, y que él había pensado que en

el caso de morirse uno de los progenitores, él se quedaría con el otro. Muere el padre y, entonces él comienza con sus males-tares. Esto significa que el sistema tenía una programación anticipatoria y que, como dijo Luis, se trata de una patología de la desvinculación a todos los niveles: madre, padre y paciente, y donde sólo la hermana ha podido separarse. Ahora, lo que sucede es que esta familia ha programado anticipatoriamente, antes de que el padre muriese, que él debía quedarse a acompañar al otro. Es muy claro el que la familia ha elaborado una programación política de su vida futura.

Pero, éste es un caso en el que yo sería optimista porque este paciente ha hecho numerosas tentativas en el curso de su vida, tentativas de desvincularse, como, entre otras, la de obtener su título universitario y la de, oponiéndose a su madre, casarse con Liliana. La madre había pensado en la joven de catorce años porque a ella le convenía mucho más, no era rival...

Psic. Juri: —No era ningún peligro.

Dra. Nicoló: —Peligro, claro. Liliana representaba el peligro, en cambio la novia de catorce años, aparte la riqueza...

Dr. Lebensohn: Riqueza y catorce...

Dra. Nicoló: —No era una rival de la madre... El establece una relación con Liliana y, Fidel hablaba de dos mujeres, yo diría dos madres... Dos madres rivales... una relación no clara, ambigua, entre hijo y madre real e hijo con madre-esposa. Y estas dos madres son siempre rivales porque luchan por la tenencia del "hijo".

La patología lo es de desvinculación, como decía Luis, y cuando él prueba desvincularse, el padre muere y, esta especie de mito familiar o programación anticipatoria, indica que Danilo debe quedarse con la madre. Ahora, hay algo que me ha llamado la atención y sobre lo que quiero fantasear. Hay que hacer una clara distinción entre hipótesis y fantasía. La hipótesis es algo bastante real, en cambio la fantasía...

Lo que me llama la atención es por qué este señor se casa un mes luego de la muerte de su padre. Y mi fantasía, entonces, es que Liliana es una mujer independiente y fuerte, que

viene de una familia en la que no se le prestó atención y que Danilo elige y luego desposa, como si estuviera casándose con su padre o sustituyéndolo, en un cierto sentido. Lo que resulta sistémicamente muy muy claro es que estas dos mujeres, que litigan y pelean por el "hijo", comienzan a estar completamente de acuerdo, cuando él está mal. Esto es sistémico al máximo. Y él acepta. Es lo que decía Fidel; cuánto es lo que él designa y cuánto lo designan los otros. El acepta ser el regulador homeostático de este sistema, la que es la posición del paciente designado, porque con sus síntomas él no discute con su mujer demasiado en torno a la madre, sencillamente, el objeto de las discusiones son sus síntomas. Y ellas, no sólo no se oponen a la terapia de él, sino que, en cambio, se ponen de acuerdo para mandarlo. Al sistema yo lo entendería como el de padre-madre y Danilo, un sistema triangular donde él estaba programado para triangularse y definitivamente se trianguló.

Pero, decía que sería optimista porque este señor ha hecho tentativas de desvinculación, digamos sus viajes a Córdoba, y el propio hecho de presentarse a terapia, que es una tentativa de autonomía.

Diré que este Danilo es un adolescente y esta una situación de desvinculación adolescente, y que él está permanentemente tras la posibilidad de ser definitivamente un adolescente para ese grupo, o la posibilidad, por el momento hipotética, de ser un adulto, marido de su mujer.

La última cosa sobre la que quiero particularmente hablar es que ésta es una entrevista pasiva. Que obtiene la información del paciente como si éste fuese un objeto de estudio, y que confirma al paciente como si él fuese el objeto de atención y estudio, es decir el adolescente que se ha ofrecido para la triangulación. En vez, una entrevista que sea capaz de estimular en el paciente su posibilidad de autonomía, su conversión en "activo" dentro del sistema familiar, por ejemplo provocando esta suposición de que es un muchacho, puede hacer que el paciente, hacia el final de la primera entrevista, aunque ésta sea sólo una consulta, asuma una posición que comience a ser una posición de cambio y de transformación.

Una cosa a la que se han referido Fidel y Luis es qué hacer en este caso: Si terapia individual o de pareja, o familiar. Yo, honestamente, debo decir la verdad, creo que faltan datos para decir algo como eso. Aunque, siendo terapeuta de familia, trabajaré con la familia o la pareja. Quizá, en esta familia, trabajaré con el sistema completo, para meter dentro a la madre y así facilitar las cosas. Pero, los datos que faltan son aquellos acerca de la energía, de la capacidad del paciente de responder al terapeuta. Si yo no conozco cuánto es capaz de movilizarse respecto a un input terapéutico, no puedo decir si una terapia de pareja o, por último, una terapia individual. El riesgo es el de hacer una terapia inútil. Lo que se prescriba dependerá de la respuesta del paciente al input terapéutico, respuesta que no figura en esta historia.

Dr. Lebensohn: —Quería preguntar una cosa. La provocación ... algo que no entendí. La provocación, ¿sería en esta sesión? ... o, trayendo a toda la familia?

Dra. Nicoló: —Admitamos que este paciente viene a mí, y, a pesar de haber sido citado en pareja, llega solo y me dice: "mi madre y mi esposa dicen que lo necesito", yo comenzaré de inmediato a decir: "Perdone, si su madre y su esposa dicen que Ud. necesita cualquier cosa, ¿Ud. va y lo hace?" Comenzaré a enfrentarlo con una parte de sí sana para ver qué me responde. Este es un momento tanto diagnóstico como terapéutico. Diagnóstico porque me dice cosas acerca del paciente, y terapéutico porque lo coloco en una situación dialéctica interna, que es una situación dialéctica también sistémica, aunque el sistema no haya venido completo. Los momentos diagnóstico y terapéutico es imposible que vayan separados.

Dr. Lebensohn: —Otra cosa que me parece muy interesante es el concepto de que están programados triangularmente porque yo lo conectaría con la idea que yo quería expresar, que éste es un momento de crisis en el sentido de que están intentando romper con el programa. O sea que en este sentido yo valoro mucho el concepto de crisis. El está programado y probablemente ella también, y entonces éste es un momento oportuno para amplificar la crisis, es decir, esto como salida del sistema

para el que han estado programados. Esto me parece importante, y se conseguiría, a mi parecer, haciendo terapia de pareja, que es el modo en que ellos se enfrentan con sus programas redundantes de sus familias de origen para poder redactar nuevas reglas, es decir, ampliando el feed-back positivo para neutralizar el feed-back negativo que quizá los ubicaría en un proceso adaptativo a sus familias de donde han partido.

Y el concepto de dos madres rivales que me pareció también ... cuando yo hablé de dos mujeres, en realidad son dos madres rivales porque él le pide a ella que se enfrente de alguna forma con la madre y la transforma en madre rival. Ella se propone y él la propone como madre rival para que lo ayude a salir de esa situación, y ella se alía con la madre, cuando no con él, en un juego permanente de los tres. Para esto él la eligió con alguna carencia afectiva ...

Dra. Nicoló: —Hay, para mí, un momento muy importante en la historia. Cuando Liliana decide intentar una solución, nueva, toma a los niños —que son la otra parte del triángulo— y se los lleva y propone que discutan juntos, como pareja. Y él se va a lo de la madre: parece que siempre debe haber un tercero. La situación que se presenta permanentemente es la de que dan un paso adelante y uno atrás. Cuando tú hablas de crisis, yo no sé si ésta es la crisis o si no han vivido numerosos momentos de crisis como pareja.

Dr. Lebensohn: —Sí, pero ésta como privilegiada.

Dra. Nicoló: —¿Estás de acuerdo en esto de las numerosas crisis?

Dr. Lebensohn: —Sí, sí, indudable.

Dra. Nicoló: —... cuando el padre muere, cuando va a casarse, cuando el asunto del departamento ... numerosas pequeñas crisis, como tentativas de desvinculación.

Psic. Juri: —Esto muy de acuerdo con Ana María en lo que ella comentó respecto de la diferencia fundamental que hay en tanto el paciente viene en forma individual o si, habiéndoselo citado como pareja, uno de los miembros de la pareja no asiste. La estrategia evidentemente varía. Mis comentarios al principio estaban tomados, a pesar de que en la lectura se hizo la aclaración

ción, a nivel individual, puesto que en los datos clínicos no teníamos ese detalle.

Quisiera hacer un comentario. Me pareció muy interesante el concepto de programación anticipatoria. Porque podríamos coincidir en un punto. Yo trabajo mucho, como comenté, con las atribuciones de identidad. La atribución de identidad no sólo implica "sos de determinada manera" sino "debés ser así". O sea, la atribución de identidad indica cómo se es y cómo se debe ser. Y esto indica una prospectiva, por cuanto si la regla es "hay que estar unidos y no se puede salir", las atribuciones de identidad girarán alrededor de una imposición en ese sentido, por cuanto si el padre muere él se puede sentir encerrado puesto que la atribución de identidad podría indicar "tienes que ocupar el lugar de tu padre", o sea, "quedarte dentro de la familia". Me pareció muy interesante, por eso quería hacer este comentario.

Dra. Nicoló: —Otra cosa... cuando uno dice "tú debes ser así", eso parece una orden que uno le da al otro. Sistémicamente eso no es así simplemente porque no hay alternativa respecto de no serlo. Existe un pattern de comportamiento y no hay ninguna otra posibilidad, porque son todos complementarios los unos de los otros, respecto de esto. Las funciones son complementarias en un sistema familiar cohesivo como éste.

Psic. Juri: —Sí, lo que agregaría es que el pattern familiar es un permanente y redundante transmitirse identidades, y mensajes que están agrupados alrededor de esas identidades. Por lo tanto, permanentemente en la familia o en la pareja se dice: "así te veo", pero también "así debes ser". Redundantemente se transmite una orden, de alguna forma, acerca de cómo debe ser la relación.

Dra. Nicoló: —De unos con otros.

Psic. Juri: —Sí, sí.

Dr. Lebensohn: —... "así te veo, así debes..." sería en lo evidente y en lo latente. ¿En los dos niveles estás hablando?, o...

Psic. Juri: —No. Diría... que la identidad... si la madre

le dice al hijo cada vez que él quiere salir, o le hace saber, que él es "malo"...

Dr. Lebensohn: —Claro...

Psic. Juri: —... esa identidad significa una orden: "Tú no debes salir".

Dr. Lebensohn: —Está bien.

Dra. Nicoló: —Yo siento que hay mucha afinidad... Para usar una imagen analógica, puede imaginarse esta familia como un recipiente, una pecera, cuya presión interior debe mantenerse. Si uno se va, la presión sobre el otro cambia. El trabajo de cada uno en la familia es el de controlar la autonomía del otro, que es el control de la suya propia.

Psic. Juri: —Quería hacer un comentario sobre un punto, que es el siguiente. Se preguntaban por qué Danilo ocupaba el lugar que ocupaba él. Desde una perspectiva de la identidad interior, podríamos decir que tiene dentro suyo —Danilo—, dos tipos de representaciones: las representaciones del Yo y las representaciones del Objeto. La representación del Yo daría la propia identidad y las representaciones del Objeto, la identidad atribuida al otro. Es muy probable, y aquí también hago una cierta presunción, que la representación del Yo que él tenga pueda ser como "débil", o "dominable", o "incapaz de salir". En tanto que la representación del Objeto que él tenga interiormente, sea la de alguien dominante. Por lo tanto, él, en la relación de pareja, si atribuye esa identidad a la esposa, puede que la sienta como dominante. Pero no sólo importa la esposa "dominante" sino la representación del Yo como "débil" o "incapaz de salir". Por lo tanto él se va a sentir asfixiado, atrapado, no solamente porque la mujer le parezca dominante, sino porque él se representa débil o dominante, y eso es importante porque la idea de que la esposa pueda ser dominante no es suficiente. Es preciso que la esposa sea "dominante" y que él, además, tenga una representación de él como "débil" o "incapaz de salir". Por eso una terapia, por ejemplo individual, puede atender a las representaciones del Yo; a la autoidentidad que él tenga. Porque en tanto él mantenga su identidad como débil o adolescente o niño incapaz de salir,

él en otras relaciones puede sentir un peligro: Porque el otro es "dominante" y porque, además, él es "débil" o dominable, o "incapaz de salir".

Dr. Lebensohn: —Me parece que es interesante lo que dice Luis porque estaba pensando en términos de relación y en términos de circularidad y de apuntar al tratamiento ... yo sentía un poco que dentro del sistema sí, viendo cómo funciona el síntoma, él aparece como el sintomático que se queja un poco de no poder ser supuestamente independiente, y que la madre es alguien que lo ahoga, y que la hermana es alguien independiente ... yo tengo la idea, desde el punto de vista sistémico que acá se ve claramente todo el sentido de complementariedad de los roles y de las cosas que aparecen y están subyacentes. Es decir que la madre quiere y aparentemente lo protege a él, pero a quien le da independencia es a la hermana, de quien parece no ocuparse, a su vez la hermana necesita que él sea de esa forma porque es la única cosa que le va a permitir ser a ella independiente, y la madre necesita a los dos, a él como dependiente —al que permanentemente le dice que sea independiente—, y a la hermana como independiente, porque de esa manera la hermana está haciendo algo que ella hubiera querido hacer, mientras al hijo lo somete como le hubiera gustado hacer con el esposo y no pudo. O sea que se visualiza una situación que es, en efecto, de complementariedad, de la que nadie puede salir porque todos necesitan de alguna forma del otro. La salida ..., si bien han habido muchas crisis y la entrevista se podría interpretar de muchas formas, es importante que él haya venido. Es decir, es la primera vez que consulta. Yo también hago la fantasía de que le habrán dicho muchas veces "hacete ver", o él lo habrá pensado, pero esta vez vino. Igual a las otras veces pero en esta crisis una diferencia; y esa diferencia es la que creo que está marcando, en el ciclo evolutivo, la verdadera posibilidad de salida. Claro, depende de cómo se interprete. Yo creo que hay que llevarlo al contexto real. Para que todo esto no sea una fantasía tiene que convertirse en realidad y la realidad descubrirla viendo cómo funcionan todos ellos.

Dra. Nicoló: —Si he entendido, tú dices que la utilización de la hermana en este caso es importante por la madre, ¿no?

Dr. Lebensohn: —Sí.

Dra. Nicoló: —La otra cosa que tú dices que me parece importante es el valor positivo del síntoma. . .

Dr. Lebensohn: —Claro, ésta es la ocasión, la única, en que él está acá, vino. Que haya venido mandado por la mujer, o llevado por su programación adolescente, pero vino. Este es un momento muy importante.

Dra. Nicoló: —Aparte que el síntoma tiene un valor positivo sistémico, ya que moviliza una situación . . .

Algo que me parece importante en el discurso que ha hecho Luis es la relación entre Yo y Objeto. El ha hablado en un nivel vertical y nosotros, en un nivel horizontal, es lo que llamamos funciones complementarias de unos con otros y se establece como modalidad comunicacional, de relación, que son funciones del sistema y parte constitutiva de las personas.

Psic. Juri: —Yo pienso que estamos de acuerdo porque la identidad, como la pienso, es una función complementaria con el otro miembro de la pareja o de la familia.

Dra. Nicoló: —Cierto.

Psic. Juri: —Por ejemplo, si la madre es una señora dependiente que desea representarse como independiente, ella necesita una representación dependiente del otro, como función complementaria.

Dra. Nicoló: —Usemos un ejemplo. Digamos que las funciones se conforman un poco como la especificidad de la célula. Al inicio las células son específicas, pero luego, con el contacto con la otra célula, comienzan a especificar sus funciones. La identidad es de cada célula, y es específica, ya que la célula hepática no es la cerebral, pero la función de una se hace y hace a la función de la otra de la cual recibe información. Es decir que la función tiene que ver con lo que es una persona, pero no es éste el objeto de nuestro estudio.

Dr. Lebensohn: —Estaba asociando en este momento que es muy interesante, escuchándolos a los dos, que llevan al concepto de mente de Bateson. El dice que una mente no lo es en

sí sino que es el punto de pasaje de la realidad total y —el concepto como mente ecológica— ... es decir que, si bien es por dentro es siempre en relación. Y el concepto de célula en la que una da información a la otra hace que uno se plantee dónde empieza la célula del hígado y dónde termina la del cerebro. Porque si una hace a la otra, yo no sé dónde empieza una y dónde la otra. Se trataría del concepto de mente individual; no existe la mente individual sino que es el punto de pasaje de muchas realidades pasadas y presentes que en ese momento se da, y que si tomamos individualmente podemos divisarla con todos los elementos, con todo lo que es, pero si lo tomamos en sentido horizontal no podemos decir que es eso sino eso más todo lo otro, coagulado en este momento.

Dra. Nicoló: —Yo voy a hacer una pregunta: ¿por qué en general se habla de una gran antítesis...?

Psic. Juri: —¿Entre Psicoanálisis e Interaccionalismo?

Dra. Nicoló: —Sí...

Psic. Juri: —Mi idea es que es un problema de dos ángulos: los psicoanalistas y los interaccionalistas.

Dra. Nicoló: —Mas no el Psicoanálisis y...

Dr. Lebensohn: —Porque son dos niveles diferentes. El Psicoanálisis, por ejemplo, habla de una estructura interna, de la personalidad. Pero un sistema está formado por dos estructuras internas en interrelación. Por lo tanto hay dos sistemas: el interno y el sistema formado por los dos sistemas. Son dos niveles. Podemos hablar del sistema interno, como yo he hablado de la representación del Yo y la representación del Objeto, internamente, como estructura interna de la personalidad, pero ésta, junto con la otra estructura interna de la personalidad conforman otro sistema que, éste sí, tiene pautas propias, diferentes patterns que los de la estructura interna.

Dra. Nicoló: —Pero ése es un concepto sistémico...

Psic. Juri: —Cierto, pero la diferencia podría consistir en que desde mi punto de vista tomo en consideración la estructura interna que alimenta la estructura del sistema.

Dra. Nicoló: —En vez, el sistémico considera al contrario, justo la viceversa.

Psic. Juri: —Habría dos extremos. El extremo en que sólo existe el sistema, la personalidad no cuenta. El otro extremo cuenta la personalidad individual y no el sistema. Creo que los dos extremos son inadecuados. En realidad el sistema conforma una estructura que influye en la conducta de cada uno, pero un sistema está formado por dos estructuras que conforman una estructura particular que condiciona a cada uno. Lo difícil es entender el sistema en abstracto porque está conformado por las dos personalidades, aunque no pueda discriminarse la conducta de cada uno aisladamente.

Dra. Nicoló: —Lo que dice Freud: el mal para el Psicoanálisis son los psicoanalistas y para la Psiquiatría los psiquiatras.

Dr. Lebensohn: —Hace unos pocos días la Dra. Selvini dijo lo mismo.

Dra. Nicoló: —¿Sí?

Dr. Lebensohn: —Sí. Dijo que el problema eran los psicoanalistas y los interaccionalistas. Lo que quería decir, yo lo escuchaba a Luis, el problema es que depende de la puntuación, de si la ponemos en el interior o en el exterior. Pero como sabemos que en realidad no podemos saber por dónde empieza y por dónde termina entonces, está bien, cada uno puede tener su punto y su esquema referencial para interpretar a la realidad, el asunto es que no nos quedemos encerrados en nuestras propias perspectivas sino que podamos... Por eso posiblemente Luis dice que es un psicoanalista raro, pero porque él tiene su esquema referencial, pero acepta el otro. En la misma forma que en este momento podemos pensar y darnos cuenta de la misma situación. Que es un poco lo que decía antes de Bateson de que, cuando él se plantea si la mente es immanente o trascendente, es decir es immanente-trascendente. No podemos saber dónde empieza o dónde termina la mente. Claro que según lo que podamos leer en un momento dado, puede ser immanente o trascendente. Pero es mucho más creativo y creador poder pensar que son las dos cosas.

Dra. Nicoló: —Una cosa que creo importante, porque si no se genera confusión; discutir teóricamente es importante y esto acrecienta nuestra creatividad, pero lo que hay que res-

catar, y para ello incluso renunciando a algunas cosas, es la verdadera praxis y lo que en ese momento se hace. La implicación del terapeuta y la actualización de las situaciones que se están produciendo. La postura del psicoanalista es menos activa...

Psic. Juri: —Por lo menos clásicamente.

Dra. Nicoló: —Sí, por lo menos clásicamente.

A modo de síntesis

Dr. Raúl Rubén Makinistian

a. El aspecto relacional o conativo

Según la concepción batesoniana de "mente", los panelistas, en un ámbito o contexto determinado, trabajaron constituyendo un sistema mental. Sistema que, entre otras características, tiene capacidad para funcionar mediante ensayo y error.

Si se prejuzga o, en términos que no aluden a síntesis sino a disociación y oposición (pares de opuestos), se piensa en un panel de tres terapeutas en el que dos tienen referenciales semejantes y el tercero uno disímil, lo presumible es que se plasme una situación simétrica en la que no haya lugar para más que declaraciones de fe a las teorías, y la sumisión a un patrón que exigiría, en el caso de que se pudiesen obviar las escaladas en honor al contexto, una rigidez que tendría como consecuencia, resultando todos algo perdedores, el aislamiento de cada uno o, peor, la coalición de algunos contra otro.

Esta clase de sistemas mentales que enaltecen "lo individual", paradójicamente, doblegan a los individuos. El hombre se ve privado del enriquecimiento de una experiencia de integración merced a la recepción del "otro"; y queda confinado a su función de pregonero subsistémico de partido,

teoría o sector.

En cambio, si se presta atención a lo ocurrido, se verá que aparece, gracias al esfuerzo de cada participante, y junto al deseo de clarificar los puntos de vista, la búsqueda de coincidencias o de planos neutros de "encuentro" o de avenencia a una misma intención. Puede observarse que va conformándose un espacio de complementarización recíproca en el que el acercamiento brinda seguridad, y relega la necesidad de controlar la relación. Luego, cuando corresponde al dismantelamiento del sistema que ha ganado libertad de acción y expresión, resulta, además de una tarea sencilla, una operación instructiva.

Puede concluirse en que el sistema preservó (y quizá enseñó), a los individuos.

b. El aspecto informativo o de contenido

Los panelistas convinieron en destacar los siguientes aspectos: 1) la consulta (que sería necesario esclarecer, investigando motivación y designación); 2) el "tipo" de familia (cohesiva o simbiótica; cerrada); y 3) la problemática (de desvinculación).

Respecto de los aportes específicos, se puede ofrecer esta síntesis:

Para el Psic. Juri son fundamentales tanto la 'internalización de los patterns familiares (familia interna)', como las 'atribuciones de identidad' destinadas en este caso, en el interjuego de personalidades, a impedir el alejamiento. Hace la distinción, y valoriza, tanto al sistema como a las personalidades que "alimentan" al sistema.

El Dr. Lebensohn señaló que un mensaje cualquiera, según la posición del terapeuta, puede ser entendido como una demanda individual o como una demanda del contexto, efectuada por medio del "gestor" o "paciente designado". Además, incluyó el enfoque de: a) el momento del 'ciclo evolutivo' en que está el sistema; b) la 'paradoja central' que bloquea

el desanudamiento; y c) la categoría de la crisis (que considera como privilegiada).

Para la Dra. Nicoló lo importante es que, dado que no existe información aséptica, y en este historial nada se sabe del terapeuta, entonces no pueden hacerse hipótesis sino sólo fantasías. Esto es, que marca la incompletud del sistema en estudio.

E introduce un concepto que es el de 'programación anticipatoria' (en esta oportunidad: la triangulación). Se muestra optimista ya que si bien la familia parece "avanzar y retroceder" permanentemente, han vivido muchas pequeñas crisis que significaron la obtención de algunos logros, y puede suponer que más ha de obtenerse en ésta que, como el Dr. Lebensohn, cree que es una crisis privilegiada.

Acerca del qué hacer, atendiendo a las representaciones internas del 'Yo' y del 'Objeto', el Psicólogo Juri prescribiría terapia individual y de pareja. El Dr. Lebensohn propone entrevistar a la familia completa (nuclear y extendida) para verificar o modificar sus hipótesis y, por fin, hacer un recorte y trabajar terapéuticamente con la pareja marital.

A diferencia, la Dra. Nicoló, si bien descuenta que trabajaría o con la familia o la pareja (algún sistema), no se expide porque piensa que faltan elementos para poder hacer una prescripción. El dato ausente que para ella es indispensable es el de la receptividad y reacción del "paciente designado" a la provocación de su aparente sumisión que, de haber sido ella la terapeuta, seguramente habría efectuado ya al comienzo, con miras a transformar la entrevista de 'momento diagnóstico' en 'momento diagnóstico-terapéutico' que, dice, no debe separarse en 'diagnóstico' y 'terapéutico'.

DIALOGOS

del Dr. Canevaro con el Dr. Alberto Serrano, terapeuta argentino radicado hace 20 años en USA. Profesor de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia en la Universidad de Texas.
Buenos Aires, Agosto 1980.

Dr. Canevaro: Como director de un Centro Comunitario en Salud Mental, dada tu preparación polifacética, mi interés sería ver cómo se inserta la terapia familiar en tu trabajo cotidiano, tanto dentro de la institución como fuera de ella. en los programas de psiquiatría comunitaria.

Dr. Serrano: La pregunta es muy compleja, muy interesante. Me parece que lo mejor sería dar un poquito de la historia de mi experiencia en San Antonio. Tal vez, tuviera que decir unas cuantas palabras de la experiencia en Galveston donde me formé, donde trabajé con Bob McGregor en el Multiple Impact Therapy Project, un proyecto sobre terapia de impacto múltiple en familias, un proyecto experimental en el cual estuve involucrado unos dos años, y donde posiblemente aprendí todos los elementos básicos que ahora he podido utilizar en una escala mucho más grande. Yo digo básicos, porque había una pequeña serie de limitaciones por el diseño de la investigación y sobre todo por la realidad de formar parte

de una escuela de medicina que tenía una serie de restricciones con respecto a la jurisdicción de la población que estábamos tratando; debido a una serie de problemas políticos entre los servicios de la ciudad y del condado y la Escuela de Medicina. Estas cosas cambiaron cuando pasé a San Antonio porque tenía muchísima más libertad de acción siendo Director Ejecutivo de un Centro Comunitario. Entonces, cuando la Escuela de Medicina, que se estaba edificando en la misma zona, en el Centro Universitario, se adhirió, nosotros nos afiliamos oficialmente con la Escuela de Medicina, manteniendo nuestra autonomía e incorporando todo lo que fuera docente. Por unos dos años tuvimos la posibilidad de desarrollar el programa, sobre todo entrenar a nuestra gente en nociones de psiquiatría familiar, ver los conceptos de cómo comprender la familia y cómo tratar a la familia, entrenando a nuestro propio staff, que después fue el elenco de profesores. Ese trabajo previo que nos llevó como digo unos dos años significó trabajar con profesionales que ya tenían una experiencia de corte psicodinámico, si no puramente psicoanalítico, pero con experiencia fundamentalmente en terapias individuales y un poquito menos en terapia de grupo, trabajando con niños, adolescentes y familias pero de una manera muy tradicional. Las evaluaciones diagnósticas eran hechas por un equipo donde el psiquiatra y un psicólogo veían en forma diagnóstica y por separado a los niños y los asistentes sociales veían a los padres casi siempre excluyendo abuelos, hermanos u otro tipo de familiar o allegado. Parte de lo que yo traté de hacer al entrar fue buscar que la evaluación diagnóstica tuviera una orientación centrada en la familia donde se pudieran incorporar familiares, allegados y a veces con frecuencia cada vez más creciente a otras personas de importancia en la vida del niño, por ejemplo un maestro, un oficial de justicia para la delincuencia juvenil, un clérigo que tal vez estuviera muy involucrado con el niño, un trabajador social del servicio de asistencia social o de protección de menores, un pediatra, en fin, quien fuera que por razones específicas del caso tuviera gran relevancia y que fuera parte del sistema social básico del niño.

Dr. Canevaro: ¿El Centro es un Centro Infanto Juvenil?...

Dr. Serrano: Exacto.

Dr. Canevaro: ¿Donde la terapia de adultos más bien viene a través de los niños y de los adolescentes?

Dr. Serrano: Sí... Por mucho tiempo el tratar a los padres era un aspecto, digamos, más bien secundario. Se consideraba que la gente con mejor formación trataba a los niños y los adolescentes que eran los problemas, y aquellos con menor formación trataban a los padres más como "counseling", más como consejo, guía, acerca de problemas de conducta, acerca de ayudarlos a comunicarse y a entender los problemas del desarrollo de un niño. Era una cosa más educacional que reconstructiva o exploratoria. Llevó mucho tiempo buscar otro tipo de complementariedad en los roles de los profesionales y una horizontalidad en la cual todos los profesionales fueran igualmente competentes, y enseñarles a no tener miedo a ver una emergencia en un niño o un adolescente. Que no fuera que solamente los psiquiatras podían hacer ese tipo de cosas sino que también otro de los profesionales, debido a su competencia y su experiencia también pudieran ver algún suicida, por ejemplo. Si bien ese tipo de intervención todavía se restringe a los psiquiatras, los asistentes sociales o psicólogos más experimentados también con frecuencia pueden ver casos de ese tipo. Pero volviendo atrás lo importante, recordando los primeros pasos, fue el miedo, la sorpresa que tenían, a veces, profesionales que estaban trabajando de una manera fragmentada en un caso cuando se los invitaba a la posibilidad de, por lo menos, una vez ver a la mamá, o a los padres y a los chicos juntos; y no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando nomás de hace 10 años atrás, y ver la sorpresa que lo que se anticipaba que iba a ser una terapia de uno o dos años, con mucha frecuencia se reducía a unas 8, 10 ó 12 sesiones una vez que veían cómo se podían

utilizar las energías potenciales de la familia, la información existente en la familia y canalizar digamos una nueva relación, una nueva comunicación expresiva y afectiva entre padres e hijos, sin eliminar la posibilidad de que a posteriori uno de ellos, o más de uno de ellos, pudiera estar en terapias de grupo o terapias individuales. Entonces la faz inicial fue de poder facilitar que todos los profesionales tuvieran una orientación familiar, que estuvieran acostumbrados a, por lo menos, las técnicas básicas de cómo hacer una entrevista con una familia y cómo continuar, luego cuando estaba indicado, con terapia familiar sin tener que abandonar otro tipo de terapias. Mi experiencia está en que muchos profesionales tienen miedo, parece que si incorporan terapias familiares tienen que olvidarse de lo demás que aprendieron antes.

Dr. Canevaro: Sin entenderlo como una etapa necesaria para una mejor integración clínica. . .

Dr. Serrano: Exacto. Digamos que dentro de la visión clínica, a mí me parece que tener una orientación familiar da una visión mucho más amplia al terapeuta y ve más objetivamente aquello que es patológico, así como aquello que es fisiológico, y sobre todo cuáles son los recursos positivos que van a facilitar nuestra ulterior intervención.

Dr. Canevaro: Una de las dificultades nuestras, en la Argentina, es que la terapia familiar se utiliza, por así decir, dentro de un gabinete, de un consultorio y que es bastante infrecuente (cosa que por suerte se está modificando en los últimos tiempos) la posibilidad de que la terapia familiar sea el enfoque en el cual esté centrada una institución. Con esto quiero decir que estimular los recursos naturales de un grupo familiar no está demasiado generalizado como técnica o como visión cuando se parte de una teoría hacia el fenómeno clínico. Esa es una dificultad que yo veo, pero la otra es la dificultad de implementar la estimulación de los recursos naturales en el medio social en que esa familia vive. Como sé que vos tenés una gran experien-

cia en estos dos aspectos de la pregunta me gustaría que desarrollaras un poco más ese concepto de estimular los recursos naturales o los recursos propios de un grupo familiar.

Dr. Serrano: Evidentemente, al oír esto otra vez pienso que tenemos que separarnos un poquito del concepto tradicional, llamado médico en USA, donde hay un paciente y un profesional: ese es el modelo médico, el modelo de enfermedad. La enfermedad pensada como individual que requiere un profesional o una institución para ayudar a ese individuo, ya sea, remover los síntomas o modificar su conducta para que se mejore o se ponga bien. En cuánto pensamos de manera sistémica, pensamos no ya que es un individuo que tiene síntomas y que está enfermo en el sentido de salud mental, sino que es un individuo en un sistema que no le ha podido dar los recursos para continuar sano o facilitar su mejoría o su adaptación, entonces el sistema ha fracasado y este fracaso está exteriorizado por un individuo que aparece con síntomas. El pensar así es muy novedoso, casi revolucionario, y nosotros los profesionales no hemos sido formados para entender la patología en ese contexto. De la misma manera, si entendemos la patología en el contexto, podremos entender las posibilidades de reparación, también en ese contexto. Lo que uno debe tratar es un sistema que necesite compensar sus mecanismos o aprender nuevas competencias para poder ser continente de ese individuo que antes tenía síntomas y que ahora posiblemente ya no los tenga; y que los síntomas eran simplemente un reflejo de una crisis en la homeostasis del sistema.

Cuando pensamos en instituciones también tenemos que hacerlo así. Muchas veces en una institución se piensa: bueno, si tenemos un nuevo jefe o nuevo pabellón o nuevo servicio, las cosas van a cambiar y de una manera individual posiblemente pueda cambiar, pero creo que es más útil pensar de una manera sistémica en qué puede pasar con la institución, que agregue por ejemplo un servicio de familia donde haya un grupo especializado que sepa más de eso, que pueda estudiarlo, experi-

mentarlo o entrenarlo, sin necesidad de que toda la institución tenga que estar en eso, así como una cosa, digamos, inicial. Pero evidentemente volviendo a lo que hablábamos antes, el conflicto que hay en USA, en muchísimos lugares, es la sensación de que si uno piensa sistémicamente, tiene que abandonar lo individual y, si uno mantiene la orientación médica de patología individual y de terapia individual no puede comprometer eso y hacer otro tipo de cosa. Yo creo que las dos posiciones extremas son erróneas, pero la realidad es que ambas son erróneas y ambas tienen verdades, ambas son útiles y no deberían abandonarse, pero es difícil evidentemente integrarlas. El campo de la terapia familiar es nuevo, bueno, pero hay gente que ha comprometido veinte años de su vida en una cosa casi militante y fanática en terapia familiar en la cual les parece que tienen que luchar tanto para que otros profesionales los oigan y los respeten, que entonces se colocan en una actitud muy purista y muy anti-individual también, o antimédica, lo cual no favorece a nuestro campo porque está gastando nuestras energías en una especie de lucha.

Dr. Canevaro: ¿La dificultad de crearse un espacio para terapia familiar proviene más bien de factores concurrentes o competitivos de los mismos profesionales, o lo ves como reflejo de una dificultad social en general, de comprender el problema de la familia?

Dr. Serrano: Yo lo veía más que nada como una cosa de las dificultades profesionales, digamos del narcisismo del profesional que ha comprometido años de su vida en una dirección y que le resulta muy difícil modificar su línea por miedo a tener que abandonarla, es decir en vez de reconocer que puede modificar, cambiar, ampliar, renovar, el miedo es que tenga que abandonar todo ahora para aprender a los 40, o los 50 años toda una imagen nueva. Un poco como me pasó a mí hará unos 10 años cuando fui a unos workshops muy intensos sobre análisis transaccional en San Francisco. Los tipos son muy carismáticos y tenían un elenco muy interesante, muy lindo, y claro, a través

de un workshop intenso de una semana donde estábamos viviendo ahí, salí con una sensación de que mucho de lo que yo había aprendido era obsoleto y que había una serie de metodologías simples y técnicas nuevas que había que aprender. Por un lado estaba como un pibe con un juguete nuevo y por el otro me sentía sumamente confuso y amenazado con la sensación de que tenía que perder y abandonar muchas de las cosas que había aprendido, sobre todo, las técnicas de corte más exploratorio, psicoanalítico. Me llevó por lo menos de 6 meses a un año poder integrar y digerir y aceptar que no tenía que hacerme un analista transaccional, que tampoco tenía que abandonar lo anterior y que había una posibilidad de integrar muchos de esos conceptos dentro de lo que me resultaba mucho más práctico a mí.

Dr. Canevaro: ¿Te parece que este recorrido que vos hiciste podría ser un modelo del futuro de la terapia familiar; o sea, según tu juicio la terapia familiar va a ir integrando recursos, técnicas, o más bien van a ser feudos separados a fin de desarrollar más profundamente un aspecto determinado de la investigación?

Dr. Serrano: Mi preferencia y lo que yo veo en una cantidad de gente que trabaja conmigo es que por ejemplo cuando terminan su formación algunos tienen una especie de lealtad, interés o vocación en una orientación familiar que otros. Pero mi interés es que todos nuestros egresados, que no están entrenados puramente en terapia familiar, tengan otro tipo de experiencia durante su formación clínica, que se sientan cómodos en poder entrevistar una familia, y en participar en terapia familiar, aunque no sea lo primario que están haciendo, que no tengan miedo a enfrentar una familia y a utilizar un buen juicio clínico. Nuestro programa, como yo digo, no es un instituto de terapia familiar, sino una institución que por el momento, no tiene nada más que los dos primeros años. Debido a la afiliación con la escuela de Medicina hay residentes de psiquiatría en su formación de tres años que están 6 meses

full time con nosotros; los que se están especializando en psiquiatría infantil que están dos años, los residentes de psicología que son del doctorado, y los estudiantes de asistencia social, a nivel de la maestría psiquiátrica, que están 6 meses con nosotros. O sea ésa es la gente, aparte de los estudiantes de medicina que tienen algunos cursos, algunos casos pero más que nada como observadores en seminarios de orientación familiar, aún cuando también participan en terapias individuales, en supervisiones y en terapias grupales. Como dije, el egresado por así decir, tiene una formación, o por lo menos tiene experiencia con el concepto de familia, con intervención en familias, sea a nivel diagnóstico o a nivel terapéutico, sin que sea la exclusiva técnica que utiliza. Por supuesto gente que continúan con nosotros a través de otros cursos o participando como profesionales van a obtener experiencias avanzadas a través de los años, y entonces ya será su formación primaria por así decirlo, como terapias familiares, o serán reconocidos como tales a través de los años.

Dr. Canevaro: ¿Alcanzás a dibujar un perfil de aquellos que se van a dedicar a la terapia familiar o de aquellos que no? ¿en unos y otros podés determinar variables que pudiéramos estandarizar?

Dr. Serrano: Es muy interesante pero nunca lo ví de esa manera, porque me parece que hay un factor muy importante, por lo menos en nuestro medio, que es no solamente el factor de vocación sino el factor de ¿dónde consigo un empleo una vez que termino? Eso a menudo determina qué posibilidades van a tener. Por ejemplo alguien que termina y es aceptado, digamos un psicólogo a nivel del doctorado, lo ponen en un centro de salud mental en una zona rural, y no es difícil que sea el único profesional avanzado, a nivel del doctorado, aparte de un psiquiatra que puede tener a veces una formación híbrida y que pueda estar solamente un tiempo parcial en práctica privada, pero con unas cuantas horas en un centro de salud mental. Este individuo puede tener entonces demasiadas responsabili-

dades administrativas y de supervisión como para ser realmente un modelo de identificación como terapeuta familiar. Ahora si ese individuo pertenece o continúa en un centro urbano, donde hay una cantidad de recursos de consulta, de supervisión, conferencias, institutos, etc., entonces puede tener una autoridad y un liderazgo en ese centro que haga que se formen una serie de profesionales debajo de él o de ella con mayor formación en terapia familiar. Lo más común entonces, es que el individuo que deja un centro universitario como el nuestro y está un poco aislado, termine haciendo lo más tradicional, lo más común, lo menos rebelde, por así decir, porque no va a tener mucho apoyo. Es triste, pero esa es la realidad. Es muy difícil que un individuo vaya solo, sea un pionero, tenga bastante presencia de ánimo, experiencia, y conocimiento como para ir ahí como maestro. Gente que ha estado con nosotros cuatro o cinco años en un nivel junior y después han ido a otro lado, han podido realmente hacer esto. Han podido incorporar, sentirse más cómodos, pensando sistémicamente, entrenando otra gente a pensar sistémicamente, a ser flexibles en el uso de diversas técnicas. Lamentablemente la mayoría no puede hacer eso, ya que no hay tiempo para ser aprendices de maestros por así decirlo. Una vez terminado su programa se van. Las circunstancias en USA son diferentes a las de acá, la mayoría de los profesionales se van a quedar en esta zona. Los nuestros buscan trabajo en una zona rural, las zonas urbanas están muy saturadas de profesionales.

Dr. Canevaro: ¿Ahora, paradójicamente, la zona rural donde se podría trabajar más con los sistemas rurales es donde vos decís que menos se practica la terapia familiar?

Dr. Serrano: Hacen trabajo con familias, utilizan a la familia pero el profesional puede no tener el concepto claro de cómo utilizar a la familia. La familia está ahí accesible, se pueden movilizar pero no tienen la tecnología para hacerlo de una manera metódica, los conceptos administrativos como para hacerlo. En los últimos años hemos desarrollado un programa de con-

sulta rural en 20 condados alrededor de San Antonio, lo cual nos lleva hasta la frontera con México, al sur, al oeste en un radio de unos 150 km alrededor de la ciudad, y es verdad por ejemplo que con el conocimiento de la gente que va, que son de lo más experimentados, es muy fácil movilizar recursos en zonas rurales cuando todo el mundo se conoce, conocen al maestro, al director, al juez, al médico, al jefe de policía, todos viven cerquita y se conocen, son parientes o son amigos, o van a la escuela juntos. Entonces es mucho más fácil que en la ciudad de San Antonio para nosotros por ejemplo, armar una familia postiza o agregarle recursos a una familia que está un poquito aislada. El trabajo es muy lindo y mucho más rápido. Se puede hacer, pero lo que hemos visto, es que aquellos profesionales que están ahí, que son nuestra clave en el sentido de contacto son muy inseguros, o están muy verdes en su desarrollo profesional, o demasiado en colusión con el grupo ahí mismo, pertenecen demasiado a la familia rural, y tal vez no se sientan con la comodidad y la flexibilidad de llamar a ese médico, a ese juez o a quien sea que haga falta. Nosotros que venimos de afuera nos resulta muy fácil, o relativamente fácil, ir en auto a una casa, la otra, la otra para poder hacer las conexiones necesarias, o estudiar a ver qué pasa.

Dr. Canevaro: ¿Podemos pensar que existan factores subliminales o factores de tipo social que produzcan un clima contrario al trabajo con las familias; algo así como si entrar en el recinto de una familia fuera algo sacrílego en cierto sentido, como si hubiera una presión para que el terapeuta no se desenvuelva naturalmente trabajando con ese medio familiar?

Dr. Serrano: Como quién es el de afuera y quién es el de adentro, ¿te das cuenta? Cuando vamos a algunas de estas ciudades chiquitas, rurales a veces la persona clave que es jefa de esa ciudad, es alguien local y tiene por lo tanto un gran poder de intervención, pero a veces por razones X esa persona que es jefe no es local, es un extranjero, por así decir, que pertenece a otro pueblo, a otra ciudad y puede no ser visto con buenos

ojos por los locales, es decir no lo ven como igual porque es de otro color, de otra religión o una profesión que no entienden. No ven a esa persona como un agente de salud que los respete, que los quiere, lo ven como alguien que realmente es un transeúnte, es alguien que va a estar ahí por 6 meses o un año y se va a ir; es decir no alguien que vino ahí a echar raíces, a casarse con alguien del lugar. Una serie de factores muy interesantes que ya son interfamiliares o sociales por lo que llamamos trans-familiar.

Dr. Canevaro: ¿Tu permanencia en San Antonio en este momento es de alrededor de nueve años?

Dr. Serrano: De 12 años.

Dr. Canevaro: Quiere decir que vos has podido conocer a lo largo de 12 años numerosas familias de una ciudad que con un millón de habitantes, podríamos pensar que a grosso modo tendrá unas 150.000 a 200.000 familias?

Dr. Serrano: Sí.

Dr. Canevaro: O sea que vos has podido conocer de alguna manera varias de esas familias.

Dr. Serrano: El programa para darte una idea más o menos ve unas 1009 familias por año, es decir que se ven en un nivel diagnóstico de las cuales un 50-60 % va a continuar el tratamiento de diversas modalidades; y estaba pensando que en este momento tengo vistas ya varias familias de las cuales yo había visto una hija o un hijo adolescente y que ahora viene como padre o madre por una consulta con sus hijos.

Dr. Canevaro: ¿La patología es menor que la que él traía anteriormente?

Dr. Serrano: Mucho más rápidamente parecieran identi-

car los problemas o reconocer que el centro es un centro donde los pueden apoyar, orientar de una manera organizada.

Dr. Canevaro: O sea que la tarea de prevención es importante, aunque sea inefable poder determinar el poder de la terapia familiar.

Dr. Serrano: Sí.

Dr. Canevaro: Pero por ejemplo en estas redes familiares, ¿qué manera tiene el centro que vos dirigís de ocuparse, en la comunidad, acerca del trabajo familiar? Por ejemplo estas redes familiares que se van constituyendo alrededor de la escuela, del trabajo y de la vecindad, ¿tienen alguna manera de trabajar con ellos ya sea en la clásica forma de *Speck y Attneave* o con técnicas autóctonas?

Dr. Serrano: No. Técnicas autóctonas. Te voy a decir cómo funciona. Funciona de manera formal y con más frecuencia de una manera informal. La manera informal tiene que ver con el hecho de que mucha de la gente que se entrenara con nosotros a través de los años han pasado a ocupar cargos en la comunidad: directores de entrenamiento, directores ejecutivos, coordinadores, consultores. Entonces ellos tienen noción de qué servicio podemos prestar nosotros, no solamente a nivel de terapia familiar, sino de ir por ejemplo y entrenarlos en workshops o consultas regulares acerca de cómo trabajar con familias. Por ejemplo en las escuelas uno de los problemas clásicos de las maestras es cómo atender a las familias o cómo ayudar a las familias que los ayuden a ellos, que no se encuentren las familias perseguidas o que ellos se sientan perseguidos. Una de las cosas en las cuales se nota nuestra experiencia en los últimos años es cómo ser puente de enlace entre familia y escuela; y eso se hace a nivel clínico o en aquellos casos que se han convertido en problemas sintomáticos; que las escuelas nos mandan para el diagnóstico y tratamiento, o las familias que vienen espontáneamente y reconocen que muchos de los pro-

blemas del chico no son solamente con la casa sino con la escuela. Entonces de qué manera los profesionales contactan la escuela, visitan la escuela, observan al niño en la escuela, hablan con los maestros, etc. si no en todos los casos, por lo menos en un suficiente número de casos para que exista una especie de aceptación de que nosotros no somos un grupo misterioso haciendo cosas muy raras, sino que estamos todos abocados a problemas humanos que son de interés común, en este caso sería que el chico funcione mejor, y a ellos les interesa que el chico funcione mejor en la escuela, y a los padres les interesa que el chico funcione mejor en la casa. Nosotros sabemos que esas experiencias no son aisladas, sino complementarias.

Dr. Canevaro: Me imagino que para eso habría que tener una política nacional que en ese sentido facilitara ciertas dificultades de índole administrativa o burocrática o incluso de la mentalidad. En ese sentido, tengo entendido que no existe una política nacional en USA que tome conceptualmente a la familia como unidad de estudio y de tratamiento.

Dr. Serrano: No. Cuando uno hace eso está rompiendo las normas tradicionales. El hecho de que haga tantos años que estamos en San Antonio nos ayuda a través de los años. Primero, hubo varias escuelas que aceptaron eso y después otras se interesaron a través de reuniones de educadores. Entonces alguien viene a nivel del superintendente que es el Director General del Distrito o Directores y preguntan: "A ver qué tenemos que hacer para conseguir que Uds. vengán". Entonces ya se hacen contratos. Evidentemente estamos hablando de la situación administrativa. Cómo se financia eso, ya es un poquito complicado, pero la verdad es que se puede hacer porque en muchas partes de USA los profesionales dicen no, esto no se puede hacer, o si se hace lo tenés que donar, ¿te das cuenta? Nuestra experiencia debido a que nuestro programa es privado, pero sin lucro, es que el programa no puede regalar servicios sin que entremos en picada. Si vamos a hacer algo nuevo, algo crea-

tivo hay que ver cuál es la mejor manera administrativa en qué se puede financiar, y así fue creciendo el programa, financiando cada nuevo módulo que se iba desarrollando. Entonces, una manera de crear la red involucrando a la familia en este sentido, en una manera indirecta, es que la escuela sea más sensible a la familia, y que pueda detectar también problemas por los cuales la familia necesite intervención de salud mental. En este momento las escuelas nos refieren más o menos del 30 al 40 % de todos los casos que vienen. O sea que es la escuela a través de los maestros, directores, que son bastante sensibles para reconocer que si el chico no anda en la escuela, o está nervioso, triste o ha cambiado su conducta de alguna manera pueden llamar a la familia y decir: aquí está pasando esto y nosotros los queremos ayudar, hasta este punto es académico pero más allá nosotros no los podemos ayudar, le recomendaríamos que fueran a un profesional de salud mental. Entonces, no es que lo manden exclusivamente a nuestro servicio, hay cantidad de gente en práctica privada o también instituciones como la nuestra, pero en cierto sentido el ablande, el conocimiento, la sensibilidad de la escuela nos ayuda notablemente para detectar los problemas, para referirlo de una manera que no sea castigadora, perseguidora y, por el otro lado para no rechazar el caso. Por ejemplo en los casos más extremos de problemas de conducta, incluso borderline, algunos psicóticos que las escuelas contienen únicamente porque saben que nosotros estamos trabajando con el chico y la familia, sino lo suspenderían, es decir que la escuela funciona casi como un hospital de día para muchos de ellos. La escuela sabiendo que tienen el apoyo terapéutico y el trabajo de la familia intensamente, no los larga solos, le aguantan al pibe un poco más. También va alguien más de la clínica para trabajar ahí con las maestras para ver qué es lo que tienen que hacer para no angustiarse, para no rechazar a un chico.

Dr. Canevaro: Cosa que obviamente acelera el proceso de curación del chico . . .

Dr. Serrano: Notablemente y sobre todo la no alienación

de que el chico tenga que ser internado, tenga que ser suspendido, que pierda escolaridad, es decir mantenerlo al máximo dentro de su sistema natural de apoyo, el cual es la escuela, el barrio, la familia, y que no tenga que cambiar nada de lo que lo está apoyando ahora, no hacerle perder nada de eso.

Dr. Canevaro: ¿Eso está dentro de la línea de las pautas fijadas a partir de 1963 en adelante?

Dr. Serrano: Exactamente. Es el enfoque comunitario. El máximo uso de los apoyos naturales y servicios ambulatorios, y utilizar recursos de hospitalización sólo por poco tiempo. Ahora la realidad, Alfredo, es que lamentablemente en USA en este momento te puedo decir que este modelo ha fracasado. Ha fracasado no en el sentido teórico sino en el sentido práctico. Zwerling seguramente te lo ha comentado porque ha estado desde el principio en eso, él es uno de los que más ha estado en la palestra y uno de los que más ha recibido las bofetadas y las ha aguantado. La mayoría de otros tipos se han quemado, lo que allá se llama el "burn out", se han quemado, han renunciado o los han echado y han salido descorazonados y amargados protestando contra el sistema comunitario porque el gobierno no prestó el apoyo económico necesario para que esto se pueda hacer. Las esperanzas al principio fueron de que esto se iba a financiar básicamente con dinero federal y apoyo estatal. El hecho de que nuestro programa hoy en día funcione con relativo éxito es, porque nosotros desde el principio vimos que el apoyo federal y estatal iba a terminarse, que era una cosa que en 8 ó 10 años se iba a agotar. Desde el principio abocarnos a utilizar algunos de esos dineros, pero tratando de desarrollar al máximo todos los recursos privados, de contratos privados, por ejemplo, o seguros u otro tipo de servicios que nos pudieran pagar. Si bien nunca nos dió la cantidad de dinero que tenían los centros de salud mental, que tenían cantidad de dinero federal, las subvenciones, nuestras subvenciones siempre fueron menores, pero nunca se han reducido mucho. Mientras muchos de los otros servicios se han ido a pique, a cero

porque se les terminaron totalmente los contratos federales, hará unos dos años, mientras nosotros pudimos sobrevivir.

Dr. Canevaro: ¿En qué influyó en el cierto fracaso el problema de los psicóticos crónicos? Tengo entendido que en USA los llaman los "ghettos de psicóticos"...

Dr. Serrano: Bueno, ¿sabés lo que pasó? Justamente el problema está en que se creó una legislación con Kennedy, muy creadora, con gran impacto pero sin que la teoría y la práctica estuvieran de acuerdo; y la práctica requería una financiación continua, y no una financiación nada más que por ocho años. Segundo, que si bien el mandato fue lo que se llamaba la des-institucionalización de los pacientes psicóticos, simultáneamente no se crearon centros ambulatorios, individuos que supieran terapia familiar para movilizar los recursos naturales. Es como si se hubiera inventado la psiquiatría comunitaria sin crear la infraestructura que pudiera ponerla en práctica, y muchas de las personas que se pusieron a cargo, los directores de psiquiatría comunitaria, no tenían ni la formación ni el concepto sistémico, ni la capacidad administrativa para llevarlo a cabo, y así fue como, varias de las cosas que surgieron, fueron de lo más tristes, como se quemaron muchas ilusiones y muchas teorías en la práctica. Una de las teorías que surgió entre los años 60 y 70 fue la noción de que movilizandando fuerzas naturales de la comunidad, los llamados paraprofesionales, los nativos, no por indios, sino nativos de la zona, es decir gente autóctona, gente nacida en el ghetto o gente que fueran indios, negros, portorriqueños, esquimales o mejicano-americanos, y que esos individuos por el mero hecho de ser de la misma raza, del mismo grupo cultural, del mismo barrio iban a ser de utilidad terapéutica. Entonces por un lado había profesionales que no tenían noción de cómo se orquestaba, digamos así, entonces ocupaban posiciones de liderazgo sin realmente cómo saber qué es lo que estaban dirigiendo, y por el otro lado darle alas a individuos paraprofesionales que en vez de, realmente cumplir una función terapéutica, se convirtieron despacito

en caciques y militantes políticos que buscaban la especulación personal y no la curación de sus gentes. Pienso en resumen que lo que hizo por el fracaso del movimiento comunitario y lamentablemente el congreso no analizó cuáles fueron las causas del fracaso. Viendo que el problema era un problema complejo, de la falta de conocimiento de los líderes, de la falta de experimentación apropiada, de que al sacar individuos de los hospitales no había clínicas o servicios ambulatorios para que se los pueda tratar correspondientemente, que no había gente con formación de terapia familiar para realmente trabajar con esas familias.

Dr. Canevaro: Me acuerdo que esa fue una de las discusiones que tuve con Minuchin en el Congreso de Florencia en el año 78 ya que él defendía fervientemente la formación de paraprofesionales y a mí me parecía lo mismo que a vos que, en tanto no haya de alguna manera una cierta preparación se convierten en líderes empáticos o primarios pero que terminan acoplándose a las fuerzas resistenciales...

Dr. Serrano: Sin formación clínica.

Dr. Canevaro: ¿Te parece a vos lo mismo?

Dr. Serrano: Sí, sí. Además que esto lo he visto, y lo interesante está en que eso creó hará unos 10 años una gran polaridad en mi programa con otros programas en los cuales se consideraba que nosotros no éramos lo bastante simpatizantes, que no delegábamos demasiado en los grupos hispanoamericanos. Mi posición era que nosotros teníamos una cuestión técnica en la cual si alguien iba a ser un profesional de salud mental tenía que tener una formación en salud mental básica, como clínico, completa, no importa qué color, religión o sexo tuviera. Era importante que alguien fuera sensible y conocedor de la cultura, del idioma, de los problemas, por ejemplo, de los grupos más desvalidos por así decirlo, muy importante, pero saber eso solamente no era suficiente. A mí me parece que es un profe-

sional incompleto que puede tal vez ayudarlos en un sentido de apoyo, es decir que ese individuo se sienta comprendido mejor, pero no creo que lo vaya a ayudar a superar los problemas de hoy para llegar a un mañana mejor. De entrada eso me trajo una cantidad de, sino enemigos, por lo menos gente que me trataba con muchísima frialdad en algunos de los grupos militantes de la comunidad. Lo interesante está que a través del tiempo yo creo que mi posición ha resultado más sólida, nuestro programa ha continuado, ha crecido, si no en proporciones desmedidas, pero por lo menos muchos de esos otros programas que en un momento tuvieron cantidad de dinero federal, se han muerto, se han terminado totalmente sin producir resultados, digamos ostensibles, en el sentido de formar gente o tener un impacto preventivo o curativo de mayor valor y los programas que han sobrevivido —eso es lo interesante— han sido programas que se han movido desde una posición de militancia hacia una posición profesional donde despacito han ido adquiriendo personal de más formación clínica, donde han establecido relaciones con nosotros acerca de intercambio de pacientes o intercambio de profesionales o intercambio de entrenamiento donde pasaron de una posición hostil-competitiva a una relación complementaria y de colaboración. Eso llevó muchos años, hablamos de la evolución, del tiempo que lleva realmente implementar un concepto de este tipo.

Dr. Canevaro: ¿Y cuál fue si es que lo hubo, la influencia del manejo político de todos estos grupos, de todos estos centros de salud mental? Digamos tiene algún tipo de influencia la política de los distintos partidos o distintas ideas en intentar captar algún tipo de...

Dr. Serrano: Allá por ejemplo vamos a hablar de los partidos más conservadores. El partido republicano prácticamente no tenía interés en este tipo de programa, sobre todo porque el programa había sido apadrinado por Kennedy como un representante democrático, y dentro del partido Demócrata, digamos la fracción liberal del partido. Durante los años de Nixon él

hizo mucho para desmoralizar y destruir mucho de lo que se había construido, porque siendo republicano él no tenía ningún interés en apoyar a los sistemas comunitarios o en que tuvieran éxito, porque ese éxito entonces sería atribuido a los demócratas. La política, evidentemente, se torna muy importante. Ahora hay un compromiso en la Legislatura, que por varios años ya se viene hablando, que se llama la Ley de Sistemas de Salud —Health Systems Act— que es algo parecido a los sistemas comunitarios pero que en realidad debe ser simplemente para salud mental, integra salud mental con salud en general. Se está hablando de centros de salud que van a tener un gran componente de salud mental, y eso tiene mucho que ver con algo que se llama la remedicalización de la psiquiatría. La psiquiatría por muchos años se desvió hacia lo sociológico y lo político, en muchos campos alejándose del campo de la medicina en general, y en cierto modo muchos acusaban de que la psiquiatría había abandonado su rol básico y se había metido en otros campos delegando demasiadas funciones a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los paraprofesionales. El Health Systems Act, seguramente va a salir el próximo año. Es una solución bastante aceptable que va a proveer por lo menos de un apoyo económico más estable a través de los años, en vez de ser algo que declina, pero que va a obligar a que los servicios de Salud no estén aislados de hospitales, de universidades. ¿Qué es lo que pasó? Que fueron manejados Centros Comunitarios por militantes o por lo que fuera. Esto en cierto modo va a obligar a que los centros estén bien conectados a lo que sea programas de prevención de salud. Yo creo que la solución es la transformación del programa, lo que ha pasado es que la ilusión de que cualquier paraprofesional pudiera ser convertido con poco entrenamiento en un profesional, en un individuo curativo, se ha reducido notablemente. Ahora, en el lado positivo, los profesionales o gente como nosotros hemos aprendido a trabajar con elementos comunitarios, no profesionales, integrándolos, extendiendo nuestra función a través de ellos, pero no delegándoles a ellos la función primaria de terapeuta.

Dr. Canevaro: El último tema del cual yo quería preguntarte algo es el problema del entrenamiento en terapia familiar. ¿Cuáles son a tu juicio los problemas básicos o conceptos básicos que debieran enfocarse acerca del entrenamiento y cómo lo ves de acuerdo a tu experiencia?

Dr. Serrano: Hay tres niveles por así decir: un nivel es el de poder entender a la familia como sistema, como una unidad que tiene aspectos patológicos y aspectos curativos, aspectos de apoyo. Es el pensar familia, el pensar sistema, eso es lo primero que tratamos de hacer con la gente que se está formando con nosotros. Y algo que tratamos de hacer por ejemplo ahora con estudiantes de medicina, la mayoría de los cuales no va a hacer psicoterapia por supuesto, es que puedan entender al individuo que van a ver como paciente en un contexto psicosocial; que ese individuo tiene una esposa, un hijo, un papá, problemas económicos, problemas de salud que están unidos a todos los demás, y que su diabetes puede afectar la emocionalidad, la sexualidad, la capacidad de trabajo, etc. Que todos los individuos están en un contexto, y en ese sentido, el estudiante de medicina entienda el contexto sistémico en el cual el individuo está funcionando. Entonces pensar familia posiblemente sea el primer paso, y una de las maneras en que lo hacemos es tratando de entender su propia posición en su sistema familiar corriente, es decir la familia actual y la familia de origen. Es decir que el pensar sistema, que al principio parece chocante para todos, es mucho más natural que lo otro, porque todos hemos nacido en un sistema y vivimos en un sistema, pero en cierto modo necesita reprogramar la manera de pensar.

La segunda fase es aprender a entrevistar familias, a no tener miedo a ver el sistema y a vernos nosotros relacionándonos o interaccionando con ese sistema, buscando información a un nivel diagnóstico, es decir: cómo diagnosticar familias. Qué es lo saludable y qué es lo enfermo, sin enamorarnos demasiado con las patologías individuales, en momentos en que este individuo posiblemente o ya esté entrenado en patologías individuales o esté simultáneamente aprendiendo de patologías indi-

viduales, entonces el poder integrar lo que está aprendiendo acerca de patologías individuales con un enfoque sistémico les trae cierta confusión y trae conflictos y lleva tiempo. En este mismo nivel de entrenamiento adquirir ciertos conceptos básicos acerca de intervenciones clínicas breves en terapia familiar, cómo hacer terapias breves, cómo intervenir, posiblemente a un nivel digamos de orientación, de consejo. No creemos que nadie pueda hacer algo muy profundo a este nivel. La tercera fase es ya de aquel que realmente va a ser un terapeuta familiar, todos estos otros son más bien clínicos que pueden ser médicos en salud mental como pueden nomás ser clínicos en otras áreas, pero que por lo menos estén familiarizados con el concepto familia. Solamente el que llega al tercer nivel puede ser un terapeuta familiar que necesita, en mi experiencia, dos años. Menos de eso yo creo que simplemente le da la posibilidad a alguien de poder hacer entrevistas familiares, no sentirse amenazado y respetar los límites, ver la familia en un contexto más grande, es decir tener un concepto básico más o menos hilvanado, pero no creo que nadie pueda hacer una terapia familiar bien integrada con menos de dos años de formación. Yo creía que se podía hacer en menos años pero a esta altura de la carrera no lo creo.

Dr. Canevaro: ¿Con experiencia directa con familias?

Dr. Serrano: Sí. Donde entonces ya uno pueda tener, no solamente adquirir, la capacidad de ver una familia a través del tiempo y todas las vicisitudes, las resistencias, los cambios que puedan sucederse. Viendo familias, no ya al nivel digamos de alivio de síntomas, que es una cosa que se puede hacer en menos tiempo. Hay una cantidad de terapeutas, sobre todo gente que trabaja tratando de manipular las estructuras y provocar cambios sintomáticos, lo cual es relativamente exitoso en menos tiempo, es decir que uno puede adquirir la tecnología necesaria para poder manejar familias en menos tiempo y provocar cambio por así decirlo, pero yo creo que para ser un terapeuta familiar como clínico, no ya como un técnico, necesita más tiempo,

más fogueo, más casos de mayor variedad de patologías, en supervisión, en coterapias, sólo combinando las terapias individuales, grupales, multifamiliares, consulta, problemas con psicóticos, problemas con neuróticos, problemas con delincuentes, incesto, etc. Eso lleva como mínimo dos años.

Dr. Canevaro: Bueno, Alberto, creo que realmente ha sido muy provechosa, muy linda la charla. Quedan muchos problemas que seguramente los retomaremos en un futuro, en otro nuevo diálogo. Considero que va a ser sumamente provechoso para los lectores de la revista.

Dr. Serrano: Quería agregar esto que no lo aclaré: unas terapias están fundamentalmente dirigidas al cambio sintomático y otras, tratan de ayudar a la familia no solamente a que haya una mejoría sintomática sino que realmente pueda mejorar su calidad de vida. Whitacker dice que hay familias que están muertas o moribundas y otras están vivas y que nuestra meta es la posibilidad de ayudar a que más familias estén vivas o vuelvan a vivir.

Dr. Canevaro: Lindo concepto. Que es lo que toca nuestra esencia o nuestra vocación de terapeutas. Quedaría en la línea de lo que vos decís de la movilización de los recursos naturales.

Dr. Serrano: Sí. Para que una familia pueda desplegar su creatividad, no ya su capacidad de sobrevida. A veces es bastante, es muy respetable que una familia pueda sobrevivir en condiciones muy deficientes. Lo más lindo es que puedan ir más allá de eso.

Dr. Canevaro: En mi experiencia terapéutica me ha dado la impresión de que así como un individuo tiene que hacer duelos muy diversos para poder realmente ocuparse de vivir más plenamente su vida, me da la impresión que una familia necesita realmente en un momento determinado algún tipo de reunión o de fusión no simbiótica o de compartir duelos en un nivel

emocional profundo o intenso para que después pueda hacer este cambio. Esa es mi impresión —no sé cuál es la tuya como clínico— que en las familias en las que no se logra ese tipo de encuentro en el aquí y ahora temporario-espacial el trabajo es positivo pero limitado y no llegarían a este tipo de salida que vos decís.

Dr. Serrano: Exacto. Es como si movilizaran algunas capacidades de compensación, pero no más.

Dr. Canevaro: ¿Vos coincidís clínicamente con esto?

Dr. Serrano: En todo. Un concepto muy lindo, que tal vez no sea desconocido acá, es la noción de la crisis en la familia. Crisis significa peligro, amenaza y oportunidad. Lo que estamos hablando es la crisis dentro de una familia, una amenaza para la integridad de la familia, pero también es la oportunidad de cambio para lograr más felicidad.

Dr. Canevaro: Es un mensaje muy lindo. Una vez más te agradezco mucho y espero que la próxima vez podamos retomar este diálogo dentro de toda la línea de amplio interés que vos tenés. Muchas gracias.

SINTESIS DE LIBROS

Family Therapy Techniques

Salvador Minuchin
H. Charles Fishman
Harvard University Press, 1981

Síntesis hecha por Cristina Ravazzola de Mazieres

Este libro comienza muchos años antes, cuando H. Charles Fischman y Thomas A. Roesler, ambos alumnos de S. Minuchin, propusieron un libro acerca de cómo aprendían las técnicas que él enseñaba.

Contiene 18 capítulos, uno de los cuales, el 16, "Paradojas", está escrito por Peggy Papp y publicado en Family Process 19, N° 1 (marzo del 80), ya que esta línea terapéutica no utiliza la paradoja tan frecuentemente como lo hacen otras escuelas en Terapia Familiar. El primer capítulo se titula "Espontaneidad" y trata de la comparación entre la experiencia de la formación como terapeuta familiar y la formación artística. En ambas, el objetivo no es la técnica a aprender, sino poder trascender la técnica, lo que significa dominar sus secretos y luego olvidarla.

Un terapeuta espontáneo es un terapeuta que ha sido entrenado en el uso de diferentes aspectos de

sí mismo en respuesta a diferentes contextos sociales. Pero su espontaneidad está constreñida por el contexto y esto es una ventaja porque cuenta con que las reglas de la familia lo van a estructurar desde dentro del campo terapéutico. Como en las artes marciales, el terapeuta debe dejarse empujar y tirar por el sistema para conocer sus recursos. En este capítulo se incluyen algunos conceptos sobre training.

El segundo trata de "las familias", organismos compuestos por múltiples cuerpos, muy difícil de ser vistos en totalidad por alguien perteneciente a la cultura occidental, problema aún exacerbado en los lenguajes de dicha cultura, que carece de palabras o frases que describan unidades de más de un componente. Los autores toman el término *holon*, acuñado por Arthur Koestler para designar aquellas entidades con doble faz, que son a la vez partes de un todo y todo con

respecto a partes que las constituyen. En terapia familiar, la unidad de intervención es siempre un holon (el individuo, la familia nuclear, la familia extensa, etc.). En este capítulo se describen asimismo, los diferentes holons que componen las familias, así como las etapas de complejidad creciente, por las que atraviesa una familia en su desarrollo.

En el tercer capítulo, el tema es el "Joining". Para ganarse el derecho de participar del proceso, y liderar a la familia en sus cambios, el terapeuta debe hacer lo que todo líder, acomodarse, seducir, someter, apoyar, dirigir, sugerir y seguir a los miembros de la familia.

El terapeuta va a acoplarse a la familia sólo de tal manera, que quede libre para sacudir a sus miembros todo lo necesario.

Los autores describen tres posiciones para el "joining", según la proximidad o distancia a que se coloca el terapeuta: una *más próxima*, en la que el recurso más apropiado es la confirmación; una *mediana*, en la que el terapeuta va siguiendo el rastro (tracking), que le brinda el relato de cada miembro de la familia, lo que no significa meramente "seguir" sino más bien un modo suave de dirigir exploraciones hacia conductas nuevas, y, finalmente, una *más distante*, en la que el terapeuta usa su instancia de experto, creando contextos que

den a la familia una sensación de su competencia, funcionando ya no como actor, sino como director.

El joining no es una técnica que puede ser separada del proceso de cambiar la familia; el joining efectuado por el terapeuta opera como factor de cambio, y es necesario a lo largo de toda la terapia.

El cuarto capítulo se refiere a la "Planificación", Hipotetización, y toma el tema de la configuración familiar como clave inmediata para la formulación de alguna hipótesis. Menciona las configuraciones más frecuentes, que son: Pas de Deux, Familias multigeneracionales, Familias Zapato, Familias Acordeón, Fluctuante, y Hogares transitorios.

También consideran información a priori si hay algunas transacciones que suponen discontinuidad en el desarrollo, y es común que las familias consulten en momentos de transición al establecerse estas transacciones nuevas. Estas situaciones son las que aportan las familias en que se incluyó un "padre" nuevo (stepfamilies), y aquellas en que alguien murió, y la familia no hace los pasos necesarios para reorganizarse, por mantener una lealtad con el miembro fantasma.

La patología asimismo, nos lleva a presuponer algunas hipótesis, especialmente si se trata de familias con un miembro identifi-

cado como fuera de control o como enfermo psicosomático.

En el quinto capítulo "Cambio", Fishman y Minuchin ubican la terapia familiar estructural a medio camino entre la escuela Estratégica de Jay Haley y Cloe Madanes, y la Existencialista o Experiencial de Carl Whitaker, definiendo el abordaje estructural en la comparación con esquemas teóricos, como el que conduce a una reorganización en las jerarquías familiares, desafiando la visión de la realidad de la familia con una orientación hacia el desarrollo de cada uno de sus miembros. Este abordaje utiliza tres estrategias principalmente: a) provocación o desafío del síntoma. b) Desafío de la estructura familiar. Y c) Desafío de la realidad familiar.

El capítulo seis "Reformulación", es trabajado por los autores tomando como ejemplo un episodio de la propia familia de Minuchin e imaginando las alternativas que hubieran podido darse de haber hecho la familia una consulta con un terapeuta familiar, poniendo el énfasis en la necesidad de que el terapeuta familiar sea capaz de introducir una construcción distinta de la que la familia hace acerca del problema, aun desde la misma recolección de datos y la manera como orienta su búsqueda de información. La tarea del terapeuta es convencer a la familia de que el mapa que han di-

señado acerca de su realidad puede ser expandido o modificado.

En el capítulo siete, pasan a describir la técnica de la "Puesta en acto" (enactment), que es la forma en que el terapeuta logra hacer interactuar a uno o más miembros de la familia con otros, recolectando así información que ya no es el relato verbal, donde la familia habla de lo que conoce como problemático y expone al terapeuta lo que selecciona previamente, sino de las reglas habituales que controlan su conducta. Asimismo, esta técnica permite al terapeuta introducir variaciones a dicha regla, bloqueando la intervención de alguno, haciendo continuar una discusión, etc., y probar la flexibilidad del sistema a sus maniobras. También consideran a esta técnica como útil para proporcionar al terapeuta una posición menos central, más periférica cuando es necesario. Describen la técnica como una danza en tres movimientos. En el primero el terapeuta observa las *transacciones espontáneas* de la familia y decide sobre qué áreas disfuncionales trabajar. En el segundo, el terapeuta organiza escenarios para que la familia haga su danza disfuncional en su presencia; y en el tercero, el terapeuta sugiere modos alternativos de interactuar, movimiento que da información predictiva y trae esperanzas de cambio a la familia. Este capítulo, como los demás, está ilustrado con

ejemplos clínicos elocuentes, tanto acerca de lo que conviene como de lo que no conviene hacer.

La palabra "Foco", eje del octavo capítulo, pertenece al dominio de la fotografía y se refiere a la selección deliberada que hace el operador de la lente en relación a un tema determinado, entre otros. Y esta operación permite al terapeuta familiar elegir los datos a organizar en una estructura con significado, que a su vez tenga relevancia terapéutica, o sea, facilite la producción de cambios. Pero esta elección no es gratuita. Estrecha la visión del terapeuta, lo vuelve vulnerable a la inducción, y, en fin, sólo puede hacerlo un terapeuta muy consciente de las señales de feed-back que le den información acerca del camino elegido. La selección que hace el terapeuta del tema a focalizar, puede ser una de las maniobras más relevantes.

Capítulo noveno "Intensidad".

Para que las intervenciones del terapeuta alcancen a la familia, deben tener "volumen" y ser percibidas como "diferentes" de lo que acontece habitualmente en el seno de la misma.

Un mensaje no es recibido sólo porque fue emitido. Las construcciones cognitivas por sí son rara vez potentes como para producir cambios en una familia.

Aun cuando un terapeuta esté atento al feed-back acerca de su

efectividad, puede ser derrotado por su apego a las reglas sociales de cortesía en las que fue entrenado desde su infancia como la manera más apropiada de responder, con respeto y aceptación de sus idiosincrasias.

Se requiere entonces entrenamiento en algunas maniobras específicas para "hacerse oír", que son enumeradas y ejemplificadas en el texto: Repetición del mensaje, repetición del mensaje en transacciones isomórficas, cambio en el tiempo en el cual las personas se encuentran envueltas en una interacción, cambio en la distancia entre las personas envueltas en una transacción y resistiendo el tironeo de los patrones transaccionales de la familia.

Capítulo décimo: Reestructuración.

La terapia es un proceso de desafío acerca de "cómo se hacen las cosas". El blanco de este capítulo son los subsistemas, ya que son el contexto para el desarrollo de la complejidad y la competencia, y sus reglas son más fuertes que aquellas que gobiernan las transacciones entre subsistemas.

Las conductas repetidas tienden a encajarse en un pattern de reglas, lo que significa que pueden reproducirse con gran economía de esfuerzo, y que son aprehendidas ipso facto como tal pattern. Luego resulta obvio seguirlas, aunque con el tiempo ya no funcionan. Estas transacciones diarias,

en un subsistema, tienden a organizar los datos de cómo vivir juntos, de modo tal de mantener la naturaleza de la relación no cuestionada por tanto tiempo como sea posible.

Hay tres técnicas importantes para desafiar la estructura de la familia: 1) la de construir fronteras (cambia la participación de los miembros); 2) la de desequilibrar (cambian las jerarquías); y 3) la complementariedad (cambiar el concepto de jerarquía lineal).

Capítulo undécimo: Frontera.

Su construcción regula la permeabilidad entre los subsistemas. La idea central es que contextos distintos determinan respuestas distintas, y así las personas funcionan en cada subsistema en los que interactúan, sólo con una parte de su repertorio. Las alternativas potenciales pueden actualizarse si el individuo comienza a actuar en otro subsistema, o las reglas de participación de ese subsistema cambian. Para esta tarea, se trabaja sobre la distancia psicológica entre los miembros de la familia y sobre la duración de la interacción dentro de un subsistema significativo.

Capítulo duodécimo: Produciendo desequilibrio, (unbalancing).

Con esta técnica, el terapeuta apunta a cambiar la relación jerárquica de los miembros de un subsistema. Cuando el terapeuta se alía con un miembro de la

familia, desafiando reglas que la familia supone que seguiría, opera disminuyendo el conocimiento de las señales por las cuales comúnmente los miembros de la familia se indican unos a otros lo apropiado de su conducta interpersonal. El miembro de la familia que cambia de posición por afiliarse con el terapeuta, no reconoce o no responde a tales señales familiares y así puede operar en forma des acostumbrada. Esta técnica presenta varios problemas, que se enumeran en este capítulo, y que el terapeuta debe aprender a manejar. Problemas éticos, problemas de la exigencia de proximidad y participación hacia el terapeuta y de encontrar el modo de relacionarse positivamente con aquellos a quienes cuestiona. Estas técnicas caen dentro de tres categorías, de acuerdo a la exigencia que ponen en la implicación personal del terapeuta: el terapeuta puede aliarse con algunos miembros de la familia, puede ignorar algunos miembros de la familia, puede entrar en coalición con algunos miembros contra ellos o alternar las alianzas.

Capítulo decimotercero: Complementariedad.

Más allá de las partes, la familia aparece como una entidad, un organismo compuesto por múltiples cuerpos y con objetivos comunes, cuyas partes están reguladas por las reglas del TODO. Cuando la terapia familiar tiene éxito

en lograr que un individuo se perciba como perteneciente a una entidad más allá de sí mismo, los miembros de la familia cambian su relación de jerarquía y perciben la realidad de una manera nueva. Las personas se perciben a sí mismas como actuando o reaccionando, desde su visión centrada en su propio self, pero no saben como ver a la vez ambos lados de la moneda.

Para desafiar la epistemología de la familia, el terapeuta debe cuestionar la familia en tres niveles: 1) el problema (la certeza de la familia de que hay un paciente identificado. 2) la noción lineal de que un miembro controla el sistema (más que "cada uno es contexto para el otro"). 3) la puntuación que hace la familia de los hechos; que son operaciones para que la familia acepte la reciprocidad de cada una de sus partes.

Capítulo décimocuarto: "Realidades". La familia viene a terapia con una visión estrecha de la realidad. Pueden estar defendiendo instituciones que ya perdieron utilidad, y quieren que el terapeuta les devuelva su manera habitual de funcionar, lustrada y reparada. En lugar de eso, el terapeuta debe ofrecer a la familia otra realidad distinta.

La realidad depende del sentido que cada uno de nosotros da a lo que reconocemos como hechos. Y tiene que ser compartida con

otros que la convaliden, y esta visión del mundo convalidada socialmente, define la realidad que a su vez determina a la persona.

En sus experiencias, los individuos "desarrollan una cosmovisión", "consolidan una cosmovisión" y "cuestionan su cosmovisión".

Capítulo décimoquinto: "Construcciones". La familia construye su realidad organizando los hechos de tal manera que mantenga sus arreglos institucionales. De las alternativas posibles, la familia elige un esquema y el terapeuta debe sacudir la rigidez de este esquema preferencial.

Pero, a su vez, el terapeuta tiene una libertad limitada como constructor de realidades, dada su propia biografía, los límites de la realidad de la estructura familiar y la forma idiosincrática en que la familia ha desarrollado sus construcciones.

El mensaje del terapeuta de que la familia y sus miembros tienen más alternativas disponibles que las transacciones preferidas, puede ser transmitido a través de distintas técnicas. Las principales usan símbolos universales, verdades familiares y el consejo del experto. El objetivo es siempre el llevar a la familia otra cosmovisión, una que no necesite del síntoma, y a maneras más flexibles y pluralísticas de ver la realidad.

El capítulo décimosexto es el

ya mencionado de Peggy Papp, acerca de las "Paradojas" y relata su experiencia en el Ackerman Institute, en un proyecto de Terapia Breve, organizado desde 1974, de trabajo con familias con hijos sintomáticos.

Basan el uso de la paradoja en la comprensión de tres conceptos: la familia como un sistema autorregulado, el síntoma como un mecanismo de autorregulación, y el concepto de resistencia del sistema al cambio, derivado de los anteriores.

Alternan el uso de la paradoja con otro tipo de intervenciones y su criterio se basa en la evaluación del grado de resistencia al cambio en aquella parte del sistema regulada por el síntoma. Si hay respuesta a resortes directos, no usan la paradoja.

Clasifican las intervenciones en: directas, basadas en la complacencia de la familia para con el terapeuta, o paradójales, basadas en el desafío, referidas a la expectativa del terapeuta de que la familia lo va a desafiar.

Capítulo décimoséptimo: "Fuerzas". Toda familia tiene elementos en su propia cultura que si son comprendidos y utilizados, pueden ser como palancas que actualicen y expandan el repertorio de conductas de los miembros de la familia.

Nuestra cultura trata de focalizar sobre déficits y desviacio-

nes aún cuando cada pocos años el movimiento de salud mental transita por el ritual de revisar sus categorías.

Actualmente los terapeutas de familias están modificando su perspectiva y fijándose en las contribuciones de la familia, ya que son las características poco reconocidas de la familia: los suministros, los cuidados y las transacciones de apoyo, las que aseguran la supervivencia en un mundo complejo.

La exploración de las fuerzas es esencial para desafiar las disfunciones. Las familias vienen a la terapia porque están detenidas en situaciones que requieren cambios que las familias no sienten disponibles en su repertorio. En este punto, la familia focaliza el stress en uno de sus miembros y estrecha su posible exploración de alternativas, definiendo a ese miembro como desviado. El terapeuta puede desafiar ese punto de vista, enfocando la capacidad de curación de la familia. Esta provocación puede hacerse a: 1) la respuesta de la familia al P.I.; o, 2) el uso que la familia hace de sus alternativas.

El capítulo décimo-octavo se llama "más allá de la técnica". Ahora se retoma el tema del primer capítulo sobre un samurai que aprende artes marciales, al que le pasa lo que al terapeuta que aprende técnicas de terapia familiar. El lector debe poner las técnicas a un lado y buscar la sabiduría. La técnica sólo

es un vehículo para la exploración creativa del terapeuta.

Relatan el cambio sufrido por las técnicas a lo largo de los años, y aún el cambio en el estilo de Minuchin, ahora más suave, más efectivo. Y el libro finaliza con una frase de Gregory Bateson: "La sabi-

duría exige un reconocimiento consciente, con raíces en la experiencia tanto emocional como intelectual, que sintetice a ambos". Cuando las técnicas son guiadas por tal sabiduría, entonces la terapia puede curar.

Comentarios

Epistemologías Conflictivas.

Carlos Sluzki

Reseaux-Systemes. Agencements. Cahiers Critiques de Therapie Familiale et de Pratiques de Reseaux.

Recherches en Therapie Familiale. N 3. Gamma. Bélgica.

Los terapeutas conocemos más algunas cuestiones epistemológicas de metodología de la ciencia que la relación interdisciplinaria epistemología-sociología. El artículo de Sluzki, "Epistemologías Conflictivas", estimula la reflexión sobre el mencionado campo interdisciplinario y sobre dificultades en el pensamiento conceptual de terapeutas que, aún teniendo un enfoque sistémico, no aprecian adecuadamente la extensión de éste.

A través de las imágenes de una parábola de Magorh Maruyama se describen las expectativas occidentales —herencia epistemológica aristotélica— que frecuentemente contaminan el proceso del pensamiento teórico en psicología (y por lo tanto el proceso de la intervención terapéutica, la actitud docente, la relación con los colegas, la vida personal de los terapeutas).

La parábola cuenta que una tribu africana, adoradora de 350 dioses emparentados, poseedora de

una filosofía de vida ajerárquica, heterogénea y armoniosa, recibe, un día de tantos, la visita de un misionero que afirma que sólo puede tenerse un Dios. "Poco importa el final de esta historia, fin verdaderamente trágico; pero, cuán irreligioso, egocéntrico y aberrante debió parecer este misionero a los miembros de la tribu, en esa misma situación, qué impíos, irrespetuosos y subversivos debieron parecerle los miembros de la tribu al misionero".

Las palabras-imágenes ("Tribu", "el Afuera de la tribu", "Lucha", "Optimismo") permiten no asumir ni la tesis del conocimiento infalible del hombre, ni el hecho de que la facultad de la razón sea su prerequisite.

"Tribu": los creyentes en la teoría de los sistemas".

"El Afuera de la tribu": la mentalidad occidental que pierde de vista las diferencias y la evolución y cambio de las diferencias; los terapeutas familiares que con-

SINTESIS DE LIBROS

gelan el proceso e inventan la estructura del sistema; los terapeutas familiares que pierden la riqueza de la diferencia y la evolución buscando semejanzas en ciclos homeostáticos”.

“Lucha”: la lucha de los miembros de la tribu para derribar las paredes que definen claramente clases y categorías, la lucha para no convertir el proceso y el devenir en un mundo de estructuras, objetos y seres, la lucha contra la tendencia a considerar el tiempo una coordenada cartesiana adicional.

“Optimismo”: es posible que los terapeutas aprendan la gramática y la metafísica de los sistemas. “Si nos animamos a tolerar la ambigüedad y a conservar nuestro sentido común mientras mantenemos

nuestra aptitud para concentrarnos en presencias no materiales como los sistemas, procesos dialécticos y otros, si sabemos obstinarnos en el reconocimiento y exploración de nuestra visión de campo, tal vez podamos descubrir que esta tarea nos revela repentinamente tierras aún desconocidas y nos lanza en una nueva ola de ignorancia que a la larga, esperamos que así sea, nos hará más sabios”.

Según este párrafo final nuestro destino puede no repetir el de la parábola: los terapeutas cambiaremos, en un tiempo inespécifico (tal como lo sugería Milton Erikson), pero en un futuro cercano.

María Cristina Vila de Gerlic

INFORMACION GENERAL

Segundas Jornadas de Terapia Familiar Sistémica

Grenoble, Francia, Mayo de 1981

Contaron con la participación de Mara Selvini Palazzoli y Giuliana Prata del Centro per lo Studio della Famiglia de Milán, y de Paul Watzlawick del Mental Research Institute de Palo Alto, California.

Se llevaron a cabo durante los días 22, 23 y 24 de mayo de 1981, en la Clinique Georges Dumas, organizadas por el C.E. R.A.S., Centre d'Etude et de Recherche sur l'Approche Systémique de Grenoble.

Se desarrollaron durante tres Sesiones Plenarias matutinas, las dos primeras a cargo de Paul Watzlawick, quien enfocó el tema “El Lenguaje en Psicoterapia”, y la última teniendo como relatoras a Mara Selvini Palazzoli y Giuliana Prata, sobre “Cómo abordar las llamadas telefónicas secretas, los ofrecimientos de revelaciones y de mensajes confidenciales, y otras trampas, para transformarlas en intervenciones terapéuticas”. Esta exposición fue completada con la presentación de videotapes.

Paul Watzlawick señaló que nuestro lenguaje no permite transmitir adecuadamente todo lo que implica la interacción,

así como "tampoco nos resulta fácil comunicar el sabor de un gateau" por medio de él.

Destacó la importancia de su empleo en la terapia; proponiendo que se utilice un lenguaje de inyuncción, entendiendo por tal al de las indicaciones expresas y las instrucciones, que reviste una forma imperativa, y que es la modalidad lingüística para el mandato de las prescripciones de comportamiento.

Este lenguaje evita las formulaciones negativas, se debe prescribir lo que hay que hacer y no lo que no hay que hacer; tiene que ser muy claro, concreto, lento y repetitivo. De estas características se deriva su fuerza para vencer las resistencias y para modificar el comportamiento, lo que se consigue al redefinir por su intermedio la realidad de segundo orden, permitiendo el acceso a metarreglas.

Mara Selvini Palazzoli y Giuliana Prata expusieron acerca de la estrategia que desarrollan para el tratamiento de las familias, y sobre cómo abordar las trampas que se pueden presentar desde la primera entrevista, transformándolas en intervenciones terapéuticas mediante diversas maniobras prácticas ya que, enfatizaron, la estrategia es una sola.

En los *ofrecimientos de revelar un secreto*, hechos por un miembro de la familia al terapeuta mediante una llamada telefónica, entregándole un mensaje escrito confidencial, etc., lo más importante no es atender al contenido de estos mensajes, sino a la coalición que proponen y contra quién es.

Cuando el paciente designado tiene un terapeuta individual, si accede a suspender su tratamiento, se lo incluye con la familia. Pero si tiene una alianza muy fuerte con su terapeuta y no acepta dejarlo, para evitar complicaciones simétricas, se puede hacer terapia con el grupo familiar sin la presencia del paciente en cuestión.

Si durante las sesiones de terapia familiar se plantean cuestiones referentes al *uso de medicamentos*, indicados por otro profesional al que han consultado, para no entrar en competición se solicita que sean decididas con quien los prescribió.

Durante dos tardes los asistentes se reunieron en seis Ateliers, en los que se trabajó sobre los siguientes temas:

"Abordaje sistémico en la terapia de pareja"; Coordinador: Philippe Caillé, Director Médico del Centro de Orientación Familiar de Oslo.

"Análisis sistémico de las funciones parentales y terapéuticas"; Coordinadora: Elizabeth Fivaz, perteneciente al Centro de Estudios de la Familia del Hospital de Cery de Lausanne.

"Ciclo de vida de la familia y teoría de los sistemas: importancia de la evaluación multigeneracional en la terapia de orientación familiar"; Coordinadora: Odette Masson, de la Unidad de Terapia Familiar y de Prevención del Servicio Universitario de Psiquiatría Infantil de Lausanne.

"Internación y paradoja terapéutica"; Coordinadores: Jean-Pierre Martinez, Pierre Burille e Yveline Rey de la Clínica Georges Dumas de Grenoble, actuando como moderador Paul Watzlawick.

"Psicoanálisis y Teoría de los Sistemas", Coordinador: André Ruffiot y Bernard Andrey de Grenoble.

"Terapia sistémica y creatividad del terapeuta"; Coordinador: Carmine Saccu del Instituto de Terapia Familiar de Roma.

La Comisión Organizadora la constituyeron Jean Pierre Martinez, Bernard Andrey, Pierre Burille e Yveline Rey, actuando como Consejeros Técnicos François Guy y Roger Livache.

Lic. Alicia Betría de Palou

SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA FAMILIAR

Resumen de las actividades realizadas durante el año 1981

I. Cursos:

- 4 de mayo al 13 de julio: Introducción al psicodrama psicoanalítico y su aplicación a las terapias familiar y de pareja.
Dr. Roberto H. Losso y Dra. Ana Packciarz de Losso.
- 4 de mayo al 30 de noviembre: Corrientes lingüísticas contemporáneas.
Dra. Analía Kornblit
- 2 de junio al 24 de noviembre: Introducción a la teoría y a la técnica de la psicoterapia familiar.
Dra. Analía Kornblit y Lic. Jaime Szwarcstein
- 27 de mayo al 30 de julio: Introducción a la obra de la Dra. Mara Selvini Palazzoli
Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Susana Jutorán
- 15 de septiembre al 15 de diciembre: Revisión de la obra de Gregory Bateson.
Dra. Analía Kornblit y Lic. Jaime Szwarcstein
- 4 de septiembre al 18 de diciembre: Teoría y Técnica de la terapia familiar.
Dr. Alfredo Canevaro y Lic. Alicia Arbiser
- 29 de agosto al 28 de noviembre: Introducción a la terapia familiar.
Dr. Roberto Marcer y Dr. Rafael Skiadaressis
- 22 de septiembre al 24 de noviembre: Introducción a la teoría general de los sistemas.
Charles François, Ricardo Guarinoni, Alejandro Piscitelli,

Nora Mattenet y Héctor Label. Grupo de estudios de Sistemas Integrados de la Sociedad Científica Argentina.

- 21 de octubre al 11 de noviembre: Terapia familiar en casos de divorcio o con familia de padres separados.
Lic. Viviana Gortari

II. Conferencias de los miércoles

8 de abril: Taller interno sobre un videotape en castellano.

29 de abril: taller interno sobre un caso clínico.

6 de mayo: "Acerca del estatuto de la familia"
Dr. Oscar Zawicke

20 de mayo: "Terapia sexual"
Lic. Viviana Gortari

27 de mayo: "Narciso y edipo". Hacia una conceptualización de la terapia familiar en niños.
Lic. Graciela Resnicoff

3 de junio: "Relación del pediatra con la familia"
Dr. Carlos Urcovich (suspendida)

10 de junio: "El sentido de la inclusión de los niños en el proceso terapéutico familiar".
Lic. Ivonne Rozenberg, Alicia Varela y Susana Barilari

17 de junio: "Algunas características familiares de la psicosis infantil a través de un caso clínico".
Dr. Roberto Marcer y Lic. Cristina Barceló.

24 de junio: "Un grupo singular: la madre y su hija adolescente".
Lic. Mabel Maldavsky de Burin

12 de agosto: "Experiencia con familias de pacientes internados en una institución psiquiátrica".

Dr. Juan Alberto Yaría

19 de agosto: Conferencia informativa sobre el modelo de trabajo del Instituto de Terapia Familiar de Roma, introducción al seminario de la Dra. Anna María Nicoló, a cargo de la Dra. María Cristina Ravazzola de Mazieres.

III. Invitados Extranjeros:

- Dr. Reynaldo Perrone: Psicoterapeuta argentino, director de Psiquiatría Comunitaria de Saint-Etienne (Francia).
- Dr. John Weakland: Miembro fundador del Centro de Terapias Breves de Palo Alto (Estados Unidos).
- Dra. Mara Selvini Palazzoli: Directora del Centro para el estudio de la familia de Milán (Italia).
- Dra. Giuliana Prata: Investigadora del Centro para el estudio de la familia de Milán (Italia).
- Dra. Anna María Nicoló: Directora didáctica del Instituto de terapia familiar de Roma (Italia)
Miembro fundadora de la Sociedad Italiana de Terapia Familiar.
- Dr. Jorge Colapinto: de la Child Guidance Clinic (Philadelphia) USA.
- Dr. Raimundo Macías Avilés: Director y Fundador del Instituto de la familia de México.

IV. Grupos de proyección y discusión de videotapes:

Semanalmente, desde el martes 31 de marzo, coordinado por: Dra. María Cristina Mazieres, Lic. Silvia Stuhlman y Lic. Aída Tarrab.

V. Grupos de supervisión:

Semanalmente, todos los miércoles desde mayo, supervisiones clínicas, coordinado por: Lic. Juan Carlos Nocetti.

VI. Jornadas, Seminarios y Workshops:

- 7 de mayo: Conferencia especial con el Dr. John Weakland. "Pasado, presente y futuro de la Terapia Familiar".
- 21 y 22 de abril: Workshop con el Dr. Reynaldo Perrone.
- Séptimas Jornadas de Actualización, del 3 al 8 de agosto, con las Dras. Mara Selvini Palazzoli y Giuliana Prata.
Qué es la terapia de contexto. Abordaje sistémico a los trastornos del comportamiento en la infancia y adolescencia.
Desarrollo del niño a la luz del modelo sistémico.
El racismo en la familia.
Las insidias de la terapia familiar.
- Octavas Jornadas de Actualización, el 28 y 29 de agosto, con la Dra. Anna María Nicoló.
El uso de la metáfora en terapia familiar.
La negación estratégica como refuerzo homeostático.
La provocación como respuesta terapéutica.
- 2, 3 y 5 de diciembre: "Indicación de terapia individual y terapia familiar". "Formación del terapeuta familiar en instituciones". Dr. Raimundo Macías Avilés.

- 5 de diciembre: Primera Jornada Interdisciplinaria con el Colegio de Graduados de Asistentes Sociales, a cargo de la Dra. María Cristina Ravazzola de Mazieres, el Lic. Juan Carlos Nocetti y la Lic. Marta Villegas.

VII. Asesoramiento a instituciones:

— a CE.NA.RE.SO: Se nos solicitó asesoramiento sobre la posibilidad de controlar terapias de grupos familiares realizados en el CE.NA.RE.SO.

Se estudió el campo, se dio una conferencia en la institución y se ofreció la posibilidad de realizar cursos y controles en el local de nuestra institución.

— a Policlínico Fernández: Se continuaron los estudios iniciados años anteriores de las condiciones de trabajo con los familiares de pacientes internados en la sala de terapia intensiva.

Se propuso la formación del "grupo permanente de familias en la sala de espera". Esto es estudiado actualmente por el grupo de médicos de la sala de terapia intensiva con el psicólogo del Policlínico Fernández.

La Comisión Directiva

CONCURSO 1981 DE TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR

El 31 de enero próximo pasado venció el término de tiempo para la entrega de los trabajos concursantes para el premio que anualmente instituyera la revista *Terapia Familiar*.

Este concurso constituye un aliciente para todos aquellos colegas que quieran escribir trabajos teóricos, clínicos o de investigación que signifiquen un aporte relevante al desarrollo del conocimiento y de la práctica de nuestra disciplina.

Una vez conocida la opinión del nuevo jurado, publicaremos en el número 10 de nuestra revista (correspondiente al último semestre de 1982) el trabajo ganador del Primer Premio.

Recordamos que en el *primer concurso (1980)* el jurado fue integrado por el Dr. Juan José Morgan, el Dr. Isidoro Berenstein, la Lic. Estrella Joselevich, la Lic. Ana Pampliega de Quiroga, el Dr. Guillermo Vidal y el Dr. Octavio Fernández Mouján.

El 1er. premio lo obtuvo la Dra. *Analía Kornblit* por su trabajo "Categorías semánticas aplicadas a un caso de drogadicción" y el 2do. premio el Dr. *José Bebhuk* por su trabajo "Un modelo de terapia relacional". Ambos recibieron una medalla y un diploma de manos del Dr. Canevaro, en emotiva ceremonia realizada el 8 de agosto en el Auditorio del Hotel Bauen.

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE

Summer Practicum in Family Therapy Rome, June 1— June 25, 1982

OBJECTIVE: To enable foreign therapists to gain experience in our model of therapy, supervision and training.

ORGANIZATION: Dr. Andolfi will lead the English speaking group. Groups in French will be led by Drs. Menghi, Nicolò and Saccu.

ACTIVITIES: Clinical work, participation in training groups, observation of direct supervision, theoretical seminars, study of clinical videotapes, indirect supervision, simulations, teaching related to leadership of training groups, a two-day workshop will be offered. Instruction will take place four

days per week for a total of 100 hours over the four weeks.

ELEGIBILITY: A minimum of three years training in family therapy and clinical experience in the field. Preference to teachers of family therapy. Priority on the basis of the date of application and professional experience.

FEE: \$1,300. A non-refundable deposit of \$300 will be required upon acceptance to hold your place. The remaining \$1000 is payable at the beginning of the program.

APPLICATION: Application forms must be received, together with applicant's Curriculum Vita, by March 1, 1982. Candidates will be notified of their acceptance by March 20th. Late applications will be considered only if space is available, at an extra charge of \$50.

REGISTRATION

To reserve your place, mail this registration form to:



Maurizio Andolfi
ISTITUTO
DI
TERAPIA
FAMILIARE
via Reno 30,
00198 Roma

Make checks payable to
Carmine Saccu.

For further information write to
Daniela Ficcone at the above address,
or phone at (06) 426790

Name	_____
Address	_____
City	_____
State	_____ Zip _____
Office Phone	_____
Home Phone	_____
Profession	_____
Degree	_____

Check off your choice below:
☐ Summer Practicum
Please put me on your mailing list
for 1983

Date _____

SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA DEL "HOSPITAL ITALIANO"

Integrado al Dto. de Medicina

Guardia médica psiquiátrica activa permanente: de un médico de planta y un médico residente

- **Consultorio Externo:** Sectores de Adolescentes, Adultos y Personas de Edad.
- **Internación:** Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal.
- **Hospital de Día:** Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal, Psicodrama.

Jefa int.: Prof. Dra. Lía Ricón

Gascón 450

Tel. 811 - 4149

CENTRO

de

D ocencia
I nvestigación y
A sistencia
P sicológica

Directores:

Dr. Roberto P. Montanelli
Dr. Carlos N. Díaz Usandivaras

PSICOPATOLOGIA DE ADULTOS

PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL

PISCOPEDAGOGIA Y CLINICA DEL APRENDIZAJE

PSICOTERAPIA DEL GRUPO FAMILIAR

DOCENCIA - INVESTIGACION

ACASSUSO 907 - SAN ISIDRO - T.E. 743-8645 - Bs. AS.

GACETILLA DE PRENSA

Entre el 13 y el 17 de agosto de 1982, se realizarán en Buenos Aires las 11 JORNADAS ASISTENCIALES INTERDISCIPLINARIAS DE SALUD MENTAL y 1 CONGRESO NACIONAL auspiciado por el Centro de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de la Matanza.

El Comité Organizador está integrado por los siguientes profesionales:

Presidente:	Dr. Mario Tisminetzky
Vicepresidente:	Lic. Luisa Wettengel de Reusch
Secretario General:	Lic. Guillermo Rivelis
Secretario Científico:	Lic. Daniel Frankel
Secretario de Rel. Públicas:	Lic. Susana Mosenson de Salt
Secretario de Finanzas:	Dr. Carlos Alhadeff

Los temas principales del Congreso serán:

- Terapia familiar interaccional en una institución de Salud Mental.
- Psicoterapia grupal de tiempo y objetivos limitados en niños y adolescentes.
- Perturbaciones intelectuales y su constitución histórica genética.
- Reflexiones acerca de la formación y el adiestramiento de profesionales del equipo de terapia breve para situaciones de crisis.
- Psicoterapia grupal en adultos en una institución de Salud Mental: objetivos y formación de profesionales.

Secretaría e Informes: Sarmiento 1562 - 4º "E" - 1042 Capital Federal.
Tel.: 35-4437/5917

REVISTA TEMAS de PSICOLOGIA SOCIAL

PUBLICACION DE LA PRIMERA ESCUELA PRIVADA DE PSICOLOGIA SOCIAL



Doctor ENRIQUE
PICHON - RIVIERE

NUMERO EXTRAORDINARIO DEDICADO AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOTERAPIA DE GRUPO COPENHAGUE 1980

ANDREE CUISARD
GUILLERMO FERSCHTUT
RENE KAES
JANINE PUGET
MARCOS BERNARD
GLADYS GAMES CHAVES

ESTHER ROMANO
CARLOS MARTINEZ BOUQUET
MARIA C. FLOREZ MONROY
ROBERTO LOSSO
ANA PACKCIARZ
CARLOS MENEGAZZO
CRISTINA QUIÑONES

ADRIAN RUD
ANA PAMPLIEGA DE QUIROGA
OSCAR BRICCHETTO
ROSA JAITIN DE LANGER
OLGA ALBIZURI DE GARCIA
MARIA MONICA ZURETTI

CEFYP

CENTRO DE FAMILIAS Y PAREJAS

DIRECTOR GENERAL:

DR. ADOLFO LOKETEK

DIRECTORAS:

LIC. MARIA ROSA GLASSERMAN

LIC. ESTRELLA JOSELEVICH

Ciclo 82 - 83

Apertura nuevos cursos para la formación de Terapeutas en Terapia Familiar

- La enseñanza seguirá un desarrollo clínico-teórico sobre una base sistémica-comunicacional- interpersonal e histórica.
- Curso especial para profesionales del interior del país.
- Inscripción limitada abierta a médicos psicólogos y trabajadores sociales.

SERRANO 1141 - (Cód. 1414)

CAPITAL

TEL. 771-6078

CENTRO DE ESTUDIO DE TERAPIA FAMILIAR

(C.E.TE.FA.) Rosario

Director: Dr. Fidel Lebensohn.

Area Docente:

1. Curso estable de formación de Terapeutas Familiares. Duración: 3 años. Ingreso: dos llamados, Noviembre de 1981 — Marzo 1982.
2. Seminarios de Actualización: "Terapia de pareja y Terapias sexuales" 23 y 24 de abril. "Terapias en transacciones psicóticas" (comparación de diferentes modelos a través del Video). Minuchin, Selvini, Whitaker, Lebensohn, Nicoló — 25 y 26 de Junio. "Ciclo de vida familiar", 31 de Julio. "Comunicación analógica", Albert Scheflen, 17 y 18 de Septiembre. "Líneas de diagnóstico y tratamiento en T. F." 19 y 20 de Noviembre.
3. Seminario de Epistemología Sistémica: "Gregory Bateson" (Seminario dedicado a la deducción e inducción epistemológica sistémica) a cargo de los Dres. Lebensohn y Makinistian con participación activa (presentación de trabajos) de todo aquel interesado en la temática, 22 y 23 de Octubre.
4. Curso especial para Terapeutas Familiares: Primer llamado: Noviembre de 1981 — Comienzo: Marzo 1982. Segundo llamado: Marzo 1982. Comienzo: Mayo 1982. Trabajos teóricos: Asistencia a los seminarios de actualización y a seminarios especiales para el curso. Trabajo Práctico: a) Supervisiones del trabajo personal de los concurrentes en cámara con vidrio unidireccional. b) A partir de Junio concurrencia de los integrantes al Hospital de Niños donde podrán trabajar directamente con familias de la institución otorgadas y supervisadas en cámaras con vidrio unidireccional por el director del C.E.TE.FA., Dr. Fidel Lebensohn. Para los colegas del interior se buscarán horarios adecuados para que puedan realizar este curso.

Informe de todas las actividades: Secretaría de C.E.TE.FA. Tucumán 1060, P.B. "A", Rosario.
Tel.: 67038.

D. I. T. E. M. S. A.

(Docencia, Investigación y Tratamiento
de Enfermedades Mentales)

1968 - 1981

CLINICA PSIQUIATRICA

Director: Prof. Dr. Jorge E. GARCIA BADARACCO

Sub-Director: Dr. Norberto J. PROVERBIO

Ponen a disposición de los colegas su ya tradicional atención como pioneros de la Comunidad Terapéutica en nuestro país, a la cual agregan los servicios de CONSULTORIO EXTERNO y ATENCION en URGENCIAS PSIQUIATRICAS, Grupos Terapéuticos, Familiares y Multifamiliares.

O'Higgins 2328/48
(1428) Capital Federal

T.E.: 781-1306/0557/7825
785-9283

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Donald A. Bloch, *New York, N.Y.*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.*, Edgar H. Auerswald, *Mau, Hawaii*, Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.*, Reuben Hill, *Minneapolis, Minn.*, Salvador Minuchin, *Philadelphia, Pa.*, Jules Riskin, *Palo Alto, Calif.*, Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.*, Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.*, Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS is the definitive Journal in the field of family psychotherapy, study, and research, published quarterly. Original articles report on the theory and practice of family treatment as well as on related research. Additionally, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to Books, Abstracts of relevant literature, Training Announcements, and news of Activities in the family field.

Among the many contributors to FAMILY PROCESS in recent years have been *Nathan W. Ackerman, Edgar H. Auerswald, John E. Bell, Nathan B. Epstein, Antonio J. Ferreira, James Framo, Jay Haley, Don D. Jackson, Mara Selvini-Palazzoli, Frank S. Pittman, Ross V. Speck, John Weakland*

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

DATE _____

Gentlemen:

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

☐ \$20.00 per year United States

☐ \$30.00 U.S.

☐ \$22.00 per year Canada &
Latin America

☐ \$32.00 Canada &
Latin America

☐ \$25.00 per year All other countries

☐ \$35.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____

STATE/COUNTRY _____

ZIP _____

All subscriptions are entered on a calendar year basis

FAMILY THERAPY NEWS



A NEWSPAPER OF THE AMERICAN ASSOCIATION
FOR MARRIAGE and FAMILY THERAPY

edited by William J. Hiebert, S.T.M.

**a newspaper especially for
professionals in marital and family therapy**

THE AAMFT NEWSLETTER OFFERS:

- Broad coverage of recent news developments in the field of marriage and family therapy.
- A focus on legislative developments affecting the field of marital and family therapy from Washington DC and around the country.
- A forum for dialog via Letters to the Editor.
- Interviews with leading therapists.
- Current data on trends in marrying, birthing, divorcing, and other family-related factors.
- International correspondents covering the happenings in marriage and family therapy across the globe.
- Thought-provoking articles on marriage and family therapy.
- Family images in the media.
- An up-to-date listing of conferences and workshops in marriage and family therapy.
- Classified advertisements announcing position openings in marriage and family therapy.

RECENT AUTHORS AND ARTICLES

- Politicization of the Family Therapy Movement
by James L. Framo
- The War for the Generation Gap
by Carl A. Whitaker
- The Old Pro: A Tribute to Milton Erickson
by Charles H. Kramer
- The Reciprocal Impact of Family Systems & Health Systems
by Donald A. Bloch
- The Tiger & The Lady: Technology & the Person in Family Therapy
by Fred Duhl
- Iranian Crisis: Caring for Families of Catastrophe
by Charles Figley
- AAMFT and AFTA, 1980 - "More of the Same?"
by Donald S. Williamson
- Training at the Tavistock Clinic
by Robin & Prudence Skinner
- Marriage & Family Therapy in the Conciliation Courts
by Leonore Levit
- The Divorced Man: Gaining Personal Fulfillment
by Patricia Repinski

order form

Please enter my subscription

☐ 1 year @ \$10 (six issues)

☐ Bill me for this order
plus postage and handling

☐ Check is enclosed

Name _____

Street _____

City _____ State _____ Zip _____

(Orders outside the United States and Canada add \$2.00 for postage and handling.)

AAMFT 924 W Ninth Street Upland CA 91786

centro médico psicológico buenos aires

Director:
Dr. Octavio Fernández Mouján

ESCUELA DE FORMACION DE POST-GRADO EN SALUD MENTAL

(Para médicos, psicólogos y psicopedagogos)

Ciclo 1982/1985

Secretaria científica y docente: Dra. Ana Goldberg

Secretaria: Sra. Julia Liebbe

Tres niveles obligatorios con materias de formación teórico-práctica (Psicoanalítica, Crisis Vitales, Psicoterapia de Grupos, Familias, Epistemología, etc.) y seminarios de aplicación práctica y profundización teórica.

Cuarto nivel (no obligatorio) de aplicación práctica en los departamentos asistenciales: terapia familiar, de grupos, infanto-juvenil, adultos, psiquiatría social, gerontopsiquiatría, comunidad terapéutica diurna.

Práctica clínica desde el primer nivel. Se realizan coadmisiones, coterapias, terapias, supervisiones y ateneos.

Las vacantes son limitadas según los cupos para la práctica clínica.

ABIERTA LA INSCRIPCION . Lunes a viernes de 15 a 19 horas.

COMUNIDAD TERAPEUTICA DIURNA

dirigida a pacientes cuya problemática requiere implementar una adecuada reinserción en su núcleo familiar, social y laboral luego de una internación, para prevenirla o como complementación de la terapia individual.

Objetivos: lograr mejores condiciones en el ámbito de las relaciones interpersonales en un contexto de seguridad emocional mediante:

- actividades verbales terapéuticas tradicionales
- actividades expresivas terapéuticas no tradicionales
- actividades de resocialización

Lunes a viernes de 13 a 17 horas.

ORO 2242, (1425) Capital

Teléfonos: 773-8289/772-8851

THIS IS YOUR JOURNAL

Share it with your friends and colleagues.

For those interested in subscribing, an order form is provided below.

Please Enter My:

Individual Subscription

☐

1 year @ \$20.
(4 issues)

☐

Check is enclosed

☐

Bill me for this order
plus postage and handling

Institutional Subscription (libraries and multi-reader establishments)

☐

Enclosed is a check for \$30 (1 year's subscription)

☐

Bill us \$30 plus postage and handling

(Orders outside of North America, add \$2 per year for postage and handling)

Name _____

Institution _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Mail to: JOURNAL
OF MARITAL
AND FAMILY
THERAPY
924 W. 9th
Upland, CA
91786



American
Association
of Marital and
Family Therapy

Spring 1981

Volume 9 Number 1

THE American Journal of Family Therapy

- COGNITIVE PROCESSES IN INTIMATE CONFLICT
- SEXUAL BEHAVIOR IN NONDYSFUNCTIONAL COUPLES
- PRESERVING INDEPENDENCE IN OLDER PERSONS USING THE FAMILY OF PROCREATION
- USE OF THE METAPHORIC OBJECT IN FAMILY THERAPY
- BOOK REVIEWS
- RESEARCH AND CLINICAL EXCHANGE
- ADLERIAN FAMILY THERAPY
- FAMILY ASSESSMENT AND FEEDBACK IN FAMILY THERAPY
- POETRY IN COUPLES GROUPS
- OPTIMAL AND NORMAL FAMILY FUNCTIONING
- DISCRIMINATORS OF CONFLICT IN MARITAL COMMUNICATION
- JOURNAL FILE

The American Journal of Family Therapy, formerly the International Journal of Family Counseling, is published quarterly by Brunner/Mazel, Inc., 19 Union Square West, New York, NY 10003.

Address all correspondence regarding subscriptions, back issues and bulk sales to: Helen Mack, Brunner/Mazel, Inc. 19 Union Square West, New York, NY 10003. **Subscription rates:** individuals \$22/1 year; institutions \$36/1 year; outside the United States add \$4.00. Back issue rates on request. Make checks payable to Brunner/Mazel, Inc.

Address all editorial communications to: Dr. S. Richard Sauber, Editor, AJFT, Brown University, Suite 306, 77 Ives Street, Providence, RI 02906.

INFORMACION GENERAL

SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA FAMILIAR

II CONGRESO ARGENTINO DE TERAPIA FAMILIAR

10 — 12 Junio de 1982

Celebrando el cuarto aniversario de su fundación, esta sociedad organiza para los días 10, 11 y 12 de junio de 1982 el II CONGRESO ARGENTINO DE TERAPIA FAMILIAR.

Como ya lo anunciáramos en agosto ppdo., este evento tendrá por objetivo promover un encuentro científico de intercambio y divulgación de experiencias, trabajos e investigaciones en Terapia Familiar, entre los especialistas del país.

Estas jornadas tienen además el carácter de preparatorias para el Congreso Argentino de Terapia Familiar de 1983, a realizarse durante los días 15 al 19 de junio de 1983.

Daremos a conocer oportunamente la integración de la Comisión Ejecutiva organizadora de dichas Jornadas, cuyos miembros estarán a su disposición para recibir y aportar las informaciones referentes a las mismas, como así también recibir los trabajos que se postulen.

LA COMISION DIRECTIVA

Gorostiaga 1731
(1426) Buenos Aires
Argentina

Tel. 773-1308